

С.Т. ИБОДОВ, С.Р. МИРЗОЕВА,
Э.Х. ТАҒОЙҚУЛОВ

АНАТОМИЯИ ЭЪТИЛОӢ

(ПАТОЛОГӢ)

*Курси лексияҳо барои
доншигоҳҳои
тиббӣ*

Душанбе 2011

УДК - 616 - 091
И - 148

Анатомияи эътилолӣ. Китоби дарсӣ. Душанбе, 2011, 214 сах.

МУРАТТИБОН:

мудири кафедраи анатомияи эътилолии ДДТТ ба
номи Абӯалӣ ибни Сино, доктори илмҳои тиб, дот-
сент **Ибодов Саидмуқим Тиллоевӣ;**

ассистенти кафедраи анатомияи эътилолии ДДТТ ба
номи Абӯалӣ ибни Сино
Мирзоева Соҳиба Рустамовна;

ассистенти кафедраи анатомияи эътилолии ДДТТ ба
номи Абӯалӣ ибни Сино
Тағайқулов Эркин Холиқулович.

МУТАРЦИМ ВА МУҲАРРИР:

муаллими кафедраи забони тоҷикӣ ДДТТ ба номи
Абӯалӣ ибни Сино **С.П. Одинаев.**

МУҚАРРИЗОН:

академики Академияи Илмҳои Омузгорӣ Иҷти-
моии ФР, Арбоби шоистаи илму техникаи ҚТ, док-
тори илмҳои тиб, профессор
Ф.А. Абдурахмонов;

дотсенти кафедраи бофташиносии ДДТТ ба номи
Абӯалӣ ибни Сино **С.Қ. Қӯраев.**

Китоб донишҷӯёро ба тағйиротҳои сохтори узву бофтаҳо, ҳуҷайраҳои
организми одам ҳангоми ҳолатҳои гуногуни эътилолӣ шинос менамояд. Усу-
лҳои муносири тадқиқот муфасссал баррасӣ мешаванд.

Барои донишҷӯёни макотиби олии тиббӣ пешниҳод шудааст.

Барои чоп аз тарафи Шӯъбаи таъбу нашри ВТ ҚТ тавсия дода шуда-
аст (протоколи № 1 аз 17 03 соли 2011).

© ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

МУҚАДДИМА

Ин китоби “курси лексияҳо”, ки ба шумо пешниҳод карда мешавад. Аввалин китоб ба забони тоҷики мебошад. Ин китоби “курси лексияҳо” дар асоси консепсияи мактаби олии ва программаи нави анатомияи паталогӣ тайёр карда шудааст. Дар китоби мазкур дар бораи этиология, патогенез, дар барои тағйиротҳои паталогӣ анатомии бемориҳои маълумот дода шудааст. Китоб барои донишҷӯёни тоҷикзабони тамоми факултаҳо пешбини карда шудааст. Муаллифони ин китоб бовари доранд, ки китоби мазкури “курси лексияҳо” барои муаллимони донишгоҳ ва донишқадаҳои тибби ҳамчун адабиёти асосӣ ба забони тоҷики истифода бурда мешавад.

Муаллифони китоб ба ҳамаи хонандагони китоб табъи хуш ва хониши бомувафақият орзу мекунанд, ҳамчунин хоҳиш мандем, ки агар тағйири иловаҳо ва пешниҳод аз тарафи хонандагон бошад расонед.

ЛЕКСИЯИ 1 ЭЪТИЛОЛИ СОХТИ МИКРОСКОПИИ ХУЧАЙРАҲО

1. Узввораҳо
2. Иштимотҳо
3. Ғишои ситоплазмавӣ (сабабҳо, натиҷаҳо, намудҳои осеб)

Дар таркиби ҳучайраҳои одам узввораҳо ва иштимотҳои зерин фарқ карда мешаванд: ҳаста (ситолема) бо масомаҳо, кариоплазма, ҳастаҷаҳо ва фазои назди ҳаставӣ ситоплазма: гиалоплазма бо узввораҳо ва иштимотҳои гуногун.

1

Ситоплазма.

Дар зери заррабини (микроскопи) электронӣ узввораҳои гуногун муайян карда мешаванд, ки барои мубодилаи моддаҳои ҳучайраҳо заруранд. Дар баъзе аз ҳучайраҳо дар шароити эътилолӣ иштимотҳое мавҷуданд, ки дар равандҳои мубодилавӣ моддаҳо иштирок намеkunанд ва аз ҷиҳати сохтшон бо ситоплазма монанд намебошанд - онҳо иштимотҳо (чарб, карбогидрат, моддаи ранговар ва ғайра) мебошанд.

Митохондрияҳо - ин индикаторҳои ҳолати фаъолияти ҳучайраҳо мебошанд, ки ҳангоми хуруҷи беморӣ фаъолияти митохондрияҳо ниҳоят зиёд мешавад. Осебҳои қисмати барзиёди митохондрияҳо бо ёрии равандҳои аутофагия бо вакуолаҳо (хубобчаҳои моеъдор), ки нақши лизосомаҳои думубораро мебозанд, амалӣ мегардад.

Намудҳои осебҳои митохондрияҳо:

дар калоншавии миқдору андозаҳо. Чунин ҳучайраҳо ҳамчун онкоситҳо маълуманд, онҳо ситоплазмаи фаровон

доранд, ядрои онҳо аксаран ба канор ҷойгир шудааст. Таҳвили онкоситарӣ дар ҳучайраҳои тараҷшӯҳҳосилкунанда оиди тағйироти синтези сафедаҳо шаҳодат медиҳад; ҳосилшавии мегамитохондрияҳо. Мегамитохондрияҳо масалан, ҳангоми гепатоситҳо бар асари бадмастӣ ва ҳангоми таллаифҳои ҷигар, дар ҳучайраҳои бофтаи рӯйпӯш - кунандаи найчаҳои гурдаҳо ҳангоми синдроми гурдавӣ, ҳангоми норасоии рибофлавин, ҳангоми захролудшавӣ бо бромидҳо, ҳангоми баъзе бемориҳои мушакҳо дучор мешаванд;

тағйирёбии шакл. Аксаран бо варамкунии митохондрияҳо асоснок шудааст. Вай бо воридшавии об ба митохондрияҳо алоқманд аст. Варамкуниро аз калоншавии ҳақиқии митохондрия, ки бо номи мегамитохондрия маълум аст, тафриқа намудан лозим аст;

тағйирёбии тегаи митохондрияҳо метавонад ба андоза, шакл ва миқдор; шаклдигаркунии тегаҳо ва камшавии миқдори онҳо таалуқ дошта бошад.

Ретикуломаҳои дохилиплазмавӣ (РД) дар ситоплазмаи ҳучайраҳо масомаҳо ва найчаҳои зиёдеро ҳосил мекунамд. Онҳо дар ташаккули гишои ҳаставӣ (ядрой) ва дастгоҳи Голчи иштирок менамоянд. Дар шароити эътилоли ду навъи тағйиротҳои морфологиро мушоҳида намудан мумкин аст - гиперплазия ва коҳишёбии ретикуломаи дохилиплазмавӣ.

Гиперплазияи барзиёд инкишофебӣ РД (суфта ё шахшӯл), яъне зиёдшавии миқдори он метавонад бо ҳосилшавии сохторҳои мутамарказ ба ҳамбастагӣ эозинофилий оварда мерасонад.

Коҳишёбии РД, яъне хурдшавии андозаи он, бо камшавии синтези сафедаҳои ҳучайра ҳамбастагӣ менамояд (ҳангоми гуруснамонӣ, бемориҳои ҷигар, пиршавӣ).

Дастгоҳи Голчи (маҷмӯи Гольджи (маҷмӯи лавҳача-нок).

Соҳторҳои Голчи бо ҳалтачаҳои пачақшудаи дорои (хубобчаҳо) доначаҳои тарашшӯҳӣ ва анастомозҳои ҳосил мешаванд, ки бо ретикуломаҳои дохилиплазмавӣ алоқаи мутақобила доранд. Дар онҳо протеинҳои барои тарашшӯҳ пешбинишуда бо гурӯҳи карбонгидратӣ васл мешаванд.

Падидаҳои морфологии ихтилолҳои функсияи тарашшӯҳӣ ё дар шакли гиперплазияи маҷмӯи лавҳачанок, яъне зиёдшавии майдони ғишоҳҳои он ва миқдори доначаҳои тарашшӯҳӣ ё дар шакли коҳишёбии маҷмӯи лавҳачанок ифода меёбанд, ки бо редуксияи (камшавии) хубобчаҳо ва талафёбии доначаҳои тарашшӯҳӣ ҳамроҳӣ менамояд.

Лизосомаҳо.

Лизосомаҳо дар таҷзияи ҳуҷайра, вайроншавии ҳуҷайраҳо ё қисми пиршавандаи онҳо ширкат намуда, ба ҳамин васила барқароршавии ҳуҷайраҳоро осон менамоянд ё ба сабзиши мӯътадили онҳо мусоидат мекунанд. Лизосомаҳо нигоҳдории таносуби биологии бо омилҳои хуруҷкунанда ҳангоми равандҳои сершумор – илтиҳоб, муҳофизати масунӣ, вайроншавии ҳадшабандии хун ва ғайра ҳалалдоршударо таъмин менамоянд.

Осебёбии ғишоҳҳои лизосомавӣ. Номӯътадилшавии (лабилизатсияи) ғишоҳҳои лизосомавӣ дар шакли тарқишу кафидагӣҳо метавонад ҳангоми таъсири омилҳои гуногуни хуруҷкунанда мушоҳида карда шавад: радиатсияи ионикунанда, аноксия (камоксигенӣ), садма, захролудшавӣ бо карбони тетраҳлордор, таъсири кремний, норасоии витаминҳо ва гипервитаминози А, таъсири эндотоксинҳои бактериявӣ ва ғайра. Дар ин ҳолат гидролазаҳо дар ҳуҷайра нуфуз мекунанд, ки боиси некроз ё вайроншавии пуравчи он тавассути худҳазмшавӣ мегардад.

Норасоии энзимҳои лизосомавӣ. Дар лизосомаҳо баъ-

зе аз энзимҳои (ферментҳои) барои мубодилаи мӯътадили хучайраҳо зарурӣ вучуд дошта наметавонанд. Энзимопатия ё бемории носозкории мубодила тавсифи модарзодӣ дорад ва аз рӯи ирсият тавассути навъи аутосомӣ-ретсессивӣ интиқол меёбад.

Ситозол.

Ситозол - ин чузъи ситоплазма мебошад, ки аз ҷиҳати сохтор ба узввораҳо дохил намешавад ва сафедаҳои дорад, ки дар онҳо ҷамъшавии узввораҳо, ферментҳои ҳалшаванда ба амал меояд, ки дар мубодилаи фосилавии хучайра иштирок мекунанд.

Зиёдшавии зичии ситозол – ин ҷавоби ғайрихоса ба навъҳои гуногуни омилҳои вайронкунанда: аноксия ё гипоксия (камоксигенӣ), захролушавӣ, таъсири вирус, захролудшавии саратонӣ, радиатсияи ионикунанда, таъсироти ҳарорати баланд, ҷараёни барқ ва ғайра мебошад.

Камшавии зичии ситозол бо камшавӣ ё қатъшавии синтези сафедаҳо, инчунин бо воридшавии об ба ситоплазма алоқманд буда метавонад. Ҳангоми камшавии мавзеи зичӣ дар бораи хромолиз изҳори ақида менамоянд.

Рибосомаҳо.

Рибосомаҳо барои шинохтани рамзи ирсии (генетики) хучайра узввораҳои ҳатмӣ ба ҳисоб мераванд. Мавзеъгирии рибосомаҳо бо навъи сафедаҳои синтезшаванда вобастагӣ дорад. Рибосомаҳои озод дар эритробластҳои базофилӣ ва дар нейронҳо мавҷудбуда синтези ҷисмчаҳои хучайравиро таъмин мекунанд. Баръакс рибосомаҳои бо гишоҳои ЭР мутаҳидшуда дар ҳамаи хучайраҳои тарашшӯхӣ ошкор карда мешаванд.

Дар шароити эътилол рибосомаҳо метавонанд шаклҳои нағз тарҳкашидашудаи геометрияро созанд. Масалан ҳангоми таъсироти афилотоксин ва дар хучайраҳои омосии лимфомаҳои Беркитт онҳо шакли спиралро доранд.

Чунин тағйироти таркиботи ҳуҷайраҳо ҳангоми гипотермия, камоксигенӣ ва норасоии сафеда дар организм мушоҳида карда мешаванд.

2

Идхолаҳои ситоплазмавӣ

Донаҷаҳои тарашшӯхӣ. Онҳо дар ҳуҷайраҳо дар се намуд мавҷуданд экзо-, эндо- ё нейротарашшӯхҳо.

Азбаски дар аксари ҳолатҳо таъсири ҳар гуна омили бемориовар (патогенӣ) бо тағйирёбии гомеостаз ҳамбастагӣ менамояд, пас дарки ахбороти бемориовар аз тарафи ҳуҷайра тавассути гишои ҳуҷайравии он амалӣ мешавад.

3

Гишои ситоплазмавӣ (ситолема).

Нифозати мӯътадили ситолема - шартӣ асосӣ дар гомеостази ҳуҷайра мебошад. Ситолема ҳамзамон ҳам ҳамчун тавора, ҳам гузаргоҳ барои ҳамаи мабдаъҳое (субстансияҳо) мебошад, ки ба ҳуҷайра роҳ меёбанд ё онро тарк мекунанд. Вай таркиби дохилии химиявии ҳуҷайраро тавассути нифзоати интиҳоби ва интиқол нигоҳ медорад.

Халалдоршавии сохт ва вазифаи гишои ҳуҷайра.

Сабабҳои осебёбии гишои ҳуҷайра:

- ҳосилшавии радикалҳои озод;
- фаъолноқшавии силсилаи комплемент;
- ҳалшавӣ (лизис) бо ферментҳо;
- ҳалшавӣ бо вирусҳо;
- таъсири омилҳои физикӣ ва химиявӣ (ҳарорати баланд ва паст, моддаҳои химиявӣ ва ғайра).

Натиҷаҳои осебёбии гишои ҳуҷайра:

- талафёбии бутунияти сохторӣ то некроз;
- халалдоршавии функсияи «таворагӣ», ки метавонад боиси воридшавии барзиёди об ба таркиби ҳуҷайра— дистрофияи вакуолӣ ё гидротикӣ гардад.

Намудҳои осебёбии гишои ҳуҷайра:

- эътилоли (патологияи) гишои ҳуҷайра метавонад бо тағйиротҳои нифозати гишоҳо, ҳалалдоршавии нокилияти гишоъ, коммуникатсияи ҳуҷайраҳо ва «шинохтани» онҳо, тағйирёбии мутаҳаррикии гишо ва шакли ҳуҷайраҳо, ихтилоли синтез ва мубодилаи гишо ҳамбастагӣ менамояд;

- осебёбии шакли гишо. Ба таври морфологӣ дар шакли деформатсия (шаклдигаркунӣ) ё атрофияи (таназзули) сохторҳои махсус, пайдо шудани роғҳо ё ковокиҳо зоҳир мегардад;

- тағйирёбии нифозати гишоҳо;

- тағйирёбии коммуникатсияи ҳуҷайраҳо ва «шинохтани» онҳо;

- аз ҳад зиёд калоншавии сохторҳои мӯътадил;

- пайдо шудани сохторҳои махсуси эътилолӣ;

- алтератсияи пайвастагиҳои ҳуҷайравӣ.

ЛЕКСИЯИ 2

МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ ДИСТРОФИЯҲО. ДИСТРОФИЯИ ПАРЕНХИМАТОЗӢ

1. *Муайянкунӣ*

2. *Морфогенез*

3. *Таснифот*

1

Дистрофия — ин тағйиротҳои миқдорӣ ва сифатии сохторӣ дар ҳуҷайраҳо ва ё моддаи байнихуҷайравии узву бофтаҳо мебошад, ки бо ҳалалдоршавии равандҳои мубодилавӣ асоснок гардидааст. Ҳангоми дистрофия дар натиҷаи ҳалалдоршавии физогӣ дар ҳуҷайраҳо ё дар моддаи байнихуҷайравӣ моддаҳои гуногун (сафедаҳо, чарбҳо, карбонгидратҳо, маъданҳо, об) чамъ мешавад.

Моҳияти морфологии дистрофия зоҳир мешавад:

- бо зиёдшавӣ ё камшавии миқдори ягон моддае, ки дар организм аз рӯи меъёр мавҷуд аст;
- бо тағйиротҳои сифатӣ, яъне хусусиятҳои физикию химиявии моддаҳо, ки ба организм ҳангоми меъёр хос аст;
- пайдо ва ҷамъшавии моддаҳои наве, ки ҳангоми меъёр барои он хос нестанд.

Ба ҳамин тариқ, дистрофия зоҳиршавии морфологии ихтилолҳои метаболизми (мубодилаи) ҳуҷайраву бофтаҳо мебошад.

Сабаби бевоситаи инкишофи дистрофия инҳо буда метавонанд: омилҳои гуногуне, ки ба танзими худии ҳуҷайраҳо осеб мерасонанд (моддаҳои захролудкунанда, омилҳои физикӣ ва химиявӣ, моддаҳои муайяни химиявӣ, радиатсияи ионикунанда), ферментопатияи (энезимопатияи) пайдошуда ё модарзодӣ, вирусҳо, ҳалалдоршавии вазифаи силсилаи барқӣ ва ноқилият, ки метаболизм ва нигоҳдории сохтории ҳуҷайраҳоро таъмин менамоянд, вайроншавии танзими эндокринӣ ва асаб.

2

Морфогенези дистрофия

Дар байни механизмҳое, ки боиси инкишофи тағйиротҳои хоси дистрофия мегарданд, инфилтратсия, декомпозиция (фанероз), синтези таҳрифёфта ва трансформатсия (тахвил) фарқ карда мешаванд.

Инфилтратсия - воридшавии барзиёди маҳсулоти мубодила аз хун ва лимфа ба ҳуҷайраҳо ё моддаи байниҳуҷайравӣ ва ё ҳалалдоршавии дохилшавии онҳо ба мубодила (метаболизм) ва ҷамъшавии баъдинаи онҳо мебошад.

Декомпозиция (фанероз) - таҷзияи моддаҳои аз ҷиҳати химиявӣ мураккаб мебошад. Таҷзияи маҷмӯи сафедаҳои мураккаб асоси тағйиротҳои фибриноидии боф-

таи пайвасткунандаро ҳангоми бемориҳои тарбодӣ ташкил медиҳад.

Трансформатсия - гузариши як модда ба таркиби моддаи дигар мебошад. Масалан, трансформатсияи карбонгидратҳо ба чарбҳо ҳангоми диабетӣ қанд, полимеризатсияи пурзӯри глюкоза ба глюкоген ва ғайра чунин мебошанд.

Синтези тахрифёфта - ин синтез дар ҳуҷайраҳо ё дар бофтаҳои моддаҳои мебошад, ки ҳангоми меёр дар онҳо дучор намешавад. Ба онҳо дохил мешаванд: синтези сафедаи ғайритабии амилоид дар ҳуҷайра ва ҳосилшавии маҷмӯи ғайритабии сафедави полисахаридӣ дар моддаи байниҳуҷайравӣ, синтези сафедаи гиалини алкоғолӣ дар гепатосит, синтез гликоген дар бофтаи рӯйпушкунандаи қисми борики нефронҳои гурда ҳангоми диабетӣ қанд.

2

Дар таснифоти дистрофия якчанд хосиятҳо ба инобат гирифта мешаванд. Дистрофияҳои зерин ҷудо карда мешаванд:

Вобаста аз мавзёгирии ихтилолҳои мубодила:

- паренхиматозӣ;
- стромалӣ- рагӣ;
- омехта.

Аз рӯи бартарӣ доштани ин ё он намуди мубодила:

- сафедагӣ;
- чарбӣ;
- карбонгидратӣ;
- маъданӣ.

Вобаста аз таъсири омилҳои ирсӣ (генетикӣ):

- пайдошуда;
- модарзодӣ.

Аз рӯи паҳншавии раванд:

- умумӣ;

чузӢй.

Ҳангоми дистрофияҳои паренхиматозӣ ихтилоҳои механизмҳои ҳуҷайравии ғозия (трофика) бартарӣ доранд. Аз ин сабаб дар узвҳои гуногун ҳангоми инкишофи ҳуди ҳамон як намуди дистрофия механизмҳои гуногуни патова морфогенетикӣ иштирок менамоянд.

Механизми осебёбии ҳуҷайра аз ин иборат аст: чамъшавии дохилиҳуҷайравии обу электролитҳо ба амал меояд, ки бо ҳалалдоршавии вазифаи барқия K^+-Na^+ — АТ-Фаза ғишои ҳуҷайравӣ ба амал меояд. Дар натиҷаи ҷоришавии K^+ , Na^+ ва ҳуҷайра боиси варамкунӣ мегардад, ки натиҷаи барвақтӣ ва бозгаштпазири осебёбии ҳуҷайра мебошад. Баъди ҷоришавии ионҳои натрий ва об варамкунии узввораҳои ситоплазмавӣ ба амал меояд. Ҳангоми варамкунии ретикулумаи эндоплазмавӣ ҷудошавии рибосомаҳо ба вучуд меояд, ки боиси ҳалалдоршавии синтези сафеда мегардад.

Дар шароити камоксигенӣ мубодилаи моддаҳои ҳуҷайравӣ гликолизи аэробӣ ба анаэробӣ тағйир меёбад, Табдилёбӣ боиси истехсоли кислотаи оксипропионат мегардад ва пастшавии рН-и дохилиҳуҷайравиро ба вучуд меоварад. Хроматин дар ҳаста ғализ мешавад, вайроншавии минбаъдаи ғишои узввораҳо ба амал меояд. Вайроншавии ғишои мембранаҳои лизосомӣ боиси ба ситоплазма воридшавии ферментҳои лизосомӣ мегардад, ки ба молекулаҳои ҳаётан муҳими дохилиҳуҷайравӣ осеб мерасонанд.

Моҳияти диспротеинозҳои паренхиматозӣ аз тағйирёбии хусусиятҳои физикию химиявӣ ва морфологии сафедаҳои ҳуҷайра иборат аст. Сафедаҳо ё дучори коагулятсия, яъне ҳадшабандӣ бо зиёдшавии миқдори пайвастагиҳои химиявӣ мегарданд, ё баръакс, колликуватсия (суюқшавӣ), яъне таҷзияи занҷираҳои полиптедӣ дар фрагментҳо мегардад, ки боиси гидрататсияи ситоплазма ме-

шавад. Баъди осебёбӣ дар ҳуҷайра нисбатан тезтар синтези сафедаҳои оилаи бутун-сафедаҳои садмаи ҳароратӣ зиёд мегардад. Дар байни сафедаҳои садмаи ҳарорат убиквитин нисбатан омехташуда мебошад. Ҳангоми осебёбии вазнин ва чамъшавии барзиёди маҷмӯи убиквитин-сафеда метавонанд идҳолаҳои ситоплазмавӣ ташаккул ёбанд.

Дистрофияи гиалинӣ-қатрагӣ

Ҳангоми дистрофияи гиалинӣ-қатрагӣ дар ситоплазма ҷисмчаҳо ва қатраҳои калони гиалинмонанди сафедагӣ пайдо мешаванд, ки байни ҳамдигар омехта гардида ва тамоми пайкари ҳуҷайраро пур мекунанд. Асоси ин дистрофияро коагулятсияи (ҳадшабандии) сафедаҳои ситоплазма бо деструксияи (созмоншикании) зоҳиршавандаи элементҳои ултрасохторҳои ҳуҷайра - некрози лонавии ҳадшагӣ (коагулятсионӣ) ташкил медиҳад.

Дар гурдаҳо ҳангоми тадқиқоти микроскопӣ чамъшавии донаҳои калони сафедаи ранги бунфаши баланд - қатраҳои гиалинӣ - дар нефроситҳо дарёфт карда мешавад. Дар ин ҳолат деструксияи митохондрия, шабакаи эндоплазмавӣ мушоҳида карда мешавад. Асоси дистрофияи гиалинӣ-қатрагии нефроситҳо норасоии дастгоҳи вакуолярӣ-лизосомии дастгоҳи эпителияи найчаҳои проксималӣ ва дисталии пурпечутоби гурдаҳо ташкил медиҳад, ки ҳангоми меёр сафедхоро ҷаббида мегиранд.

Дар ҷигар ҳангоми тадқиқоти микроскопӣ дар гепатоситҳо ҷисмчаҳо ва қатраҳои табиаташон сафедагӣ дарёфт карда мешаванд - ин гиалини алкоғолӣ мебошад. Ҳосилшавии ин сафеда ва ҷисмчаҳои Маллори падидаи вазифаи таҳрифёфтаи сафедагӣ-синтетикӣ гепатосит мебошад ва доимо ҳангоми майнушӣ ошкор карда мешавад.

Оқибати дистрофияи гиалинӣ-қатрагӣ номусоид аст: вай бо раванди бозгаштнопазир ба охир мерасад, ки ки боиси некрози интиҳоеи коагулятсионии ҳуҷайра мегардад.

Аҳамияти вазифагии ин дистрофия хеле калон аст — якбора пастшавии вазифаии узв ба амал меояд.

Дистрофияи гидропӣ ё хубобчавӣ.

Дистрофияи гидропӣ ё хубобчавӣ бо дар ҳуҷайра пайдо шудани хубобчаҳои моеъдор, бо моеи ситоплазмӣ пуршуда тавсиф меёбад. Моеъ дар халтачаҳои тӯри эндоплазмагӣ ва митохондрияҳо, баъзан дар ҳастаи ҳуҷайра ҷамъ мешавад. Механизми инкишофи дистрофияи гидропӣ мураккаб аст ва ихтилолҳои обу электролитҳо ва сафедаро инъикос менамояд, ки боиси тағйирёбии фишори коллоидӣ-осмосӣ дар ҳуҷайра мегардад.

Сабабҳои инкишофи дистрофияи гидропӣ дар узвҳои гуногун яхела нест. Дар гурдаҳо - ин осебёбии полоиши гломерулярӣ (гломерулонефрит, амилоидоз, диабетиканд) мебошад, ки боиси гиперфилтратсия ва норасоии системаи ферментии нефроситҳо гашта, ҳангоми меъёр ҷаббиши обро таъмин менамоянд; захролудшавӣ бо гликолҳо, гипокалиемиа. Дар чигар дистрофияи гидропӣ ҳангоми гепатитҳои вирусӣ ва захрогенӣ пайдо мешавад. Сабабҳои дистрофияи гидропии пӯстпарда сироятҳо, аллергия буда метавонанд.

Ҳангоми дистрофияи гидропӣ ранги берунии узву бофтаҳо ҳам тағйир меёбад.

Манзараи микроскопӣ: андозаи ҳуҷайраҳои лаҳимагӣ (паренхиматозӣ) калон шуда, ситоплазмаи онҳо бо хубобчаҳо (вакуолаҳо) пур мебошад, ки моеи шаффоф дорад. Ҳастаҳо ба канор ҷой иваз мекунанд, баъзан хубобчадор ё пуч мешавад. Афзоиши гидропия боиси таҷзияи ултрасохторҳо ва бо об пуршавии ҳуҷайраҳо, пайдо шудани ковокиҳо бо моеъ пуршуда мегардад, аз ин сабаб чунин тағйиротҳоро дистрофияи ковокидорҳо (баллонӣ) номида мешаванд.

Оқибати дистрофияи гидропӣ одатан номусоид аст;

вай бо некрози интиҳои колликуватсионии ҳуҷайра ба анҷом мерасад.

Дистрофияи шахшулшавандагӣ.

Дистрофияи шахшулшавандагӣ иллатӣ бо аз ҳад зиёд ҳосилшавии моддаҳои шахшулшаванда дар таркиби ҳуҷайраҳои бофтаи рӯйпӯшкунандаи пӯст (гиперкератоз, ихтиоз) ё ҳосилшавии моддаи шахшулшаванда дар он қое, ки ҳангоми меъёр вучуд дошта наметавонад — шахшулшавандагӣ иллатӣ дар луобпардаҳо, масалан дар луобпардаи ковокии даҳон (лейкоплакия), сурхрӯда, гарданаки бачадон. Дистрофияи шахшулшавандагӣ метавонад қузъӣ ё умумӣ, модарзодӣ ё пайдошуда, бошад.

Сабабҳои дистрофияи шахшулшавандагӣ гуногунанд:

- илтиҳоби музмин, ки бо омили сироятӣ алоқаманд аст;

- таъсири омилҳои физикӣ ва химиявӣ;

- авитаминозҳо;

- ихтилолҳои модарзодии инкишофи пӯст ва ғайра.

Оқибати он метавонад духела бошад: бартараф намулдани сабаби пайдошуда дар оғози раванд метавонад боиси барқароршавии бофта гардад, вале дар ҳолатҳои хеле амиқшуда ҳалокати ҳуҷайраҳо фаро мерасад.

Дистрофияҳои паренхиматозии чарбӣ (липидозҳо).

Дистрофияи паренхиматозии чарбӣ — ин падидаи сохтории ихтилолҳои мубодилаи липидҳои ситоплазмавӣ мебошанд, ки метавонанд бо қамъшавии чарб дар ҳолати озод дар ҳуҷайраҳои пайдо шавад, ки ҳангоми меъёр дар онҳо дида намешавад. Сабабҳои дистрофияи чарбӣ гуногунанд:

- норасоии ҳаво;

- сироятҳои вазнин ё давомнок қараёнбанда;

- авитаминозҳо;

- ғизои яктарафа.

Дистрофияи паренхиматозии чарбӣ асосан бо чамъшавии триглицеридҳо дар ситоплазмаи ҳуҷайраҳои паренхиматозӣ тавсиф меёбад. Ҳангоми вайрон шудани алокаи сафедаҳо бо липидҳо - декомпозитсия - деструксия (созмоншикании) сохторҳои гишои ҳуҷайраҳо ба вучуд меояд ва дар ситоплазма липоидҳои озод пайдо мешаванд, ки субстрати морфологии дистрофияи паренхиматозии чарбӣ мебошанд.

Аломатҳои микроскопии дистрофияи чарбӣ: ҳар гуна чарбҳои дар ҳалкунандаҳои муқаррарӣ маҳлул мегардад (рангомезишшавӣ бо рангҳои гематоксилин ва эозин).

Рангомезишшавӣ махсуси чарбҳо аз истифода бурдани асбоби махсуси мустаҳзар тайёркунандаи яхкунанда талаб менамояд, ки аз бофтаи тару тоза сохта истифода мебаранд. Чарбҳоро бо ёрии як қатор усулҳои гистохимиявӣ ошкор карда мешаванд:

- судани IV, чарбра бо ранги сурх ранг мекунад;
- судани III - ба бунафш;
- судани сиёҳи В ва кислотаи осмиевӣ - ба сиёҳ;
- сульфати (нильского) кабуд кислотаҳои чарбиро бо ранги кабуди сиёҳранг, чарбҳои мӯътадилро бошад - ба сурх ранг мекунад.

Дистрофияи чарбии чигар бо якбора зиёдшавии миқдор ва тағйирёбии таркиби чарбҳо дар гепатоситҳо зоҳир мегардад. Дар ҳуҷайраҳои чигар сараввал қатрачаҳои чарбии хурд пайдо мешаванд, сипас қатраҳои хурди онҳо (фарбеҳии хурдқатрагӣ) пайдо мешаванд, ки минбаъд бо қатраҳои калон (фарбеҳии калонқатрагӣ) ё ба як ҳубобчаи (вакуолаи) чарбӣ омехта мешаванд ва тамоми ситоплазма ро пур карда, ҳастаро ба канор тела медиханд.

Сабаби дистрофияи чарбии чигар - чамъшавии триглицеридҳо дар ситоплазмаи ҳуҷайраҳои чигар - дар натиҷаи вайроншавии мубодила (метаболизм) ҳангоми шароитҳои зерин пайдо мешавад:

· хангоме, ки сафарбарии чарбҳо ба бофтаи чарбӣ зиёд мешавад;

· хангоме, ки суръати табдилёбии кислотаҳои чарбӣ ва триглицеридҳо дар чигар аз сабаби фаъолнокии баланди силсилаи мувофиқи ферментӣ зиёд аст;

· хангоме ки туршшавии триглицеридҳо то атсетил-КоА ва қисмҳои кетонӣ дар узвҳо кам гаштааст;

· хангоме ки синтези сафедаҳо - аксепторҳои чарбҳо нокифоя аст.

Навъҳои дистрофияи чарбии чигар.

Дистрофияи шадиди чарбии чигар. Хангоми дистрофияи шадиди чарбии чигар триглицеридҳо дар ситоплазма ҳамчун ҳубобчаҳои хурди бо ғишои маҳдудшуда ҷамъ мешаванд (дистрофияи хурднуқтагии чарбии чигар).

Дистрофияи музмини чарбии чигар. Қатраҳои чарб дар ситоплазма пайваست гашта, ҳубобчаҳои калонро ташкил медиҳанд. Қатраҳои чарб ситоплазма бо ҳам пайваст шуда ҳубобчаҳои чарбӣ ҳосил мешаванд.

Дистрофияи чарбии мушакпардаи дил бо ҷамъшавии триглицеридҳо дар мушакпарда тавсиф меёбад.

Сабабҳои дистрофияи чарбии мушакпардаи дил.

Ҳолатҳои музмини камоксигенӣ, махсусан хангоми камхунии зоҳиршаванда. Хангоми дистрофияи музмини чарбӣ рахҳои рангҳои зард бо қитъаҳои сурхи чигарӣ якдигарро иваз мекунанд («дили палангӣ»).

Иллатҳои заҳролудшавӣ. Ба таври макроскопӣ дил серковок, ранги зарди мунташир дорад, ҳаҷми дил калон ба назар мерасанд, ҳуҷраҳои он кашишхӯрда мебошанд.

Дар гурдаҳо хангоми дистрофияи чарбӣ чарбҳо дар ситоплазмаи ҳуҷайраҳои бофтаи рӯйпӯшкунандаи найчаҳои проксималӣ ва дисталӣ пайдо мешаванд.

Намуди берунии гурдаҳо: онҳо ҳаҷман калон, серковоканд, моддаи қишрӣ варамида, хокситаранг, ки дар сатҳ ва буриш намоён аст.

Сабаби пайдоиши дистрофияи чарбии гурдаҳо бо инфилтратсияи эпителияи найчаҳои гурдаҳо ҳангоми липемия ва гиперхолестеринемия алоқаманд аст.

Оқибати дистрофияи чарбӣ аз дараҷаи он вобастагӣ дорад. Агар он бо шикасти дағали сохторҳои ҳуҷайравӣ ҳамбастагӣ дошта бошад, одатан бозгаштпазир мебошад. Вайроншавии мубодилаи липидҳои ҳуҷайравӣ дар аксарӣ ҳолатҳо бо ҳалокати ҳуҷайраҳо анҷом меёбад.

Аҳамияти функционалии дистрофияи чарбӣ калон аст: фаъолияти узвҳо дар ин маврид якбора ҳалалдор мешавад, дар як қатор ҳолатҳо бошад қатъ меёбад.

Дистрофияи паренхиматозии карбонгидратӣ.

Полисахаридҳо, гликозаминогликанҳо ва гликопротеидҳо бо ШИК-аксуламал ошкор карда мешаванд. Барои ошкор намудани гликоген ШИК-аксуламалро бо саниши ферментативӣ-коркарди бофтапораҳо бо амилаза пурра мекунад. Гликоген бо кармини Бест ба ранги сиёҳ ранг карда мешавад. Гликозаминогликанҳо ва гликопротеидҳо бо ёрии як қатор усулҳо муайян карда мешаванд, ки аз онҳо нисбатан бештар рангкунӣ бо толуидинии кабуд ё метилении кабуд истифода бурда мешавад. Ин рангҳо барои ошкор намудани моддаҳои хромотропӣ имконият медиҳанд, ки аксуламали метахромазияро медиҳанд.

Дистрофияи паренхиматозии карбонгидратӣ метавонад бо вайроншавии мубодилаи гликоген ё гликопротеидҳо алоқаманд бошад.

Вайроншавии мубодилаи гликоген.

Ҳалалдоршавии миқдори гликоген дар камшавӣ ё зиёдшавии миқдори он дар бофтаҳо ва пайдоиши он дар он ҷое алоқаманд аст, ки одатан ошкор карда намешавад. Ин ихтилолҳо нисбатан равшан ҳангоми диабети қанд ва ҳангоми дистрофияҳои ирсии карбонгидратӣ-гликогенӣ-

зҳо зоҳиршаванда мебошанд.

Гликогенозҳо бо мавҷуд набудан ё норасоии фермент асоснок шудаанд, ки дар таҷзияи гликогени захирашуда иштирок менамояд ва аз ин сабаб ба ферментопатияҳои ирсӣ ё бемориҳои ҷамъшавӣ дохил мешавад.

Дистрофияҳои карбонгидрати бо ҳалалдоршавии мубодилаи, гликопротеидҳо алоқаманд.

Ҳангоми ҳалалдоршавии мубодилаи гликопротеидҳо дар ҳучайраҳо ё моддаи байнихучайравӣ ҷамъшавии мутсинҳо ва мукоидҳо ба амал меояд, ки ҳамчунин моддаҳои луобӣ ё луобмонанд номида мешаванд. Аз ин сабаб ҳангоми ҳалалдоршавии мубодилаи гликопротеидҳо дар бораи дистрофияи луобӣ ҳукм меронанд.

Тадқиқоти микроскопӣ барои ошкор намудани нафақат луобҳосилшавии пурзӯр, балки тағйиротҳои хусусияти физикию химиявии луоб имконият медиҳанд.

Оқибати он аз рӯйи дараҷа ва давомнокии луобҳосилшавӣ муайян карда мешавад. Дар баъзе ҳолатҳои таҷдиди (регенератсия) бофтаи рӯйпӯшкунанда боиси пурра барқароршавии луобпарда мегардад, дар ҳолатҳои дигар - вай коҳиш меёбад, баъдан тасаллубнок мешавад.

ЛЕКСИЯИ 3 ДИСТРОФИЯИ МЕЗЕНХИМАЛӢ

Дар таркиби бофтаи пайвасткунанда се навъ тору нахҳо мавҷуданд: нахҳои шилмдиҳанда, ёзанда ва ретикулӣ.

Синтези нахҳои шилмдиҳандаи нав - қисми ҷудонашавандаи раванди таҷдид (регенератсия) мебошад, вале ин раванд ҳангоми илтиҳоби музмин низ мушоҳида карда мешавад. Ҳалалдоршавии синтези нахҳои шилмдиҳанда боиси ихтилоли сихатшавии захмҳо ва шиканандагии зиёди мӯйрагҳо мегардад.

Моддаи асосӣ аз моеъи, ки дар таркибаш сафедаҳои

плазмавӣ, гликозаминогликанҳои гуногун (хондроитин дерматан-, гепарин, кератансулфатҳо ва гайрисулфатӣ - кислотаи гиалуронӣ) ва фибронектин иборат аст.

Дар таркиби бофтаи пайвасткунанда ҳуҷайраҳои пайдоишашон гематогенӣ мавҷуданд, ки фагоситозро амалӣ менамоянд (лейкоситҳои полиморфӣ-ядрӣ, гистиоситҳо, макрофагҳо), инчунин аксуламалҳои масуниро таъмин менамоянд (плазмобластҳо, плазмоситҳо, лимфоситҳо, макрофагҳо).

Ба диспротеинозҳои пайкарурагӣ дохил мешаванд:

- варами мукоидӣ;
- варами фибриноидӣ;
- гиалиноз;
- амилоидоз.

Варами мукоидӣ, варами фибриноидӣ ва гиалиноз аксаран марҳилаҳои оқибатии созмоншикании (дезорганизатсияи) бофтаи пайвасткунанда мебошанд.

Амилоидоз аз ин равандҳо бо он фарқ мекунад, ки ба таркиби мачмӯи ҳосилшавандаи сафедагӣ-полисахаридӣ сафедаи ғайримуқаррарии ҳангоми меъёр дучорнашавандаи фибриллярӣ дохил мешавад, ки бо ҳуҷайраҳои махсус - амилоидобластҳо синтез мешаванд.

Варами мукоидӣ - зиёдшавии миқдор ва азнавтасимикунии мукополисахаридҳо, асосан гликозаминогликанҳо, асосан моддаи бофтаи пайвасткунанда мебошад. Ҷамъшавии гликозаминогликанҳо ҳамеша аз осебёбии девори мӯйрагҳо оғоз мегардад, ки боиси инкишофи камоксигени бофтаҳо, фаъолнокии гиалуронидаза сустшавии алокаи байни гликозаминогликанҳо ва сафедаҳо мегардад.

Барои ошкор намудани гликозаминогликанҳо ранго-мешишҳои махсус истифода мебаранд.

Ба таври микроскопӣ нахҳои шилмдиҳанда одатан сохтори даставии худро нигоҳ медоранд, вале варами мекунад ва бенах мешаванд. Ба таври макроскопӣ узвҳо

амалан тағйир наёфтаанд. Варами мукоидӢ аксаран дар девораи шараёнхо, дарғотҳои дил, андарунпарда ва руйпардаи дил, дар ғилофаки буғумхо инкишоф меёбад.

Сабабҳо: бемориҳои сироятӣ-аллергӣ; бемориҳои тарбодӣ; атеросклероз; бемории фишорбаландӣ; камоксигенӣ.

Варами мукоидӢ - раванди бозгаштпазир, метавонад барқароршавии пурраи сохт ва функсияи вазифа бавучуд ояд. Агар таъсири омили бемориовар идома ёбад, варами мукоидӢ метавонад ба варами фибриноидӣ гузарад.

Вазифаи узв дар гистионе, ки варами мукоидӢ инкишоф меёбад, кам халалдор мешавад.

Варами фибриноидӣ - созмоншикании амиқ ва бозгаштнопазири бофтаи пайвасткунанда мебошад.

Фибриноид - ин моддаи мураккабе мебошад, ки аз ҳисоби сафедаву полисахаридҳо, нахҳои таҷзияшавандаи шилмдиханда ва моддаи асосӣ, инчунин сафедаҳои хунобаи хун ва нуклеопроteidҳои ҳучайраҳои вайроншудаи бофтаи пайвасткунанда ҳосил шудааст. Ҷузъи асосии фибриноид фибрин мебошад.

Ба таври микроскопӣ дастаи нахҳои шилмдиханда гомогенӣ, эозинофилӣ, якбораи ШИК-позитивӣ мегарданд.

Ба таври микроскопӣ узву бофтаҳое, ки дар онҳо варами фибриноидӣ инкишоф меёбад, кам тағйир ёфтаанд.

Варами фибриноидӣ ё характери силсилавӣ (пахншуда) ё мавзей (ҷузъӣ) дорад.

Иллати силсилавӣ ҳангоми: бемориҳои сироятӣ-аллергӣ, бемориҳои аллергия ва аутоиммунӣ ва бемориҳои аутоиммунӣ; аксуламалҳои ангионевротикӣ мушоҳида карда мешавад.

Ба таври мавзей фибриноид ҳангоми илтиҳоби музмин ошкор карда мешавад. Масалан, дар қаъри реши музмини меъда, решҳои ғозиявии (трофикии) пӯст.

Дар фарҷоми варами фибриноидӣ гоҳо некрози фиб-

риноидӢ инкишоф меӢбад, ки бо вайроншавии пурраи бофтаи пайвасткунанда тавсиф меӢбад.

Варами фибриноидӢ боиси вайроншавӢ, ҳатто гоҳо қатъшавии вазифаи узв мегардад.

Ҳангоми гиалиноз дар бофтаи пайвасткунанда моддаи саҳти нимшаффофи якхела (гиалин) ҳосил мешаванд, ки тағояки шишамонандро ба хотир меоваранд.

Ҳангоми тадқиқоти иммуногистохимиявӢ дар таркиби гиалин на фақат сафедаҳои хуноба - фибрин, балки қузьҳои маҷмӯи масунӢ (иммуноглобулинҳо, қисмчаҳои комплементӢ), ва ҳатто гоҳо қарбҳо ошқор қарда мешаванд. Моддаи гиалинӢ нисбати қислотаҳо, алқалҳо, ферментҳо устувор, ШИК-мусбат мебошанд, рангкунандаҳои туршро (эозин, фуксини турш)-ро нағз қабул мекунанд, бо пикрофуксин ба ранги зард Ӣ сурх ранг қарда мешаванд.

Гиалиноз метавонад дар оқибати равандҳои гуногун инкишоф Ӣбад:

- қаббиши плазмавӢ;
- варами фибриноидӢ;
- тасаллуб.

Фарқ қарда мешавад:

- гиалинози рағҳо;
- гиалинози аслии бофтаи пайвасткунанда.

Ҳар яке аз ду навъи гиалиноз метавонад характери қислававӢ ва қузьӢ дошта бошад.

Гиалинози рағҳо. Ба гиалиноз асосан шараӢну шараӢнчаҳои хурд дучор мешаванд. Қабл аз он осебӢбии эндоthelia, гишои бунгоҳӢ хучайраҳои мушакҳои суфтаи деo-раи рағҳо ва қаббидашавии он бо сафедаҳои хунобаи хун воқеъ мегардад.

Сабабҳои гиалинози қислававии рағҳо:

- фишорбаландии шараӢнӢ ;
- диабет, бемориҳои тарбодӢ;
- атеросклероз.

Механизмҳои асосии инкишофи он инҳо мебошанд:
 · созмоншикании сохторҳои нахӣ;
 · баландшавии нифозати рағию бофтагӣ (плазморрагия).

Ба таври микроскопӣ ҳангоми гиалиноз шаарёнчаҳо ба найчаҳои ғафси шишамонанди дорои равзанаи якбора тангшуда ё пурра маҳкамшуда табдил меёбанд.

Се навъи гиалини рагӣ фарқ карда мешавад:

· оддӣ, ки аз чузъҳои кам тағйирёфтаи хунобаи хун пайдо мешаванд;

· липогиалин, ки липидҳо ва бета-липопротеидҳо дорад;

· гиалини мураккаб, ки аз маҷмӯҳои масунӣ, фибрин ва сохторҳои вайроншудаи девораи рагӣ сохта шудааст.

Гиалинози чузъии шараёнҳо ҳамчун падидаи физиологӣ дар испурчи калонсолон ва одамони кӯҳансол мушоҳида карда шуда, хусусиятҳои физиологию морфологии испурчро ҳамчун узви анбори хун инъикос мекунанд.

Дар аксари ҳолатҳо фарҷоми он номусоид аст, зеро раванд бозгаштнопазир аст.

Гиалинози паҳншудаи шараёнчаҳо (артериолаҳо) метавонад норасоии функционалии узв гардад (норасоии функционалӣ ҳангоми таллайфи артериолосклерозии гурдаҳо). Шиканандагии рагҳо боиси инкишофи хунравӣ мегардад.

Гиалинози аслии бофтаи пайвасткунанда. Гиалинози силсилаи бофтаи пайвасткунандаи рагҳо одатан дар фарҷоми варами фибриноидӣ инкишоф ёфта, боиси созмоншикании торҳои шилмдиҳанда ва чаббиши бофта бо сафедаҳои хуноба полисахаридҳо мегардад.

Гиалинози чузъӣ ҳамчун фарҷоми тасаллӯб (склероз) дар ҳадшаҳо, илтиёмҳои фиброзии ковокиҳои зардобӣ, девораи рагҳо ҳангоми атеросклероз ва ғайра инкишоф меёбад. Асоси гиалинозро дар ин ҳолат вайроншавии му-

бодилаи моддаи бофтаи пайвасткунанда ташкил медиҳад.

Тадқиқоти микроскопӣ. Дастаи торҳои шилмдиҳанда фибриллярнокии худро аз даст медиҳанд ва ба моддаи якхелаи саҳти тағоякмонанд омехта мешаванд; унсурҳои хучайравӣ фишурда мешаванд ва коҳиш меёбанд.

Манзараи макроскопӣ. Ҳангоми гиалинози зоҳиршаванда бофтаи пайвасткунанда торҳои саҳт, тағоякмонанд, сафедранг, нимшаффоф мегардад.

Фарҷом. Дар бисёр ҳолатҳо аз сабаби бозгаштнопазирии раванд номусоид аст, вале ҷаббида шудани моддаи гиалинӣ низ имконият дорад. Гоҳо бофтаи гиалинишуда луобнок мегардад.

Гиалинози ҷузъӣ сабаби норасоии вазифаи узв шуда метавонад.

Амилоидоз - ин диспротеинози пайкарӣ-рагӣ мебошад, ки бо ҳалалдоршавии амиқи мубодилаи сафедаҳо ва пайдо шудани сафедаи ғайримуқаррарии фибриллярӣ ва замшавии он дар бофтаи фосилавӣ ва девораи рагҳо ҳамбастагӣ менамояд.

Амилоид ба гиалин хеле монанд аст ва дар зер микроскопи (заррабини) рушноигӣ ҳамчун моддаи бешакл, гемогенӣ ба назар мерасад; саҳт, шишамонанд, сафедаи рангаш бунафш.

Ҳамаи навъҳои амилоид тавсифи зерини физикийю химиявӣ доранд:

· ҳангоми ба бофтаи нави амилоиддор ҷакондани йодидҳо вай ранги хокистаранг мегирад;

· дар мустаҳзарҳои гистологӣ амилоид ба таври зерин ба назар намуда метавонад: ҳангоми рангкунӣ бо гематоксилин ё эозин ранги якхелаи бунафш дорад; дар рушноии кутбнокшуда амилоиди бо конгои сурх рангкардашуда шиканиши шуои дугонаи сабзи равшан дорад; ҳангоми рангкунӣ бо метилвиоле, йод грюн, конго ранги амилоид метахромазияро намоиш дода ранги сурхи хиштмо-

нанд гирад;

- амилоид ба таври иммуногистохимиявӣ бо ёрии антителаҳои барои зергурӯҳои гуногуни фибриллаҳо хос ошкор карда шавад;

- ҳангоми омузиш дар зери микроскопи электронӣ амилоид дар шакли фибриллаҳои шохнокнашудаи ғафсиашон 7,5-10 нм ошкор карда мешавад;

- ҳангоми тадқиқоти рентгендифраксионӣ муқаррар карда шудааст, ки амилоид аз сохтори бета-қабатнок иборат аст.

Сохтори химиявии сафедаи амилоид: амилоид аз имуноглобулинҳо, амилоиди пайдоишаш дигар.

Таснифоти клиникии амилоидоз бо навъи сафеда ва навъи бофта, ки дар он ҷамъ мешавад, паҳншавӣ ва сабаби имконпазири пайдоиши он асоснок карда шудааст.

- Амилоидози силсилавӣ;

- амилоидози аввалияи силсилавӣ бо ҷамъшавии бартаридоштаи амилоид дар таркиби дил, роҳи меъдаву рӯдаҳо, забон, пӯст ва асабҳо;

- амилоидози дуюмбора бо ҷамъшавии бартаридоштаи амилоид дар чигар, испурч, гурдаҳо, рӯдаҳо, ғадуди болои гурда.

Амилоидози маҳдуд (ҷузъӣ)): амилоидози маҳдуд метавонад шакли укдагӣ, омосмонанд дошта бошад. Вай хеле кам дучор мешавад ва дар забон, масона, шуш ва пӯст мушоҳида карда мешавад.

Амилоид дар номияҳо: амилоид дар пайкари миқдори зиёди ғадудҳои эндокринӣ ҷамъ мешавад.

Амилоидози оилавии модарзодӣ:

- асабзод (нейропатикӣ);

- гурдазод (нефропатией);

- дилӣ.

Амилоидози пиронсоли;

- миқдори начандон зиёди амилоид аксаран дар дил;

· гадуди зери меъда;

· испурчи одамони солхӯрда мушоҳида карда мешавад.

Амилоид бо ҳучайраҳои махсусе ангиизиш меёбад, ки амилоидобластҳо номида мешаванд. Ҳангоми шаклҳои гуногуни амилоидоз нақши амилоидобластҳоро ҳучайраҳои гуногун бозида метавонанд.

Амилоид чамъ мешавад: дар андарунпарда ё рӯйпардаи рағҳои хунгард; дар бофтаи мушаки қад-қадӣ нахҳои ретикулярӣ ё коллагенӣ; дар ғишои мембранаи бунгоҳии бофтаи рӯйпушкунанда.

Намуди берунии узвҳо ҳангоми амилоидоз аз дараҷаи инкишофи раванд вобастагӣ дорад. Агар замшавии амилоид зиёд набошад намуди берунии узв кам тағйир меёбад ва амилоидоз фақат ҳангоми тадқиқоти микроскопӣ таъхис карда мешавад. Ҳангоми амилоидози зоҳиршаванда ҳаҷми узвҳо калон мешавад, паридаранг, бо ҷилои чарбӯӣ мебошанд..

Аломатҳои иллати нисбатан зоҳиршавандаи бофта тобиши паридарангу хокситаранг ва намуди нисбатан ҳоси муммонанд ё чарбумонанд дар мустаҳзар мебошад.

Дар испурҷ амилоид метавонад ҳам ҷудоғона дар фолликулҳои лимфавӣ, ҳам баробар дар тамоми лаҳм паҳн гардад. Дар ҳолати аввал фолликулҳои испурҷ дар буриш намуди донаҳои нимшаффоферо доранд, ки донаҳои нахи сағорро ба хотир меоваранд. Дар ҳолати дуюм испурҷ калон, саҳт, хокитаранги сурх, ҳамвор буда, дар буриш тобиши чарбӯӣ дорад (испурҷи чарбӯӣ). Испурҷи сағой ва чарбӯӣ марҳилаҳои пайдарҳаи раванд мебошанд.

Дар гурдаҳо амилоид дар девораҳои шараёнчаҳои хун баранда ва хун оваранда, дар ҳалқаҳои мӯйрагӣ ва мезангияи калобачаҳо, дар ғишои бунгоҳии найчаҳо ва дар пайкар захира мешаванд. Гурдаҳо саҳт, ҳаҷман калон ва «чарбӯӣ» мешаванд. Ба андозаи афзоиш ёфтани раванд калобачаҳои мӯйрагӣ пурра бо амилод иваз мешаванд,

бофтаи пайвасткунанда нумӯъ мекунад ва пучшавии амилоидии гурдаҳо инкишоф меёбад.

Дар чигар захира амилоид байни ретикулоэндотелиоситҳои ситорамонанди синусоидҳо, қад-қади пайкари ретикулярии ҳиссачаҳо, дар девораи рағҳо, маҷроғоҳ ва дар бофтаи пайвасткунанда роҳҳои порталӣ (баввобӣ) мушоҳида карда мешавад. Ба андозаи ҷамъшавии амилоид ҳучайраҳои чигар коҳиш меёбанд ва нобуд мешаванд.

Дар рӯдаҳо амилоид ба пайкари мӯякҳои луобпарда, инчунин ба девораи рағҳои ҳам луобпарда ва ҳам қабати зерилоубӣ меафтад.

Амилоидози ғадудҳои болои гурда, одатан, дутарафа аст, замшавии амилоид дар моддаи қишрӣ қад-қади мӯйрағҳо дучор мегардад.

Дар дил амилоидҳо дар зери эндокард, дар нахҳо ва рағҳои пайкар, инчунин дар эпикард қад-қади варидҳо ошкор карда мешавад.

Дар мушакҳои скелет, дар миокард амилоид қад-қади бофтаи пайвасткунанда байнимушакӣ, дар девораи рағҳо ва дар асабҳо мушоҳида мешавад. Ба таври периваскулярӣ ва гирдиасабӣ замшавии фаровони моддаи амилоидӣ ҳосил мешавад.

Дар шуш замшавии амилоидҳо аввал дар девораи шохрониҳои шараёну варидҳо, инчунин дар бофтаи пайвасткунандаи гирди бронхҳо пайдо мешавад. Баъдтар амилоид дар тавораҳои байниалвеоларӣ пайдо мешавад.

Дар мағзи сар ҳангоми амилоидози пиронсолӣ амилоид дар пулакчаҳои пиронсолии қишр, рағу пардаҳо дарёфт мешавад.

Амилоидози пӯст бо замшавии мунташири амилоид дар пистонакҳои пӯст ва қабати ретикулярии он, дар девораи рағҳо ва ғишоҳои бунгоҳии ғадудҳои ҷарбӣ ва баззоқӣ тавсиф меёбад, ки бо вайроншавии нахҳои чандир, коҳишёбии якбораи пӯстпарда ва ҳосилаҳои пӯст ҳамбас-

тагӢ менамояд.

Амилоидози ғадуди болои гурда баъзе хусусиятҳои худро дорад. Ба ғайр аз иллатҳои шараёнҳои ғадудҳо амилоидози қазирачаҳо низ дучор мегардад, ки хангоми пиронсолии амиқ дучор мешавад.

Фарҷом. Номусоид, амалан бозгаштнопазир.

Амилоидози зоҳиршаванда боиси дистрофия ва коҳишёбии (атрофияи) лаҳима ва тасаллуби пайкари узвҳо, норасоии вазифаи онҳо мегардад.

Дистрофияҳои пайкарӣ-рагии чарбӣ хангоми вайроншавии мубодилаи чарбҳои мӯътадил ё холестерин ва чарбҳои он пайдо мешаванд.

Вайроншавии мубодилаи чарбҳои мӯътадил.

Чарбҳои мӯътадил - ин чарбҳои ноустуворе мебошанд, ки захираҳои энергияи организмро таъмин менамоянд.

Вайроншавии мубодилаи чарбҳои мӯътадил дар зиёдшавии захираи онҳо дар бофтаи чарбӣ зоҳир мегардад. Вай метавонад умумӣ ва ҷузъӣ бошад.

Фарбеҳӣ ё ғафсӣ-зиёд шудани миқдори чарбҳои мӯътадил дар анбори чарбҳо мебошад. Фарқ карда мешавад:

- фарбеҳии аввалия (идиопатикӣ);

- фарбеҳии дуюмбора.

Сабаби фарбеҳии якумин (идиопатикӣ) номаълум аст.

Навъҳои фарбеҳии дуюмбора:

- ғизой (алиментарӣ);

- мағзисарӣ;

- эндокринӣ;

- ирсӣ.

Аз рӯи падидаҳои берунӣ навъи ҳаматарафаи мутаносиби фарбеҳӣ фарқ карда мешавад, ки ба се зергурӯҳ тақсим карда мешавад:

- болоӣ;

- миёна;

· поёнӣ.

Аз рӯи зиёдшавии вазни бадани бемор чор дараҷаи фарбеҳӣ чудо карда мешавад:

· дараҷаи I фарбеҳӣ - вазни барзиёди бадан то 30%-ро ташкил медиҳад;

· дараҷаи 2 фарбеҳӣ - вазни барзиёди бадан то 50%-ро ташкил медиҳад;

· дараҷаи 3 фарбеҳӣ - вазни барзиёди бадан то 99%-ро ташкил медиҳад;

· дараҷаи фарбеҳӣ 4- вазни барзиёди бадан то 100% ва зиёдтарро ташкил медиҳад.

Аз рӯи миқдору андозаи ҳуҷайраҳои чарбӣ ду вариант чудо карда мешавад:

· гипертрофикӣ;

· гиперпластикӣ.

Ҳангоми варианти гипертрофии фарбеҳӣ миқдори ҳуҷайраҳои чарбӣ тағйир намеёбад, вале андозаи ҳуҷайраҳои чарбӣ аз ҳисоби миқдори барзиёди триглицеридҳо дар онҳо якҷанд маротиба зиёд гардидааст. Ҷараёни клиникии беморӣ бадсифат мебошад.

Ҳангоми варианти гиперпластикӣ шумораи ҳуҷайраҳои чарбӣ зиёд мешавад. Вале тағйироти мубодилаи моддаҳо тағйир намеёбад. Ҷараёни беморӣ хушсифат мебошад.

Фарҷоми фарбеҳии умумӣ хеле кам мусоид мебошад.

Фарбеҳии умумӣ инкишофи оризаҳои вазнинро муайян мекунад.

Зиёдшавии ҷузъии миқдори насчи чарбӣ бо истилоҳи липоматоз ифода карда мешавад. Намунаи липоматоз бемории Деркум буда метавонад. Вай бо пайдошавии замшавиҳои уқдаҳои дардноки чарб дар насчи зерипӯстии дасту пойҳо ва бадан тавсиф меёбад, ки аз рӯи намуди беруни омос (липома)-ро ба хотир меоваранд. Сабаби ин беморӣ эндокринопатияи полигландулярӣ мебошад.

Намунаи липоматоз ҳамчунин фарбеҳии холигии бофта ё узв ҳангоми коҳишёбӣ мебошад (беҷошавии чарбии гурда ё ғадуди чоғар ҳангоми коҳишёбии онҳо).

Вайроншавии мубодилаи холестерин ва эфирҳои он

Вайроншавии мубодилаи холестерин ва эфирҳои он асоси атеросклерозро ташкил медиҳад. Ҳангоми гиперхолестеринемия вай аз хун ба пардаи дохилии рағҳо ворид мегардад. Моддаҳои ҷамъшаванда минбаъд таъзия мешаванд ва ба таври захрогин фаъолият намуда, онҳо боиси некрози пардаи дохилӣ мегарданд. Дар пардаи дохилӣ детрити чарбу-сафедагӣ ҳосил мешавад, сипас бофтаи пайвасткунанда нуфуз намуда, пулакча ташаккул меёбад.

Дистрофияҳои стромалӣ-рагии карбогидратӣ метавонанд бо вайроншавии тавозуни гликопротеидҳо ва гликозаминогликанҳо алоқманд бошанд. Дистрофияи стромалӣ-рагии карбогидратӣ, ки бо ҷамъшавии гликопротеидҳо алоқаманд аст, ки луобнокшавии бофтаҳо номида мешавад. Баръакси варами мукоидӣ ҳангоми ин раванд ивазшавии нахҳои коллагенӣ бо моддаи луобмонанд ба вучуд меояд. Бофтаи пайвасткунандаи стромаи узвҳо, бофтаи чарбӣ, тағояк варам, нимшаффоф, луобмонанд буда, ҳучайраҳои онҳо бошанд ситорашакл мешаванд.

Сабабҳо: носозкории ғадудҳои эндокринӣ, кахексияи ҳар гуна пайдоиш (генез).

Раванд метавонад бозгаштпазир бошад. Шиддатёбии он боиси колликутсия ва некрози бофта, ҳосилшавии ковокиҳои аз луоб пуршуда мегардад.

Аҳамияти он бо вазнинии раванд, давомнокии он хактерии бофтаи ба дистрофия дучоршуда муайян карда мешавад.

ЛЕКСИЯИ 4 ДИСТРОФИЯИ ОМЕХТА

Гемоглобин (хромопротеиди баландмолекулярӣ) - пигменти оҳандори нафаскашӣ мебошад, ки асоси эритроситҳоро ташкил дода, нақши барандаи оксигенро иҷро мекунад.

Таҷзияи эритроситҳо бо маҳлулшавии гемоглобин (НЬ) гемолиз номида мешавад.

Гемолиз - аз рӯи моҳияти худ ҳодисаи физиологӣ мебошад, ки бо пиршавии эритроситҳо ва вайроншавии мунтазами онҳо дар зери таъсири гемолизинҳои физиологӣ алоқаманд аст.

Гемоглобини озод таъсири захрогин надорад. Вале ҳангоми ба метгемоглобин гузаштани он зери таъсири баъзе омилҳои гемолизкунанда метгемоглобинемия ва метгемоглобинурияи пайдошуда аҳамияти тақдирсоз дошта метавонанд. Метгемоглобин боиси вайроншавии нафаскашии бофтагӣ аз сабаби душвории ночурии (диссоциатсияи) оксиген мегардад. Иллатнокшавии пайдошудаи гурдаҳо бошад (нефрози гемоглобинуриягӣ) бо норасоии шадиди гурдаҳо (анурия ва уремия) ба анҷом мерасад.

Дар натиҷаи таҷзияи физиологӣ эритроситҳо ва гемоглобин пигментҳои ферритин, гемосидерин ва билирубин ҳосил мешаванд.

Дар шароитҳои эътилолӣ, ба ғайр пигментҳо ҳангоми меёӣ зиёдшавандаи гемоглобиногенӣ метавонад як қатор пигментҳои наф - гематоидин, гематинҳо ва порфирин ҳосил шаванд.

Мубодилаи оҳан ҳангоми меёӣ тарзе ҳамоҳанг сохта мешавад, ки суммаи умумии оҳани организм дар доираи маҳдуд нигоҳ дошта мешавад.

Зиёдшавии миқдори умумии оҳани узв ҳангоми гемосидероз ва гемохроматоз мушоҳида карда мешавад.

Оҳани барзиёд дар макрофагҳо ва ҳуҷайраҳои лаҳимаӣ дар шакли ферритин ва гемосидерин ҷамъ мешавад ва метавонад боиси осебҳои ҳуҷайраҳои лаҳимаӣ гардад.

Вобаста ба пайдоишашон ферритини анаболӣ ва катаболӣ фарқ карда мешавад.

Ферритини анаболӣ аз оҳане ҳосил мешавад, ки дар рӯдаҳо ҷаббида мешавад, катаболӣ бошад - дар испурч аз эритроцитҳои гемолизшуда.

Ферритин лазури берлиниро таҳти таъсири калийю оҳану синероддор ва кислотаи хлорид ё хлориду водородӣ (реаксияи Перлс) ҳосил намуда, инчунин метавонад бо ёрии зиддизардобӣ махсус ҳангоми тадқиқоти иммунофлюоресцентӣ муайян карда шавад. Миқдори зиёди ферритин дар чигар (маҳзани ферритин), испурч, мағзи сурхи устухон ва лимфогиреҳҳо мавҷуд аст, ки мубодилаи он бо синтези гемосидерин, гемоглобин ва ситохромҳо алоқманд аст.

Дар шароити эътилол миқдори ферритин метавонад ҳам дар хун ва ҳам дар бофтаҳо зиёд гардад.

Вайроншавии мубодилаи билирубин.

Билирубин - маҳсули интиҳории катаболизми ҳалқаи порфиринии молекулаи гемоглобин буда, на оҳан ва на сафеда надорад.

Вайроншавии мубодилаи билирубин бо ихтилоли ҳосилшавӣ ва ҷудошавии он алоқаманд аст.

Маҷмӯи аломатҳои, ки бо зиёдшавии миқдори билирубин дар хун, ҷамъшавии он дар бофтаҳо ва ранги зард гирифтани пӯст, сулбия, луобҳо, зардобпардаҳо ва узвҳои дохилӣ тавсиф меёбанд, зардпарвин номида мешавад.

Зардпарвин ҳангоми мавҷуд будани шароитҳои зерин пайдо шуда метавонад:

- ҳосилшавии зиёди билирубин;
- ихроҷи камшудаи чигар (нобуд шудани ҳуҷайраҳои

чигар);

- инсидоди мачрои талха.

Аз рӯи механизмҳои инкишофи зардпарвин се намуни он фарқ карда мешавад:

- болоичигарӣ (гемолитикӣ) - бо ҳосилшавии зиёди билирубин аз сабаби таҷзияи зиёди (гемолизи) эритроцитҳо тавсиф меёбад;

- чигарӣ (лаҳимаӣ) - ҳангоми осебҳои гепатоситҳо (дистрофия ва некрози онҳо) пайдо шуда, дар натиҷаи ин фарогирӣ, алоқамандкунӣ ва ихроҷи билирубин ҳалалдор мегардад, ки боиси зиёд шудани миқдори он дар хун мегардад;

- зеричигарӣ (механикӣ)-обтуратсияи роҳҳои талха ба вучуд меояд, ки боиси ҷамъшавии билирубини алоқаманд дуртар аз тавора дар роҳҳои талха ва чигар (холестаз) мегардад.

Гемосидерин - пигменти тиллоранги зард, одатан бешақл мебошад, ки ҳангоми таҷзияи гем ҳосил мешавад ва полимери ферритин аст.

Гемосидерин маҳсули таҷзияи дохилиҳуҷайравии ферментативии гемоглобин мебошад.

Гемосидерин 24 соат пас аз лаҳзаи хунравӣ пайдо мешавад.

Ҳуҷайраҳои, ки дар онҳо гемосидерин ҳосил мешавад, сидеробластҳо номида мешаванд. Дар сидеросомаҳои онҳо синтези доначаҳои гемосидерин ба вучуд меояд.

Сидеробластҳо метавонанд ҳам табиати мезенхимаӣ, ҳам эпителиалӣ дошта бошанд. Гемосидерин доимо дар ҳуҷайраҳои ретикулярӣ ва эндотелиалии испурч, мағзи сар, чигар, мағзи сурхи устухон, лимфагиреҳо ошкор карда мешавад.

Дар моддаи байнихуҷайравӣ вай дучори фагоситоз тавассути сидерофагҳо мегардад. Дар гемосидерин мавҷ-

уд будани оҳан барои бо ёрии он ошкор намудани реаксияҳои хос имконият медиҳад:

- ҳосилшавии лазури берлинӣ (реаксияи Перлс);
- кабудии турнбулӣ (коркарди буришҳо бо сулфиди аммоний);
- бо калийи оҳану синеродӣ ва кислотаи хлордору водородӣ.

Реаксияҳои мусбат ба оҳан гемосидеринро аз пигментҳои ба он монанд фарқ мекунад (гемомеланин, липофустсин, меланин, билирубин).

Ҳосилшавии барзиёди гемосидерин дар шароитҳои эътилол номи гемосидерозро гирифтааст.

Гемосидерози умумӣ ва ҷузъӣ фарқ карда мешавад.

Гемосидерози ҷузъӣ - ҳолате мебошад, ки ҳангоми вайроншавии хориҷирагии эритроцитҳо (гемолизи экстраваскулярӣ), яъне дар лонаҳои хунравӣ инкишоф меёбад.

Гемосидерози ҷузъӣ метавонад на фақат дар доираи китъаҳои бофта (гематома-хуномос балки узви пурра низ инкишоф ёбад.

Гемосидерози умумӣ ё мутамарказ ҳангоми вайроншавии дохилирагии эритроцитҳо (гемолизи интраваскулярӣ) инкишоф ёбад.

Сабабҳои гемосидерози умумӣ: бемориҳои силсилаи узвҳои хунофар; захролудшавии бо захрҳои гемолитикӣ ва намакҳои металҳои вазнин асоснокшуда; баъзе аз бемориҳои сироятӣ; гузарондани хуни гурӯҳи дигар, резус номувофиқ (сепсис)

Оҳани барзиёд ба мисли гемосидерин дар макрофаги ҳамаи узвҳо, махсусан мағзи сурхи устухон, чигар ва испурч захира мешавад. Нақши сидеробластҳо дар ин узвҳо унсурҳои ретикулярӣ, эндотелиалӣ ва гистиоситарӣ мебозанд.

Гемосидероз дар мағзи сурхи устухон ва чигар ҳангоми биопсия таъхис карда шавад ва аҳамияти махсуси кли-

никӣ надорад.

Шаклҳои равшани гемосидероз, махсусан чигар («таллайюфи пигментӣ»), ғадуди зерӣ меъда, ғадудҳои баззоқӣ ҳангоми гемохроматоз мушоҳида карда мешаванд.

Гемохроматоз - ин бемории махсуси ба гемосидерози умумӣ наздике мебошад, ки фарқияти асосии он дараҷаи таҳмил бо оҳан ва мавҷуд будани ҳуҷайраҳои лаҳмавии осебёфта мебошад.

Гемохроматоз метавонад аввалия (ирсӣ) ва дуюмбора бошад.

Гемохроматози аввалия - бемории мустақил аз гурӯҳи бемориҳои ҷамъшавӣ мебошад. Бо роҳи доминантӣ-аутосомӣ интиқол меёбад ва бо нуқсони ирсии ферментҳои рӯдаи бориқ алоқаманд аст.

Аломатҳои асосии беморӣ инҳо мебошанд: ранги биринҷии пӯст; диабетӣ қанд; таллайюфи пигментии чигар, ки боиси норасоии чигар мегардад; кардиомиопатияи пигментӣ, ки метавонад сабаби фавт гардад.

Гемохроматози дуюмбора - беморие мебошад, ки ҳангоми норасоии пайдошудаи системаҳои ферментии таъминкунандаи мубодилаи ғадуди ғизоӣ инкишоф меёбад, ки бо гемосидерози мутамарказ ҳамбастагӣ менамояд.

Сабаби ин норасоӣ метавонад воридшавии барзиёди оҳан бо ғизо (дорухӯи оҳандор), буриши (резексияи) меъда, алкоголизми (бадмастии) музмин, такроран хунгузаронӣ ва ғайра бошад.

Ҳангоми гемохроматози дуюмбора миқдори оҳан на фақат дар бофтаҳо, балки дар ҳунобаи хун низ зиёд шудааст.

Падидаҳои асосии клиникаӣ морфологияи беморӣ ба гемосидерози аввалия шабоҳат доранд.

Вайроншавии мубодилаи гематоидин, гематин, гематопорфирин.

Гематоидин -пигменти беохан ҳангоми таҷзияи эритроцитҳо ва гемоглобин ба таври дохилиҳуҷайравӣ баъди 5-10 рӯзии пас аз гемосидерин пайдо мешавад, вале баръакси гемосидерин дар ҳуҷайраҳо боқӣ намононад ва ҳангоми ҳалокати онҳо дар байни ҳуҷайраҳои некрозшуда озодона меҳобад.

Ҷамъшавии гематоидин дар ҳуномосҳои нисбатан кӯҳна, сактаҳои ҳадшабанда, ҳамзамон дуртари бофтаҳои зинда - дар қисматҳои марказии хунравӣ, на дар канораҳо дарёфт карда мешавад.

Гематинҳо шакли туршшудаи гем мебошанд ва ҳангоми гидролизи оксигемоглобин ҳосил мешавад.

Ба гематинҳо дохил мешавад:

- гемомеланин (пигменти вараҷавӣ) аз гемоглобин бо таъсири плазмодияҳои вараҷа ҳосил мешавад, ки дар эритроцитҳо муфтхӯрӣ (паразитӣ) мекунад;

- гематини намаки турш (гемин) ба гемоглобин таъсир расондани ферментҳои шираи меъда ва кислотаи хлорид ҳосил мешавад;

- пигменти формалинӣ ҳосилаи гематин шуморида мешавад. Хусусиятҳои гистохимиявии ин пигментҳо яхела аст.

Порфирин - пигменти флюорестсиякунанда, дорои оҳан мебошад, вале бо усулҳои муқаррарии гистохимиявӣ муайян карда мешавад.

Ҳангоми меъёр ба миқдори начандон зиёд дар хуну пешоб мавҷуд аст, нақши антогонисти меланинро мебозад ва ҳассояити пӯстро ба рушноӣ зиёд мекунад. Ҳангоми вайроншавии мубодилаи порфирин миқдори онро дар хуну пешоб зиёд мекунад. Пешобе, ки миқдори зиёди порфирин дорад, сурх мешавад. Пигмент ҳамчунин дар фазла низ мушоҳида карда мешавад. Ин ҳолат номи порфи-

рияро гирифтааст.

Сабабҳои порфирия:

- захролудшавӣ (бо сурб, сулфонал, барбитуратҳо);
- авитаминози РР (хангоми пеллагра);
- нуқсонҳои модарзодии вайроншавии мубодила.

Ҳангоми порфирия аломатҳои нисбатан вазнини ҳасосияти баланди пӯст нисбати нурҳои ултрабунафш инкишоф меёбад. Дар қисматҳои кушодаи бадан - рӯй, дастҳо, рухсора -эритемаҳо, хуббобчаҳо, решҳо дар заминаи коҳишёбии амиқи пӯст ва депигментатсияи он ба вучуд меоянд. Устухону дандонҳо қахваранг мегарданд.

Вайроншавии мубодилаи пигментҳои протеиногенӣ (тирозинтриптофанӣ).

Ба пигментҳои протеиногенӣ (тирозиногенӣ) дохил мешаванд:

- меланин;
- пигменти доначаҳои ҳуҷайраҳои энтерохромаффинӣ;
- адренохром.

Вайроншавии мубодилаи меланин (меланозҳо) дар ҳосилшавии пурзӯр ё нестшавии он зоҳир мегардад. Меланози пайдошуда ва модарзодӣ фарқ карда мешавад. Вай метавонад паҳншуда ва мавзёғирифта бошад.

Гипермеланози паҳншудаи пайдошуда дар клиника дар шакли гиперпигментатсияи пӯст зоҳир мешавад .

Сабабҳои гипермеланози паҳншудаи пайдошуда:

- иллатнокшавии ғадудҳои болои гурдаи табиаташон силӣ ё омосӣ (бемории Адиссон), амилоидоз;
- ихтилолҳои эндокринӣ (гипогонадизм, гипопитуитаризм);

- авитаминозҳо (пеллагра, синга);

- захролудшавӣ бо карбонгидартҳо.

Аҳамияти раванд бо вазнинии бемории асосӣ муайян карда мешавад.

Гипермеланози паҳншудаи модарзодӣ (ксеродермаи пигментӣ) бо ҳассосияти баланди пӯст нисбати нурҳои ултрабунафш тавсиф меёбад ва бо пигментатсияи доғдори пӯст ва падидаҳои гиперкератоз ва омос зоҳир мегардад.

Гипермеланози пайдошудаи лонавӣ (меланози рӯдаи ғафс; доғҳои пигментии пӯст; гиперпигментатсияи лонавӣ ҳангоми аденомаҳои гипофиз, гипертиреозидизм, диабети қанд, холи модарзодии (невуси) пигментӣ, меланомаҳо.

Гипомеланози паҳншуда бо норасоии ирсии тирозиназа алоқаманд аст. Албинизм (сафедандомӣ) бо набудани меланин дар пиёзакҳои мӯй, пӯстпарда ва пӯст, дар шабакия ва инабия зоҳир мегардад.

Гипомеланози пайдошудаи лонавӣ (лейкодерма, витилиго)

Сабабҳо:

- лепра;
- сифилис;
- диабети қанд;
- иперпаратиреозидизм.

Вайроншавии мубодилаи пигментҳои липидогенӣ (липопигментҳо).

Дар байни ин гурӯҳи пигментҳои ҷарбию сафедагӣ липофуссин, сероид ва липохромҳо нисбатан омӯхташуда мебошанд. Ин пигментҳо амалан хусусиятҳои якхелаи физикохимиявӣ ва гистохимиявӣ доранд.

Липофустсин - дар ситоплазма дар натиҷаи осебёбии гишоҳои узввораҳои ситоплазмавӣ ҷамъ мешавад. Ин дар натиҷаи норасоии антиоксидантҳои ҳуҷайравӣ ба амал меояд, ки ҳангоми меёр туршшавии перекиси ҷарбҳои гишои узввораҳоро пешгирӣ менамоянд.

Липофустсиноз аввалия (ирсӣ) ва дуюмбора мешавад.

Липофустсинози аввалия (ирсӣ) бо ҷамъшавии ин-

тихобии липофустсин дар ҳучайраҳои узви муайян (гепатози ирсӣ (синдроми Дабин-Чонсон); липофустсинози ҳучайраҳои асаб (синдром Шпилмейер-Шегрен) тавсиф меёбад.

Липофустсинози дуҷумбора дар одамони пиронсолон ҳангоми аз ҳад ҳаробшавӣ (кахексия) ё ҳангоми мавҷуд будани бемориҳои музмин (коҳишёбии миокард, чигар) мушоҳида карда мешавад. Аксаран он дар ҳучайраҳои мушаки дил, ҳучайраҳои чигар ва дар ҳучайраҳои асаб ҷамъ мешавад. Сабабҳои ҷамъшавии он метавонанд заҳролудшавии доругӣ (аналгетикҳо), норасоии витамини Е (пигменти норасоии витамини Е) бошад. Гоҳо вай дар ҳучайраҳо ҳангоми таҳмили баланди функционалӣ (липофустсинози миокард ҳангоми нуқсони дил) пайдо мешавад. Липофустсин ягон ҳел ҳалалдоршавии вазифаи ҳучайраҳоро ба вуҷуд намеоварад.

Сероид - липопигменте мебошад, ки дар макрофагҳо бо роҳи гетерофагия ҳангоми ҷаббиши ҷарбҳо ҳосил мешавад.

Дар шароитҳои эътилол ҳосилшавии сероид ҳангоми некрози бофтаҳо, махсусан дар қитъаҳои хунравӣ мушоҳида карда мешавад.

Липохромаҳо асосан аз ҷарбҳои иборатанд, ки дар онҳо каратиноидҳо - сарчашмаи ҳосилшавии витамини А вуҷуд доранд. Липохромҳо ба насчи ҷарбӣ, қишри ғадуҳои болои гурда, ҷисми зарди тухмдонҳо ранги зард медиҳанд.

Дар шароити эътилолӣ ҷамъшавии барзиёди липохромҳо мушоҳида шуда метавонад.

Вайроншавии мубодилаи нуклеопроteidҳо.

Нуклеопроteidҳо аз сафеда ва кислотаҳои нуклеинӣ - дезоксирибонуклеинӣ (КДН) ва рибонуклеинӣ (КРН) сохта шудаанд.

Вайроншавии мубодилаи нуклеопроteidҳо бо ҳосилшавии барзиёди кислотаи карбамид, инкишофи гиперурикемия ва воридшавии намакҳои он ба бофтаҳо зохир мегардад. Ин ҳангоми никрис (подагра); бемории санги пешоб; сактаи турши пешоб мушоҳида карда мешавад.

Вайроншавии мубодилаи калтсий, мис, калий ва оҳан аҳамияти бештари амалӣ доранд.

Мубодилаи калтсий.

Вайроншавии мубодилаи калтсий дар бофтаҳои организм оҳаксорӣ номида мешавад.

Вобаста ба бартарӣ доштани омилҳои умумӣ ва ҷузъӣ дар инкишофи калтсийнокшавӣ се шакли оҳаксорӣ фарқ карда мешавад:

- метастатикӣ;
- дистрофӣ;
- метаболӣ.

Калтсийнокшавии метастатикӣ ҳангоми зиёд шудани ҷамъшавии калтсий ё фосфор дар хун (гиперкалциемиа) пайдо мешавад. Калтсийнокшавӣ нисбатан бештар дар девораи шараёнҳо, тавораҳои алвеолярии шушҳо, дар лубпардаи меъда, дар миокарди меъдачаи чап ва дар гурдаҳо ба амал меояд.

Сабабҳои оҳаксори метастатикӣ бо ихроҷи пурзӯри намакҳои калтсий аз маҳзан ва хориҷшавии ками калтсий аз организм алоқаманд аст.

Ҳангоми микроскопи калтсий бо ранги баланди бунафш (базофилӣ) рангнок мешавад. Дар марҳилаҳои барвақтии калтсификатсия лонаҳои ҷамъшавии калтсий доначадор, лонаҳои калон бошанд бешакл ба назар мерасанд. Ба таври гистохимиявӣ калтсийро бо усули нукраноккунии Косс ошкор менамоянд. Дар атрофи ҷамъҳои оҳак аксуламалӣ илтиҳобӣ дида шуда, гоҳо ҷамъ-

шавии макрофагҳо, хучайраҳои азимчусса, ҳосилшавии дончаҳо (гранулемаҳо) мушоҳида карда мешавад. Намуди берунии узву бофтаҳо кам тағйир ёфтааст.

Фарҷом номусоид аст: намакҳои воридшуда амалан ҷаббида намешаванд.

Ҳангоми калтсийнокшавии байнибофтагии гурдаҳо (нефрокалсиноз) метавонад норасоии музмини гурдаҳо пайдо шавад.

Калтсийнокшавии васеи рағҳои хунгард метавонад боиси ишмеия, махсусан дар пӯст гардад. Гоҳо ҳангоми осебёбии васеи алвеолаҳо ихтилоли диффузияи газҳо ба амал меояд. Ба ғайр аз ин ҳодисаҳои калтсийнокшавӣ вазифаи хучайраҳои лаҳмавино дар ҷигар ҳалалдор намекунад.

Ҳангоми оҳаксории дистрофӣ (петрификатсия) мубодилаи (метаболизми) калтсий ва фосфор ҳалалдор нашудааст. Дараҷаи ҷамъшавии онҳо дар ҳунобаи хун мӯтадил мебошад. Калтсийнокшавӣ дар натиҷаи ихтилоҳои ҷузъии бофтаҳо ба вуҷуд меояд. Замшавии намакҳои калтсий характери ҷузъӣ дорад ва одатан дар бофтаҳои мавтшуда ё дар ҳолати дистрофияи амиқ қарордошта ошкор карда мешавад.

Сабаби асосии оҳаксории дистрофӣ - тағйирёбии ҳосияти таркиби физикию химиявии бофтаҳо мебошад, ки бо алкалшавии муҳит аз сабаби истеъмоли пуршиддаи оксиген ва ҷудошавии ангидриди карбон, тағйирёбии хусусиятҳои коллоидҳои сафедагӣ (ҳадшабандии сафеда) ва пурзуршавии фаъолнокии фосфотазаҳо ҳамбастагӣ менамояд. Дар чунин бофтаҳо лонаҳои андозаашон гуногуни зичиашон-петрификатҳо пайдо мешаванд.

Оҳаксории метаболӣ (калтсинози байнибофтагӣ). Механизми инкишофи он то охир маълум нест. Ба ноустувории силсилаи буферии (рН ва коллоидҳои сафедагии) хун ва моеъи бофтаҳо аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд, аз ин

сабаб калтсий дар онҳо ҳатто ҳангоми чамъшавии зиёд нигоҳ дошта намешавад, аксаран тамоили ирсӣ нақш мебозад.

Калтсинози байнибофтагӣ фарқ карда мешавад:

· силсилавӣ;

· маҳдуд.

Намунаи калтсийнози байнибофтагии силсилаи калтсийнози омосмонанд мебошад.

Калтсийнози маҳдуди байнибофтагӣ ё никриси оҳақӣ бо замшавии намакҳои калий дар шакли лавҳачаи пӯсти дастҳо, гоҳо — пойҳо тавсиф меёбад.

Фарҷом номусоид аст: калтсийи чамъшуда одатан чаббида намешавад ё бо душворӣ чаббида мешавад.

Паҳншавӣ, мавзёгирӣ ва характери оҳаксоршавӣ аҳамият дорад.

Мубодилаи рӯҳ.

Вайроншавии мубодилаи рӯҳ ҳангоми бемории Вилсон нисбатан равшантар зоҳир мегардад. Ҳангоми ин беморӣ ихроҷи рӯҳ ба талха ҳалалдор шудааст, ки боиси зиёдшавии миқдори рӯҳ дар организм ва чамъшавии он дар ҳуҷайраҳо мегардад. Ҳазинашавии рӯҳ дар гепатоситҳо бо паст шудани дар ҷигар ҳосилшавии серулоплазмин асоснок шудааст, ки барои дар хун алоқманд намудани рӯҳ қобилият дорад. Ҷигар ва ядроҳои мағзи сар-бофтаҳои нисбатан бештар осебёбанда мебошанд, аз ин сабаб бемории Вилсон ичнунин дистрофияи ҷигарию мағзисарӣ номида мешавад.

Мубодилаи калий.

Зиёдшавии миқдори калий дар хун (гиперкалиемия) ва дар бофтаҳо ҳангоми бемории Аддисон мушоҳида карда мешавад ва бо иллатнокшавии қишри ғадудҳои болои гурда алоқманд аст, ки ҳормонҳои он тавозуни электро-

литҳоро назорат мекунанд. Ҳангоми баъзе аз аденомаҳои гадуи болои гурда гипокалиемиа (алдостерома ва инкишофи синдроми Кон) низ мушоҳида шуда метавонад.

Норасоии калий асоси бемории ирсиро ташкил медиҳад, ки «фалаҷи давравӣ» номида мешавад. Беморӣ бо хуруҷҳои беҳолӣ ва инкишофи фалаҷи таҳрикаи ҳамбастагӣ менамояд.

ЛЕКСИЯИ 5 ВАЙРОНШАВИИ ГАРДИШИ ХУН

Халалдоршавии умумии гардиши хун.

Пурхунии умумии шараёнӣ ё гиперемияи шараёнӣ - ин зиёдшавии миқдори ҷузьҳои таркиби хун (эритроситҳо) мебошад, ки гоҳо бо зиёдшавии ҳаҷми хуни даврзананда ҳамбастагӣ менамояд. Ба таври клиникӣ сурхшавии пӯсти луобпардаҳо, баландшавии фишори шараёнӣ мушоҳида карда мешавад.

Пурхунии умумии варидӣ - яке аз намудҳои аз ҳама бештар дучоршавандаи ихтилолҳои умумии гардиши хун мебошад ва падидаи клиникию морфологии норасоии дил ё шушу дил мебошад.

Моҳияти патофизиологӣ ва патоморфологии пурхунии умумии варидӣ аз азнавтасимшавии ҳаҷми хун дар доираи умумии гардиши хун ва ҷамъшавии он дар қисмати варидии даври калони гардиши хун (варидҳои дарунҳолӣ ва гоҳо дар рағҳои шушҳо) ва камшавии он дар қисмати шараёнҳо иборат мебошад.

Пурхунии умумии варидӣ аз рӯи ҷараёни клиникӣ шадид ва музмин буда метавонад.

Пурхунии шадидии умумии варидӣ падидаи синдроми норасоии умумии дил ва гипоксия (асфиксия) мебошад.

Дар натиҷаи гипоксия тавораи гистогематикӣ осеб

меёбад ва нифозати мӯйрағҳо (капиллярҳо) якбора баланд мешавад. Дар бофтаҳо рукуди варида, чаббидашавии хуноба (плазморрагия), омос, рукуд (стаз) дар мӯйрағҳо ва хунравии зиёди диапедезӣ (муҳоҷиартӣ) мушоҳида карда мешавад. Дар узвҳои лаҳимаӣ тағйироти дистрофӣ ва некрозӣ пайдо мешаванд. Тағйироти нисбатан хоси морфологӣ ҳангоми пурхунии умумии варида дар шушу ҷигар инкишоф меёбанд.

Пурхунии умумии музмин ҳангоми синдроми музмини дил (дилу рағҳо) ё дилу шушҳо инкишоф меёбад.

Падидаҳои клиникӣ морфологӣ пурхунии музмини умумии варида.

Ҳангоми муоинаи зоҳирии бемори гирифтори пурхунии умумии варидаи ҳам шадид ва ҳам музмин кабудпӯстӣ (сианоз) диққатҷалбкунанда аст.

Омоси пӯст ва насчи зерпӯстӣ аз сабаби он зоҳиршаванда аст, ки рағҳои лимфавӣ ҳамчунин васеъ ва аз лимфа пур мебошанд. Зардобпардаҳо, мағзпардаҳо ва луобпардаҳо кабудранг мебошанд.

Ҳаҷми узву бофтаҳо ҳангоми пурхунии варида калон, дар натиҷаи миқдори зиёди гемоглобини барқароршуда кабудранг ва аз сабаби ихтилоли ҳамроҳикунандаи лимфагардиш ва омос, баъзан - аз сабаби инкишофи бофтаи пайвасткунанда саҳт мешаванд.

Ҷигар ҳангоми рукуди музмини варида калон, саҳт аст, канораҳои он мудаввар, сатҳи буриш гуногунранг, зарди хокистаранг ва тобиши сурхи ҷигарӣ мебошанд («ҷигари мускатмонанд»).

Қайд кардан зарур аст, ки дар ҳамаи узвҳои дарунӣ ҳангоми рукуди варида дар натиҷаи норасоии оксиген дағалу саҳтшавии торҳои коллагени пайкари узвҳо ба вучуд меояд ва падидаи инкишоф меёбад, ки одатан саҳтшавии рукудӣ ё индуратсияи кабудчагии узв номида мешавад.

Дар шуш ғангоми рукуди дуру дарози варидҳо сахт-шавии хокситаранги шуш инкишоф меёбад. Ин натиҷаи кори нокифояи музмини меъдачаи чапи дил мебошад. Гипоксияи ғангоми рукуди варидӣ мушоҳидашаванда, фишори баланди дохили рағҳо боиси вайроншавии нифозати мӯйрағҳо ва варидчаҳо мегардад.

Ба ҳамин тарик, ғангоми пурхунии музмини варидии шуш ду намуди тағйиротҳо инкишоф меёбанд: пурхунии рукудӣ, гипертония дар даври хурди гаридиши хун ва инкишофи бофтаи пайвасткунанда, яъне тасаллӯб (склероз).

Камхунии умумӣ.

Вобаста ба этиология ва патогенез фарқ карда мешавад:

- камхунии умумии шадид;
- камхунии умумии музмин.

Камхунии умумии шадид - ҳолате мебошад, ки ғангоми талафёбии тези зиёди хун, яъне ғангоми камшавии ҳаҷми хуни гардишкунанда (ХХГ) дар даври умумии гардиши хун дар фосилаи кутоҳи вақт инкишоф меёбад.

Сабабҳои камхунии умумии шадид: ҷароҳатҳои гуногун бо осебёбии узв, бофтаву рағҳо; кафидани худрустаи раги калон, аз ҷиҳати эътилолӣ тағйирёфта ё дил; кафидани узви аз ҷиҳати эътилолӣ тағйирёфта.

Падидаҳои клиникии камхунии умумии шадид:

- паридарангии пӯсту луобпардаҳо;
- ҷарҳ задани сар;
- гоҳо ҳолати ғашён ё беҳушӣ;
- набзи сусти тез-тез;
- фишори пасти хун.

Беморон аксаран аз камхунии шадид дар натиҷаи садами гиповолемӣ ба ҳалокат мерасанд.

Падидҳои патоморфологии камхунии умумии шадид:

- паридарангии якбораи пӯст, луобпардаҳои намоён,

зардобпардаҳо; бофтаҳои узвҳои дохилӣ диққатҷалбкунанда аст;

· ковокиҳои дил ва рағҳои калон ҳолӣ, испурч хурд, чиндор аст;

· аломати нисбатан ҳоси ин раванд - хунравиҳои нуқтагӣ ва доғдор дар зерӣ эндокарди меъдачаи чапи дил (доғҳои Минаков).

Фарҷом аз ду ҳолат вобастагӣ дорад:

· аз миқдори хуни талафёфта;

· аз суръати талафёбии хун.

Умуман, ин раванд бозгаштпазир аст, агар одам хуни на он қадар зиёд ва на он қадар босуръатро талаф дода бошад. Механизмҳои таллофӣ (компенсаторӣ) ба қор мебароянд: хун аз маҳзанҳои хун ба рағҳои қанорӣ бароварда мешавад. Кашишхӯрии рағҳо тағйир меёбад - девораи рағҳо кашиш меҳӯрад. Ва ба туфайли ин ду ҳолат организм ФШ-и хунро, ки бо ҳаёт мувофиқ аст, нигоҳ медорад.

Ҳатари асосии камхунии умумии шадид аз ҳалалдоршавии гемодинамика иборат мебошад. Чорабиниҳои табиб бояд ба барқарор намудани ҳаҷми хун равона карда шаванд.

Камхунии умумии музмин ё анемия, - ин камшавии миқдори эритроцитҳо ва ё мавҷуд будани гемоглобин дар воҳиди ҳаҷми хун мебошад. Ҳаҷми умумии хуни гаридшкунанда дар организм тағйир намеёбад.

Дар патогенези камхунии умумии музмин ду омил аҳамият доранд:

· ҳалалёбии вазифаи узвҳои хунофар;

· гемолизи пурзӯри эритроцитҳо.

Сабабҳои камхунии умумии музмин:

· бемории узвҳои хунофар;

· бемориҳои музмини сироятӣ;

· бемориҳои музмини паразитарӣ (муфтхурӣ);

- захролудихои хориҷзод (экзогенӣ);
- захролудихои дарунзод (эндогенӣ);
- гуруснагӣ (пурра ё қисман), авитаминоз;
- хунравихои хурд, вале тез-тез такроршаванда.

Падидаҳои клиникии камхунии умумии музмин:

- паридарангӣ;
- мондашавии сабӯк;
- сустӣ (беҳолӣ);
- паст шудани қобилияти корӣ;
- чарх задани сар;
- ҳолатҳои беҳушӣ.

Дар таҳлилҳои хун - камшавии миқдори эритроцитҳо ва пастшавии мавҷудияти гемоглобин.

Падидаҳои патологоанатомии камхунии умумии музмин:

- паридарангии пӯст, луобпардаҳо, узвҳои дохилӣ;
- тағйиротҳои дистрофии узвҳои лаҳимаӣ (махсусан бештар -дистрофияи чарбӣ);
- хангоми гемолизи пурзӯри эритроцитҳо гемосидерози умумӣ инкишоф меёбад;
- дар натиҷаи гипоксия метавонанд хунравихои диapedезӣ пайдо шаванд.

Фарҷом ва аҳамият. Умуман, раванд бозгаштпазир аст. Вале агар сабаб бартараф карда нашуда бошад ва раванд шиддат ёбад, он метавонад боиси марг гардад. Марг дар натиҷаи ихтилолҳои бозгаштнопазири мубодилаи моддаҳо фаро мерасад, ки бо норасоии оксиген алоқаманд аст.

Ғализшавии хун - ин коҳишёбии қисмати таркибии моеи хун, яъне дар хуни канорӣ кам шудани миқдори обу баъзе аз электролитҳо мебошад. Дар натиҷа хун ғализ мешавад, часпакии он баланд шуда, хусусиятҳои реологии хун тағйир меёбад, миқдори ҳуҷайраҳо ба воҳиди ҳаҷм нисбатан зиёд мешавад.

Сабабҳои ғализшавии хун:
 дарунравӣ ва қайкунии устувор;
 сӯхтагиҳои паҳншудаи дараҷаи дуюм, ҳангоме ки моддаи моеъ ба ҳуббобчаҳои сӯхтагӣ меравад;
 захролудшавӣ бо моддаҳои захролуди ҷангӣ (МЗҶ);
 иллати ятрогенӣ - диурези номувофиқ гузарондашудаи босуръат.

Падидаҳои патологоанатомии ғализшавии хун:
 хун ғафс, часпак, сиёҳ аст;
 дар рағҳо суддатҳо (тромбҳо) ҳосил мешаванд, махсусан тағйиротҳои зиёд дар маҷрои рағҳои хунгарди майдатарин ва ҳосилшавии суддатҳои (тромбҳои) хурд ва слачфеномен мушоҳида карда мешавад (часпиши эритроситҳо ба монанди сутунчаҳои тангашакл, часпиши онҳо ба девораи мӯйрағҳо).

Раванд ҳангоми бартараф намудани сабаб бозгаштпазир аст, ва аз ҳама муҳимаш, ҳангоми босаводона муолиҷа намудан таркиби хун метавонад барқарор гардад - фарҷом мусоид аст. Дар дигар ҳолатҳо ғализшавии хун бо ихтилоли равандҳои мубодила ҳамбастагӣ намуда, соиши хун дар девораи рағҳо баланд шуда, часпакии хун зиёд мешавад, ин бошад кори дилро душвор намуда, боиси инкишофи норасоии шадиди дил шуда метавонад. Ғализшавии хун ба инкишофи суддат (тромбоз) мусоидат менамояд.

Суюқшавии хун гидремия, - зиёдшавии миқдори об дар таркиби хуни канории одам мебошад. Хеле кам ба назар мерасад:

ҳангоми бемории гурдаҳо;
 ҳангоми тез наздикшавии омосҳо;
 ҳангоми ба таври дохиливаридӣ ворид кардани миқдори зиёди моеъ.

Аҳамияти суюқшавии хун амнфӣ аст. Вай метавонад бо зиёдшавии ҳаҷми хуни гардишкунанда ҳамбастагӣ

намояд, ки кори дилро душвор намуда, норасоии дил инкишоф ёфта метавонад; гоҳо моеъи воридшуда дар хун нигоҳ дошта намешавад ва дар ин ҳолат омоси шуш инкишоф меёбад, ки сабаби марганҷомӣ шуда метавонад.

ЛЕКСИЯИ 6 ТРОМБОЗ. ЭМБОЛИЯ.

Тромбоз -лахтабандии ҳаётии хун дар равзанаи рағҳо, дар ковокиҳои дил ё аз хун пайдошудани ҷисмчаҳои сахт мебошад. Лахтаи хуни дар ин маврид ҳосилшуда тромб номида мешавад.

Лахтабандии хуни рағҳо баъди марг мушоҳида карда мешавад (лахтабандии баъдимаргии хун). Ҷисмчаҳои сахти дар ин маврид ҳосилшударо лахтаи баъдимаргии хун меноманд.

Ғайр аз ин, лахтабандии хун дар таркиби бофтаҳо ҳангоми хунравӣ аз рағи осебёфта ба вучуд меояд ва механизми мӯътадили гемостатикӣ мебошад, ки ба қатъ намудани хунравӣ ҳангоми осебёбии рағ равона карда шудааст.

Тромбоз аз лахтабандии хун фарқ мекунад, вале ин фарқият каме шартӣ мебошад, чунки ҳам дар ин ва ҳам дар он ҳолат аксуламали селмонанди лахтабандии хун ба кор мебарояд. Тромб ҳамеша ба ҳуҷайраҳои эндотелии рағҳои хунгард часпидааст ва аз қабатҳои байни ҳамдигар алоқаманди тромбоситҳо, нахҳои фибрин ва чузъҳои шаклии хун иборат аст, лахтаи хун бошад аз нахҳои бетартибона ҷойгиршудаи фибрин ва тромбоситу эритроцитҳои байни онҳо ҷойгиршуда таркиб меёбад.

Халалдоршавии гемостаз

Тромбҳосилшавии аз ҳад зиёд боиси тангшавии ковокии рағи ё хунгард (окклюзияи) пурра маҳкамшавии он мегардад.

Пастшавии ҳадшабандии хун боиси хунравии аз ҳад

зиёд мегардад ва ҳангоми ихтилолҳои гуногуне мушоҳида крада мешавад, ки хунравии зиёдро ба вучуд меоваранд.

Омилҳои ба тромбозисилшавӣ таъсиркунанда: осебҳои хучайраҳои эндотелии рағҳои хунгард, тағйирҳои чоривавии хун, тағйирҳои хусусиятҳои физикию химиявии хун.

Механизмҳои тромбозисилшавӣ:

- хадшабандии хун - коагулятсия;
- часпидани тромбозитҳо - агрегатсия;
- часпидани эритроцитҳо - агглютинатсия;
- таҳшинии сафедаҳои хуноба - преципитатсия.

Тромб лахтаи хуне мебошад, ки ба девори рағи хунгард дар ҷои осебҳои он часпидааст, асосан ғизлати саҳт дорад, хушк аст, ба асонӣ порча-порча мешавад, қабатнок, бо сатҳи раҳдор ё шахшул мебошад. Ҳангоми ташреҳ онро аз лахтаи баъдимаргии хун тафриқа намудан лозим аст, ки аксаран шакли рағро такрор намуда, бо девораи он алоқа надорад, намнок, чандир, якҷинса, бо сатҳаш суфта мебошад.

Вобаста ба соҳт ва намуди берунии фарқи карда мешавад:

- тромби сафед (аз тромбозитҳо, фибрин, лейкоцитҳо ва микдори наҷандон зиёди эритроцитҳо иборат аст;
- тромби сурх (аз тромбозитҳо, фибрин ва микдори зиёди эритроцитҳо иборат аст);
- тромби омехта (соҳтори қабатнок дорад, дар он унсурҳои хун мавҷуданд, ки ҳам барои тромби сафед ва ҳам барои тромб сурх ҳосанд);
- тромби гиалинӣ (аз эритроцитҳои гемолизшуда, тромбозитҳо ва сафедаҳои таҳшиншудаи хуноба иборат аст, ва лекин фибрин надорад; моддаи ҳосилшуда тағоякро ба хотир меоваранд).

Аз рӯйи муносибат ба ковокии рағҳо фарқ карда мешавад:

- тромби наздидеворагӣ (қисми зиёди ковоки озод аст);
- тромби мусаддидкунанда ё маҳкамкунандаи тромб (ковокии раги хунгард пурра маҳкам аст).

Мавзёгирии тромбҳо.

Тромбози шараёнӣ одатан баъди осебёбии ҳучайраҳои эндотелияи рағҳо ва тағйирёбии чузъии чараёни хун ҳосил мешавад.

Тромбози дил. Тромбҳо дар доираи ҳучрачаҳои дил ҳангоми ҳолатҳои зерин ҳосил мешаванд:

- илтиҳоби дарғотҳо;
- осебёбии девори эндокард;
- маҷрои хуни турбулентӣ ва руқуд (стаз) дар даҳлезаки дил.

Тромбози варидӣ.

Тромбофлебит. Ҳангоми тромбофлебит тромбози варидӣ дуҷумбора ҳамчун натиҷаи илтиҳоби шадиди варидҳо пайдо мешавад.

Флеботромбоз - ин тромбози варидҳо мебошад, ки ҳангоми набудани аломатҳои равшани илтиҳоб дучор мегардад.

Фарҷоми тромбоз. Ҳосилшавии тромбҳо боиси ҷавоби организм мегардад, ки ба бартараф намудани тромб ва барқарор намудани гардиши хун дар раги хунгарди осебёфта равона карда шудааст. Барои ин якчанд механизмҳо мавҷуданд:

- ҳалшавии тромба (фибринолиз), ки боиси пурра вайроншавии тромб мегардад - фарҷоми идеали мусоид, вале хеле кам дучор мегардад. Фибрини тромбро ташкилкунанда тавассути плазмин вайрон мешавад, ки бо омили Хагеман (омили XII) ҳангоми фаъолноқшавии каскади дохи-

лии хадшабандии хун фаъолнок карда мешавад;

- ташаккул ва бенайчашавӣ (реканализатсия) одатан дар тромбҳои калон ба вучуд меояд. Ҳалшавӣоҳиста-оҳитса ва фагоситози тромб бо инкишофи бофтаи пайвастунанда ва коллагенизатсия (ташаккул) ҳамбастагӣ менамояд;

- петрификатсияи тромба - ин фарҷоми нисбатан мусоид мебошад, ки бо замшавии намакҳои калтсий дар тромб тавсиф меёбад;

- таҷзияи тааффунии тромб - фарҷоми номусоид, ки ҳангоми сироятнокшавии тромб аз хун ё девораи рағҳо ба вучуд меояд.

Аҳамияти тромбоз муайян карда мешавад:

- бо суръати инкишоф;
- мавзегирӣ;
- паҳншавӣ;
- фарҷом.

ЭМБОЛИЯ

Эмболия - дар маҷрои хун интиқол ёфтани ҳиссаҷаҳои бегона ва тавассути онҳо маҳкам шудани ковокии рағи хунгард мебошад. Ҳуди ҳиссаҷаҳо эмболҳо номида мешаванд.

Вобаста аз самти ҳаракати эмбол фарқ карда мешавад:

- эмболияи муқаррарӣ (ортоградӣ) (ҷойивазкунии эмбол ба самти маҷрои хун);

- эмболияи ретроградӣ (ҳаракати эмбол ба самти муқобили маҷрои хун таҳти таъсири қувваи вазнинӣ);

- эмболияи парадоксалӣ (ҳангоми мавҷуд будани нуқсон дар тавораи байни пешдил ё байнимеъдачагӣ эмболҳо аз варидҳои даври калон ба шуш нарасида ба шараёнҳо меафтанд).

Патогенези эмболия фақат ба маҳкамшавии механи-

кии ковокии рағҳо вобаста намудан хатост. Дар инкишофи эмболия ҷои ташаннучи рефлектории ҳам рағи асосии магистралӣ ва ҳам шохчаҳои паҳӯии он аҳамияти калон дорад, ки боиси ихтилолҳои вазнини носозкории гардиш (дистсиркуляторӣ) мегардад.

Мавзёғирии эмболия аз ҷои пайдоиш ва андозаи эмбол вобастагӣ дорад.

Ҳосилшавии эмболҳо дар варидҳои даври калони гардиши хун. Эмболҳое, ки дар варидҳои даври калони гардиши хун ё дар нимаи рости дил ҳосил мешаванд, шараёнҳои даври хурдро маҳкам мекунанд, ба истиснои он ҳолатҳое ки онҳо ба андозае хурд ҳастанд, ки тавассути мӯйрағҳои шуш гузашта метавонанд. Ҷойи маҳкамшавӣ дар рағҳои шуш аз андозаи эмбол вобастагӣ дорад.

Эмболҳое, ки дар шоҳаҳои вариди баввобӣ (порталӣ) пайдо мешаванд, боиси ҳалалдоршавии гардиши хун дар чигар мешаванд.

Ҳосилшавии эмбол дар дил ва шараёнҳои давраи калони гардиши хун: эмболҳои дар дил ва шараёнҳои даври калони гардиши хун ҳосил мешаванд, боиси эмболия дар шӯъбаҳои наздиктари (дисталии) даври калон мегарданд.

Тромбоэмболия: кандашудани қисми тромб ва ҳаракат кардани он бо ҳамроҳии хун - сабаби асосии эмболия мебошад.

Тромбоэмболияи шараёни шуш (ТЭШШ).

Оризаи нисбатан ҷиддии тромбоэмболия - ин эмболияи шуш мебошад, ки метавонад боиси марги ногаҳонӣ гардад. Эмболияи шуш аксаран ҳангоми ҳолатҳои зерине мушоҳида карда мешавад, ки ба пайдоиши флеботромбоза таъҷил доранд:

баъди амалиёти ҷарроҳӣ дар давраи барвақтии баъдичарроҳӣ тромбози варидҳои амиқ инкишоф меёбад; давраи барвақтии баъдитававлудӣ;

иммобилизатсияи иловагӣ дар чойи хоб;
 норасоии дил;
 истифодаи контрасептивҳои (маводи пешгирикунандаи хамл) даҳонгузар.

Падидаҳои клиникӣ ва аҳамияти ТЭШШ

Андозаи эмбол - омили нисбатан аҳамиятноке мебошад, ки дараҷаи падидаҳои клиникӣ эмболияи шараёнҳои шуш ва аҳамияти онро муайян мекунад.

Эмболҳо фаровон. Эмболҳои калон метавонанд дар баромадгоҳи меъдаҷаи рост ё дар танайи шараёни шуш қарор гиранд, ки дар он ҷо монеаро барои гардиши хун ва марғи ноғаҳонӣ дар натиҷаи рефлeksi пулмокоронарӣ (шушу рағҳои иқлилӣ) ба вучуд меоваранд. Бо эмбол маҳкамшавии шоҳаҳои калони шараёнҳои шуш ҳамчунин метавонад боиси марғи ноғаҳонӣ дар натиҷаи вазоконструкцияи вазнини ҳамаи рағҳои даври хурди гардиши хун гардад, ки ба таври рефлекторӣ дар ҷавоби пайдоиши тромбоэмбол дар рағ ё ташаннуҷи ҳамаи рағҳо пайдо мешавад.

Эмболҳои андозаашон миёна. Дар одамони солим шараёни бронхҳо лаҳимаи шушро бо хун таъмин мекунад, вазифаи шараёни шуш бошад - асосан мубодилаи газҳо мебошад. Аз ин сабаб эмболҳои андозаашон миёнаи шуш боиси пайдоиши қисмати шуш мегардад, ки таҳвил меёбад, вале дар мубодилаи газҳо иштирок намекунад.

Эмболҳои хурд. Шоҳаҳои хурди шараёни шушро маҳкам мекунад ва метавонанд бе аломатҳои клиникӣ ҷараён ёбанд - ин аз паҳншавии эмболия вобастагӣ дорад. Дар аксари ҳолатҳо эмболҳо таҳти таъсири фибринолиз таҷзия мешаванд.

Тромбоэмболияи рағҳои даври калони гардиши хун

Сабабҳо: тромбоэмболия дар рағҳои даври калони

гардиши хун ҳангоми ҳосилшавии эмболҳо дар нимаи чапи дил ё шараёнҳои кутрашон калон пайдо мешавад.

Падидаҳои клиникӣ ва аҳамияти тромбоэмболияи даври калони гардиши хун муайян карда мешаванд:

- бо андозаи раги иллатёфташуда;
- инкишофи гардиши хуни шохаҳо (коллатералӣ);
- ҳассосияти бофтаҳо нисбати ишемия.

Эмболияи ҳавоӣ ҳангоми ба маҷрои хун воридшавии миқдори кофии ҳаво (тақрибан 150 мл) мушоҳида карда мешавад.

Сабабҳо:

- амалиёти ҷарроҳӣ ё осебҳои вариди дохилии юғӣ;
- зоишҳо ва исқоти ҳамл;
- эмболия ҳангоми хунгузаронӣ;
- инфузияҳои (қатрачаконии) дохиливаридӣ;
- тадқиқотҳои рентгенконтрастии ангиографӣ.

Эмболияи ҳавоӣ фақат ҳангоми ҳалалёбии техникаи дастамалҳо ба вучуд меояд. Ҳангоми ТСШ (тахвили сунъии шуш)-и номувофиқ гузарондашуда дар шароити оксигентасияи гипербарий.

Ҳангоми ба маҷрои хун афтидани ҳаво он тавассути меъдачаи рост мегузарад, ки дар он ҷо омехтаи кафқдор ҳосил шуда, маҷрои хунро саҳт душвор мегардонад, бо ҳаво маҳкам шудани 2/3 мӯйрағҳои шуш боиси марганҷомӣ мегардад.

Эмболияи газӣ бо азот (синдроми декомпрессионӣ).

Сабабҳо: синдроми декомпрессионӣ.

Дар ҳубобчаҳои азот дар маҷрои хун тромбоситҳо кафшер мебанданд ва механизми ҳадшабандии хунро фаъол мекунанд. Тромбози пайдошудаи паҳнёфтаи дохилирағӣ ҳолати ишемии бофтаҳоро бад менамояд, ки аз сабаби маҳкам шудани мӯйрағҳо бо ҳубобчаҳои газ ба вучуд

омадааст. Дар ҳолатҳои вазнин некрози бофтаҳои мағзи сар ба вучуд меояд, зеро азот дар бофтаҳои аз чарбҳо бой маҳлул мешавад, ки боиси марганҷомӣ мегардад. Дар ҳолатҳои вазниниашон камтар пеш аз ҳама мушаку асабҳои онҳоро асабноккунанда иллатнок мешаванд; ин боиси ташаннучҳои вазнини мушакҳо ва дарди пуршиддат мегардад.

Эмболияи чарбӣ.

Эмболияи чарбӣ ҳангоми ба маҷрои хун ворид шудани қатраҳои чарб ба амал меояд.

Гарчанде механизми ба маҷрои хун ворид шудани қатраҳои чарб оддӣ ба назар мерасад, боз якчанд механизмҳои вучуд доранд, ки аз таъсири онҳо падидаҳои клиникии эмболияи чарбӣ вобастагӣ доранд. Маълум аст, ки андозаи қатраҳои чарб дар маҷрои хун калон шуда метавонанд. Тахмин карда мешавад, ки ихроҷи катехоламинҳо дар натиҷаи осеб боиси сафарбарии кислотаҳои озоди чарбӣ мегардад, ки ба туфайли онҳо зиёдшавии пуршиддати қатраҳои чарб ба вучуд меояд. Илтиёми (адгезияи) тромбоситҳо дар қатраҳои чарб боиси калоншавии минбаъдаи андозаҳои онҳо мегардад, ки ҳамчунин ба трмбоз оварда мерасонад. Ҳангоме, ки ин раванд ба таври мутамарказ ба амал меояд, ин раванд ба синдроми лахтабандии паҳнфтои дохилирагӣ баробар аст.

Қатраҳои гардишкунандаи чарб аввал ба мӯйраги шуш ворид мегарданд. Ҳиссачаҳои калони чарб ($> 20\text{мкм}$) дар шуш боқӣ мемонанд ва боиси норасоии нафаскашӣ мегарданд (диспноэ ва вайроншавии мубодилаи газҳо). Ҳиссачаҳои хурдтари чарб тавассути мӯйрагҳои шуш мегузаранд ва ба даври калони гардиши хун ворид мегарданд. Падидаҳои хоси клиникии эмболияи чарбӣ:

- дар пӯст пайдо шудани доначаҳои хунрез;
- пайдо шудани ихтилолҳои шадиди паҳншудаи асабӣ

(неврологӣ).

Имконияти инкишофи эмболияи чарбӣ бояд ҳангоми пайдо шудани ҳолатҳои зерин ба назар гирифта шавад:

- ихтилолҳои нафаскашӣ;
- ихтилолҳои мағзи сар;
- доначаҳои хунрез дар рӯзи 1-3-юми баъди осеб.

Ташхис ҳангоми ошкор намудани қатраҳои чарб дар пешоб ва балғам тасдиқ карда мешавад. Тақрибан 10%-и мизочон дорои аломатҳои клиникии эмболияи чарбӣ ба ҳалокат мерасанд. Ҳангоми аутопсия қатраҳои чарбиро дар бисёре аз узвҳо мушоҳида намудан мумкин аст, ки барои ин ба таври махсус ранг намудани мустаҳзарҳо барои чарб зарур аст.

Аҳамияти эмболия яқсон нест ва бо намуди эмбол, паҳншавии эмболия ва мавзёғирии онҳо муайян карда мешавад.

Камхунӣ ё ишемия, - кам шудан ё қатъ шудани маҷрои хуни шараёнӣ ба узв, бофта ё қисми бадан.

Вобаста ба сабаб ва шароитҳои пайдоиш намудҳои зерини камхуниро чудо мекунанд:

- ангиоспастикӣ (дар натиҷаи ташаннуҷи шараёнҳо аз сабаби таъсири барангезандаҳои гуногун);
- инсидодӣ (дар натиҷаи маҳкам шудани ковокии шараён, бо тромбоз ё эмболияи шараёнҳо, инчунин инкишофи бофтаи пайвасткунанда дар ковокиҳои шараёнҳо ҳангоми илтиҳоби девораи он);
- компрессионӣ (дар натиҷаи фишор овардан ба шараёнҳо ҳангоми гузоштани тофтабанд, ҳангоми бо рағбаст (лигатура) бастанӣ шараёнҳо, инчунин ҳангоми фишор овардани омос, хадша ё узви калоншуда);
- ишемия дар натиҷаи аз нав тақсимшавии хун.

Тағйиротҳои морфологии узву бофтаҳо ҳангоми ҳамаи намудҳои ишемия ба ин ё он андоза бо гипоксия ё

аноксия, яъне норасоии оксиген алоқаманданд. Вобаста ба сабабҳои ба вучуд овардани камхунӣ, ногаҳонӣ будани пайдоиши он, давомнокӣ ва дараҷаи камшавии маҷрои хуни шараёнӣ ишемияи шадид ва музмин фарқ карда мешавад.

Омилҳое, ки фарҷом ва аҳамияти камхунии чузъиро муайян мекунанд:

- дараҷаи инкишофи шоҳаҳои рағҳои паҳлӯӣ;
- ҳолати шараёнҳои паҳлӯӣ (коллатералӣ);
- самаранокӣ фаъолияти системаи дилу рағҳо;
- суръати пайдоиши монеа; сироятпазирии бофта нисбати ишемия;
- дараҷаи мубодилавии (метаболии) бофта.

ЛЕКСИЯИ 7 САКТА. ВАЙРОНШАВИИ ГАРДИШИ ЛИМФА

Сакта - ин қитъаи мавтшудаи узв ё бофта мебошад, ки аз гардиши хун дар натиҷаи якбора қатъшавии маҷрои хун (ишемия) хориҷ карда шудааст. Сакта - намуди рагӣ (ишемиявӣ) некрози хадшагӣ (коагулятсионӣ) ё колликватсионӣ мебошад.

Сабабҳои инкишофи сакта:

- ишемияи шадид, ки бо ташаннучи дуру дароз, тромбоз ё эмболия, фишороварии шараён асоснок шудааст;
- Фаъолияти узв дар шароитҳои нокифоя будан бо хун таъминшавии он.

Манзараи макроскопии сактаҳо. Шакл, бузургӣ, ранг ва ғизлати сакта гуногун буда метавонад.

Шакли сакта. Одатан сактаҳо фонашакл мебошанд. Дар ин маврид нӯги тези фона ба даромадгоҳҳои узв равона шуда, қисми васеи он бошад ба канорҳо мебарояд.

Бузургии сактаҳо. Сакта метавонад қисми зиёд ё та-

моми узвро фаро гирад (сактаи зерумумӣ ё умумӣ) ё фақат дар зери заррабин (микроскоп) ошкор карда мешавад (микроинфаркт).

Ранг ва ғизлати сактаҳо. Агар сакта аз рӯи навъи некрози хадшагӣ инкишоф ёбад, пас бофта дар қисмати мавтшуда саҳт, хушк, сафеди зардранг мешавад (сактаи миокард, гурдаҳо, испурч). Агар сакта аз рӯи навъи некрози колликватсионӣ инкишоф ёбад, пас бофтаи мавтшуда мулоим ва суюқ мешавад (сактаи мағзи сар ё лонаи мулоимшавии хокистаранг).

Вобаста ба механизми инкишоф ва намуди берунӣ фарқ карда мешавад:

- сактаи сафед (ишемиявӣ) (дар натиҷаи пурра қатъшавии маҷрои хуни шараёнӣ ба узвҳо);
- сактаи сурх (хунрез) (аз сабаби баромадан ба минтақаи сактаи хун аз рағҳои некрозшудаи маҷрои микрогардиш);
- сактаи сафед бо тоҷаки хунрез.

Сактаҳои ғайритаафунӣ (асептикӣ) ва тааффунӣ (септикӣ) фарқ карда мешаванд. Аксарияти сактаи узвҳои дохилӣ, ки бо муҳити атроф дахлдор нестанд, ғайритааффунӣ мебошанд. Сактаҳои тааффунӣ ҳангоми воридшавии сирояти думҷобораи бактериявӣ ба бофтаҳои некрозшуда пайдо мешаванд.

Ба таври микроскопӣ қитъаи мавшуда бо вайроншавии соҳт, шакли ҳуҷайраҳо ва нестшавии ҳастаҳо фарқ мекунад.

Аҳамияти бештари клиникиро сактаи дил (миокард), мағзи сар, рӯдаҳо, шуш, гурдаҳо, испурч доро мебошанд.

Дар дил сакта одатан сафед бо тоҷаки хунрез мебошад, шакли нодуруст дорад, бештар дар меъдачаи чап ва тавораи байнимеъдачагӣ, хеле кам - дар меъдачаи рост ва дахлезакӣ дил дучор мегардад. Мавтшавӣ метавонад дар эндокард, перикард ва миокард мавзёи гирад ё тамоми

пахноии миокардро фаро гирад. Дар қисмати сакта дар эндокард гоҳо ғуборҳои суддатӣ (тромботикӣ, дар перикард бошад - фибринозӣ ҳосил мешаванд, ки бо инкишофи илтиҳоби реактиви атрофи қитъаҳои некроз алоқаманд аст.

Дар мағзи сар болотари доираи Виллизиев сактаи сафед ҳосил мешавад, ки тез мулоим мешавад (лонаи мулоимшавии ҳокистаранги мағзи сар). Агар сакта дар заминаи ихтилолҳои зиёди гардиши хун, рукуди варидӣ ба амал ояд, пас лонаи мавтшавии мағи сар бо хун ҷаббида ва сурх мешавад (лонаи мулоимшавии сурхи мағзи сар). Дар қисмати танаи мағзи сар поёнтари доираи Виллизеев ҳамчунин сактаи сурх инкишоф меёбад. Сакта одатан дар гирехҳои зерқишрӣ мавзёи гирифта, роҳҳои ноқилияти мағзи сарро вайрон мекунад, ки бо фалаҷҳо зоҳир мегардад.

Дар шуш дар аксари ҳолатҳо сактаи хунрез ҳосил мешавад. Сабаби он аксаран тромбоземболия, гоҳо - тромбоз (суддат) ҳангоми илтиҳоби рағҳо (васкулит) мебошад. Қитъаи сакта нағз маҳдуд гардида, шакли конусро дорад, ки асоси он ба ҷануб нигаронида шудааст. Дар ҷанб дар қисмати сакта ғуборҳои фибрин (плеврити реактивӣ) пайдо мешавад. Дар нӯги конус, ки ба решаи шуш нигаронида шудааст, гоҳо тромб ё эмболи шохҳои шараёни шуш ошкор карда мешавад. Бофтаи мавтшуда сахт, доначадор буда, ранги сурхи сиёҳранг дорад.

Дар гурдаҳо сактаи сафед бо тоҷаки хунрез, қисмати конусшакли некроз ё моддаи қишрӣ, ё тамоми паҳноии лаҳимаро фаро мегирад.

Дар испурҷ сактаҳои сафед, гоҳо бо илтиҳоби фибринозии реактиви гилофак ва минбаъд ҳосилшавии илтиёмҳо (часпишҳо) бо диафрагма, баргаки берунии сифок, ҳалқаҳои рӯдаҳо дучор мешавад.

Дар рӯдаҳо сактаҳо хунрезанд ва ҳамеша дучор таҷ-

зияи тааффуни (септикӣ) мегарданд, ки боиси суроҳшавии девораи рағҳо ва инкишофи илтиҳоби сифок (перитонит) мегардад.

Сакта - осеби бозгашнопазири бофта мебошад, ки бо некрози ҳам ҳуҷайраҳои лаҳимаӣ ва ҳам бофтаи пайвасткунанда тавсиф меёбад.

Суръати ҷараёни сакта ва вақте, ки барои шифоёбии комил талаб карда мешавад, вобаста ба андозаи иллатҳо тағйир меёбанд. Сактаи хурд дар давоми 1-2 ҳафта сихат мешавад, барои сихатшавии қисмати калон 6-8 ҳафта ва зиёдтар вақт талаб карда мешавад.

Фарҷомҳои номусоиди сакта: маҳлулшавии римноки он дар дил- миомалътсия ва кафидани ҳақиқии девори дил ва инкишофи гемотампонадаи ковокии перикард.

Аҳамияти сакта бо мавзегирӣ, анлоза ва фарҷоми сакта муайян карда мешавад, вале барои организм ҳамеша аҳамияти ниҳот калон дорад, чунки сакта —некрози ишемияӣ мебошад, яъне қисмати узв аз фаъолият хориҷ карда мешавад.

Вайроншавии гардиши лимфа

Вайроншавии гардиши лимфа ба таври клиникӣ ва морфологӣ пеш аз ҳама дар шакли норасоии ҷараёни бозгашти лимфа зоҳир мегардад, ки шаклҳои он гуногун буда метавонанд.

Падидаҳои аввалини ҷараёни бозгашти лимфа - ин рукуди лимфа ва васеъшавии рағҳои лимфагард мебошад. Реаксияҳои таллофишавӣ-мутобиқат дар ҷавоби рукуди лимфа инкишофи рағҳои паҳлӯӣ ва азнавсозии рағҳои лимфагард мебошад, ки ба ҳуфрахҳои тунукдевоари васеъ табдил меёбанд (лимфангиоектазия).

Падидаҳои таллофинопазирии гардиши лимфа омоси лимфогенӣ ё лимфедема мебошанд. Лимфедема шаклҳои зерин дорад:

чузъӣ (минтақавӣ);
умумӣ.

Ҳам лимфодемаи чузъӣ ва ҳам умумӣ аз рӯи чараёни худ шадид ва музмин буда метавонанд.

Лимфедемаи музмини чузъӣ модарзодӣ ва пайдошуда буда метавонад.

Модарзодӣ бо гипоплазия ё аплазияи лимфагиреҳҳо ва рағҳои пойҳо алоқаманд аст.

Лимфадемаи пайдошудаи музмини чузъӣ аз сабаби фишороварӣ (омос) ё холишавии рағҳои лимфагард инкишоф меёбад.

Дар заминаи лимфедема бозистии (стази) лимфа (лимфостаз), тромбҳои сафедагӣ инкишоф меёбад, ки бо баландшавии нифозат ва ҳатто кафидани мӯйрағҳои лимфагард ва лиффоррея ҳамбастагӣ менамояд.

Бо лимфорреяи дохилӣ инкишофи астсити хилусӣ (широбагӣ) ва хилоторакс алоқаманд аст.

Астсити хилусӣ - ҷамъшавии моеи хилусӣ дар ковокии шикам ҳангоми рукуди якбораи лимфа дар рағҳо ё ҳангоми осебёбии лимфарағҳои рӯдаҳо ва масориқаи он мебошад. Моеи хилусӣ сафед буда, ширро ба хотир меоварад.

Хилоторакс -ҷамъшавии моеи хилусӣ (широба) дар ковокии ҷанб аз сабабҳои зерин мебошад:

осебёбии маҷрои сина ҳангоми ҷарроҳӣ ё ҳангоми ворид намудани доруҳо;

маҳкам шудани он бо тромб ё фишороварии омос.

Аҳамияти норасоии системаи лимфавӣ пеш аз ҳама бо ихтилолҳои мубодилаи (метаболизми) бофтаҳо муайян карда мешавад.

ЛЕКСИЯИ 8

МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ ОМОСӢО. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. ОМОСӢОИ ЭПИТЕЛИАЛӢ.

Назарияҳои инкишофи омосҳо.

Омос яке аз падидаҳои тибби имрӯза мебошад, ки паҳлӯҳои гуногуни он то кунун пурра омӯхта нашудаанд ва оиди пайдоиши омосҳо назарияҳои гуногун мавҷуданд. Яке аз чунин назарияҳо назарияи пайдоиши бисёрнасла мебошад, ки мувофиқи он омили аввалияи саратонвар боиси мутатсияи ҳуҷайраи алоҳида мегардад, ки ҳангоми тақсимшавии он сипас насли омоси ба вучуд меояд, ки номияро ташкил медиҳад.

Мувофиқи назарияи «майдони омосӣ» омили саратонвар ба миқдори зиёди ҳуҷайраҳои монанд таъсир расонда, боиси пайдоиши майдони ҳуҷайраҳои навпайдошуда (омосӣ) шуда метавонад. Номияҳо метавонанд баъдан дар натиҷаи афзоиши як ё миқдори зиёди ҳуҷайраҳои дохили ин майдон рушд намоянд. Ин назария пайдоиши баъзе аз номияҳоро дар пӯст, роҳҳои пешоббарор, чигар, ғадуҳои ширҳосилкунанда ва рӯдаҳо шарҳ медиҳад.

Назарияи мутатсияҳои генетикӣ. Назарияи дигари пайдоиши омосҳо назарияи мутатсияҳои генетикӣ номида шудааст. Агар танзимкунандаи инкишофи генҳо осеб бинад, ихтилолҳои генома метавонанд боиси омоси навпайдошуда гардад. Таҳвили омосӣ дар натиҷаи фаъолнокӣ (ё уфрӯнишинии) пайдарҳамиҳои махсуси КДН ба вучуд меояд, ки бо номи генҳои танзимкунандаи инкишоф ё протоонкогенҳо маълуманд. Ин генҳо як қатор омилҳои инкишофро ва ретсепторҳоро барои омилҳои инкишоф ба рамз медароранд.

Назарияи саратонварҳои (онкогенҳои) вирусӣ. Баъзе аз КРН-вирусо пайдарҳамии кислотаҳои нуклеиниро дар бар мегиранд, ки нисбати протоонкоген комплементарӣ

мебошанд ва метавонанд пайдарҳамии вирусии КДН-ро синтез намоянд (ҳангоми таъсири транскриптазаи бозпас), ки моҳиятан монанд мебошад.

Назарияи эпигенетикӣ. Мувофиқи назарияи эпигенетикӣ осеби асосии ҳучайравӣ на дар дастгоҳи генетикии ҳучайра, балки дар механизми танзими фаъолнокии генҳо, махсусан дар сафедаҳо ба вучуд меояд, ки синтези онҳо генҳои танзимкунандаи инкишофро ба рамз медарорад. Дарачаи гуногуни фаъолнокии генҳо, ки барои тафрикаи бофтаҳо ҷавобгар мебошанд, чи хеле ки тахмин карда мешавад, бо механизмҳои меросии эпигенетикӣ муайян карда мешавад.

Назарияи рад намудани назорати масунӣ. Мувофиқи ин назария тағйиротҳои неопластикӣ нисбатан бештар дар ҳучайраҳои организм ба вучуд меоянд. Дар натиҷаи осебёбии КДН ҳучайраҳои неопластикӣ молекулаҳои навро синтез мекунанд (неоантигенҳо, антигенҳои омосӣ). Силсилаи масунии организм ин неоантигенҳоро ҳамчун «бегона» мешиносад, ки боиси фаъолнокии ҷавоби ситотоксикӣ масунӣ гашта, ҳучайраҳои неоплатсикиро нобуд месозад. Номияҳои ба таври клиникӣ зоҳиршаванда танҳо дар он ҳолатҳое пайдо мешаванд, ки вай шинохта нашавад ва аз тарафи силсилаи масунӣ вайрон карда нашавад.

Морфогенези омосҳо.

Таконҳои бисёркарата ва омилҳои бешумор. Кнудсен назарияро пешниҳод намуд, ки барои инкишофи омосҳо ду такон лозим аст. Такони аввал бо воҳурии нахустин бо омили саратоновар вобастагӣ дорад - ин лаҳза барангезиш, моддаи саратоноваре, ки боиси ин тағйирот мегардад - барангезанда номида мешавад. Таъсироти дуюм, ки инкишофи навҳосилшудаи омосиро ба вучуд меоварад - промотсия, омили он бошад - промотор номида мешавад.

вад. Ҳоло далели мавҷудияти ин марҳилаҳо - таконҳои бсиёркарата (панҷто ва зиёдтар) собит карда шудааст. Исбот карда шудааст, ки омилҳои зиёде боиси ин таконҳо шуда метавонанд ва ҳар як такон дар геноми ҳуҷайраи ба таъсирот дучоршуда тағйиротхоро ба вучуд меоварад, ки ба насл интиқол дода мешавад (яъне ба насли навоҳосилшуда). Давраи байни такони аввал ва пайдоиши омоси аз ҷиҳати клиникӣ муайяншаванда давраи ниҳонӣ номида шудааст..

Шиноҳти осебҳои қаблиомосӣ хеле муҳим аст, зеро ҳангоми бурида партофтани бофтаи тағйирёфта инкишофи омосҳо пешгирӣ карда мешавад. Бо вучуди он, ки рушди зиёд (гиперплазия) ва шаклдигаркунии бофта (метаплазия) барои инкишофи омосҳо хатарнок нестанд, таъсири доимии омили бемориовар метавонад боиси ба ҳалалдоршавии рушд (дисплазия) таҳвил ёфтан гардад, ки хатари зиёди табдил ёфтан ба омосро дорад.

Аломатҳои ҳалалдоршавии рушд (дисплазия) инҳо мебошанд:

Тағйирёбии ҳаста:

- ҳалалдоршавии рушд бо васеъшавии муносибати ҳастаю ситоплазмавӣ тавсиф меёбад;
- зиёдшавии миқдори хроматин;
- вайроншавии сохт ва ҷойгиршавии хроматин;
- вайрошавии шаклгирии гишои ҳаста (ғафсшавию пучшавӣ).

Тағйирёбии ситоплазма:

- ихтилолҳои ситоплазмавӣ ҳангоми ҳалалдоршавии рушд аз сабаби вайроншавии тафриқаи мӯътадил ба вучуд меоянд;
- зиёдшавии суръати тақсимшавии ҳуҷайраҳо
- вайроншавии сабзиш - ҳуҷайраҳои рушдашон ҳала-

лѐфтаи рӯйпӯш (эпителиалӣ) монандиро бо ҳуҷайраҳои бунѐдии танагӣ нигоҳ медоранд.

Дисплазияи эпителиалӣ ҳолати қаблиомосӣ мебошад, ки бо хатари баланди пайдоиши саратон алоқаманд аст.

Хатари пайдоиши саратони олудашуда (инвазивӣ) аз: зохиршавандагии дисплазия; давомнокии дисплазия; мавзъгирии дисплазия вобастагӣ дорад.

Фарқияти байни дисплазия ва саратон. Дисплазия ва carcinoma in situ, аз саратони ҳақиқӣ бо ду хусуияти муҳими худ фарқ мекунад: олудашавӣ (инвазивность) ва базгаштпазирӣ (реверсияпазирӣ).

Набудани олудашавӣ (инвазивноқӣ): бофтаи нуқсондор ҳангоми дисплазия ва carcinoma in situ, тавассути гишои бунгоҳӣ ворид намегардад.

Реверсияпазирӣ: бофтаи диспластикӣ гоҳо метавонад худ ба худ ба ҳолати мӯътадил баргардад, саратон бошад раванди бозгаштнопазир мебошад. Вале дисплазияи вазнин метавонад бозгаштнопазир бошад.

Ташхиси дисплазия.

Тадқиқоти макроскопӣ. Дисплазияи эпителиалӣ, аз ҷумла carcinoma in situ, одатан беаломат (асимптоматикӣ) мебошад ва дар бисёр мавридҳо ҳангоми тадқиқи микроскопии луобпарда иллатҳо (патология) ошкор карда намешавад.

Тадқиқоти микроскопӣ: рудаҳо бо роҳи ҳароши эпителия барои ташхиси ситологӣ ҳосил карда мешавад. Баҳодиҳии микроскопии тағйиротҳои ҳаста ва диспластикӣ барои гузоштани ташхис ва муайян намудани дараҷаи зохиршавандагии дисплазия имконият медиҳанд.

МОРФОЛОГИЯИ ОМОСҲО

Органоидноқӣ.

Омос аз лаҳима (паренхима) ва пайкар иборат аст. Лаҳима - бофтаи аслии омос буда, моддаи асосии онро

ташкил медиҳад ва инкишофу характери онро муайян месозад. Пайкар аз бофтаи пайвасткунанда иборат аст; газ таркиби он рағҳои хунгарди ғизодиҳанда ва торҳои асаби омос мегузаранд.

Атипизм (ғайримуқаррарият) - ин маҷмӯи хусусиятҳои биологӣ мебошад, ки бофтаи навҳосилшударо (номияро) аз бофтаи ибтидоӣ фарқ мекунонад. Хусусиятҳои нави барои ҳуҷайраҳои муқаррарӣ хоснабударо гирифтани ҳуҷайраҳои омосӣ номи анаплазия ё катаплазияро гирифтааст. Истилоҳи катаплазия дар адабиёти муосири илмӣ бештар қор фармуда мешавад. Фарқ қарда мешавад:

- морфологӣ;
- функционалӣ;
- атипизми антигенӣ;
- атипизми мубодилаи моддаҳо (метаболизм).

Атипизми морфологӣ ба бофтагӣ ва ҳуҷайравӣ тақсим қарда мешавад.

Атипизми бофтагӣ бо ҳалалдоршавии андозаҳо, шакл ва муносибати байниҳамдигарии сохторҳои бофтагӣ тавсиф меёбад. Вайроншавии муносибати байниҳамдигарии сохторҳои бофтагӣ дар омосҳои эпителияи пушишӣ бо он зоҳир мешавад, ки қабати (пласти) метавонад дар ғафсии пӯст (дерма), на дар сатҳи он ҷойгир шуда метавонад. Дар омосҳои пайдоишашон мезенхимиялӣ дастаи мӯякҳо бо дарозӣ, ғафсӣ, ҷойгиршавии бетартибона фарқ мекунад. Атипизми строма метавонад бо тавсифи миқдорӣ ва сифатии ҷузъи мӯякдор, инчунин таносуби ҷузъҳои ҳуҷайравӣ ва мӯякӣ зоҳир қардад. Атипизми бофтагӣ нисбатан барои омосҳои болиғ, хушсифат хос аст.

Атипизми ҳуҷайравӣ дар дараҷаи рушноӣю оптикӣ бо полиморфизми (бисёршаклагии) ҳуҷайраҳо, ядро ва ядрочаҳо, полиплоидия, тағйирёбии индекси ядроиву ситоплазмавӣ ба ғоидаи ядроҳо, пайдоиши митозҳои зиёдифода мешавад.

Дар номияҳои бадзот ҳалалдоршавии тафрика ҳам дар ситоплазма ва ҳам дар ядроии ҳуҷайра муайян карда мешавад. Ин тағйиротҳо ба дисплазия монандӣ доранд, вале дар ин ҷо нисбатан зоҳиршавандатор мебошанд. Онҳо полиморфизм (гуногуншаклии ҳуҷайраҳо), калоншавии андозаҳои ядро, зиёдшавии таносуби ядроиву ситоплазмавӣ, гиперхромияи ядроҳо, ҳалалёбии тақсимшавии хроматин дар ядро, вайроншавии сохтори гишои ядрой ва ғайраро дар бар мегиранд. Зоҳиршавандагии ин ихтилолҳои ситологӣ ба андозаи зиёдшавии дараҷаи бадсифатӣ зиёд мешавад.

Падидаи муҳими атипизми морфологӣ ҳуҷайраи омосӣ эътилоли речаи митозӣ мебошад. Муқаррар карда шудааст, ки дар ҳуҷайраҳои омос ҳосилшавии кейлонҳо ҳалалдор гардидааст, ки дар шароитҳои мӯътадил ғайлонокии митозии ҳуҷайраҳо танзим мекунад ва ҳамчун ингибатори тақсимои ҳуҷайравӣ амал мекунад.

Атипизми ултрасохторҳо, ки ҳангоми тадқиқот бо ёрии микроскопи электронӣ ошкор карда мешавад, бо зиёдшавии миқдори рибосомаҳо асосан озодона ҷойгиршуда, полисомаҳо, пайдоиши митохондрияҳои нуқсондор зоҳир мегардад.

Ихтилолҳо дар гишои сатҳӣ. Ба тағйиротҳои сатҳии (рӯякии) гишо дар ҳуҷайраҳои омосӣ дохил карда мешавад:

- ҳалалдоршавии ғайлонокии ферментҳои гишо (мембрана);
- камшавии миқдори гликопротеинҳо;
- ҳалалдоршавии нифозат, интиқоли гишоӣ вачунбаи барқи;
- вайроншавии микронайчаҳо ва микрофиламенҳои ситоскелет.

Атипизми мубодилаи моддаҳои (метаболии) бофтаи омосӣ дар миқдори зиёди кислотаҳои нуклеинӣ, хо-

лестерин, гликоген зоҳир мегардад. Дар бофтаи омосӣ равандҳои гликолитикӣ аз туршшавӣ бартарӣ доранд, силсилаи аэробии ферментӣ каманд, яъне ситохромоксидаза, каталаза. Гликолиз бо чамъшавии кислотаи оксипропионат дар бофтаҳо ҳамбастагӣ менамояд. Ин гуногунрангии мубодилаи омос монандии онро бо бофтаи ҷанинӣ зиёд менамояд, ки дар онҳо ҳамчунин падидаҳои гликолизи анаэробӣ бартарӣ доранд.

Маҳсулоти синтези ҳуҷайраҳои омосӣ: синтез ва тарашшӯҳи моддаҳо бо ҳуҷайраҳои омосӣ аз ду сабаб аҳамияти муҳим дорад:

- мавҷуд будани онҳо метавонад мавҷудияти номияхоро дар организм нишон диҳад, яъне онҳо нақши нишонаҳои (маркерҳои) омосро мебозанд;

- онҳо метавонанд боиси пайдошавии падидаҳои клиникӣ (синдромҳои парнеопластикӣ) гарданд, ки бо таъсири бевоситаи омос ба бофта алоқаманд нестанд.

Антигенҳои онкофеталӣ - ин антигенҳое мебошанд, ки одатан танҳо дар давраи дохилибатнӣ серҳаракат мегарданд, вале метавонанд дар ҳуҷайраҳои неопластикӣ мушоҳида карда шаванд.

Ферментҳо - баландшавии фаъолнокӣ дар зардоби маҳсули простатикии фосфотазаи турш ҳангоми саратони ғадуди олоти таносул, одатан баъди нуфузи ғилофаки ғадуд бо омос мушоҳида карда мешавад.

Иммуноглобулинҳо - дар номияҳо аз В-лимфоситҳо аксаран иммуноглобулинҳо синтез карда мешаванд. Азбаски ин номияҳо бисёрнасла мебошанд, пас танҳо як намуди иммуноглобулинҳо синтез карда мешавад.

Тарашшӯҳи аз ҳад зиёди гормонҳо - дар номияҳои боландтафриқа аз ҳуҷайраҳои узвҳои эндокринӣ аксаран синтези аз ҳад зиёди гормонҳо мушоҳида карда мешавад. Истеҳсоли зиёд на танҳо ба туфайли зиёдшавии миқдори ҳуҷайраҳо, балки аз сабаби ҳалалдоршавии механизмҳои

мӯътадили танзими синтез ба вучуд меояд.

Истеҳсоли эктопиии гормонҳо - синтези ҳормонҳо бо ҳучайраҳое, ки ҳангоми меъёр онҳо синтез карда намешаванд (ба истилоҳ истеҳсоли эктопиии ҳормонҳо) метавонад дар баъзе аз номияҳои бадзот мушоҳида карда шавад. Ин падида дар натиҷаи депрессияи генҳо, ки бо раванди неопалстикӣ алоқаманд аст, пайдо мешавад.

Атипизми антигенӣ. Тавсифи антигении омос ба ин ё он андоза се аломатро дар бар мегирад: аз даст додани баъзе аз антигенҳои барои бофтаи мӯътадили ибтидоӣ хос; пайдо шудани антигенҳои махсуси омосӣ; нигоҳ доштани баъзе аз антигенҳои бофтаи ибтидоӣ.

Атипизми функционалӣ. Як қатор омосҳо, махсусан болиғ, (тафрикашуда), метавонанд хусусиятҳои функционалии бофтаи ибтидоиро нигоҳ доранд. Ҳучайраҳои но болиғи (тафриканашудаи) омосӣ метавонанд қобиляти иҷро намудани функсияи бофтаи (узви) ибтидоиро аз даст диҳанд, ҳамзамон луобҳосилшавӣ гоҳо дар ҳучайраҳои якбора таҳаввулшудаи саратонӣ (масалан, меъда) ференцированные) нигоҳ дошта мешавад.

Мустақилияти нисбӣ.

Мустақилият - ин инкишофи мустақил, аз организм вобастанабудаи омос мебошад. Бо вучуди он ки омос аз даври умумии гардиши хун бо хун таъмин мешавад, СМА асабнок гашта, ба таъсири ҳормонҳо дучор мегардад, мустақилияти он аз бисёре аз омилҳое мушоҳида мешавад, ки ҳангоми меъёр ба равандҳои инкишоф таъсири танзимкунанда мерасонанд.

Вобастагии ҳормонии номияҳо: бисёре аз номияҳое, ки аз сабаби ҳормонҳо ба вучуд наомадаанд, бо вучуди ин вобастагии ҳормонии инкишофро доро мебошанд. Ҳучайраҳои чунин номияҳо, чи хеле ки тахмин карда мешавад, дар гишоҳо ретсепторҳо барои алоқамандкунӣ доранд: ҳангоме ки таъсири ҳормонҳо маҳдуд мегардад, инкишоф

аксаран «суст мегардад», вале қатъ намешавад. Ин хусусиятҳо барои муолиҷаи баъзе аз омосҳо истифода бурда мешаванд.

Беинтиҳои инкишоф. Хучайраҳои омосӣ «фанонопазир» мебошанд, онҳо барои беинтиҳо тақсим шудан қоиблият доранд (хучайраҳои мӯътадил танҳо 30 тақсимодро иҷро карда метавонанд - ҳадди Хайфлик). Инкишофи омос танҳо дар натиҷаи ҳалокати организм-ҳомили омос қатъ шуда метавонад.

Вайроншавии инкишофи хучайраҳо - яке аз аломатҳои асосии омос мебошад; вай барои муайян намудани хушсифатӣ ё бадсифатии номияҳо истифода бурда мешавад.

Нуфузи аз ҳад зиёди хучайраҳо: хучайраҳои неопластикӣ назар ба хучайраҳои мӯътадил хеле тезтар тақсим шуда метавонанд.

Суръати инкишоф ва бадсифатӣ - суръати нуфузи хучайраҳои неопластикӣ хеле тағйирёбанда мебошад. Баъзе аз номияҳо ба андозае сусти инкишоф меёбанд, ки инкишофи онҳо бо солҳо чен карда мешавад; номияҳои дигар ба андозае тез паҳн мешаванд, ки калоншавии андозаи онҳо метавонад дар муддати якчанд рӯз мушоҳида карда шавад. Маълум аст, ки дараҷаи бадсифатии номия аз суръати инкишоф вобастагӣ дорад: ҳар қадаре ки омос тезтар инкишоф ёбад, ҳамон қадар бадсифаттар аст.

Баҳодиҳии суръати инкишоф - ба таври клиникӣ суръати инкишофи номия метавонад бо вақте чен карда шавад, ки барои ду баробар калоншавии андозаи омосҳо зарур аст. Ин вақт метавонад аз якчанд рӯз ҳангоми лимфомаи Беркитт то якчанд моҳ барои аксарияти номияҳои бадсифати эпителиалӣ ва то якчанд сол барои баъзе аз номияҳои хушсифат тағйир ёбад. Аломати гистологии дағали суръати инкишоф индекси митозӣ мебошад, ки одатан ҳамчун миқдори тарҳҳои митозӣ барои 1000 хучайраи омосӣ дар қисмати нисбатан фаъоли номия муайян

карда мешавад. Одатан индекси митозӣ ҳар қадар ки баландтар бошад, суръати инкишофи номия ҳамон қадар зиёдтар аст. Вале қоидаи мазкур истисноҳои бешуморе дорад. Усулҳои нисбатан дақиқ ба муайян намудани антигенҳои даври ҳуҷайравии навъи сиклинҳо ва АЯҲН (антигени ядроӣ ҳуҷайраи нуфузкунанда) асоснок гардидаанд.

Ғайрмақсаднокӣ.

Инкишофи омосие, ки барои организм ҳеҷ гуна фоида намеоварад, балки баръакс ҳамаи силсилаҳои муҳофизатиро мутобикатии онро фуру менишонад, аз рӯи фаҳмиши назарияи Дарвин қомилан мувофиқи мақсад нест.

Таҳти мафҳуми рушди омос тағйироти бозгаштнопазири устувори сифатии як ё якчанд хусусияти омос фаҳмида мешавад. Мувофиқи назарияи рушди омосҳо хусусиятҳои алоҳидаи омосҳои бадсифат метавонад ҳеле тағйир ёфта, новобаста аз ҳамдигар пайдо шаванд, ки асоси рушди мустақили аломатҳои гуногуни омосро ташкил медиҳад. Мувофиқи назарияи рушд омосҳои хушсифат яке аз марҳилаҳои рушд мебошад, ки на ҳамеша дар шакли омоси бадсифат зоҳир мегардад. Аз ин сабаб номияҳои хушсифатро ба омосҳои дорои хатари баланд ва минималии бадфарҷомӣ (малигнизатсия) тақсим мекунанд. Мустақилияти инкишофи хусусиятҳои алоҳидаи омос пешбининашаванда будани рафтори онро муайян менамояд. Мисоли рушди омосҳо гузариши омоси хушсифат ба бадсифат (малигнизатсия), табдилёбии омос аз нофаъоли ҳормонӣ ба фаъоли ҳормонӣ, инкишофи метастазаҳо ва ғайра мебошад.

МЕТАСТАЗАҲО

Метастазақунӣ (решадавонӣ) - ҳосилшавии лонаҳои дуюмбораи инкишофи омос (метастазҳо) дар натиҷаи паҳншавии ҳуҷайраҳо аз лонаи аввалия ба дигар бофтаҳо

мебошади. Метастазаҳо танҳо аз номияҳои бадсифат пайдо мешаванд.

Метастазакуни (решадавоии) аз панҷ марҳила иборат аст:

- воридшавии ҳуҷайраҳои омосӣ ба ковокии рағи хунгард ё лимфагард;
- интиқоли ҳуҷайраҳои омосӣ тавасути ҷраёни бозгашти хун ё лимфа;
- бозистиҳои ҳуҷайраҳои омосӣ дар ҷойи нав;
- гузариши ҳуҷайраҳои омосӣ ба бофтаи наздирағҳо;
- инкишофи метастаза.

Намудҳои асосии метастазаҳо вобаста ба роҳҳои решадавоии инҳоянд:

- лимфогенӣ;
- гематогенӣ;
- имплантатсионӣ;
- омехта.

Метастазаҳои лимфогенӣ барои саратонҳо ва меланнома хосанд, вале гоҳо ба ин тариқа саркомаҳо низ решадавоии метавонанд, ки барои онҳо решадавоии гематогенӣ нисбатан хостар аст. Ҳуҷайраҳои бадсифат қад-қадиррағҳои лимфагард аввал ба лимфогенҳои минтақавӣ ворид мегарданд, ки паҳншавии онҳо дар натиҷаи таъсири ҷавоби масуни муваққатан боз дошта шуда метавонад, ҳангоми муолиҷа бо усули ҷарроҳӣ аз омос лимфогенҳои канорӣ низ бурида гирифта мешаванд, ки инкишофи метастазаҳои барвақтиро пешгирӣ менамояд.

Метастазаҳои гематогенӣ. Ба маҷрои хун афтидани ҳуҷайраҳои омосӣ, ҷи хеле ки тахмин карда мешавад, дар марҳилаи барвақтии инкишофи бисёре аз номияҳои бадсифат ба вуҷуд меояд. Аз тарафи ҳуҷайраҳои неопластикӣ ҳосил шудани омили омосии ангиогенез инкишофи мӯйрағҳои навро дар атрофи ҳуҷайраҳои омос барангезиш мебахад ва ба вакуляризатсияи (рагнокшавии) метастазаҳои

сабзанда мусоидат менамояд.

РешадавоӢ дар ковокиҳои бадан (тухмнокшавӣ). Ба ковокиҳои зардобии бадан воридшавии ҳучайраҳои бадсифат (масалан, плевра, сифок ё халтаи дил) ё сатҳи зеринкабутияти метавонад бо паҳншавии ҳучайраҳо дар ин ковокиҳо (метастазаҳои тавассути ковокидор) ҳамбастагӣ намояд. Барои тасдиқ намудани решадавоӢ тадқиқоти ситологии моеъ аз ин ковокиҳо барои мавҷудияти ҳучайраҳои ғаримуқаррарӣ истифод бурда мешавад.

Метастазаҳои пинакраванда - ҳучайраҳои омосие мебошанд, ки метавонанд дар тамоми организм паҳн гарданд, дар муддати солҳои зиёде нофаъол боқӣ монанд (ё лоақал хеле сусти инкишоф ёбанд). Барои вайрон намудани чунин метастазаҳо баъди гузарондани муолиҷаи асосии ҷарроҳии лонаи аввалия ҳатман даври табobati химиявӣ гузаронда мешавад.

Метастазаҳо нисбатан бештар дар ҷойи шабакаи якуми мӯйрагӣ мавзёе мегиранд, ки аз рағҳо ҳосил шуда, хунро аз ҷойи мавзёгирии аввалияи омос мебаранд. Баъзе аз навъҳои саратон ҷойҳои хоси решадавоӢ доранд, гарчанде механизми дақиқи он номаълум аст. Сабаби боздошташавии суддати (эмболи) омосӣ метавонад сирф механикӣ бошад-курси рағ метавонад аз курси ҳучайраи омосӣ хурдтар бошад, вале ҷои бозистии эмболи аввалия боз бо он муайян шуда метавонад, ки дар сатҳи рағҳои узвҳои гуногун даррақҳои махсусе вучуд доранд, ки метавонанд ҳучайраҳои қарини омосӣ бошанд.

Нисбатан бештар метастазаҳо дар лимфagиреҳҳо, чигар, шуш инкишоф меёбанд. Камтар - дар мушакҳои дил, мушакҳои скелет, пӯст, испурч, ғадуди зерин меъда. Ҷои фосилавино аз рӯи мавзёгирии метастазаҳо СМА, силсилаи устухон, гурдаҳо, ғадудҳои болои гурда ишғол мекунанд. Саратони ғадуди олоти таносул, шуш, ғадудҳои ширхосилкунанда, ғадуди сипаршаклу гурдаҳо нисбатан

бештар дар учтухон, саратони шуш бошад - дар ғадудҳои болои гурда реша медавонанд.

Хуруҷи омос - ин пайдоиш дар ҷойи пешина баъди бо роҳи чарроҳӣ бурида гирифтани муолиҷаи шуӣ мебошад. Омоси хуруҷкунанда аз ҳучайраҳои омосии боқимонда ё майдони бурида нагирифта нашудаи омоси инкишоф меёбад. Аз нуқтаи назари хуруҷкунӣ давраи нисбатан хатарнок - соли аввали пас аз бурида гирифтани омос мебошад, сипас басомади хуруҷкунӣ кам мешавад.

Инкишофи омос

Се намуди инкишофи омосро фарқ карда мешавад:

- экспансивӣ (тез паҳншаванда);
- инфилтративӣ (реша давонанда);
- аппозитсионӣ (чафсшуда).

Ҳангоми инкишофи тез паҳншаванда (экспансивӣ) омос рушд ётфа, бофтаҳои атрофро тела медиҳад. Бофтаҳои омосро ихотақунанда таназзул меёбанд, бо бофтаи пайвастанда иваз карда мешаванд ва омос гуё бо гилофак (гилофаки бардуруғ) пушонда мешавад. Инкишофи тез паҳншаванда одатан оҳиста-оҳиста ба амал меояд, баъди омосҳои хушсифати болиғ хос аст.

Ҳангоми инкишофи решадавонанда омосро ба бофтаҳои атроф ворид мегарданд ва онҳоро вайрон мекунанд. Сарҳади омос ҳангоми инкишофи решадавонанда равшан муайян карда намешавад. Инкишофи решадавонандаи омос одатан босуръат аст ва баъди омосҳои ноболиғ, бадсифат хос аст. Навҳосилшудаҳои бадсифат ба бофтаи муътадил роҳ меёбанд ва аз ҳучайраҳои навоҳилшуда шоҳаҳоро ташаккул медиҳанд, ки ба ҳар тараф реша медавонанд. Баъди воридшавии тавассуди гишои бунёдӣ ҳучайраҳои бадсифат метавонанд ба рағҳои лимфогард ва хунгузар реша давонанд, ки қадами аввалинест ба сӯи паҳншавии силсилавӣ. Ҳучайраҳои решадавонандаи навоҳилшуда тамоюли паҳншавиро бо роҳҳои муқоимати

нисбатан камтар доранд; дар ниҳояти кор вайроншавии бофта ба амал меояд.

Инкишофи чафшудаи (аппозитсионии) омос аз ҳисоби таҳвили навҳосилшудаи ҳучайраҳои мӯътадил ба омосӣ ба вучуд меояд, ки дар майдони омосҳо мушоҳида карда мешавад. Намунаи чунин инкишоф лифомоси девораи пеши шикам мебошад.

Нисбати ковокии узви дарунҳолӣ инкишофи дарунзод ва берунзоди омосҳо фарқ карда мешавад. Инкишофи дарунзод - ин инкишофи решадаванандаи омос ба қари девораи узв мебошад. Инкишофи берунзод - ин инкишофи зуд паҳншавандаи омос дар ковокии узв мебошад.

Намуди берунии омос.

Чор намуди асосии омос аз рӯи манзараи макроскопӣ фарқ карда мешавад:

- гирехшакл;
- моеъшакл;
- маддашакл;
- ангуштшакл.

Гирехи навҳосилшудаи чандири дорои сарҳадҳои равшан мебошад. Гирех метавонад шакли калаппушаки занбуруғро дар пояки васеъ, салиларо (омоси поядорро) дошта бошад. Сатҳи он суфта, доначадор ё пистонакӣ буда метавонад ва гулкарамро ба хотир меоварад.

Моеъшакл - ин навҳосилшудаи чандири дорои сарҳадҳои норавшан мебошад.

Маддашакл - намуди макроскопии омос дар шакли нуқсони бофта бо канорҳои навардшакл, қари доначадор ва инкишофи решадавананда мебошад.

Ангуштшакл - навҳосилшудаи дорои сарҳадҳои муайян буда, ковокӣ дорад.

Андозаҳои омос

Андозаи омосҳо аз якчанд миллиметр то даҳҳо сантиметр дарбар гирифта метавонад. Андозаи омос бо суръати инкишофи он, давомнокии мавҷудияташ, мавзегирӣ муайян карда мешавад. Аз рӯи андозаи омос дар бораи дараҷаи бадсифатии он ҳукм рондан мумкин нест, зеро омосҳои хеле хурд метавонанд бадсифат бошанд ва бори аввал дар клиника бо метастазаи (решадавонии) худ ошкор карда мешавад.

Бохунтаъминшавии омос - аз ҳисоби маҷрои хунгузари организм тавассути рағҳои дар ботфаҳои атроф мавҷудбуда ба амал меояд. Ғайр аз ин, бо таъсири моддаи табиаташ сафедагии ҳосилкунандаи омос - ангиогенин - номияҳои шабакаи мӯйрағҳои (капиллярҳои) танайи омос ба вучуд меоянд. рағҳои омос ҳамчунин бо ғайримуқаррарии будани худ тавсиф меёбанд. Нисбатан бештар онҳо аз рағҳои навъи синусоидии дорои девораи тунук ва ковокиаш васеъ иборат мебошанд; девораи рағҳои омосӣ аксаран аз як қабат ҳучайраҳои эндотелиалӣ иборат аст, ки бевосита дар бофтаи номия ҷойгиранд ё аз ҳучайраҳои ҳуди омос таркиб ёфтаанд (силсилаи кушодаи гардиши хун дар омос). Ҳамчунин номутаносиби зоҳиршавандаи тақисмоти рағҳо дар бофтаи омосӣ мушоҳида карда мешавад.

Хусусиятҳои қайдшудаи бо хун таъминшавии омосҳо ба ихтилоҳои ғизоӣ ва дар бофта инкишоф ёфтани навҳосилшудаҳои тағйиротҳои дуҷумбора дар шакли хуншорӣ, руқудӣ варидҳо, варам, тангшавии рағҳо, некрозҳо намунаҳои гуногуни дистрофия, илтиҳоб замина мегузорад.

Таснифоти омосҳо.

Аз рӯи ҷараёни клиникӣ ҳамаи омосҳо ба хушсифат ва бадсифат тақсим мешаванд. Омосҳои хушсифат - болиганд, онҳо ба таври экспансивӣ инкишоф меёбанд, бофтаҳои атрофро инфильтратсия намеkunанд ва ғилоафаки

гайрихақиқиро аз бофтаи фишурдашудаи мӯътадил ташаққул медиҳанд, дар онҳо атипизми бофтагӣ бартарӣ дорад, реша намедавонанд. Омосҳои бадсифат- но болиғанд, ба таври инфилтративӣ инкишоф меёбанд, атипизми хучайравӣ бартарӣ дошта, реша медавонанд.

Ба таври гистогенетикӣ бо муайян намудани мансубияти омос ба сарчашмаи муайяни бофтагӣ инкишоф асоснок гардидааст. Мувофиқи ин принцип омосҳои зерин фарқ карда мешаванд:

- бофтаи эпителиалӣ (рӯйпӯшкунанда);
- бофтаи пайвандӣ (пайвасткунанда);
- бофтаи мушакӣ;
- рағҳо;
- бофтаи меланинҳосилкунанда;
- силсилаи асаб ва пардаҳои мағзи сар;
- силсилаи хун;
- тератома.

Ба таври гистологӣ аз рӯи дараҷаи балоғат (тибқи таснифоти ТУТ). Асоси таснифотро принципи зоҳиршавандагии атипия ташкил медиҳад. Бофтаҳои болиғ бо бартарӣ доштани атипизми бофтагӣ, но болиғ бошад - бо хучайравӣ тавсиф меёбанд. -

Ба таври онконологӣ - тибқи таснифоти байналмиллалии бемориҳо.

Аз рӯи паҳншавии раванд. Силсилаи байналхалқии TNM, дар ин ҷо Т (tumor) - тавсифи омос, N (nodus) - мавҷуд будани метастазҳо дар лимфогиреҳо, М (metastasis) - мавҷуд будани метастазҳои алоҳида мебошад.

ОМОСҲОИ ЭПИТЕЛИАЛӢ

Папиллома ба таври макроскопӣ намуди гиреҳи дорои сатҳи пистонакро дорад, ки гулкарам, марҷони бо обсабзҳои баҳрӣ пушондашударо ба хотир меоварад. Ғизлати гиреҳ метавонад саҳт ё мулоим бошад. Дар папилло-

маҳои сахт пайкар нағз зоҳир шудааст, ки аз бофтаи сахти нахдори пайваस्तкунанда иборат аст. Ғайр аз ин, сахтии папиллома метавонад характери сохтори лаҳимаро муайян созад; масалан дар папилломаҳое, ки лаҳима сохтори эпителии паҳнхучайраи шохронандаро дорад, аз рӯи ғизлат ҳамеша сахт мебошанд. Дар папилломаҳои нарм аз рӯй ҳаҷм лаҳима бартарӣ дорад, пайкар аз бофтаи нахдори ковоки пайваस्तкунанда бо рағҳои зиёди деворатунук ҳосил шудааст. Андозаи омосҳои болои сатҳи пӯст ё луобпарда аз якчанд миллиметр то якчанд сантиметр тағйир меёбад.

Ба таври микроскопӣ омос аз пистонакҳои зиёд иборат аст, ки падидаи атипизми бофтагӣ мебошад. Принципи ташаккули пистонак чунин аст. Канори пистонак аз лаҳимае иборат аст, ки аз бофтаи рӯйпӯшкунандаи инкишофёбанда, аксаран бо миқдори зиёди қабатҳо шакл гирифтааст. Дар эпителия қутбнокии хучайраҳо, стратификасия, бутунияти гишои худӣ нигоҳ дошта мешавад. Ба ҳамин тариқ, атипизми хучайравӣ суғуст зоҳир шудааст. Пайкари омос дар марказ ҷойгир шудааст. Атипизми бофтагӣ бо инкишофи нобаробари эпителия ва пайкар ва ҳосилшавии барзиёди рағҳои ғайримуқаррарии хурди хунгард зоҳир мегардад.

Папилломаҳо дар пӯст, луобпардаҳо, ки бо эпителияҳои тағирёбанда ё шохроннашуда мавзёе мегиранд. Папилломаҳои ҳалқ ва масона аҳамияти бештари клиникӣ доранд.

Папилломаи ҳалқ. Аз рӯи сохти гистологӣ аксаран ин папилломаи паҳнхучайра мебошад. Ин номия дар кӯдакон, махсусан то яксола ва дар калонсолон, аксаран дар мардҳо дучор мегарданд.

Папилломаҳои кӯдакону ноболиғон ё папилломаҳои ҷавонона (ювенилӣ) аксаран зиёд мебошанд (папилломатози ҳалқ). Мавзёгирии нисбатан бештар - сеяки пеши

садопардаҳо мебошад. Гоҳо онҳо дар чинҳои даромадгоҳ ва луобпардаи ҳалқ мавзёи гирифта метавонанд.

Ба таври макроскопӣ намуди ҳосилаҳои озаҳдори сурхи бунафшро бо сатҳи хурддона дар пояки тунук доранд. Аксаран онҳо папилломаҳои нарм мебошанд.

Ба таври микроскопӣ лаҳимаи ин номияҳо нумуи пистонакии бисёрқабатаи паҳни шохроннашавандаро, гоҳо бо падидаҳои шохронии эпителия ҳосил менамоянд. Гоҳо лаҳима аз эпителияи респираторӣ иборат аст ва дар ин ҳолат пистонакҳо бо эпителияи мукаабшакл, призмашакл ва ҳатто бо эпителияи муякҷадори ларзон пушонда шудаанд. Пайкари пистонакҳо аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат буда, аз дохилаш рағҳои хунгарди зиёде мегузаранд. Онҳо ба осонӣ осеб мебинанд, хунрав мешаванд.

Ба таври клиникӣ папилломаҳои ҳалқ бо гирифтагии овоз то беовозӣ (афония) зоҳир мегарданд. Папилломаҳои пояҳои дароз дошта ҳангоми афтидан ба ковокии роғи овоз метавонанд боиси марги нобаҳангоми кӯдак аз асфиксия гарданд.

Муолича - бурида гирифтани омос бо усули чарроҳӣ. Баъди бурида гирифтани папилломаҳои ҳалқӣ кӯдакон аксаран хуруҷ мекунанд, ба паҳншавӣ дар тамоми луобпардаи ҳалқ майл доранд. Вале папилломаҳои бадсифати кӯдакон хеле кам мушоҳида мегарданд. Дар давраи балогати ҷинсӣ папилломаҳо гоҳо ба регрессияи худруста дучор мегарданд.

Папилломаҳои дар калонсолон пайдошаванда одатан алоҳида мебошанд. Ба таври макроскопӣ ва микроскопӣ аксаран онҳо характери папилломаҳои сахтро доранд. Лаҳимаи онҳо аз нумуи бофтаи пайвасткунандаи нахдори бо миқдори начандон зиёди рағҳо иборат аст.

Мавзёи гиригии папилломаи ҳалқӣ калонсолон ба мисли кӯдакон аст. Хусусияти фарқкунанда он аст, ки па-

пилломаи ҳалқи калонсолон суст инкишоф меёбанд, хуруҷҳо камтар ва дар мӯҳлати нисбатан дарозтари баъди бурида гирифтани рӯй медиҳанд. Папилломаҳои бадсифати калонсолон бештар мушоҳида мешаванд, тибқи маълумоти баъзе аз муаллифони то 20% ҳолатҳо, махсусан дар одамони тамокукаш мушоҳида карда шудааст.

Папилломаи пешобдон. Папилломаҳои масона аксаран дар мардони солхӯрда дучор мегарданд. Ин бо он алоқаманд аст, ки дар мардони ин синнусол назар ба занон рукуди пешоб бештар инкишоф меёбад, ки бо хусусияти сохти пешоброҳаи мардон, ба он фишор овардани ғадуди калоншудаи олотӣ таносул асоснок мегардад.

Папилломаҳо бештар дар қисмати секунҷаи Лето мавзӯ мегарданд, ки бо резишгоҳҳои ҳолибҳо ва найи пешоббарор маҳдуд шудааст.

Ба таври макроскопӣ - ин одатан омоси ягонаи эксофити дар пояк ё асоси васеъ бо сатҳи пистонакӣ, бахмалмонанд, ғизлати нарм, ранги сафеди бунафш мебошад. Хеле кам папилломатози мунташир дучор мегардад.

Ба таври микроскопӣ папилломаи пешобдон аз зоидаҳои (шоҳаҳои) бисёри тунуки пистонакии шохнроншаванда иборат аст. Пайкараш хеле хурд аст, вай аз бофтаи пайвасткунандаи наҳдори ковок бо фаровнии рағҳои тунукдевора, навъи мӯйрағӣ шакл гирифтааст. Пайкар бо якчанд қабат эпителияи тағирёбандаи пушонда шудааст. Атипизми ҳуҷайравӣ хеле суст зоҳир шудааст. Танҳо як қабати ҳуҷайраҳои бунгоҳӣ бо гиперхромияи ядроҳо ва мавҷуд будани митозҳои алоҳида фарқ мекунад. Дар қабатҳои боқимонда ядроҳои ҳуҷайраҳо равшан, хроматинаш маълум, бе митозҳо мебошад. Гишои асосӣ дар тамоми пахноияш бутун аст.

Муолиҷа - бурида гирифтани омос бо усули ҷарроҳӣ. Папилломаҳо аксаран дар натиҷаи васеъгии майдони омос ва имкониятҳои маҳдуди бурида гирифтани омос бо ёрии

ситоскоп хуруҷ менамоянд. Ба андозаи зиёд шудани микдори хуруҷҳо хатари бадсифатшавии папилломаҳои пешобдон низ зиёд мегардад.

Оризаҳо. Пистонакҳои дароз аз сабаби ҳаракати турбулентии пешоб метавонанд ҳам шаванд, тоб хӯранд. Тобхӯрии пистонак метавонад бо ихтилоли шади ди гардиши хун ва сактаи он ҳамбастагӣ намояд. Ҳангоми кандани пистонак вобаста аз майдони бофтаи омосии некрозшуда микро- ё макрогематурия мушоҳида карда мешавад. Папиллома нуму карда, аксаран худ сабаби вайроншавии чараёни бозгашти пешоб мегардад. Ҳамаи ин барои воридшавии сироят ва пайдо шудани чунин оризаҳое ба мисли ситит, уретропиелонефрит мусоидат менамояд. Пистонакҳои кандашуда метавонанд сабаби маҳкам шудани найи пешоббарор ва инкишофи анурии бардуруғ (козиб) гарданд.

Аденома - омоси болиғи хушсифат аз эпителияи гуддаи мебошад. Ба таври экспансивӣ инкишоф ёфта, ба таври микроскопӣ намуди гиреҳи нағз маҳдудшудаи ғизлаташ нарми чандир, сафеди бунафшрангро дорад. Гоҳо дар омос кистаҳо мушоҳида карда мешаванд, дар ин маврид оиди кисто- ё дистoadенома ҳукм ронда мешавад.

Аденомаҳо дар ҳамаи узвҳои гуддаи, инчунин луобпардаҳое дучор мегарданд, ки онҳо дар сатҳ дар шакли салила (полип) часта мебароянд. Онҳоро салилаҳои аденоматозӣ (гуддаи) низ меноманд. Аденомаҳои гадудҳои тарашшӯҳи дохилӣ метавонанд хусусиятҳои функционалии бофтаи ибтидоиро нигоҳ доранд ва ба микдори зиёд гормонҳои мувофиқро барангезиш диҳанд. Ин аденомаҳои фаъоли гормонӣ синдроми хоси клиникӣ доранд, ки барои дар клиника ташхис намудани ин номияҳо имконият медиҳанд.

Аденома сохтори узвӣ дорад, лаҳима аксаран аз ҳучайраҳои эпителияи призмашакл ё мукаабшакл иборат аст.

Эпителия маҷмуият ва қутбнокиро нигоҳ медорад, дар гишои асосӣ ҷойгир шудааст ва сохторҳои ғадудиро ташаккул медиҳад. Сохторҳои ғадудӣ бо бофтаи пайваستкунанда пушонда шудаанд, ки аз дохили он рағҳои хунгард мегузаранд.

Вобаста ба сохти гистологии ҷузъи эпителиалӣ вариантҳои зерини аденомаҳо фарқ карда мешаванд:

- алвеолярӣ (атсинарӣ), ки шӯъбаҳои интиҳории ғадудхоро нусхабардорӣ мекунанд;
- тубулярӣ, ки характери маҷроии сохторҳои эпителиалиро нигоҳ медоранд;
- трабекулярӣ, ки сохтори болорӣ доранд;
- устувор, ки дар он ковокии сохторҳои ғадудӣ вучуд надорад;
- кистозӣ ё эктазияи якбора зоҳиршавандаи ковокии ғадуд ва ҳосилшавии ковокиҳо (систoadенома).

Аз рӯйи таносуби лаҳима ва пайкар аденомаҳо ба гурӯҳҳои зерин тақсим карда мешаванд:

- аденомаи оддӣ (лаҳима нисбат ба пайкар бартарӣ дорад);
- фиброаденома (тақрибан таносуби баробари лаҳима ва пайкар);
- аденофиброма (бартарияти зоҳиршавандаи пайкар, аз рӯйи сохтор фибромаро ба хотир меоварад, вале ғадудҳои алоҳида дорад).

Аденомаи ғадуди ширҳосилкунанда

Аденомаҳои оддӣ, тубулярӣ дар ғадуди ширҳосилкунанда кам дучор мегарданд. Омоси аз ҳама бештар дучоршавандаи ғадудҳои ширҳосилкунанда фиброаденома мебошад.

Фиброаденома дар ҳар синну сол, вале бештар аз 20 то 50-солагӣ дучор мегардад. Ба таври макроскопӣ намуни гиреҳи дорои сарҳадҳои дақиқро дорад, яъне ба таври экспансивӣ инкишоф меёбад. Ғизлати он саҳт мебошад.

Аз рӯйи сохти гистологии худ он фиброаденомаи тубулярӣ мебошад. Дар фиброаденома атипизми бофтагӣ зоҳир шаванда аст: ғадудҳо ҳиссаҷаҳоро намесозанд, онҳо кутр ва шакли гуногун доранд. Пайкар аз бофтаи пайваस्तкунандаи нахдори зич бо миқдори начандон зиёди рағҳои хунгард иборат аст. Вобаста ба кутри маҷроғоҳои омосҷоро ҳосилкунанда, ки бо муносибати байниҳамдигарии чузъҳои эпителиалӣ ва бофтаи пайвасткунанда асоснок шудаанд, фиброаденомаи периканаликулярӣ ва интраканаликулярӣ фарқ карда мешаванд.

Фиброаденомаи периканаликулярӣ бо инкишофи консентрии бофтаи пайвасткунандаи атрофи ғишои асосӣ маҷроғоҳо тавсиф меёбад. Ковокии маҷроғоҳо танг, вале нигоҳ дошта шудааст.

Фиброаденомаи интраканаликулярӣ бо дарозшавии маҷроғоҳои ғадудӣ, дар ковокиҳои онҳо ҷаста баромадани дастаи торҳои коллагенӣ тавсиф меёбад, ки ба таври перпендикулярӣ нисбати ғишои асосӣ маҷроғоҳо ҷойгир шудаанд, ки дар натиҷа ковокии маҷроғоҳо роғмонанд мегардад.

Фиброаденомаи баргшакл (фиброаденомаи интраканаликулярӣ бо пайкари хуҷайравӣ) аксаран дар занҳои 40—50 сола дучор мегардад, мушоҳидаҳои алоҳидаи инкишофи ин омос дар мардҳо низ баён шудаанд. Омос андозаҳои калон (то 20 см ва зиёдтар) дошта метавонад. Тез инкишоф меёбад. Ба таври макроскопӣ уқда сохтори булакдори дорои расми хоси турмонанд дорад, ки сохти баргро ба хотир меоварад. Ковокиҳои роғмонанд, лонаҳои некрозӣ ва хунравӣ дида мешаванд.

Ба таври микроскопӣ шакли фиброаденомаи интраканаликулярӣ ё омехта гоҳо бо маҷроғоҳои ба таври киставӣ васеъшударо дорад, ки дар ковокии онҳо идҳолаҳои бофтаи пайвасткунанда салиламонанд мавҷуд буда, бо як ё якчанд қабати эпителияи мукаабшакл пушонда шудаанд.

Пайкари бисёрхучайравӣ бо полиморфизми зоҳиршаванда буда, тарҳҳои митоз, лонаҳои хунравӣ ва некроз дучор мегарданд.

Ҳамаи фиброаденомаҳо бояд ба таври ҷарроҳӣ бо тадқиқи ҳатмию ғаврии гистологии маводи буридашуда бурида гирифта шаванд. Ташҳиси қатъии гистологӣ ба табиби клиникавӣ барои муайян намудани ҳаҷми амалиёти ҷарроҳӣ ва усули минбаъдаи муолиҷа кӯмак мерасонад.

Систаденомаи тухмдон.

Дар байни омосҳои хушсифати эпителиалии тухмдон систаденомаҳо нисбатан бештар дучор мегарданд. Онҳо дар ҳар гуна синну сол дучор шуда метавонанд, вале нисбатан бештар дар синни аз 30 то 60-солагӣ мушоҳида карда мешаванд. Ба таври макроскопӣ онҳо шакли кистаро доранд.

Кистаҳои зеринро фарқ карда мешаванд:

- якхучайравӣ (якковока);
- бисёрхучайравӣ (бисёрковока).

Вобаста ба сохти пӯшиши дохилӣ кистаҳо ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешаванд:

- девораҳамвор;
- пистонакӣ ё папиллярӣ.

Пистонакҳои ҳақиқӣ ва бардуруғ фарқ карда мешаванд. Пистонакҳои ҳақиқӣ- ин барҷастагҳои эпителиалӣ мебошанд, ки пайкар доранд. Пистонакҳои бардуруғ- аз эпителияҳои нуфузкунанда иборат аст. Пистонакҳосилкунӣ - ин нишонаи шиддатнокии равандҳои нуфузкунанда дар эпителияи истаденома мебошанд. Он аломати номусоиди морфологӣ мебошад, ки дар бораи имконияти гандашавии омос шаҳодат медиҳанд.

Аз рӯи характери мӯҳтавӣ кистаҳо ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешаванд:

- серозӣ (зардобӣ);

· мутсинозӣ, ки лоуб (мутсин) ҳосил мекунад.

Пушиши эпителиалӣ дар баъзе аз систаденомаҳои папиллярӣ бо монандии зиёдаш бо эпителияи луобпардаи бачадон (эндометрия) фарқ мекунад ва ба ин тариқ ба тағйиротҳои гормонии дар организм рӯйдиханда воқуниш нишон медиҳад.

Аҳамияти систаденомаи тухмдон. Дар клиника як қатор оризаҳо имконпазиранд. Тобхӯрии киста бо инкишофи некрози девора, кафдиани он ва баромадани мӯхтавӣ ба ковокии шикам нисбатан хатарнок мебошанд. Ин тағйиротҳо метавонанд бо инкишофи садамаи дарднок, гоҳо марганҷомӣ ҳамбастагӣ карда метавонанд. Ҳангоми чараёни нисбатан муосид инкишофи илтиёмҳои байниҳалқавии рӯдаҳо имконият дорад, ки бо инкишофи бемории илтиёмӣ оризадор шуда метавонад. Кафидани киста бо хунравӣ ҳамбастагӣ карда метавонад. Фасодшавии киста имконият дорад.

ЛЕКСИЯИ 9

ОМОСҲОИ ҒАЙРИЭПИТЕЛИАЛӢ. ОМОСҲОИ МЕЗЕНХИМИАЛӢ ВА БОФТАИ МЕЛАНИНҲОСИЛКУНАНДА

Омосҳои болиғ, хушсифати фибробластӣ.

Фиброма - ин омоси болиғ аз бофтаи пайвасткунандаи нахдор мебошад. Аксаран дар байни пӯстпарда (эпидермис) ва устухон дар насчи чарбии зерпӯстӣ, дар пайҳо ва мушакпардаҳои дасту пойҳо, тана мавзёи мегирад. Дар узвҳои дохилӣ ин омос хеле кам дучор мегардад.

Ба таври макроскопӣ фиброма намуди гиреҳи дорои сарҳадҳои аниқ, вобаста аз сохти гистологӣ ғизлати саҳт ё нармро дошта, дар буриш ранги сафеди бунафш бо лифсории зохиршавандаро доро мебошад.

Ба таври микроскопӣ фиброма аз дастаи торҳои боф-

таи пайвасткунанда иборат аст, ки дарозӣ ва ғафсии гуногун дошта, дар самтҳои гуногун ҷойгир шудаанд.. Полиморфизми фибробластҳо суст зоҳир шуда, ядроҳо гиперхромӣ мебошанд.

Ба таври клиникӣ фиброма суст инкишоф меёбад, ба организм таъсири умумӣ намерасонад, агар дар узвҳои ҳаётан муҳим мавзё нагирад, пас ҷараёни он хушсифат мебошад. Эҳтимолияти гандашавӣ чандон калон нест. Фибромаҳои нарм гоҳо хуруҷ мекунанд.

Десмоид - номияи бофтаи пайвасткунанда мебошад, ки аз рӯи манзараи гистологии худ фибромаро ба хотир меоварад. Бо инкишофи инфилтративии ихуд фарқ мекунад. Атипизми бофтагӣ ва ҳуҷайравӣ суст зоҳир шудааст. Вобаста ба мавзёгирӣ фарқ карда мешавад:

- десмоиди абдоминалӣ (шикамӣ);
- десмоиди экстраабдоминалӣ (берунишикамӣ).

Десмоиди абдоминалӣ нисбатан хушсифат ҷараён ёфта, ба гандашавӣ майл надорад. Десмоиди экстраабдоминалӣ аксаран дар мардону занони ҷавон мушоҳида карда мешавад. Дар минтақаи апоневрозҳо ва мушакҳо дар дасту пойҳо, атрофи китф, сурунҳо мушоҳида карда мешавад. Бо вучуди мавҷуд набудани миқдори зиёди митозҳо, бо инкишофи тези агрессивии инфилтративии худ фарқ мекунад. Аксаран хуруҷ намуда, гоҳо бадсифат мешавад.

Омосҳои ноболиғ, бадсифати фибробластӣ.

Фибросаркома - омоси ноболиғ, бадсифати бофтаи пайвасткунандаи нахдор мебошад. Фибросаркомаҳо омосҳои нисбатан кам дучоршаванда мебошанд.

Ба таври макроскопӣ фибросаркома метавонад дар шакли гиреҳ ва ба шакли инфилтрат инкишоф ёбад.

Ба таври микроскопӣ вай аз ҳуҷайраҳои ноболиғи фибробластмонанд ва торҳои коллагенӣ иборат аст. Во-

баста аз дараҷаи катаплазияи ҳуҷайраҳо фибросаркомаҳои тафриқашуда ва тафриқанашуда фарқ карда мешаванд .

Фибросаркомаҳои тафриқашуда бо полиморфизми зохиршаванда ва гиперхромияи ядроҳо фарқ мекунанд. Барои фибромаҳои тафриқанашуда мономорфизм, дисхромия ва гиперхромияи ядроҳо, фаровонии митозҳои ғайримуқаррарӣ хос аст. Фибросаркомаҳо асосан бо роҳи гемотогенӣ дар шуш, баъзан-дар чигар, сипас ба таври лимфогенӣ дар лимфогиреҳҳои канорӣ реша медавонанд.

Омосҳои болиғ, хушсифат аз бофтаи чарбӣ.

Липома - яке аз омосҳои аз ҳама бештар дучоршавандаи бофтаҳои нарм мебошад.

Ба таври макроскопӣ липома аксаран намуди гиреҳи сохтораш ковокидор, ғизлати нарми чандир, ранги зард дошта, аз рӯйи намуди берунӣ бофтаи чарбиро ба хотир меоварад. Ҳангоми мавзёгирӣ байни мушакҳо метавонад норавшан маҳдуд гашта, инкишофи инфилтративиро барангезиш диҳад. Метавонад андозаҳои калон (зиёда аз 20 см), махсусан ҳангоми мавзёгирии ақибсифоқӣ дошта бошад.

Ба таври микроскопӣ омос одатан аз рӯйи навъи бофтаи муқаррарии чарбӣ сохта шудааст ва он бо андозаҳои гуногуни ҳиссаҳо ва ҳуҷайраҳои чарбӣ фарқ мекунад. Ҳангоми мавҷуд будани миқдори зиёди қабатҳои бофтаи пайвасткунанда саҳти торҳо дар бораи фибролипома ҳукм меронанд. Фаровонии рағҳои омосҳо дар баъзе мавридҳо оиди ангиолипомаҳо ҳукм рондан имконият медиҳад.

Ба таври клиникӣ дар аксарияти ҳолатҳо липома бо чараёни хушсифати худ фарқ мекунад.

Гибернома - омоси болиғи хушсифат аз чарби кабуд мебошад. Бештар дар занони ҳамаи синну сол дучор мегардад.

Гибернома аксаран дар гардан, камар, рон, девораи

шикам, дар миёнадевор, яъне дар ҷойҳое, ки ҳангоми ме-
ёър ва дар эмбриогенез ҷарби кабуд мавҷуд аст, мавзё
мегирад.

Ба таври макроскопӣ шакли гиреҳи сохтораш ҳисса-
дор, ранги кабудро дорад.

Ба таври микроскопӣ аз ҳуҷайраҳои бисёрғӯша ва
мудаввар иборат буда, ҳиссачаҳоро ташаккул медиҳад, ки
бо қабатҳои тунуки бофтаи пайвасткунанда маҳдуд шу-
даанд. Ядроҳои ҳуҷайраҳо дар марказ ҷойгир шуда, як яд-
роча доранд. Дар ситоплазмаи ҳуҷайраҳои ҷарбӣ, дон-
чаҳои хурди эозинофили ё кафқдор воমেҳуранд. Таркиби
химиявии ҷарб ҳатто дар як ҳуҷайра гуногун аст. Аксаран
холестерин ошкор карда мешавад.

Гибернома хуруҷ намекунад ва реша намедавнада.

Омосҳои ноболиғ, бадсифати аз бофтаи ҷарбӣ.

Липосаркома - омоси ноболиғӣ бадсифат аз бофтаи
пайвасткунанда. Аксаран онҳо дар бофтаҳои нарми рон,
соки по ва қисмати пасисифоқӣ пайдо мешаванд.

Ба таври макроскопӣ липосаркома шакли гиреҳ ё лун-
даро нисбати бофтаҳои атроф дорад. Ғизлаташ зич, сатҳи
буриш обдор, гуногунранг - бо лонаҳои луобнокшавӣ, хун-
равӣ ва некроз доранд.

Ба таври микроскопӣ якбора бо гуногуншаклии (по-
лиморфизми) бофтагӣ ва ҳуҷайравӣ зоҳир мегардад. Вай
аз липобластҳои балоғаташон гуногун иборат буда, ҳуҷай-
раҳои азимчуса бо ядроҳои аҷоиб дучор мешаванд. Дар
асоси бартарӣ доштани ин ё он шаклҳои ҳуҷайравии омос-
ро ташкилдиханда фарқ карда мешавад:

- липосаркомаи баландтафриқа;
- липосаркомаи полиморфӣ (пасттафриқа) .

Липосаркомаи полиморфӣ бо ҷараёни нисбатан бад-
сифат фарқ мекунад. Азбаски липосаркомаҳо аксаран зиёд
буда метавонанд, ҳамзамон ё пайдарҳам дар як ё чанд қис-

мати бадан инкишоф меёбанд, дар бораи басомади решада-
давоӣ ҳукм рондан хеле мушкил аст. Аксарияти вариан-
тҳои липосаркома суст ҷараён меёбанд ва хеле кам реша
медавононд.

Гиберномаи бадсифат - омоси ноболигӣ бадсифат аз
ҷарби кабуд мебошад. Мавзёгирии омос, ҷинс ва синни
бемор бо ҷунин нишондиҳандаҳои гибернома мувофи-
қанд.

Ба таври макроскопӣ гиберномаи бадсифат липосар-
комаро ба хотир меоварад. Ҳангоми дар зерӣ пӯст мавзё
гирифтани гоҳо захми мешавад.

Ба таври микроскопӣ полиморфизми якбора зоҳир-
шавандаи ҳуҷайраҳои мултилокулярӣ хос аст. Ҳуҷайраҳои
азимҷусаи як ё бисёрҷадроӣ бо ситоплазмаҳои гомогении
базофилий ва хурддона хеле зиёданд. Митозҳо каманд.

Ба таври клиникӣ ба хуруҷкунӣ майл дорад. Хеле кам
реша медавонад.

Омосҳои бофтаи зулоӣ (синовиалӣ).

Синовииомаҳо аксаран дар синни 30-40 солагӣ, беш-
тар дар мардҳо дучор мешавад .

Ба таври макроскопӣ шакли гиреҳи саҳти андозааш 5
см ва зиёдтар, дар буриш якҷинса , ранги сафеди бунафш
дорад. Дар қисмати буғуми дасту пойҳо мавзё мегирад.

Ба таври микроскопӣ омос гуногуншакл буда, дар он
роғу кистаҳои андозаашон гуногун дучор мешаванд, ки
бо ҳуҷайраҳои байзашакл, мукаабшакл, призмашакл пу-
шонда шудаанд, ки ҳуҷайраҳои эпителияи ғадудҳоро ба
хотир меоваранд.

Омосҳои бофтаи мезотелиалӣ.

Мезотелиома - омоси болиғи хушсифат буда, нисба-
тан кам дучор мегардад. Аз рӯйи манзараи гистологӣ вай
соҳти фибромаро дорад, ки аз унсурҳои ҳуҷайравӣ бой аст,
аз ин сабаб онро мезотелиомаи фиброзӣ меноманд.

Мезотелиомаи бадсифат - ин номияи хеле кам дучор-

шаванда аз ҳуҷайраҳои мезотелиалӣ, асосан дар ҷанб (плевра) инкишоф меёбад, вале ҳамчунин дар сифоқ ва перикард мушоҳида шуда метавонад.

Верификатсияи гистологии ҳам меотелиомаҳои ҳам болиғ ва ҳам ноболиғ хеле мушкул аст. Ташҳиси дақиқро бо ёрии типикунонии иммуногистохимиявӣ бо истифодаи антителиҳои бисёрнасла, инчунин усули кишти бофтаҳо гузоштан мумкин аст.

Омосҳои асабҳои канорӣ.

Невринома (шваннома, неврилеммома) - омоси болиғ, хушсифат бо пардаи шванновии асабҳо вобастагӣ дорад. Дар бофтаҳои нарм ба самти танай асабҳо, аксаран асаби шунавой, баъзан -дар узвҳои дохилӣ мавзё мегирад.

Нейрофиброма -омоси болиғи хушсифат аз унсурҳои эндопериневрия мебошад. Мавзёгирӣ, манзараи макроскопии он ба невринома монандӣ дорад.

Невриномаи бадсифат - омоси ноболиғи бадсифат мебошад. Ба таври макроскопӣ омос намуди як ё якчанд гирехҳои ғизалаташон нарми чандир (инкишофи мулти-марказӣ хос аст), ранги зардчаранги бунафши сафед бо қитъаҳои васеи хунравӣ, луобҳосилшавӣ, некроз, мавҷудияти ковокиҳои серкистаро дорад.

Ба таври микроскопӣ бо полиморфизми якбора зохиршаванда тавсиф меёбад. Ҳуҷайраҳо бо ядроҳои байзашакл ва барҷаста хосанд, ки бетартибона ҷойгир шудаанд ё симпластҳои бисёрядроӣ, ҳуҷайраҳои алоҳидаи ксантомӣ дучор мегарданд.

Омосҳои гирехи асаби симпатикӣ.

Ганглионеврома - омоси болиғи хушсифати дизонтогенетикӣ мебошад. Дар миёнадевори ақиб, дар стаҳи ретоперитонеалӣ, дар гардан, дар насҷи кос, дар таркиби гадудҳои болои гурда мавзё мегирад.

Ба таври макроскопӣ аз гирехи ҳиссадор, саҳт, аз бофтаҳои атроф нағз маҳдудшуда иборат аст.

Ба таври микроскопӣ ҳуҷайраҳои навъи ганглиозӣ хошанд, ки дар байни дастаҳои бофтаи пайвастандаи нахдори ковок ва торҳои асаб ҷойгиранд.

Нейробластома (симпатобластома, симпатогониома) -омоси ноболиғи бадсифат мебошад, ки аз ҳуҷайраҳои иборат мебошад, ки симпатогонияро ба хотир меоваранд. Бештар дар таркиби ғадуди болои гурда, дар миёнадевори ақиб мавзё мегирад.

Ба таври макроскопӣ намуди гирех, ҷо-ҷо бо инкишофи мунташир, ғизлати нарм, ранги зардҷатоб, бо қитъаҳои васеи некроз ва хунравиро дорад.

Ба таври микроскопӣ аз ду намуди ҳуҷайраҳои иборат аст. Аз рӯи бартарӣ доштани ҳуҷайраҳои симпатобластомаҳо ва симпатогониомаҳо фарқ карда мешавад.

Ду намунаи метастазҳо ҷудо карда мешавад - асосан дар ҷигар (метастазаҳои Пеппер) ва дар косахонаи ҷашм (метастазаҳои Гетчинсон).

Ганглионейробластома - мушабеҳи бадсифати ганглионеврома мебошад.

Дар лимфогирехҳои канорӣ реша медавонад. Метастазаҳои гематогениро дар шуш, ҷигар, устухонҳо дода метавонад.

Омосҳои бофтаи меланинҳосилкунанда.

Меланома (меланобластома, меланомаи бадсифат) -омоси ноболиғи бофтаи меланинҳосилкунанда мебошад. Мавзёгирӣ:

- пӯст;
- пардаи пигментии ҷашм;
- қабати мағзии ғадудҳои болои гурда;
- пардаҳои мағзи сар.

Бештар меланома дар пӯсти рӯй, дасту пойҳо ва тана мавзё мегирад.

Аз рӯи манзараи макроскопӣ ду шакли он ҷудо карда мешавад—меланомаи гирехӣ ва меланомаи ба таври рӯякӣ

пахншаванда.

Ба таври микроскопӣ полиморфизм якбора зоҳиршаванда аст, омос аз ҳуҷайраҳои дукшакл ё гуногуншакл, зишт иборат аст. Дар ситоплазмаи аксарияти ҳуҷайраҳо меланини зардчатоби кабуд ошкор карда мешавад. Баъзан меланомаҳои бепигментие дучор мешаванд, ки бо шиддатнокии баланди худ фарқ мекунанд. Митозҳо хеле зиёд мебошанд.

Меланома барвақт метастазаҳои гематогенӣ ва лимфогениро дар ҳамаи узвҳо медиҳад.

ЛЕКСИЯИ 10 **ОМОСҲОИ БОҒТАҲОИ ХУНОФАР ВА** **ЛИМФОИДӢ.**

Омосҳои рағҳои хунгард ва лимфатикӣ.

Гемангиома - омоси болиғ, хушсифат, бо рағҳои хунгард бой мебошад.

Гемангиомаи мӯйрагӣ - ин номияи ҳақиқӣ бо нуфузи ҳуҷайраҳои эндотелиалӣ ва ташаккули мӯйрағҳои ғайримуқаррарӣ мебошад. Бештар дар пӯст, дар луобпардаҳои роҳи меъдаву рӯда мавзё мегирад.

Ба таври макроскопӣ аз гиреҳи сурх ё кабудранг бо сатҳи ҳамвор ё дӯнгичадор иборат буда, дар буриш сохти ҳуҷайрадор дорад.

Ба таври микроскопӣ омос аз рағҳои шохароншудаи навъи мӯйрагии дорои ковокии танг иборат аст, ки на ҳамеша бо хун пур аст. Эндотелия варамида, гиперхромӣ мебошад.

Гемангиомаи кавернозӣ (серковок) - номияе мебошад, ки аз ковокиҳои аҷоиби навъи сунусоидҳои андозаашон гуногун иборат аст, ки байни ҳамдигар пайваст мешаванд. Бештар дар чигар, роҳи меъдаву рӯда, мағзи сар дучор мегардад.

Ба таври макроскопӣ гиреҳи аз бофтаҳои атроф нағз маҳдудшудаи аргувонии кабудранг иборат буда, дар буриш ранги исфанҷро ба хотир меоварад.

Ба таври микроскопӣ аз ковокиҳои тунукдеворе иборат аст, ки бо як қабат ҳуҷайраҳои эндотелиалӣ пушонда шудаанд ва аз хун пур мебошанд.

Ангиомаи шараёнӣ (хушамонанд, шохдор) - конгломерати рағҳои инкишофёфтаи навъи шараёнӣ мебошад ва дар байни онҳо қитъаҳое дучор мешаванд, ки гемангиомаи мӯйрагиро ба хотир меоваранд.

Гемангиомаи варидӣ -ба таври микроскопӣ асосан аз рағҳои навъи варидӣ иборат аст. Дар чуқурии бофтаҳои нарм, байни мушакҳо ҷойгир мешавад.

Гломусангиома (омоси Барре-Массон) - омоси болиғи хушсифати пайдоишаш рағӣ мебошад (гломуси миоартериалӣ).

Ба таври макроскопӣ ду намуди он фарқ карда мешавад:

- гломусангиомаи солитарӣ;
- зиёд паҳншуда (гломусангиомаи оилавӣ).

Аксаран дар шакли гиреҳи ягонаи қутраш 0,3-0,8 см,ғизлаташ нарм, хокистаранги бунафш дучор мешавад. Мавзёгирии дӯстдоштааш дар соид ва панҷаи по, асосан дар қисмати нохуни ангуштон мебошад.

Ба таври микроскопӣ аз рағҳои роғмонанди навъи синусоидӣ иборат мебошад, ки бо эндотелияҳо пушонда шуда, бо пурзаҷаҳои ҳуҷайраҳои эпителиодӣ ихота шудааст, ки ҳуҷайраҳои гломусиро ба хотир меоваранд.

Гемангиопериситома - омоси пайдоишаш рағӣ мебошад, ки дар он дар баробари ташаккули рағҳо нуфузи ҳуҷайраҳои наздирағӣ ба вуҷуд меояд.

Лимфангиома - омос аз рағҳои лимфагард мебошад. Асосан дар қисмати гардан, дар луобпардаи ковокии даҳон, сатҳи акибисифоқӣ, масориқа мавзё мегирад. Сох-

ти микроскопии он ба сохти гемангиома монандӣ дорад.

Гемангиоэндотелиома - ин омоси аз ҳама бадсифаттарин баррасӣ карда мешавад.

Аксаран дар пӯст, бофтаҳои нарми дасту пойҳо, тана, сар, баъзан- дар узвҳои дохилӣ мавзӯи мегирад.

Ба таври макроскопӣ гиреҳи кутраш то 10 см, сохташ ҳиссачадор, дар баъзе ҷойҳо бо инкишофи инфилтративӣ мебошад. Гиреҳҳо нарм, сероб, бунафш ё сурхранг бо лонаҳои некроз мебошанд.

Ба таври микроскопӣ омос аз рағҳои ғайримуқаррарӣ, бетартибона пайваस्तшуда иборат мебошад, ки бо якчанд қабати ҳуҷайраҳои ғайримуқаррарии эндотелиалӣ пушонда шудаанд. Полиморфизми ҳуҷайравӣ, гиперхромияи ядроҳо зохиршаванда аст.

Гемангиоэндотелиома ба таври васеъ асосан бо роҳи гематогенӣ дар шуш, устухон, чигар реша медавнада. Метастазаҳо дар лимфогиреҳҳои канорӣ мушоҳида шуда метавонанд.

Лимфангиоэндотелиома - аз рӯи сохт ба гемангиоэндотелиома монандӣ дорад. Аксаран дар заминаи лимфостази музмин ба вучуд меояд.

Омосҳои бофтаҳои ҳунофар ва лимфодӣ.

Лейкемия (лейкоз) - ин нуфузи силсилаи бофтаи ноболиғи омосӣ узвҳои ҳунофар бо паҳншавии гематогенӣ ба дигар увзу бофтаҳо мебошад.

Тасниф.

Аз рӯи ҷараёни клиникӣ:

- лейкозҳои (лейкемияҳои) шадид;
- лейкозҳои (лейкемияҳои) музмин.

Лейкози шадид бо оғози шадид (табларзаи баланд, падидаи захролудшавии вазнин) ва тез шиддат ёфтани беморӣ тавсиф меёбад. Шаклҳои нисбатан бештар дучоршавандаи лейкозҳои шадид лейкози (лейкемияи) шадиди

лимфобластӣ ва лейкози (лейкемияи) шадиди миелобластӣ мебошанд.

Лейкемияҳои шадид бо нуфузи бластҳо бе аломати тафриканокшавӣ тавсиф меёбанд. Дар хуни беморон камшавии миқдори дигар унсурҳои таркибии хун аз сабаби тангшавии ин шохаҳо бо ҳуҷайраҳои неопластикӣ мушоҳида карда мешавад. Дар натиҷа камхуни пайдо мешавад, ки одатан вазнин ва тез инкишофёбанда мебошад, бо паридарангии пӯст ва аломатҳои гипоксия зоҳир мегардад. Тромбоситопения боиси пайдоиши хунравии петехиявӣ (нуқта-нуқта) мегардад (диатези хунрез). Нейтропения дар шакли бемориҳои тез-тези сироятӣ ва захмшавӣ дар луобпардаҳо зоҳир мегардад. Якбора пастшавии масунӣ ва реактивияти умумии организм бо фаъолнокушавии сироят ва инкишофи илтиҳоби алтеративӣ ҳамсбатагӣ менамояд.

Дар беморони гирифтори лейкемияи промиелобластӣ ДВС-синдром инкишоф ёфта метавонад.

Дар чигар хангоми ҳамаи шаклҳои лейкози шадид нуфузи ҳуҷайраҳои бластӣ метавонад ҳам дар қисмати роҳҳои даромадгоҳӣ (порталӣ) ва ҳам дар самти мӯйраҳои синусидӣ мавзӯи гирад, ки бо деструксияи (созмоншикании) болорчаҳои чигар, тағйиротҳои дистрофии гепатоситҳо то ҳуди некрози лонавии онҳо ҳамбастагӣ менамояд.

Муолиҷаи беморон истифодаи доруҳои ситостатикӣ ва антибиотикҳоро пешбинӣ менамояд.

Сабабҳои фавт:

- хунравӣ;
- хунрезӣ дар майна;
- захролудшавӣ (интоксикация);
- ҳамроҳшавии сироятҳо (сепсис) ва ғайра .

Лейкемияҳои (лейкозҳои) музмин одатан бо огози тадриҷӣ, шиддатёбии суст тавсиф меёбад, ҳатто бе муо-

лица низ давомнокии ҳаёт 10-15 солро ташкил дода метавонад.

Фарқияти лейкозҳои музмин аз шадид:

- дар беморон камхунии умумии музмин инкишоф меёбад;
- дар натиҷаи тағйиротҳои дистрофӣ ва инфилтратсияи онҳо бо ҳучайраҳои омосӣ (инфилтартҳои лейкоемӣ) калоншавии узвҳои дохилӣ ба амал меояд;
- ҳангоми ҳамаи лейкомияҳои музмин калоншавии испурч, калоншавии мутамаркази лимфагиреҳҳо ба вучуд меояд.

Чигар ба андозаи зиёд ҳангоми лейкози миелоситарӣ назар ба лимфоситарӣ аз ҳисоби инфилтратҳои лейкоемӣ калонтар аст.

Лимфолейкозҳои музмин тавсиф меёбанд:

- хеле калоншавии андозаҳои ҳам узвҳои иммунокомпетентӣ ва ҳам лаҳимавӣ (паренхиматозӣ);
- набудани диатези хунрез;
- набудани некрозҳое, ки метавонанд дар давраи хуруҷи (кризи) бластҳо пайдо шаванд.

Лимфомаҳо.

Таснифи лимфомаҳо:

- лимфомаҳои ғайрихочкинӣ;
- лимфомаҳои Хочкин.

Фарқияти байни лимфомаҳо ва лейкомияҳо.

Лимфоситҳои омосӣ дар хун гардиш мекунанд ва аксаран онҳо дар бофтаҳои лимфоидии организм васеъ паҳн мешаванд. Агар эътилоли мағҳи устухон ва зиёдшавии миқдори лимфоситҳо дар хун бартарӣ дошта бошад, пас ин раванд лейкомия номида мешавад. Агар эътилоли бофтаҳои лимфоидӣ бартарӣ дошта бошад, пас ин равандро лимфома меноманд.

Лимфома ва лейкомия ба бемориҳои бисёрсабаба (полиэтиологӣ) дохил мешаванд.

Нуфузи омосии ҳуҷайраҳои лимфоидиро аз нуфузи мӯътадил фарқ кардан лозим аст, ки ҳангоми ҷавоби масунӣ (гиперплазияи реактивӣ) пайдо мешавад. Меъёрҳои нисбатан муҳим вайроншавии сохти лимфагиреҳ ва мавҷудияти бисёрнаслагии ҳуҷайраҳои омосӣ мебошанд.

Лимфомаҳои ғайриҳочкинӣ.

Номенклатура ва таснифи лимфомаҳои ғайриҳочкинӣ.

Ҳамаи лимфомаҳо ба се гурӯҳи калони пешгӯикунанда тақсим карда мешаванд:

- лимфомаҳои суст рушдкунанда;
- мӯътадил рушдкунанда;
- лимфомаҳои тез рушдкунанда.

Навъҳои лимфомаҳои ғайриҳочкинӣ:

- Лимфомаҳои В-ҳуҷайравӣ;
- Лимфомаҳои Т-ҳуҷайравӣ.

Лимфомаи Хочкин (лимфогранулематоз) - ин лимфомаи бадсифате мебошад, ки бо мавҷуд будани ҳуҷайраҳои Рид-Березовский-Штернберг дар бофтаи иллатёфта, ҷараёни музмин, хуручкунанда (гоҳо шадид) бо инкишофи бартаридоштаи бофтаи омосӣ дар лимфагиреҳҳо тавсиф меёбад.

Сабаби инкишофи бемории Хочкин номаълум аст.

Ба таври клиникӣ беморӣ дар марҳилаҳои барвақтӣ аломатҳои махсус надорад. Дар беморон сустӣ, тез мондашавӣ мушоҳида карда мешавад. Минбаъд дар заминаи субфебрилитет баландшавии ҳарорат (то 40°C) мушоҳида карда шуда, хориши саҳти пӯст, серарақии шабона ташвиш медиҳад. Камхунӣ инкишоф меёбад, дар хун эозинофилия мушоҳида карда шуда, СТЭ (суръати таҳшинии эротроситҳо) баланд аст.

Ду варианти бемории Хочкин фарқ карда мешавад: чӯдогона ё маҳдуд;

мутамакказ.

Ҳангоми шакли ҷудоғона аксаран лимфогиреҳҳои гардан, миёнадевор, насчи ақибисифоқӣ, гоҳо қадкашак иллатнок мешаванд.

Ҳангоми раванди мутамакказ, одатан, испурч иллатнок мешавад.

Ғузоштани ташҳиси лимфомаи Ҳочкин бо дарёфт намудани ҳуҷайраҳои классикии омосии бисёрҷадроғии Рид-Березовский-Штернберг ва ҳуҷайраҳои калони фаъолона тақисмшавандаи моноклеарӣ (нишонаҳои Ҳочкин номида шудаанд) асоснок карда мешавад.

Манзараи гистологӣ ҳангоми лимфомаи Ҳочкин нисбатан мураккаб ва махсус мебошад. Ба ғайр аз ҳуҷайраҳои омосӣ, онро ҳуҷайраҳои ғайриомосӣ низ ҳосил менамоянд:

- лимфоситҳо;
- плазмоситҳо;
- гистиоситҳо;
- эозинофилҳо;
- нейтрофилҳо;
- фибробластҳо.

Таносуби ҳуҷайраҳои Рид-Березовский-Штернберг (ва вариантҳои ҳуҷайраҳои моноклеарии Ҳочкин) лимфоситҳо, гистиоситҳо ва характери фиброз асоси тасниф намудани лимфомаи Ҳочкинро ба 4 зергурӯҳ ташкил мекунад:

- варианти бартарӣ доштани лимфоситҳо;
- склерози (тасаллуби) нодулярӣ;
- варианти омехтаи ҳуҷайравӣ;
- варианти лоғаршавии лимфоидӣ.

Беморон аз захролудӣ, камхунӣ, ҳамроҳшавии сироятҳои дуҷумбора ба ҳалокат мерасанд.

Бо вуҷуди тадқиқотҳои зиёд ва ҷамъшавии маълумотҳои сершумори иммунологӣ ташҳиси лимфомаи Ҳочкин

чун пештара ба тадқиқоти гистологӣ-ёфтани ҳуҷайраҳои классикии Рид-Березовский-Штернберг дар бофтаҳои иллатнок шартӣ зарурии гузоштани таъхис мебошад.

Интихоби табобат на танҳо аз сохти гистологӣ, балки аз марҳила ва дигар бузургҳои клиникӣ фобастагӣ дорад. Шаклҳои мавзёғирифтаи бемори Хочкин ё бо табобати нури рентгенӣ ё табобати химиявӣ муолиҷа карда мешаванд. Табобати маҷмӯии химиявӣ бо истифодаи якчанд доруҳо нисбатан самаранок мебошад, ки метавонад боиси шифоёбии беморони гирифтори марҳилаи паҳншудаи беморӣ гардад.

ЛЕКСИЯИ 11 БЕМОРИҲОИ ТАРБОДӢ. ТАРБОД. НУҚСОНҲОИ ДИЛ

1. *Муайянкунӣ*
2. *Этиология ва патогенез*
3. *Морфогенез*
4. *Эндокардит*
5. *Миокардит*
6. *Перикардит*
7. *Патаритрит*
8. *Нуқсонҳои дил*

Бемориҳои силсилаи бофтаи пайвасткунандаро то ҳозир бемориҳои тарбодӣ меноманд. Ҳангоми бемориҳои тарбодӣ тамоми силсилаи бофтаи пайвасткунандаю рағҳо аз сабаби ҳалалдоршавии гомеостази масунӣ (иммунологӣ) иллатнок мегардад. Ба гурӯҳи ин бемориҳо дохил мешаванд: тарбод, артрити тарбодмонанд, бемории Бехтерев, бодхӯрда, дерматоидӣ ва ғайра. Иллатнокшавии бофтаи пайвасткунанда ҳангоми бемориҳои тарбодӣ дар шакли номуташаккилии шиддатёбандаи силсилавӣ зоҳир

мегардад ва аз чор марҳила иборат аст: варамнокии мукоидӣ, тағйиротҳои фибриноидӣ, аксуламалҳои илтиҳобии ҳучайравӣ ва тасаллуб (склероз). Вале ҳар яке аз ин бемориҳо аз сабаби дар онҳо ё дигар узву бофтаҳо мавзъириашон хусусиятҳои клиникаию морфологии худро доранд. Ҷараёнаш музмину мавҷмонанд мебошад.

2

Этиологияи бемориҳои тарбодӣ ба таври пурра омӯхта нашудааст. Ба сироят, вирус, омилҳои генетикӣ, таъсири як қатор омилҳои ҷисмонӣ (сардшавӣ, инсолятсия) ва доруҳо (таҳаммулнопазирии доруҳо) диққати бештар дода мешавад.

Асоси патогенези бемориҳои тарбодиро аксуламалҳои иллатии масунӣ - аксуламали ҳассосияти баланди ҳам навъи фаврӣ ва ҳам оҳиста ташкил медиҳад.

Тарбод (бемории Сокольский-Вуйо) - бемории сироятӣю аллергия бо иллати бартаридоштаи дилу рағҳо, ҷараёни мавҷмонанд, давраҳои хуруҷ (ҳамлаҳо) ва ремиссия (беҳбудии муваққатӣ) мебошад.

Этиология. Дар пайдоишу инкишофи бемориҳо нақши стрептококки гемолитикии гурӯҳи А, инчунин тавасути стрептококк муҳассисшавии организм исбот карда шудааст.

Патогенез. Ҳангоми тарбод ҷавоби мураккаб ва ғуногуншакли масунӣ (аксуламали ҳассосияти баланди ҳам навъи фаврӣ ва ҳам оҳиста) ба антигенҳои стрептококк пайдо мешавад. Ба антителаҳое, ки ба таври ангуштшакл бо антигенҳои стрептококк ва антитгенҳои бофтаи дил, инчунин ба аксуламалҳои ҳучайравии масунӣ воқуниш нишон медиҳанд, аҳамияти асосӣ дода мншавад.

3

Морфогенез. Асоси сохти тарбодро номуташаккилии

силсилави шиддатёбандаи бофтаи пайвасткунанда, иллатёбии рағҳо, махсусан мачрои рағҳои хурдтарин ва равандҳои иллатии масунӣ ташкил медиҳанд. Ба дараҷаи нисбатан баландтар ин равандҳо дар бофтаи пайвасткунандаи дил (моддаи асосии эндокарди дарғотӣ ва назди деворӣ) ифода меёбанд, ки дар он ҳамаи марҳилаҳои номуташаккилии онро мушоҳида намудан мумкин аст: варамнокии мукоидӣ, тағйиротҳои фибриноидӣ, аксуламалҳои илтиҳобии ҳучайравӣ ва тасаллӯб (склероз).

Варамнокии мукоидӣ марҳилаи рӯякии бозгаштпазирӣ номуташаккилии бофтаи пайвасткунанда мебошад ва бо пурзӯршавии аксуламалҳои метохроматикӣ ба гликозаминогликанҳо (асосан кислотаи гиалурон) инчунин обиштагариӣ (гидрататсия) моддаи асосӣ тавсиф меёбад.

Тағйиротҳои фибриноидӣ (варамнок ва некроз) аз марҳилаи номуташаккилии амиқу бозгаштопазир иборат аст; ба варамии мукоидӣ зам гашта, онҳо бо ганогенизатсияи нахҳои коллагенӣ ва чаббидашавиашон бо сафедаҳои хуноба, аз ҷумла бо фибрин ҳамбастагӣ менамоянд.

Аксуламалҳои ҳучайравии илтиҳобӣ бо ҳосилшавии доначаомосҳои (грануломаҳои), махсуси тарбодӣ ифода мегардад, ки ташаккули он аз лаҳзаи тағйиротҳои фибриноидӣ оғоз меёбад ва сараввал бо лонаи осеби бофтаи пайвасткунанда ҷамъшавии макрофагҳо тавсиф меёбад, ки бо ядроҳои гиперхромӣ дар ҳучайраҳои калон интиқол меёбанд. Дар ситоплазмаи ҳучайраҳо зиёдшавии миқдори КРН ва доначаҳои гликоген ба амал меояд. Минбаъд доначаомосҳои (грануломаи) тарбодӣ бо ҷойгиршавии хоси ҳучайраҳо дар атрофи моддаҳои мутамарказ ҷойгиршудаи фибриноид ташаккул меёбад. Доначаомосҳои тарбодӣ, ки аз макрофагҳои калон иборатанд, «шукуфанда» ё болиғ номида мешаванд. Баъдан ҳучайраҳои доначаомосҳо пуч шудан мегиранд, дар байни онҳо фибробла-

стҳо пайдо шуда, моддаи фибриноидӣ камтар мешаванд - доначаомоси «пажмурдашаванда» шакл мегирад. Дар натиҷа фибробластҳо ҳуҷайраҳои доначаомосҳоро танг мекунанд, дар онҳо нахҳои аргирофиллӣ, сипас коллагенӣ пайдо мешаванд, фибриноид пурра ҷаббида мешавад; доначаомос характери хадшабанда мегирад. Даври инкишофи доначаомос -3-4 моҳ мебошад.

Дар ҳамаи марҳилаҳои инкишоф доначаомосҳои тарбодӣ бо лимфоситҳо ва ҳуҷайраҳои плазмавӣ ихота карда мешаванд. Раванди морфогенези гирехчаи тарбодӣ аз тарафи Ашоф (1904), баъдтар нисбатан муфассалтар аз тарафи В.Г. Талалаев (1921) баён шуда буд, аз ин сабаб гирехчаи тарбодӣ доначаомоси ашоф-талалаевӣ номида мешавад. Доначаомосҳои тарбодӣ дар бофтаи пайваستкунандаи эндокарди ҳам дарғотӣ ва ҳам наздидеворӣ, миокард, эпикард, рӯпардаи рағҳо ҳосил мешаванд. Ба ғайр аз доначаомосҳо ҳангоми тарбод акусуламалҳои ғайриҳоссаи ҳуҷайравӣ мушоҳида карда мешаванд, ки характери пахншаванда ё лонавӣ доранд. Ба акусуламалҳои ғайриҳоссаи бофтаҳо рағҳои хунгард дар силсилаи маҷрои макрогардишӣ дохил мешаванд. Тасаллуб (склероз) марҳилаи интиҳории номуташаккилии бофтаи пайвасткунанда мебошад. Вай характери силсилавӣ дорад, вале дар бофтаҳои дил: девораҳои рағҳо ва зардобпардаҳо нисбатан зохиршаванда аст.

Анатомияи эътилолӣ(патологӣ). Тағйиротҳои нисбатан хос ҳангоми тарбод дар дилу рағҳо инкишоф меёбанд.

4

Эндокардит - илтиҳоби эндокард - яке аз падидаҳои нисбатан равшани тарбод мебошад. Аз рӯи мавзегирӣ эндокардити дарғотӣ, дили ва наздидеворагӣ фарқ карда мешавад. Тағйиротҳои нисбатан зохиршаванда дар табақаҳои митралӣ ё парталӣ инкишоф меёбанд. Ҳангоми

эндокардити тарбодӣ тағйиротҳои дистрофикӣ ва некробиотикии эндотелия, варамидаи мукоидӣ, фибриноидӣ ва некрзи (мавтшавии) асоси пайвасткунандаи эндокард, гранулематоз (доначасорӣ) дар ғафсии эндокард ва суддахосилшавӣ дар сатҳи он мушоҳида карда мешавад. Ҳамбастагии ин равандҳо гуногун аст, ки барои чудо намудани чор намуди эндокардити тарбодии дарғотӣ имконият медиҳад (Абрикосов А.И., 1947):

- паҳнфта ё валвулит (илтиҳоби даричаи дил);
- шадиди серозӣ;
- фибропластикӣ;
- бозгаштпазир-серозӣ.

Эндокардити паҳнфта ё валвулит бо иллатёбии паҳнфтаи табақаҳои дарғотҳо, вале бе тағйирёбии эндотелия ва замшавии тромботикӣ ҳамбастагӣ менамояд. Эндокардити шадиди серозӣ бо ҳосилшавии эндотелия ва дар канори интиҳории табақаҳо ҳосилшавии замшавии тромботикӣ дар шакли озахҳо ҳамроҳӣ менамояд. Эндокардити фибропалстикӣ ҳамчун натиҷаи ду шакли пешинаи эндокардит бо тамоюли махсуси раванда ба фиброзу хадшабандӣ инкишоф меёбад.

Эндокардити бозгаштпазир-серозӣ бо номуташаққилии такрории бофтаи пайвасткунандаи дарғотҳо, тағйирёбии эндотелияи онҳо ва замшавии тромботикӣ дар заминаи тасаллӯб (склероз) ва ғафсшавии табақаҳо тавсиф меёбад. Дар фарҷоми эндокардит тасаллӯб ва талинози эндокард инкишоф меёбад, ки боиси ғафсшавии он ва шаклдигаркунии табақаҳои дарғот мешавад, яъне ба инкишофи нукдил оварда мерасонад.

5

Миокардит - илтиҳоби миокард, ки доимо ҳангоми тарбод иушоҳида карда мешавад. Се шакли он чудо карда мешавад:

- укдадори сермахсул (грануломатозӣ);
- пахнѐфтаи фосилавии экссудативӣ;
- лонавии фосилавии экссудативӣ.

Миокардити укдадори сермахсул дар бофтаи пайвасткунандаи наздирагии миокард ҳосилшавии доначаҳо тавсиф меёбад, ки танҳо ҳангоми тадқиқи микроскопӣ ба назар мерасанд - онҳо дар тамоми миокард паҳну парешон гардидаанд, бештар дар мушаки даҳлезакӣ чап, девораи ақибӣ меъдачаи чап. Доначаҳо дар марҳилаҳои гуногуни инкишоф қарор доранд. Дар фарҷоми миокардити укдавӣ тасаллуҷи наздирагӣ инкишоф меёбад, ки ба андозаи шиддатёбии тарбод метавонад боиси кардиосклероз гардад.

Миокардити пахнѐфтаи фосилавӣ бо омос, пурхунии интерсинсетсияи миокард ва инфилтратсияи зиёди он бо лимфоситҳо, гистиоситҳо, нейтрофилҳо ва эозинофилҳо тавсиф меёбад. Доначаҳо кам дучор мешаванд. Дил серковок шуда, хуфрачаҳои он васеъ мешаванд, қобилияти кашишхӯрии дил аз сабаби тағйиротҳои дистрофикӣ (ғизогирӣ) ҳалалдор мегардад, ки дар нтича таллофинопазирӣ метавонад боиси ҳалокати бемор гардад. Анҷоми натиҷаи муосид дар микоард кардиосклерози пахнѐфта инкишоф меёбад.

Миокардити лонавӣ бо инфилтратсияи лонавии миокард бо лимфоситҳо, нейтрофилҳо тавсиф меёбад. Доначаҳо кам дучор мешаванд.

6

Перикардит характери зардобӣ, зардобию фибринозӣ ё фибринозӣ дорад ва аксаран бо ҳосилшавии илтиёмҳо анҷом меёбад. Облитератсияи ковокиҳои пирохани дил ва оҳаксории дар он ҳосилшудаи бофтаи пайвасткунанда (дили зирехӣ) имконият дорад.

Рағҳои ковокиашон гуногун, махсусан маҷрои рағҳои хурди кутохтарин, доимо ба раванди эътилолӣ ҷалб ме-

шаванд. Васкулитҳои тарбодӣ пайдо мешаванд - дар шараёнҳо, шараёнчаҳо тағйиротҳои фибриноидии девораҳо, гоҳо суддат (тромбоз) сар мезанад. Дар фарҷоми васкулит тасаллуби рағҳо инкишоф меёбад.

7

Эътилоли рағҳо - патаритрит - яке аз падидаҳои доимии тарбод ба шумор меравад. Дар ковокии бугум тарашшӯхоти зардобию фибринозӣ пайдо мешавад. Зулолпарда (пардаи синовиалӣ) пурхун буда, дар марҳилаи шадид дар он варамнокии мукоидӣ, васкументҳо мушоҳида карда мешаванд. Тағояки бугумҳо тағир намеёбад, шаклдигаркунӣ одатан инкишоф намеёбад.

Оризаҳои тарбод аксаран бо эътилоли дил алоқамандӣ доранд. Дар фарҷоми эндокардит нуқсонҳои дил пайдо мешаванд.

8

Нуқсонҳои дил - тамоюлҳои устувори сохти дил мешаванд, ки вазифаи онро ҳалалдор менамоянд. Нуқсонҳои пайдошуда ва модарзодии дил фарқ карда мешаванд.

Нуқсонҳои пайдошуда бо эътилоли дастгоҳи дарғотии дил ва рағҳои хунгард тавсиф ёфта, дар натиҷаи бемориҳои дил баъди таваллуд пайдо мешаванд.

Анатомияи эътилолӣ. Шаклдигаркунии тасаллубии дастгоҳи дарғотӣ боиси норасоии дарғотҳо ё тангшавии (стенози) сӯроҳҳои даҳлезак ва меъдача ё латҳурии рағҳои хунгард мегардад.

Нуқсони дарғотӣ (митралӣ) аксаран ҳангоми тарбод пайдо мешавад. Тангшавии сӯроҳии дарғоти митралӣ аксаран дар дараҷаи ҳалқаи фиброзӣ инкишоф меёбад ва сӯроҳи намуди роғи тангро дорад. Ҳангоми тангшавӣ (сте-

ноз) чараёни хун дар доираи хурди гардиши хун мушкил мешавад, даҳлезакӣ чап васеъ гардида, девораи он ғафс мешавад, эндокард тасаллуб мешавад, сафедчаранг мегардад, девораҳои меъдачаи чап дар натиҷаи гипертензияи шуш ғафс мешавад, ковокии меъдача васеъ мешавад.

Ҳангоми нуқсони дарғотҳои аортивӣ дар натиҷаи тарбод тасаллуби девори нимдоира ва нуқсони аз сабаби худи ҳамон равандҳо инкишоф меёбад, ки нуқсони дарғотиро (митралиро) ташкил медиҳанд. Даричаҳо байни ҳамдигар сабзиш ёфта, ғафс мешаванд, дар даричаҳои ғафсшуда оҳақ чамъ мешавад, ки дар баъзе ҳолатҳо боиси бартарӣ доштани норасоии дарғотҳо, дар ҳолати дигар – боиси тангшавӣ (стеноз) мегардад. Дил дар ин маврид аз ҳисоби меъдачаи чап ба гипертрофия дучор мегардад.

Нуқсони пайдошуда таллофипазир ва таллофинопазир буда метавонад.

Таллофипазир - бе ихтилолҳои гардиши хун чараён ёфта, бо гипертрофияи шӯъбаҳои дил асоснок мегардад, ки аз сабаби нуқсон ба онҳо таҳмили бештаре меафтад. Вале гипертрофия ҳудудҳои ҳудро дорад ва дар марҳилаи муайяни инкишофаш дар миокард тағйиротҳои зинтрофикӣ ба амал меоянд.

Нуқсони таллофинопазир бо ихтилолҳои фаъолияти дил тавсиф меёбад, ки боиси норасоии дилу рағҳо мегардад. Дил серковок шуда, ковокиҳои он васеъ мегарданд, дар гӯшакчаҳои он суддатҳо (тромбҳо) ҳосил мешаванд. Дистрофияи сафедагӣ ва чарбии тори мушакҳо, дар пайкар-лонаҳои инфилтратсияи илтиҳобӣ ошкор карда мешаванд. Дар узвҳо рукуди вардӣ сар зада, кабудпӯстӣ, омосҳо, обварами ковокиҳо пайдо мешавад.

ЛЕКСИЯИ 12

ЭЪТИЛОЛИ ҲУЧАЙРАҲОИ ХУН ВА МАҒЗИ ХУН. КАМХУНӢ

1. КамхунӢ (анемия)
2. Анатомиаи эътилолӢ
3. Камхуниҳои гемолитикӢ

Бемориҳои силсилаи хун гуногунанд. Камхуниҳо, гемобластозҳо, тромбоситопения ва тромбоситопатия нисбатан инкишоф ёфтаанд.

1

Анемия ё камхунӢ - гурӯҳи бемориву ҳолатҳое мебошанд, ки бо камшавии миқдори умумии гемоглобин тавсиф меёбанд. Дар аксари ҳолатҳо бо пастшавии миқдори эритроцитҳо дар воҳиди муайяни ҳаҷми хун ҳамбастагӣ менамоянд.

Вобаста ба пайдоиш (этиология) ва патогенез камхуниҳои зерин фарқ карда мешаванд

- баъдихунрезӣ (постгеморрагӣ);
- дар натиҷаи ҳалалдоршавии хунҳосилшавӣ;
- дар натиҷаи вайроншавии зиёди хун (гемолитикӣ)

Камхуниҳои баъдихунрезӣ (постгеморрагӣ) чараёни шадид ё музмин дошта метавонанд. Чараёни шадид баъди ҳуравҳои фаровон аз рағҳои меъда ҳангоми решмараз, аз реши рӯдаҳо ҳангоми домана, ҳангоми кафидани найчаи бачадон ҳангоми ҳомиладорӣ хориҷибачадонӣ ва ғайра мушоҳида карда мешавад.

2

Анатомиаи эътилолӢ. Ҳучайраҳои мағзи сурхи устухон дар эпифизҳои устухонҳои найчашакл нуфуз мекунанд, мағзи сурхи устухон обдор ва равшан мешавад. Мағзи зарди устухонҳои найчашакл низ бо ҳучайраҳои катори эрит-

ропозӢ ва миелоидӢ ҳосил шудааст, ғайр аз ин дар испурч, лимфагиреҳҳо, ғадуди чоғар, пӯст лонаҳои хунофарии хориҷимағзиустухонӣ пайдо мешаванд. Камхунии музмин ҳангоми талафёбии сусту дурударози хун (ҳангоми хуншорӣ аз омоси таҷзияшавнадаи меъда, рағҳо, варидҳои хунрезӣ (геморроидии) рӯдаҳо, ковокиҳои бачадон, гемофилия ва ғайра) инкишоф меёбад.

Пӯст ва узвҳои дарунӣ паридаранг мебошанд. Дар мағзи сурхи устухони устухонҳои найчашакл падидаҳои таҷдид ва табдилёбии мағзи устухони зард ба сурх зоҳиршавандаанд. Аз сабаби талафёбии музмини хун ишемияи бофтаҳо, тағйиротҳо пайдо мешавад, ки инкишофи дистрофияи қарбӣ миокард, қигар, гурдаҳоро асоснок менамояд. Дар зардобпардаҳо ва луобпардахр, дар узвҳои дохилӣ хунравии нуктагӣ пайдо мешаванд.

Камхунӣ дар натиҷаи ҳалалдоршавии хунҳосилшавӣ ҳангоми норасоии оҳан, витамини В 12, кислотаи фолиевӣ, камхунииҳои гипо- ва апластикӣ пайдо мешавад.

Ҳангоми муоинаи беруна паридарангии пӯст, меъдаҳои сафедпардаи чашм мӯйян қарда мешавад. Дар пӯст ва луобпардаву зардобпардаҳо бошад хунравии нуктагӣ ба назар мерасанд. Узвҳои дарунӣ дар буриш ранги зангор доранд (гемосидероз). Дар меъдаву рӯдаҳо тағйиротҳои атрофикӣ (қоҳишёфта) ба назар мерасанд. Забон суфта, қилодор буда бо доғҳои сурх пушонда шудааст. Луобпардаи меъда тунук, суфта буда, аз қинҳо маҳрум аст. Ғадудҳо қамшуда, эпителияи онҳо қоҳишёфта мебошад, фоликулҳои лимфоидӣ низ қоҳишёфтаанд. Қигар қалон, саҳт, тобиши қабуди зангор дорад. Ғадуди зерӣ меъда саҳт, қоҳишёфта мебошад. Мағзи сурхи устухони устухонҳои паҳн сурхи сиёҳтобанд; дар устухонҳои найчашакл он намуди атоламонанд дорад.

Испурч қалон, мулоим, ғилофак қиндор, бунафши сурхранг бо тобиши зангор мебошад, ҳангоми тадқиқоти

гистологӣ - коҳишёбии фолликулҳо, дар лаҳми сурх – ло-наҳои хунофарии экстрамодулярӣ ва миқдори зиёди сиде-рофагҳо ба назар мерасад.

Камхуниҳои гипо- ва алатикӣ натиҷаи фурунишинии зиёди хунофарӣ, махсусан чузъҳои ҷаволни гемопоз мебошад.

Дар молишаки мағзи сурхи устухони сарсина шаклҳои хучайравии қатори эритро- ва микропозиро дарёфт на-мудан мумкин аст. Ҳангоми таъсири дуру дароз мағзи сурхи устухони фаъол ҳолӣ ва бо мағзи зарди устухон иваз карда мешавад. Хунравии зиёд дар зардобпардаву лу-обпардаҳо, дистрофияи қарбӣ миокард, чигар, гурдаҳо пайдо мешавад.

3

Камхунии гемолитикӣ - гурӯҳи бемориҳои хун, ки ҳангоми он равандҳои вайроншавии хун нисбат ба равандҳои хунҳосилшавӣ бартарӣ доранд. Гемолиз доҳилирагӣ ва берунирагӣ шуда метавонад. Аз сабаби гемолиз ҳангоми ин гуна камхуниҳо доимо гемосидериози умумӣ ва зард-парвини гурдаҳо дучор мегардад. Камхунии бо гемолизи доҳилирагӣ асоснокшуда ҳангоми сӯхтанҳои вазнин, ва-рача, сепсис, гузарондани хуни номувофиқ ба вучуд ме-ояд.

Камхунии бо гемолизи берунирагӣ асоснокшуда ха-рактери ирсӣ доранд. Таҷзияи эритроцитҳо дар микроуз-вҳои испурч, мағзи сурхи устухон, лимфогиреҳо ба вучуд меояд. Яъне барои ин гуна камхуниҳо камхунӣ, испурчка-лонӣ (спленомегалия), зардпарвин хос аст.

ЛЕКСИЯИ 13

ЭЪТИЛОЛИ ҲУЧАЙРАҲОИ ХУН ВА МАҒЗИ УСТУХОН. ЛЕЙКОЗҲО. ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ.

1. Сафедхунии (лейкози) шадид
2. Сафедхунии (лейкози) музмин
3. Лимфогранулематоз

1

Лейкозҳо (сафедхунӣ) - бемориҳои силсилаи омӯшӣ мебошанд.

Лейкозҳои шадид: тафриканашуда, миелобластӣ, лимфо-, плазмо-, монобластӣ, эритромиелобластӣ, мегакариобластӣ. Лейкозҳои музмин: пайдоишашон миелоситарӣ, музмини миелонидӣ; эритромиелози музмин, эритремия, полиситемия (синдроми Ванер-Ослер); пайдоишашон лимфоситарӣ, лимфолейкози музмин, лимфоматози пӯст (бемории Сезари), лейкозҳои парепротейнемӣ, бемории миелонидӣ, бемории занҷираҳои вазнин (бемории Франклин), макроглобулинемияи аввалия, пайдоишаш моноситарӣ, лейкози музмини моноситарӣ, гистоситозҳо.

Ташҳиси лейкози шадид ҳангоми дар мағзи сурхи устухон ошкор намудани ҳучайраҳои бластӣ гузошта мешавад. Лейкози шадиди тафриканашуда бо инфилтратсияи мағзи сурхи устухон, испурч, лимфагиреҳо, бодомакҳо, луобпардаҳо, девори рағҳо, гурдаҳо, миокард, мағзи сар, ҳучайраҳои гемопоэз иавсиф меёбад. Испурчу чигар каме калон мешаванд, мағзи устухон сурх, обдор бо тобиши хокистаранг мебошад. Инфилтратсияи лейкоемӣ бо синдроми хунрез (геморрагӣ) ҳамбастагӣ менамояд.

Лейкози шадиди миелобластӣ бо инфилтратсияи мағзи устухон, испурч, чигар, гурдаҳо, ҳучайраҳои омӯшии навъи миелобластҳо тавсиф меёбад, ки хусусиятҳои худро доранд: гликоген доранд, ба сероксидаза аксуламали мусбӣ

медиханд. Мағзи устухон сурх ё хокистаранг бо тобиши сабзранг мебошад.

Ҳангоми лейкози шадидии промиелоситарӣ бо полиморфизми ядроиву ҳучайравӣ, дар ситоплазма мавҷуд будани псевдоподҳо (почаҳои қалбакӣ) ва доначаҳои гликозаминогликогенҳо тавсиф меёбад. Лейкози шадиди плазмобластӣ аз ҳучайраҳои моқабли В-лимфоситҳо, ки ба ҳосил намудани иммуноглобулинҳо қобилият доранд, ҳосил мегардад.

Ҳангоми эритромиелози шадиди Гулелимо дар мағзи устухон инкишофи эритроситҳо ва дигар ҳучайраҳои ядродори эритропоэз, миелобластҳо, монобластҳо ва бластҳои тафриқанашуда ба вуҷуд меояд. Ҳангоми лейкози шадиди мегакариобластӣ дар хун ва мағзи устухон дар баробари бластҳои тафриқанашуда мегакариобластҳо, чамъшавии тромбоцитҳо мавҷуд аст.

2

Лейкози шадиди пайдоишаш миклоситарӣ: миелози музмин бо тағйиротҳои мағзи устухон (промиелоситҳо ва миелоситҳо, ҳучайраҳои бластӣ, падидаи пикноза ва кое-риозид); хун (хуни хокистаранги сурх, узвҳо камхун мебошанд), испурч (калон аст, гоҳо генорарнитҳои ишемӣ мушоҳида шуда, фолликулҳо коҳишёфта мебошанд); чигар (калон аст, дар буриш хокистаранги қаҳваранг, гепотоситҳо дар ҳолати дистрофияи чарбӣ қарор доранд); лимфогиреҳҳо (калон, мулоим, хокистаранги сурх мебошанд) тавсиф меёбад.

Ҳангоми эритремия ҳамаи узвҳо пурхун, испурч калон мебошад, миокард ғафс мешавад, дар чигар, испурч, мағзи устухон лонаҳои хунофарии эксибрамодулярӣ бо миқдори зиёди мегакардиоситҳо, дар марҳилаи баъдтар - дигаргуниҳои инфилтратсияи (иртишоҳи) лейкозӣ ба назар мерасанд.

Лимфолейкози музмин аз В-лимфоситҳо инкишоф меёбад. Микдори лейкоцитҳо дар хун якбора зиёд мегардад, дар байни онҳо лимфоситҳо бартарият пайдо мекунаанд. Дар мағзи устухони устухонҳо дар байни мағзи устухони сурх қитъаҳои зардранг дучор мешаванд; ҳангоми тадқиқоти гистологӣ - лонаҳои нумӯи ҳуҷайраҳои омосӣ; лимфагиреҳҳо калонанд, дар буриш обдор, сафеди бунафшранг мебошанд; испурч калон, дар буриш сурхранг аст, филликулҳо нигоҳ дошта шудаанд ё дар лаҳм гум мешаванд, чигару гурдаҳо калон, сахтанд.

Лимфоматози пӯст ё бемории Сезари, бо инфилтратсияи пӯсти бо Т-лимфоситҳо омосдор тавсиф ёфта, баъди мағзи устухон дар хун микдори лейкоцитҳо зиёд мешавад, ҳуҷайраҳои Сезари пайдо мешаванд, лимфагиреҳҳои канорӣ, испурч калон мешаванд. Хусусияти асосии лейкозҳои парапротеинемӣ қобилияти иммуноглобулинҳои якҷинса ё ҳиссаҳои онҳо - парапротеинҳоро синтез кардан мебошад. Ба чунин лейкозҳо бемории миеломӣ дохил мешавад, ки бо инкишофи ҳуҷайраҳои омосии катори лимфоплазмоситарӣ - ҳуҷайраҳои миеломӣ дар мағзи устухон ва хориҷи он тавсиф меёбад, ки боиси вайроншавии устухонҳо мегардад.

Лейкозҳои музмини пайдоишашон моноситарӣ. Лейкози музмини моноситарӣ чараёни дурударози хушсифат бе ҳалалдоршавии ҳунофарии мағзи устухон дошта, ин лейкоз бо бӯҳрони бластӣ анҷом меёбад.

Гислосинтозҳо - бемориҳои сарҳадии лимфопролиферативии бофтаи ҳунофар мебошад.

3

Лимфогранулематоз (бемори Ходчкин) - бемории музмини хуруҷкунанда мебошад, ки ҳангоми он омосҳо асосан дар лимфагиреҳҳо нумӯ мекунаанд.

Ҳангоми лимфогранулематози алоҳида (ЛГА) як гур-

ӯҳи лимфагиреҳҳо иллатнок мешавад - сараввал онҳо нарм, обдор, хокистаранг ё хокистаранги бунафш, баъдан гиреҳҳо сахт, хушк бо қитъаҳои мавтшавӣ (некроз) ва тасаллуб (склероз) мебошанд.

Ҳангоми ЛГА-и мутамарказ нумуи бофтаи омосӣ на фақат дар лонаи мавзёғирии аввалия, балки хеле дуртари сарҳади он ошкор карда мешавад. Испурч калон шуда, лаҳми он дар буриш сурхи дорои лонаҳои мавтшавӣ (некроз) ва тасаллуб (склероз) мебошад («испурчи порфиринӣ»).

Ҳангоми тадқиқоти микроскопии лонаҳои омос ва галберҳои метастазӣ - нумӯи лимфоситҳо, гистоглобулинҳо, ҳуҷайраҳои ретикулярӣ ба назар расида, ҳамчунин нумӯи ҳуҷайраҳои ғайримукаррарӣ (ҳуҷайраҳои хурди Ходкин -ба лимфобластҳо монанд, ҳуҷайраҳои якядроии бузурги Ходткин, ҳуҷайраҳои бисёрадроии Рид-Безовский-Шитернберг) хос аст.

ЛЕКСИЯИ 14 БЕМОРИҲОИ УЗВҲОИ ҲОЗИМА. ГАСТРИТ.

1. *Гастрити шадид (илтиҳоби шадиди меъда)*
2. *Гастрити музмин (илтиҳоби музмини меъда)*

Бемориҳои узвҳои ҳозима бо гуногунрангии худ фарқ мекунанд. Як гурӯҳи онҳо бемориҳои аввалияи мустақил буда, гурӯҳи дигар дуюмбора ҳангоми бемориҳои гуногун пайдоишашон сироятӣ ва ғайрисироятӣ инкишоф меёбанд. Нисбатан бештар бемориҳои меъдаву рӯдаҳо дучор мегарданд

1

Гастрит - бемории илтиҳобии луобпардаи меъда мебошад. Гастритҳои шадид ва музмин фарқ карда меша-

ванд. Илтиҳоби луобпарда метавонад тамоми меъда (гастрити паҳнѐфта) ӛ қисмҳои алоҳидаи онро (гастрити лонавӣ) фаро гирад.

Ба таври морфологӣ ҳангоми гастрити муқаррарӣ (катаралӣ) луобпардаи меъда саҳт, омоснок, варамида мебошад, сатҳи он бо моддаи фаровони луобӣ пушонда шудааст, хунравии зиёди хурд-хурд дида мешаванд, ба таври микроскопӣ дистрофия (носозкории тағзия), некробиоз, шахшулшавии эпителия ошкор карда мешавад, ки боиси эрозия мегардад.

Ҳангоми гастрити фибринозӣ дар сатҳи луобпардаҳои саҳтшуда пардаи фибринозии хокситаранг ӛ зарди қаҳваранг ҳосил мешаванд. Амиқии мавтшавии (некрози) луобпарда дар ин маврид гуногун аст, аз ин сабаб вариантҳои хунравӣ (некрози сатҳӣ) ва лифтеритикии (некрози амиқ) гастрити фибринозиро ҷудо мекунанд.

Ҳангоми гастрити римнок ӛ флегмонозӣ девораи меъда якбора ғафс шуда, чинҳои луобпарда дағал, хуншор, бо чамъшавии фибринози римнок мебошанд. Аз сатҳи буриш моеъи римноки зарди сабзранг мешорад .

Гастрити некрозӣ одатан ҳангоми ба меъда афтидани моддаҳои химиявӣ, моддаҳои химиявии дар меъда ҷабанда ба амал меояд, ки луобпардаро месӯзонанд ва вайрон мекунанд (гастрити хӯранда). Некроз метавонад қисмҳои боло ӛ амиқ луобпардаро фаро гирифта лахтабанданда ӛ обшаванда мекунад. Тағйироти некрозӣ одатан бо ҳосилшавии эрозияву решҳои шадид анҷом меѐбанд, ки метавонад боиси инкишофи флегмона ӛ сурохшавии меъда гардад.

Оқибати гастрити музмин гуногун аст. Гастрити катаралӣ метавонад бо пурра барқароршавии луобпарда анҷом ѐбад. Баъди тағйироти зиёди дострезитивӣ (ҳангоми гастритҳои флегмонозӣ ва некрозӣ) коҳишѐбии луобпарда ва шаклдигаркунии тасаллубии девори меъда

инкишоф меёбад. Ҳангоми хуруҷҳои тез-тез гастрити катаралӣ метавонад боиси музмин гардад.

2

Гастрити музмин бо тағйиротҳои дуру дароз вучуддоштаи бадғизоии (дистрофии) эпителияи луобпарда тавсиф меёбад, ки дар натиҷа вайроншавии таҷдид ва азнавсозии сохтори он ба вучуд меояд, ки бо коҳишбӣ (атрофия) ва тасаллуби (склерози) он анҷом меёбад.

Гастрити музмини сатҳӣ бо тағйиротҳои бадғизоии (дистрофии) эпителияи сатҳӣ тавсиф меёбад. Дар баъзе аз қисмҳои эпителия ғафс шуда, ба шакли мукаабшакл наздик мешавад ва бо тарашиҳои пастшуда фарқ мекунад, дар қисмҳои дигар бошад -эпителия баланди призмашакл ва тарашиҳаш зиёд мебошад Қабати асосии (лавҳачаи) луобпарда варамида, бо лимфоситҳо, нейтрофилҳои алоҳида ва ҳуҷайраҳои плазмавӣ иртишоҳ (инфилтратсия) шудааст.

Ҳангоми гастрити музмини ғозиявӣ сифати нав ва асосӣ - атрофияи луобпарда, ғадудҳои он пайдо мешавад, ки инкишофи тасаллубро муайян менамояд. Луобпарда тунук мешавад, миқдори ғадудҳо аз ҳисоби бофтаи пайвасткунанда афзоиш мекунад. Ҳамчунин азнавсозии эпителия ба вучуд омада, эпителияи сатҳӣ ва ғадуддор тағйир меёбад. Сатҳи луобпардаи меъда бо эпителиоситҳои хошиядор пушонда шудаанд, ҳуҷайраҳои қадаҳшакл ва ҳуҷайраҳои Панет пайдо шуда, ғадудҳо номаълум мешаванд, ғадудҳои псевдопилорӣ (козиби баввоби меъда) ҳосил мешаванд. Ба метаплазияи луобпарда дистазия ҳамроҳ мешавад.

Барои хуруҷи (шиддатёбии) гастрити музмин омоси пайкар, пурхунии рағҳо, инфилтратсияи ҳуҷайравӣ, дар инфилтрат мавҷуд будани лейкофилҳо хос аст ва эрозия пайдо мешавад. Ҳангоми беҳбудии муваққатӣ (ремиссия)

ин аломатҳо вучуд надоранд.

Аҳамияти гастрити музмин калон аст. Гастрити музмини таназзулбанда бо халалёбии рушди (дисплазияи) вазнини бемории қабоисаратонии меъда мебошад.

ЛЕКСИЯИ 15 БЕМОРИҲОИ УЗВҲОИ ҲОЗИМА. РЕШМАРАЗ.

1. Муайянкунӣ

2. Анатомиаи эътилолӣ

3. Реши шадиди меъда

4. Реши музмини меъда

1

Решмараз - бемории музмин, ба таври марҳилавӣ чараёнбанде мебошад, ки зухуроти асосии клиникӣ ва морфологии вай реши хуручкунандаи меъда ё рӯдаи дувоздаҳангушта мебошад.

Дар инкишофи решмараз омили ғайрисироятӣ (*Helicobacter pylori*), ҳамчунин омилҳои эмотсионалӣ, алиментарӣ, ирсӣю конституцсионалӣ аҳамият доранд.

Дар байни омилҳои бемориовари решмараз омилҳои умумӣ ва ҷузъӣ фарқ карда мешаванд. Омилҳои умумӣ аз халалдоршавии танзими асабӣ ва гормонии фаъолияти меъда ва рӯдаи дувоздаҳангушта, ҷузъӣ бошад - аз ихтилолҳои омили ҳуҷайравӣю ҳозимаӣ, тавораи луобӣ, таҳрика ва тағйиротҳои морфологии меъда ва рӯдаи дувоздаҳангушта иборатанд.

2

Анатомиаи эътилолӣ.

Мояи морфологии решмараз реши музмини хуручкунанда мебошад. Дар раванди ташаккул вай аз марҳилаҳои эрозия ва реши шадид мегузарад.

Эрозияҳо - нуқсонҳои луобпарда мебошанд, ки аз ла-
вҳачаи мушакии луобпарда берун намебароянд. Дар меъ-
да метавонанд эрозияҳои зиёде ба вуҷуд оянд, ки одатан
ба осонӣ рӯйпуш (таҷдид) мешаванд. Вале дар мавриди
инкишофи решмараз баъзе аз эрозияҳо сиҳат намешаванд;
на танҳо луобпарда, балки қабатҳои нисбатан чуқуртари
девори меъда дучори некроз (мавтшавӣ) мегарданд, ре-
шҳои шадиди ҳозимавӣ (пептикӣ) инкишоф меёбанд.

Ба андозаи тозашавӣ аз маводҳои некрозӣ қариб реш
ошкор карда мешавад, ки бо қабати мушакҳо, гоҳо зар-
добпарда ҳосил шудааст. Аксаран дар натиҷаи омехтаи
гемоглобин қариб он ранги хокистаранги тира ё сӣёх
дорад. Нуқсонҳои амиқи луобпарда гоҳо қифшакл мебо-
шанд, ҳамзамон асоси қиф ба луобпарда, қуллаи он бо-
шад – ба пӯшиши зардобӣ нигаронда шудааст.

3

Решҳои шадиди меъда одатан дар ҳамгашти хурд, дар
қисмҳои антралӣ (мансуби ковокиҳо) ва баромадгоҳи меъ-
да пайдо мешаванд. Ҳамгашти хурд «роҳрави ғизой» ме-
бошад ва аз ин сабаб ба осонӣ осеб мебинад, ғадудҳои
луобии он шираи нисбатан ғаъоли меъдаро чудо меку-
нанд, чинҳо шахшудаанд ва ҳангоми кашишхӯрии қабати
мушакҳо барои пушондани нуқсон қобилият надоранд.-
Бо ин хусусиятҳо дер сиҳатшавии реши шадиди чунин
мавзегирӣ ва гузариши он ба музмин алоқаманданд.

4

Решҳои музмини меъда одатан ягона мебошанд. Бай-
зашакл ё доирашакл буда, андозаашон аз якчанд милли-
метр то 5-6 см мебошад. Вай ба чуқуриҳои гуногуни дево-
ри меъда, то худ қабати зардобпарда ворид мегардад.
Қариб реш суфта, канорҳояш ба таври навардшакл бар-
дошта шудаанд, саҳт, обиланок мебошанд (реш пинаба-

ста). Канори реши ба сурхрӯда нигарондашуда серсурох мебошад ва луобпарда дар канори нуқсон овезон аст, ки ба баввоб, нишеб нигаронида шудааст, баъзан намуди суфачаро дорад, ки зинаҳои он аз қабатҳои девора ҳосил шудаанд. Чунин намуди канорҳо бо бечошавии қабатҳо ҳангоми перисталтикаи (кашишхурии) меъда шарҳ дода мешавад.

Ҳангоми тадқиқи микроскопии реши музмини меъда дар давраи беҳбудӣ (ремиссия) дар канорҳои реш бофтаи пайвасткунанда мушоҳида карда мешавад, луобпарда аз канорҳо ғафс, гиперплазияшуда мебошад. Дар қисмати қаъри реш қабати вайроншудаи мушакҳо ва бофтаи онро ивазкунандаи ҳадшавӣ намоён аст, қаъри реш метавонад бо қабати тунуки эпителия пушонда шавад. Дар бофтаи пайвасткунанда рағҳои зиёд бо девораҳои ғафсшуда мавҷуданд, ковокии баъзе аз рағҳо танг ё аз ҳисоби инкишофи хучайраҳо бо гематома маҳкам шудаанд.

Дар давраи хуруҷ дар қисмати қаъру канорҳои реш минтақаи васеи некрози фибринозӣ пайдо мешавад. Дар сатҳи моддаи некрозӣ рашҳои фиброзӣ-римӣ ё римӣ ҷойгир мешавад. Минтақаи некрозро бофтаи пайвасткунандаи доначадор бо миқдори зиёди рағҳои тунукдевора ва хучайраҳо маҳдуд менамояд. Чуқуртари бофтаи пайвасткунандаи доначадор бофтаи пайвасткунандаи дағалнах ҷойгир мешавад.

Оиди хуруҷи реш ҳамчунин тағйиротҳои фибриноидии девораи рағҳо, варамкунии мукоидӣ ва фибриноидии бофтаи пайвасткунанда дар қаъри реш шаҳодат медиҳанд. Аз сабаби ин тағйиротҳо андозаи реш калон мешавад. Дар ҳолатҳои, ки хуруҷ бо беҳбудӣ (ремиссия) иваз мешавад, тағйиротҳои илтиҳобӣ фуру менишинанд, дар минтақаи некроз бофтаи пайвасткунандаи доначадор мебарояд. Дар фарҷоми тағйиротҳои фибриноидии рағҳо ва эндотерит тасаллуби девораҳо ва маҳкамшавии равзанаи рағҳо ин-

кишоф меёбад.

Ба ҳамин тарик, хуручи решамараз ҳатто дар ҳолати оқибатҳои мусоид боиси пурзӯршавии тағйиротҳои ҳадшагӣ мегардад ва вайроншавии ғозияи (трофикаи) рағҳои онро амиқтар менамояд. Морфогенез ва анатомияи эътилолии реше музмини рӯдаи дувоздаҳангушта аз реше меёбад фарқ намекунад.

ЛЕКСИЯИ 16 БЕМОРИҲОИ УЗВҲОИ ҲОЗИМА. АППЕНДИСИТ (ИЛТИҲОБИ КӢРРӢДА).

1. Муайянкунӣ
2. Анатомияи эътилолӣ
3. Шаклҳои морфологии аппендисити шадид
4. Аппендисити музмин

1

Аппендисит - илтиҳоби шохҳои кирмшакли кӢррӢда бо синдроми ҳоси клиникӣ мебошад. Аппендисит аутосирояти энтерогенӣ (аз рӯда ҳосилшуда) мебошад. Флораи рӯдаҳои бемориовар гашта, қаламчамикробҳои рӯдаҳои энтерококк аҳамияти бештаре дорад.

2

Анатомияи эътилолӣ.

Ду шакли аппендисит фарқ карда мешавад: шадид ва музмин.

3

Аппендисити шадид. Шаклҳои зерини морфологии он чӯдо карда мешаванд:

- муқаррарӣ (оддӣ);
- рӯякӣ;
- деструктивӣ (флегмонозӣ, систолиематозӣ, флегмо-

нозӣ-римӣ, қаросонӣ)

Ин шаклҳо инъикоси морфологии марҳилаҳои илтиҳоби шадиди аппендисит буда, бо вайроншавӣ (деструксия) ва некроз анҷом меёбанд. Одатан онҳо 2-4 рӯз давом мекунанд. Тағйиротҳои барои аппендисити шадиди муқаррарӣ хос дар давоми соатҳои аввали оғози хуруҷ инкишоф меёбанд. Онҳо аз ҳалалдоршавии гардиши лимфаву хун дар шакли рукуди мӯйрағҳо ва варидчаҳо, омос, хунравихо иборатанд, ки барои кӯррӯда зохиршаванда мебошанд.

Соатҳои минбаъда дар заминаи тағйиротҳои носозкории гардиш дигаргуниҳои илтиҳоби рашхавии римӣ, луобҳо ба вучуд меоянд, ки самараи аввалия номида мешаванд. Дар қуллаи ҷунин дигаргунӣ, ки ба ковокии шоха нигаронда шудааст, нуксонҳои рӯякии эпителия ба назар мерасанд. Ин тағйиротҳои микроскопӣ аппендисити шадиди рӯякиро тавсиф медиҳанд, ки ҳангоми он шоха варамакарда, зардобпардаи он бошад - пурхун ва хира мешавад.

Тағйиротҳо ҳангоми аппендиситҳои муқаррарӣ ва рӯякӣ бозгаштпазир мебошанд, агар онҳо шиддат ёбанд, аппендисити шадиди деструктивӣ инкишоф меёбад. То охири шабонарӯзи аввал инфилтрати лейкоцитарӣ ба тамоми ғафсии девораи шоха паҳн мешавад - аппендисити флегмонозӣ инкишоф меёбад.

Андозаҳои шоха калон мешаванд, зардобпардаи он хира ва пурхун мебошад, дар сатҳи он чирки фибринозӣ пайдо мешавад, девора дар буриш ғафс аст, аз ковокӣ рим ҷудо мешавад. Масориқа варамида, пурхуншуда мебошад. Агар дар заминаи илтиҳоби паҳншудаи римии шоха римхонаҳои зиёди хурд-хурд (думмалҳо) пайдо шаванд, дар бораи аппендисити анолиематозӣ, агар ба флегмонозӣ ярашавии луоб ҳамроҳ шавад - дар бораи аппенлисти флегманозӣ-римӣ ҳукм меронанд.

Тағйиротҳои римию деструктивро аппендисити қаро-

сонӢ анҷом медиҳад. Шоха дар ин маврид ғафс буда, бо чирки сабзи хираранги фибринозӣ-римӣ пушонда шудааст. Девораи он ҳамчунин ғафс шуда, хокситаранги тира мебошад, аз ковокӣ рим чудо мешавад. Ҳангоми тадқиқоти микроскопӣ лонаҳои васеи некроз бо мавҷудияти бактерияҳо, хунравӣ, суддатҳо (тромбҳо) дар рағҳо ошкор карда мешаванд.

4

Аппендисити музмин баъди аппендисти дучоршудаи шадид инкишоф меёбад ва бо равандҳои тасаллубӣ ва коҳишёбанда тавсиф меёбад, ки дар заминаи онҳо тағйироти илтиҳобӣ-деструктивӣ пайдо шуда метавонанд, одатан илтиҳоб ва деструксия бо нумӯи бофтаи пайвасткунандаи дончадор дар девор ва ковокии шоха иваз мешавад. Бофтаи пайвасткунандаи дончадор сабзида, ба хадшагӣ табдил меёбад. Тасуллуби нодир ва коҳишёбии ҳамаи қабатҳои девора, маҳкамшавии ковокии шоха пайдо шуда, байни кӯррӯда ва бофтаҳои атроф илтиёмҳо пайдо мешаванд.

Гоҳо ҳангоми маҳкамшавии хадшагӣ дар ковокии шоха моеъи зардобӣ (серозӣ) ҷамъ мешавад, - обварами шоха инкишоф меёбад. Агар мӯҳтавии ҳуҷайраҳо тарашшӯҳи ғадудҳо - луоб бошад, пас ин дар бораи кистаи луобӣ (мукотселе) шаҳодат медиҳад.

ЛЕКСИЯИ 17 САРАТОНИ УЗВҲОИ ҲОЗИМА

1. *Саратони сурхрӯда*
2. *Саратони меъда*
3. *Таснифоти саратони меъда*
4. *Анатомияи эътилолии саратони меъда*
5. *Оризаҳои саратони меъда*

Бемориҳои роҳи меъдаву рӯда бо гуногунрангии худ фарқ мекунанд. Тағйиротҳо метавонанд табиати илтиҳобӣ, дистрофикӣ, гиперпластикӣ ва омосӣ дошта бошанд.

1

Саратони сурхрӯда аксаран дар сарҳади миёнаи хирной ва поёнии он ба вучуд меояд, ки ба дараҷаи бифуркатсияи хирной мувофиқ аст. Инкишофи саратони сурхрӯдаро барангезиши музмини луобҳои он (машрубот, тамокукашӣ, ғизои дағали гарм), тағйиротҳои хадшагӣ баъди сӯхтагӣ, сироятҳо, ихтилолҳои анатомӣ (дивертикула, этиологияи эпителия ва ғадудҳо) асоснок менамояд.

Анатомияи эътилолӣ. Шаклҳои зерини макроскопии саратони сурхрӯда фарқ карда мешаванд: ҳалқашакли саҳт, пистонакӣ ва ярашавӣ.

Саратони ҳалқашакли саҳт ҳосилаи омосӣ буда, ҳар яке аз онҳо девори сурхрӯдаро дар қитъаи муайян фаро мегирад. Ковокии сурхрӯда танг шудааст. Ҳангоми таҷзия ва ярашавии омос гузаронандагии сурхрӯда барқарор мешавад.

Саратони пистонакӣ ба мисли саратони замбуруғмонанди меъда мебошад. Вай ба осонӣ таҷзия мешавад ва дар натиҷа решҳое ҳосил мешаванд, ки ба узву бофтаҳои атроф ворид мешаванд.

Саратони ярашуда реши саратоние мебошад, ки байзашакл буда, ба самти сурхрӯда паҳн шудааст. Дар байни шаклҳои микроскопии саратони сурхрӯда бофтаҳо фарқ карда мешаванд. Дар байни шаклҳои микроскопии саратони сурхрӯда паруйономаи *in situ*, саратони ҳучайрапахн, аденокарсинома, ғадудию пардадор, ғадудию ҳучайрапахн, мукоэпидермалӣ ва тафриканашуда фарқ карда мешавад.

2

Саратони меъда Дар инкишофи саратони меъда нақши ҳолатҳои қаблисаратонӣ (бемориҳое, ки ҳангоми онҳо хатари инкишофи саратон баланд аст) ва тағйиротҳои қаблисаратонӣ хеле калон аст. Ба ҳолатҳои қаблисаратонӣ гастрити музмини коҳишёфта, камхунии баданҷом, реша-марази музмини меъда, аденомаҳо, ба тағйиротҳои қаблисаратонӣ бошад-метаплазияи рӯдаҳо, дисплазия дохил мешаванд. Дисплазияи эпителия гуфта қисматҳои бечошудаи қабати эпидемиалӣ номида мешаванд, ки бо ҳучайраҳои атипизмашон дар дараҷаи гуногун нуфуз мекунанд. Метаплазияи рӯдагии эпителияи луоби меъда ҳамчун яке аз омилҳои асосии хатари саратони меъда баррасӣ карда мешавад. Вобаста ба мавзёгии саратон дар ин ҷо он қисми меъда шаш намуди он фарқ карда мешавад: баввобӣ, хамидагии хурд, кардиалӣ, хамидагии калон, қарри узв (фундалий) ва умумӣ. Вобаста ба характери инкишоф шаклҳои клиникаию анатомии саратони меъда ҷудо карда мешаванд.

3

Таснифи саратони меъда

1. Саратон бо никишофи бартариётдоштаи энзофилии зуд паҳншаванда (экспансивӣ);
 - пӯлакчамонанд;
 - полинозӣ;
 - замбуруғшакл (фунтозӣ);
 - ярашуда;
 - саратони аввалия-реши;
 - табақчамонанд (саратон-реш);
 - саратон аз реши музмин (саратон-реш).
2. Саратон бо никишофи бартариётдоштаи эндофинтии рашҳӣ:
 - рашҳӣ-реши;

· паҳншуда.

3. Саратон бо характери экзозендофилӣ, омехтаи инкишоф; шаклҳои гузаришӣ.

Аз ҷиҳати сохти гистологӣ аденокарсинома, саратони тафриқанашуда, паҳнхучайра, ғадудӣ- паҳнхучайра ва таснифнашаванда ҷудо карда мешаванд.

4

Анатомияи эътилолӣ.

Саратони пӯлакчамонанд - шакли нисбатан кам дучоршаванда буда, дар шӯъбаи баввобӣ, дар хамидагии хурд ё калон дар шакли ғафсии начандон калони луобпардаи дарозиаш 2-3 см мавзёе мегирад. Мутахаррикии чинҳои луобпарда дар ин ҷо маҳдуд гардидааст. Аз ҷиҳати сохти гистологӣ саратони пӯлакчамонанд одатан сохтори аденокарсиномаро дорад.

Саратони полинозӣ намуди укдаро бо сатҳияи мӯякдори диаметраш 2-3см дорад, ки дар пояк ҷойгир мешавад. Бофтаи омос хокситарии гулобиранг, хокситарии сурхранг буда, аз рағҳои хунгард бой аст. Аз ҷиҳати сохти гистологӣ - аксаран гирехшакл, ҳосилаҳои дӯнгичамонанд дар асоси васеи кутох буда, дар сатҳи гирех аксаран эрозияҳо, хуншорӣ ва ғубори фиброзию римнок ба назар мерасад.

Омоси мулоим, хокситарии гулобиранг ё хокситарии сурхранг буда, нағз маҳдуд шудааст. Аз ҷиҳати сохти гистологӣ он карсинома (саратон) аст.

Саратони ярашуда ярашавиҳои гуногуни аз ҷиҳати пайдоиш бадзоди меъдари мутаҳид мекунад (саратони аввалия-решӣ, табакчамонанд ва саратон аз решӣ музмин). Саратони аввалия-решӣ кам омӯхта шудааст. Ба ин шакл саратони экзофитӣ бо ярашавиҳо дар ҳуди оғози инкишоф, саратони пӯлакчамонанд бо ҳосилшавии решӣ саратонии аввал шадид, сипас музмин дохил карад мешаванд. Аз

чихати сохти гистологӣ - аксаран саратони тафриқанашуда аст.

Саратони табакчамонанд ҳангоми ярашавии омоси ба таври экзофитӣ сабзишбанда (полинозӣ ё фукозӣ) пайдо мешавад ва аз ҳосилаи мудаввар, баъзан андозаҳои калон, бо канораҳои навардчамонанди сафедча ва ярашавӣ дар марказ иборат аст. Қаъри реш бофтаҳои ҳамсоёе мебошанд, ки дар онҳо омос инкишоф мекунад. Аз чихати сохти гистологӣ аксаран аденокарсинома аст.

Саратони рашҳи-решӣ бо инфилтратсияи зоҳиршавандаи панкреозии девора ва ярашавии омос тавсиф меёбад. Аз чихати сохти микроскопӣ он саратони тафриқанашуда мебошад. Саратон-реш аз решеи музмини меъда ташаккул меёбад. Бо аломатҳои решеи музмин фарқ мекунад: инкишофи васеи бофтаи пайвасткунанда, тасаллӯб (склероз) ва суддати рағҳо, вайроншавии мушакпарда дар қаъри реш, ғафсшавии луобпарда дар атрофи реш. омос аксаран ба таври эндофитӣ инкишоф меёбад ва сохти гистологии аденокарсиномаро дорад.

Саратони паҳншуда ба таври эндофитӣ дар луобпарда, қабатҳои луобию мушакӣ инкишоф меёбад. Девори меъда дар ин маврид ғафс, сахт, сафедча ва беҳаракат аст. Луобпарда сохти муқаррарии худро гумм мекунад: сатҳи он ноҳамвор, чинҳо дорои ғафсии нобаробар, баъзан эрозияҳои хурд мушоҳида карда мешавад. Омос аз чихати сохти микроскопӣ аз вариантҳои карсиномаи тафриқанашуда иборат аст.

Шаклҳои гузаришии саратон - карсиномаҳои экзофитӣ, ки дар марҳилаи муайяни инкишоф нумуи зоҳиршавандаи рашҳӣ доранд, ё эндофитӣ бо тамоюл ба инкишофи дохилимеъдаӣ, ё ду (ё зиёдтар) омосҳои саратонии дорои шаклҳои гуногуни клиникӣ аностатикӣ дар ҳуди меъда мебошанд. Ба саратони меъда паҳншавӣ берун аз сарҳади ҳуди узв ва инкишофи он дар узву бофтаҳои ҳам-

соя хос аст. Решадовонӣ (метастазаҳо) барои саратони меъда хеле хос мебошанд. Саратони меъда бо роҳҳои лимфогенӣ, гематогенӣ ва геплатосиситӣ реша медавонад .

Роҳи лимфогенӣ дар паҳншавии омос нақши асосӣ мебозад ва аз ҷиҳати клиникӣ нисбатан муҳим мебошад. Решадовонӣ дар лимфогиреҳҳои минтақавии ба самти ҳамидагии хурду калони меъда ҷойгиршуда аҳамияти махсус доранд.

Дар лимфогиреҳҳои дуртар ҷойгиршуда решадовонӣ ҳам бо роҳи ортоградӣ (қад-қадӣ маҷрои лимфа) ва ҳам ретроградӣ (дар муқобили маҷрои лимфа) пайдо мешаванд. Ба таври ретроградӣ решадовонӣ дар лимфогиреҳҳои болоиқулфакӣ, одатан чап, дар лимфогиреҳҳои атрофии рӯдаи мустақим (параректалӣ) дохил карда мешаванд. Намунаи классикии он саратони крупенбергии тухмдонҳо мебошад. Одатан иллати решадовонӣ ба ҳарду тухмдонҳо тааллуқ дорад, ки якбора калон, ғафс ва сафедча мешаванд.

Карсиноматози сифок - ҳамсафари бештари саратони меъда; ҳамзамон паҳншавии лимфогении саратон дар сифок бо роҳи имплантатсионӣ пурра карда мешавад. Решадовонҳои гематогенӣ дар силсилаи вариди даромадгоҳ паҳн гаридад, ҷигарро иллатнок менамоянд, решадовонӣ баъдтар дар шуш, ғадуди зерӣ меъда, устухонҳо, гурдаҳо, ғадудҳои болои гурда дучор мешаванд.

5

Ду гурӯҳи оризаҳои саратони меъда чудо карда мешаванд. Дар натиҷаи тағйиротҳои дуҷумбораи некрозӣ ва таҷзияи карсинома сурухшавии девора, хунравӣ, илтиҳоб ёфтани дабилаи (флегмонаи) меъда пайдо мешавад.

Реша давондани саратони меъда ба даромадгоҳҳои ҷигар ё сараки ғадуди зерӣ меъда, маҳкамшавии маҷроҳои талхагузар ва вариди қифӣ боиси инкишофи зардпарвин, фишорбаландӣ атсит ва ғайра мегардад. Воридшавии омос

ба чархакрӯдаи кундаланг ё решаи масорикаи ҳучайраи муқаррарӣ боиси пучшавӣ гашта, бо ногузаронандагии рӯдаҳо ҳамроҳи менамояд. Оризаи тез-тез дучоршавандаи саратони меъда лоғаршавӣ мебошад.

Дар байни омосҳои рӯдаҳо саратон аҳамияти муҳим дорад. Саратон ҳам дар рӯдаи борик ва ҳам дар рӯдаи ғафс дучор мегардад. Саратони рӯдаи борик одатан дар қисмати пистонаки калони рӯдаи дувоздаҳангушта дучор мегардад. Омос андозаҳои калон надорад, хеле кам боиси душворшавии чараёни бозгашти талха мегардад ё сабаби зардпарвини зеричигарӣ аст ва бо илтиҳоби роҳҳои талха оризодор мегардад. Саратони рӯдаи ғафс бештар дар рӯдаи мустақим, гоҳо дар рӯдаҳои сигмашакл, кӯррӯда, кунҷҳои чигар ба назар мерасад.

Қабул аз саратони рӯдаи ғафс одатан колити музмини решӣ, полиноз чой дошта, омос ё унсурҳои музмини рӯдаи мустақим дучор мегарданд. Вобаста ба характери инкишоф шаклҳои экзоэндофилӣ ё гузаришии саратон фарқ карда мешаванд. Ба саратонҳои эндофилӣ пулакчашакл, каминозӣ ва дӯнгичакалон, ба эндофитию решӣ - паҳншудаи рашхӣ, ки одатан ковокии рӯдахоро танг мекунанд, ба гузаришӣ - саратони табакчашакл дохил карда мешаванд. Аз ҷиҳати сохти гистологӣ аденокарсинома, паҳнхучайра, гадудию паҳнхучайра, саратони тафриқанашуда, таснинашванда ҷудо карда мешавад.

Шаклҳои экзофитии саратон одатан сохтори аденокарсенома, шаклҳои эндофитӣ бошанд - сохти саратони тафриқнашавандаро доранд. Саратони рӯдаи мустақим дар лимфагиреҳҳои минтақавӣ ва чигар реша медавнада.

ЛЕКСИЯИ 18

БЕМОРИҲОИ ЧИГАР. ГЕПАТИТҲО.

1. Муайян намудани гепатит
2. Гепатитҳои вирусӣ
3. Гепатити вирусии В

Бемориҳои чигар гуногунанд. онҳо метавонанд ирсӣ ва пайдошуда, аввалия ва дуюмбора бошанд. Боиси бемориҳои чигар сироятҳо (гепатити вирусӣ, менингоспироз, опистороз, тиф) шуда метавонанд. Ба захролудшавиҳо - табиаташон ҳам эндогенӣ (уремия), ва ҳам экзогенӣ (алкогол, захрҳои гепатотропӣ, захролушавиҳои ғизоӣ). Ихтилоли гардиши хун (садама, рукуди музмини варидӣ), халалдоршавии тағзия (норасоии сафедаҳо ва витаминҳо) ва мубодилаи моддаҳо (бемориҳои мубодилавии чигар) аҳамияти калон доранд.

1

Гепатитҳо - бемориҳои чигар мебошанд, ки асоси онҳо хоро илтиҳобе ташкил медиҳад, ки бо тағйиротҳои дисрофӣ ва некрозии лаҳима, инфилтратсияи илтиҳобии сибрана зоҳир мешаванд.

Гепатит аввалия ва дуюмбора буда метавонад. Пайдоиши гепатити аввалия, яъне гепатит ҳамчун бемории мустақил аксаран бо таъсири вируси гепатотропӣ (гепатити вирусӣ), алкоголь (алкоголӣ) ё доруҳо (доругӣ) алоқманд аст. Дар байни гепатитҳои аввалия вирусӣ ва алкогольӣ аҳамияти бештаре доранд. Этиологияи гепатити дуюмбора, яъне ҳамчун падидаи бемории дигар хеле гуногунранг аст. Ин сироятҳо ситанегамия, домана, исҳоли хунин, вараҷа, сил, сепсис) захролудшавиҳо (тиреотоксикоз, захролудшавии ками чигар бо захрҳо, бемориҳои бофтаи пайваस्तкунанда) мебошанд.

2

Гепатити вирусӣ - бемории вирусист, ки асосан бо иллатнокшавии чигар ва найи ҳозима тавсиф меёбад. Беморӣ бо номи С.П. Боткин номида шудааст, ки соли 1888 бори аввал ин назарияро нисбати этиология ва патогензи он пешниҳод намуд.

Барангезандаҳои гепатит - вирусҳои А (HAV), В (HBV) ва делта (HDV), С (HVC). HAV - вирус КРН-дори гепатити А - боиси гепатити вирусии А мегардад.

Роҳи интиқол - фазлай-дахонӣ аз одами бемор ё хомили вирус мебошад. Давраи инкубатсионӣ 15-45 рӯз аст. Барои ин навъи гепатит хуруҷҳои эпидемиявӣ (геаптити эпидемиявӣ) хос аст. Ҷараёни гепатити А, одатан, шадид мебошад, аз ин сабаб он боиси инкишофи таллайф намегардад. НӢV боиси гепатити вирусии В мегардад, ки барои он механизми тавассутипуъстии интиқол хос аст: хунгузаронӣ, тазриқ.

Сарчашмаи сироят одами бемор ё хомили вирусӣ мебошад. Давраи инкубатсионӣ 25-180 рӯз давом мекунад. Гепатити вирусии В, ки метавонад ҳам лонавӣ ва ҳам музмин бошад. Вай - ҳамрадифи доимии АПНМ (СПИД) мебошад. HDV, ки КРН-вируси нуқсондор мебошад, боиси делта-гепатити вирусӣ мегардад. Вай метавонад ҳамзамон бо гепатити вирусии В пайдо шавад ё падидаи суперсироят дар ҳомилони HBV бошад. Дар байни гепатитҳои вирусӣ гепатити вирусии В аҳамияти бештари эпидемиологӣ ва клиникӣ дорад.

3

Гепатити вирусии В.

Этиология. Вируси гепатити В вируси КДН-дор (заррачаи Дейн), шуморида мешавад, ки се детерминантҳои антигениро дар бар мегирад:

- антигени сатҳӣ (HBsAg);

- антигени дилшакл (HBsAg), ки бо он бемориоварии вирус алоқаманд карда мешавад;
- H BeAg, ки ҳамчун нишонаи (маркери) КДН-полимери-даза баррасӣ карда мешавад.

Патогенез. Ҳоло назарияи вирусии иммуногенетикии патогензи гепатити вирусии В қобили қабул мебошад, ки мувофиқи он гуногунрангии шаклҳои он бо хусусиятҳои ҷавоби масунӣ ба воридшавии вирус алоқманд карда мешавад.

Анатомияи эътилолӣ. Шаклҳои зерини клиникаю морфологияи гепатити вирусӣ фарқ карда мешаванд :

- шадиди давравӣ (зардчагӣ);
- безардча;
- некрозӣ;
- талхадонӣ (холестетикӣ);
- музмин.

Ҳангоми шакли шадиди давравӣ тағйиротҳои морфологӣ аз марҳилаи беморӣ вобастагӣ доранд. дар марҳилаи авҷи беморӣ чигар калон, саҳт ва сурх шуда, ғилофаки он ғафс мебошад. Аз ҷиҳати сохти микроскопӣ ихтилоли сохти чигар ва полинотрофияи зоҳиршавандаи гепатоситҳо ба назар расида, аксаран дар ҳуҷайраҳо тарҳи митоз дида мешавад.

Дистрофияи гидропикӣ ва баллонии гепатоситҳо бартарӣ дорад, дар қисмҳои гуногуни ҳиссаҳо некрозҳои лонавӣ (доғдор) ва якҷояшавандаи гепатоситҳо, ҷисмҳои Каунсилмен дар шакли ҳосилаҳои мудаввари гомогенӣ бо ядроҳои пикнозикӣ ё бе ядро дучор мешаванд. Ба таври сибромадиффузӣ бо лимфоситҳо ва микроорганизмҳои дорои ометҳои ҳуҷайраҳои плазмавӣ, лейкоцитҳои эозинофилӣ ва нитрофилӣ инфилтратсия шудааст .

Микдори ҳуҷайраҳои ситорашакли ретикулоэндотелиалӣ хеле зиёд аст. Ҳуҷайраҳои инфилтрат аз пайкар ба лаҳимаи ҳиссаҳо мебароянд ва генамбоситҳои лавҳачаи

ҳаммарзро вайрон мекунанд, ки боиси пайдоиши некрозҳои зинадор мегарданд. Дар қисмҳои гуногуни ҳиссаҷаҳо мӯйрағҳои зиёди бо талха пуршуда мавҷуд мебошанд. Ҳамчунин вайроншавии пардаи гепатоситҳо ба амал меояд, ки боиси «таркиши» ферментативӣ ҳангоми гепатит, баландшавии фаъолнокии аминотрансферазаҳо, ки калибрҳои синтези ҳуҷайравӣ мебошанд, мегардад.

Дар марҳилаи шифоёбӣ андозаҳои чигар мӯътадил мешаванд, гиперемияи он камтар мегардад, ғилофак каме ғафс, хира буда, байни ғилофак ва сифок илтиёмҳо дучор мегарданд. Аз ҷиҳати сохти микроскопӣ барқароршавии сохти ҳиссаҷаҳо, камшавии илтиёми тағйиротҳои некрозӣ ва дистрофикӣ дучор карда мешавад. Таҷдиди гепатоситҳо зоҳиршаванда аст. Инфилтрати лимфомакрофагӣ дар қисми пориталӣ ва дар дохили ҳиссаҷаҳо лонавӣ мегардад. Дар ҷойи некрозҳои якҷояшудаи гепатоситҳо дағалшавии нахҳои ретикулярӣ ва сабзиши торҳои коллагенӣ дида мешавад.

Ҳангоми шакли ғайрисилсилавии гепатит аз ҷиҳати сохти микроскопӣ манзараи дигаре ба назар мерасад: дистрофияи гепатоситҳо, лонаҳои некрози онҳо, ҷисмҷаҳои Каунсилмен кам вомерхуранд, инкишофи ретикулоэндотелиоситҳои ситорашакл саҳт зоҳиршаванда аст, инфилтрати илтиҳобӣ ҳамаи қисмҳои ҳиссаҷаҳо ва суддатҳои боби-ро фаро меигранд, вале лавҳачаи ҳаммарзро вайрон намекунанд; холестаз вучуд надорад.

Барои шакли некрозӣ некрози рушдкунандаи лаҳимаи чигар хос аст. Андозаи чигар хурд гашта, ғилофаки он ноҳамвор, ранги бофта бошад - хокистаранг ё сиёҳ мегардад. Аз ҷиҳати сохти микроскопӣ - некрозҳои пулакчашакли фаровони чигар ба назар мерасанд. Ҳангоми лотароскопия ҳангоми шакли талҳадонии гепатит- тағйиротҳои ба мисли беморони чигарашон сурх дида мешаванд, вале чигар бо лонаҳои зарди сабзранг ва тарҳи зоҳиршаван-

даи ҳиссагӣ аст, аз ҷиҳати сохти микроскопӣ- падидаҳои холелидаз. Тағйиротҳои ғайримуолиҷавӣ бо зардпарвин ва хуншориҳои пӯст, зардобпардаҳо ва луобпардаҳо, калоншавии лимфогиреҳо зоҳир мегарданд.

ЛЕКСИЯИ 19 БЕМОРИҲОИ ЧИГАР. ТАЛЛАЙЮФ.

1. Муайян намудани гепатоз
2. Анатомиаи эътилолии гепатоз
3. Гепатози равганӣ.
4. Таллайюфи чигар

1

Гепатозҳо - бемориҳои чигар мебошанд, ки бо дистрофия ва некрози гепатоситҳо тавсиф меёбанд. Дистрофияи захрогин ё некрози рушдкунандаи фаровони чигар, бемории шадид, гоҳо музмин аҳамияти зиёдтар доранд, ки бо некрози рушдкунандаи фаровони чигар ва норасоии чигар тавсиф меёбанд.

2

Анатомиаи эътилолӣ. Сараввал (дар рӯзҳои аввал) чигар калон, зичмонанд ё пажмурда, рангаш зарди баланд мебошад. Сипас ҳаҷмаш хурдтар, пажмурда мегардад, ғилофак бошад - чиндор, дар буриш ранги бофтаи чигар хокистаранг, ранги гилмонанд мебошад. Аз ҷиҳати сохти микроскопӣ дар рӯзҳои аввал - дистрофияи чарбии (чигар) гепатоситҳои маркази ҳиссаҷаҳо, некрози тез ивазшавандаи онҳо ва ҳосилшавии детрити чарбию сафедагӣ ба назар мерасад. Некроз шиддат ёфта, тамоми қисмҳои ҳиссаҷаҳо фаро мегирад: танҳо дар канораҳои онҳо болои рағҳо, борики гепатоситҳо дар ҳолати дистрофияи чарбӣ боқӣ мемонад. Ин тағйиротҳои чигар бо марҳилаи дист-

рофияи зард тавсиф меёбад. Баъдан чигар ҳаҷман хурд ва сурхчатоб мешавад. Ҳангоми некрози фаровони чигар зардпарвин, пурхуншавии лимфагиреҳҳо ва испурч, хуншорӣ дар пӯст, луобпардаҳо ва зардобпардаҳо, некрози эпителияи найчаҳои гурдаҳо мушоҳида карда мешавад.

3

Гепатози чарбӣ- бемории музмин мебошад, ки бо зиёдшудани ғуншавии чарб дар гепатоситҳо тавсиф меёбад. Чигар ҳангоми гепатози чарбӣ рангаш зард, ҳаҷман калон, сатҳи он суфта мебошад. Ҳаҷман калоншавии гепатоситҳо метавонад чангакшакл, ва калоннайчавӣ бошад. Иртишоҳӣ чарбӣ метавонад гепатоситҳои алоҳида, гурӯҳи гепатоситҳои минтақавӣ ё тамоми қисми чигарро фаро гирад. Ҳаҷман калоншавии гепатоситҳо ё ба намуди обилаҳои марказӣ, ё периноридалӣ инкишоф меёбад.

4

Таллайюфи чигар - бемории музминест, ки бо норасоии афзоишбанди чигар аз сабаби пучшавии чигар ва тағйиротҳои бофтаҳои чигар тавсиф меёбад. Тағйиротҳои хоси чигар - дистрофия ва некрози гепатоситҳо, таҷдиди тахрифёфта, тасаллӯб (склероз), шаклдигаркунии узв мебошанд. Дар ин маврид чигар зичу дунгичадор буда, аксаран андозааш хурд шудааст. Аз ҷиҳати сохти микроскопӣ намудҳои нопурраи сенталӣ, хурдгиреҳи, калонгиреҳи, омехтаи таллайюф ҷудо карда мешаванд.

Ҳангоми таллайюфи нопурраи сенталии гиреҳ таҷдид ба амал намеояд, лаҳимаи чигарро сенибаҳои борик бурида мегузаранд.

Ҳангоми хурдгиреҳӣ - таҷдиди гиреҳҳо андозаҳои якхела (кутрашон то 1см) дошта, аксаран сохтори монолобулярӣ доранд, сенибаҳо дар онҳо борик мебошанд.

Ҳангоми калонгиреҳӣ - гиреҳҳо андозаҳои гуногун

доранд, кутри калонтари онҳо - то 5 см мебошанд, сенидаҳои онҳо васеъ буда, лаҳзаи асосӣ дар инкишофи таллайю дистрофия ва некрози гепатоситҳо мебошад. Нобудшавии гепатоситҳо боиси камшавии таҷдиди дуҷумбораи онҳо ва пайдоиши гирехҳо-таҷдидгорҳо мегардад, ки аз ҳама атроф бо бофтаи пайвасткунанда ихота карда шудаанд. Ташаккули гирехҳо бо тасаллуби паҳнёфта ҳамбастагӣ менамояд. Азнавсозии сохти ҷигар ҳалқаи сарбастаро ҳангоми таллайюфи ҷигар ба анҷом мерасонад: садди байни хуну гепатоситҳо боиси ҳалокати он мегардад, ҳалокати гепатоситҳоро бошад аксуламали ҳуҷайраҳои мезенхимӣ ва таҷдид таҳрифаноки лаҳима дастгирӣ менамояд, ки боиси вазниншавии манзараи мавҷуда мегардад.

Таллайюфи баъдинекрозӣ дар натиҷаи некрозҳои фаровони лаҳимаи ҷигар инкишоф меёбад.

Таллайюфи поридалӣ дар натиҷаи ба ҳиссачаҳо резашавии сенибаҳои фиброзӣ аз бофтаҳои васеъшуда ва тасаллубии бобӣ ва периноридалӣ ташаккул мейбад, ки боиси пайвастшавии варидҳои марказӣ бо варидҳо атрофӣ ва пайдоиши ҳиссачаҳои хурд-хурди козиб мегарданд.

Таллайюфи омехта бо ҳамроҳшавии некрозҳои фаровони ҷигар бо тағйиротҳо ҳангоми таллайюфи поридалӣ ё замшавии аксуламали мезенхимӣ-некрозӣ ҳагоми таллайюфи баъдинекрозӣ алоқаманд буда, аксаран боиси пайдоиши илтиёмҳо ва «тақсимшавии» ҳиссачаҳо мегардад.

ЛЕКСИЯИ 20 БЕМОРИҲОИ ГУРДАҲО. ГЛОМЕРУЛОПАТИЯ.

1. Гролемуропатия. Анатомиаи эътилолӣ
2. Громелуронефрити шадид
3. Громелуронефрити музмин.
4. Синдроми нефротикӣ
5. Тасаллуби лонавии сегментарии гломерулӣ

Бемориҳои гурдаҳо, ки хангоми онҳо протеинурия, илтиём ва гипертрофияи дил мушоҳида карда мешавад, дар оғози асри XIX аз тарафи Р. Брант муттаҳид крада шуда буданд. Бемории Брантро одатан ба нефритҳо, нефрозҳо ва нефросклерозҳо чудо мекунад. Вале таснифи мазкур талаботи нефрологияи муосирро қонеъ намекунад. Ҳоло 2 нефропатия (иллатҳои гурда) ё гурӯҳи бемориҳои гурда чудо карда мешаванд - гломеруло-ва тубулопатия (иллатҳои калобаҳои гурда ва иллатҳои найчаҳои гурда). Асоси гломерулопатии - ҳалалдоршавии хун полоиши калобаҳо (тӯпчаҳо) ташкил медиҳад. Барои тубулопатия пеш аз ҳама ҳалалдоршавии вазифаи бозчабиш ва тарашшӯҳии найчаҳои гурд хос аст. Ҳамчунин нефрити байнибофтавӣ, пиелонефрит, бемории санги гурдаҳо, нефросклероз фарқ карда мешавад. Гурӯҳи махсусро нуқсонҳои инкишофи гурдаҳо, пеш аз ҳама полистезоз, омози гурдаҳо ташкил медиҳанд.

1

Гломерулопатия.

Гломерулонефрит - бемории табиаташ сироятию алергӣ ё муайяннашуда мебошад, ки асоси онро илтиҳоби дутарафаи мунташир ё лонавии ғайриримии дастгоҳи калобачаҳои гурдаҳо бо аломатҳои хос (олигурия, промен-турия, гемантурия, цилиндрурия, фишорбаландии шараёни, диспротеинемия, омосҳо, уремия) ташкил медиҳад, ки ҳамбастагии онҳо гуногун буда метавонад, аз ин сабаб шаклҳои гематурӣ (хунпешобӣ), нефротикӣ (гурдавӣ), гипертонӣ (фишорбаландӣ), омехтаи гломерулонефрит фарқ карда мешавад.

Анатомияи этиологӣ. Шаклҳо интра- ва экстрамӯйрагӣ, гломерулонефритҳо аз рӯи ҷойгиршавӣ; аз рӯи характери илтиҳоб - экссудативӣ, пролиферативӣ ва омехта фарқ карда мешаванд.

Гломерунефрити интрамӯйрагӣ бо инкишоф ёфтани раванди эътилолӣ дар калобачаҳои мӯйрагӣ тавсиф меёбад. Дар бораи ин шакл ҳангоме ҳукм меронанд, ки мезанглия ва ковокиҳои мӯйраги калобачаҳо бо нейтрофилҳо инфилтратсия шудаанд (гломерунефрит экссудативӣ) ва ҳангоме ки нуфузи ҳучайраҳои эндотелиалӣ ва махсусан мезангиалӣ (гломерунефрит пролиферативӣ) мушоҳида карда мешавад.

Ҳангоми гломерулонефрити экстрамӯйрагӣ илтиҳоб на дар рағҳо, балки дар ковокии гилофаки тӯбчаҳо инкишоф меёбад.

Гломерулонефрити экссудативии (рашҳии) экстрамӯйрагӣ зардобӣ (серозӣ), фиброзӣ (лифӣ) геморагӣ фарқ карда мешавад; барои гломерулонефрити пролиферативии экстрамӯйрагӣ (берунимӯйрагӣ) нуфузи ҳучайраҳои гилофаки калобачаҳо бо ҳосилшавии ҳилолҳои хос характерноқ аст. Аз рӯи характери ҷараён гломерулонефрити шадид, зершадид ва музмин фарқ карда мешавад.

2

Гломерулонефрити шадид, ки одатан аз таъсири стрептококкҳо ба вучуд меояд, патогенези он бошад бо маҷмӯҳои даврзанандаи масунӣ алоқманд буда, 10-12 моҳ ҷараён ёфта метавонад. Дар рӯзҳои аввали беморӣ пурхунии (гиперемияи) калобачаҳо хос аст, баъдан инфилтратсияи мезанглия ва ҳалқаҳои мӯйрағҳо нейтрофилҳо ҳамроҳ мешаванд. Ба ин раванд тамоми калобачаҳо ҷалб мешаванд. Гурдаҳо дар ин маврид калон, варамноқ буда, сурхи тира мебошанд, қишри гурдаҳо хокистарранг буда дар сатҳи гуногунранг буриш мебошанд.

Гломерулонефрити зершадид аз сабаби иллатноқшавии калобачаҳо ҳам бо маҷмӯҳои даврзанандаи масунӣ ва ҳам антителаҳо инкишоф меёбад. Тағйиротҳои берунимӯйрагӣ сермахсули калобачаҳо мебошанд.

Дар натиҷаи нуфузи эпителияи ғилофак, подоситҳо ва макрофагҳо ҳосилаҳои ҳилолшакл («ҳилолӣ») пайдо мешаванд, ки калобачаҳоро фишор медиҳанд. Ҳалқаҳои мӯйрагӣ дучори некроз мегарданд, дар ковокиҳои онҳо суддатҳои фибринӣ пайдо мешаванд. Тағйироти калобачаҳо бо дистрофияи нефроситҳо, омосу инфилтратсияи сибранаи гурдаҳо ҳамроҳ мешавад, тасаллуб (склероз) ва гиалинози калобачаҳо, атрофияи найчаҳо ва фибрози сибранаи гурдаҳо барвақт фаро мерасад. Гурдаҳо дар ин маврид калон, пажмурда, қабати қишрӣ васеъ, варамнок, зарди хокистарранг, тираанг, мебошанд.

3

Гломерулонефрити музмин - бемории мустақил мебошад. Сабаби инкишофаш номаълум аст. Аз намудҳои мезантиалӣ ва фибриностатикӣ иборат аст.

Барои шакли мезантиалӣ тағйироти на танҳо калобачаҳо т, балки найчаҳо (дистрофия, атрофия) ва сибрана (инфилтратсияи ҳучайравӣ, тасаллуб ва ғайра) ҳос аст. Гурдаҳо саҳт, паридаранг, бо доғҳои зард дар қабати қишрӣ мебошанд. Ҳангоми навъи фибропластикӣ (тасаллубӣ) тасаллуб ва гиалинози ҳалқаҳои мӯйрагӣ ва ҳосилшавии илтиёмҳо дар ковокии ғилофакҳо ҳос аст. Гурдаҳо метавонанд хурд шаванд, бо фурӯрафтагии начандон калон дар сатҳ, саҳт, сурхи хокистарӣ бошанд.

Одатан, гломерулонефрити музмин дучори таҳаввул дар шакли пучшавии дуҷумбораи гурдаҳо мегардад. Гурдаҳо хурд, ва саҳт мешаванд, дар сатҳи болои онҳо доначаҳои хурд пайдо мешаванд, ки ҳамдигарро иваз намудани тасаллуб (склероз) ва атрофия (коҳишбӣ) дар қитъаҳои нефронҳои бузургшуда (варамнокӣ) шарҳ дода мешавад.

4

Синдроми нефротикӣ бо протеинурияи зиёд, дистро-

теинемия, гипорпротеинемия, гиперменидемия ва омосхо тавсиф меёбад. Синдроми аввалияи нефротикӣ метавонад аз нефрози лимфидӣ, нефропатияи лимбранозӣ, тасаллуби лонавии сегментарӣ (гиалиноз) иборат бошад.

Нефрози липоидӣ - нефропатия бо андозаҳои минималӣ буда, бо тағйиротҳои ҷолоиши гломерулярӣ тавсиф меёбад, ки танҳо ҳангоми тадқиқот дар зермикроскопии электрони ошкор карда мешаванд ва бо талафёбии подоситҳои шохаҳои хурди он зоҳир мегардад. Ғишои асосӣ тағйир наёфтааст, найчаҳои асосии нефронҳо васеъ, эпителия варамнок аст, дисрофия, некротиоз, атрофия (коҳишбӣ) ва ҷудошавии ҳуҷайраҳои эпителияӣ найчаҳо бо таҷдиди дуҷумбораи (регенератсияи) он ҳамбастагӣ менамояд. Сибрана варам, лимфагиреҳо васеъ мебошанд. Гурдаҳо калон, пажмурда буда, ғилофак ба осонӣ ҷудо мешавад. Нефропатияи мембранозӣ бо ғафсшавии мунташири девори мӯйрагҳои калобачаҳо ҳангоми набудан ё хеле суст нумӯш кардани мезангиоситҳо тавсиф меёбанд. Гурдаҳо калон, гулобии паридаранг ё зард буда, сатҳи онҳо суфта аст.

5

Склерози (тасаллуби) лонавии сегментарии гломерулярӣ (гиалиноз) дар давраи ташаккули синдроми нефротикӣ (аввалия) ё бо нефрози липоидӣ (интиҳобӣ) алоқаманд аст. Тасаллуб ва гиалиноз ба таври интиҳобӣ дар калобачаҳои юктагломерулярӣ инкишоф меёбанд; калобачаҳои алоҳида иллатнок мешаванд (тағйиротҳои манзаравӣ), ки қисмҳои алоҳидаи дастаи рагҳо дучори тасаллуб ва гиалиноз мегарданд. Ҳамчунин доимо ошкор карда шудани ҷарбҳо дар моддаҳои гиалинӣ ва мезангиоситҳо хос аст.

ЛЕКСИЯИ 21

БЕМОРИҲОИ ГУРДАҲО. АМИЛОИДОЗИ ГУРДАҲО. ТУБУЛОПАТИЯ.

1. Амилоидози гурдаҳо
2. Тубулопатияҳои шадид
3. Тубулопатияҳои музмин.

1

Амилоидози гурдаҳо - падидаи амилоидози умумӣ мебошад.

Дар марҳилаи интиҳой ранги гурдаҳо кам тағйир ёфтаанд, гарчанде дар пистончакҳо тасаллӯб ва амилоидоз ба самти рағҳои мустақим ва найчаҳои пешоб чамъкунанда ошкор карда мешавад. Тасаллӯб ва амилоидози пирамидаҳо кам зоҳиршавандаанд ва боиси коҳишёбии бисёре аз найчаҳои амиқ ҷойгиршуда мегарданд. Гурдаҳо калон саҳт, сатҳи онҳо хокистарранги сафед ё зарди хокистарранг буда, дар буриш қабати кишрӣ васеъ, моеи мағзӣ хокистари гулобиранг, намуди «чарб» дорад. Дар марҳилаи нефротикӣ миқдори амилоидҳо зиёд мешавад. Гурдаҳо калон, саҳти амилоидӣ мебошанд.

Дар марҳилаи азотеникӣ (уремӣ) аз сабаби амилоидози афзоишёбанда ва тасаллӯб нобудшавии найчаҳои гурдаҳо коҳишёбии онҳо, тағирёбии бофтаи пайвастанда баназар мерасад. Андозаи гурдаҳо муқаррарӣ ё хурд, саҳт бо ҷуқурчаҳои ҳадшагӣ мебошанд.

2

Тубулопатия (иллати найчаҳои гурда). Норасоии шадиди гурдаҳо бо некрози эпителии найчаҳо ва ихтилоли амиқи ҷараёни бозгашти хуну лимфайи гурдаҳо тавсиф меёбад.

Сабабҳои асосӣ - захролудӣ ва сироят мебошанд. Ин-

кишофи он бо механизмҳои садама - ар гуна этиология вобаста аст. Марҳилаҳои ибтидоӣ (садамагӣ), олигоанурӣ ва марҳилаи барқароршавии диурез фарқ карда мешаванд. Намуди берунии гурдаҳо новобаста аз марҳилаи беморӣ якхела аст: калон, варамнок, омосӣ, ғилофаки фиброзӣ пуршиддат буда, ба осонӣ чудо мешавад. Ситурдаи васеи хокистари сафедранг хеле кам аз пистонакҳои сурхи сиёҳ маҳдуд аст, дар минтақаи интермедиалии гурдаҳо ва ҳавзак аксаран хуншорӣ пайдо мешавад.

Дар марҳилаи ибтидоӣ пурхунии якбораи варидҳои миктақаи гентероидаль ва пистонакҳо ҳангоми ишемияи қабати қширӣ мушоҳида карда мешавад, ки дар он ҷо мӯйрағҳо дар ҳолати фишурдашуда қарор доранд. Омоси интеротисия бо лимфатоз ҳамбастагӣ менамояд. Эпителияи найчаҳо дар ҳолати дистрофия қарор дорад .

Дар марҳилаи амегакурӣ тағйиротҳои некрозии найчаҳо зоҳиршаванда мебошанд. Омоси генитерситисия пурзӯр мешавад, инфилтратсияи лейкоцитарӣ, геморрагия ҳамроҳ мегардад. Рукуди варидҳо низ нисбатан зоҳиршаванда аст, ки дар замина онҳо аксаран суддати варидҳо ба амал меояд. Дар марҳилаи барқароршавии диурез бисёре аз қалобачаҳо пурхун гардида, омос ва инфилтратсия бошад камтар мегардад. Қитъаи некрози эпителияи найчаҳо бо қазирачаҳо - таҷдидёбандаи ҳучайраҳои сафеди эпителиалӣ ҳамдигарро иваз мекунанд, лонаҳои тасаллӯб (склероз) ҳосил мешаванд.

3

Ба тубулопатияҳои музмини пайдоишашон инсидодӣ гурдаи миеломӣ ва гурдаи никрисӣ дохил мешаванд.

Асоси тағйиротҳои барои гурдаи миеломӣ хосро нефрози парапротеиномӣ ташкил медиҳад, ки аз сабаби олудашавии қисмати гурдаҳо ва бандшавии найчаҳо бо сафедани хурдмолекулярӣ - парапротеин, инкишоф меёбад, ки

бо хучайраҳои миелемӣ тарашишӯх менамояд. Дар генез пучшавии дуҷумбораи гурдаҳо ба амал меояд, гоҳо милоидоз ҳамроҳ мешавад.

Ҳангоми гурдаи ниқрисӣ олудашавӣ, интерсититсия ва инсидоди найчаҳо бо баландшавии кислотаи карбамидро ихроҷ намудани гурдаҳо (гаперурикурия) алоқаманд аст, ки миқдори он низ ҳамчунин зиёд аст (гиперурикия). Дар натиҷаи бо кислотаи карбамид ва намакҳои он осебёбии ҳавзаки гурдаҳо, инчунин сирояти дохилӣ дар гурдаву ҳавзаҳо аксаран пиелонефрит инкишоф меёбад.

ЛЕКСИЯИ 22 БЕМОРИҲОИ УЗВҲОИ ТАНОСУЛ ВА ҒАДУДҲОИ ШИРҲОСИЛКУНАНДА.

1. *Бемориҳои носозгорӣ: гиперплазия ва аденомаи модулии ғадуди простата.*
2. *Эндосервикоз.*
Адномантози ғарданаи бачадон.
3. *Дисплазияи хушсифати ғадуди ширӣ.*
4. *Бемориҳои илтиҳобии узвҳои таносул ва ғадудҳои ширҳосилкунанда.*
5. *Омосҳои узвҳои таносул ва ғадуди ширҳосилкунанда*

Бемориҳои узвҳои таносул ва ғадудҳои ширҳосилкунанда ба носозгорӣ (дисгармоналӣ), илтиҳобӣ ва омосӣ чудо мешаванд. Ҳамзамон ҳангоми баҳодихии тағйиротҳо дар узвҳои таносул ва ғадуди ширҳосилкунанда ба назар гирифтани синну соли бемор зарур аст.

1

Бемориҳои носозгорӣ. Ба онҳо гиперплазияи модулярӣ ва аденомаи ғадуди олоти таносул, гипоплазияи ғадудҳои

луобпардаи бачадон, эндосервикоз, аденоматоз ва салилаҳои гарданаи бачадон, дисплазияи хушсифати ғадуди ширҳосилкунанда дохил мешаванд.

Гиперплазияи модулярӣ ва аденомаи ғадуди олооти таносул дар 95% мардҳои аз 70 сола болотар мушоҳида карда мешавад. Ғадудҳо калон, чандири нарм ва баъзан дӯнгичадор мебошанд. Дар буриш ғадуд аз гирехчаҳои алоҳида иборат аст, ки бо қабатҳои бофтаи пайваस्तкунанда ҷудо шудаанд. Аз ҷиҳати сохти гистологӣ шаклҳои ғадудӣ (аденоматозӣ), мушакӣ-фиброзӣ (стромалӣ) ва омехтаи гиперплазияи модулярӣ ҷудо карда мешаванд.

Гиперплазияи ғадудӣ бо калоншавии унсурҳои ғуддатор тавсиф меёбад.

Мушакӣ-фиброзӣ - пайдоиши миқдори зиёди торҳои мушакҳои суфта мебошад, ки дар байни онҳо унсурҳои коҳишёфтаи ғадуд мушоҳида карда шуда, серхиссагии ғадудҳо ҳалалдор мешавад. Ҳангоми шакли омехтаи иллати ғадуди олооти таносул ихтилолҳои бофтагӣ ҳамбаста мешаванд, ки барои ду намуди аввал ҳосанд, гоҳо ҳосилаҳои кистагии пайдоишашон репеенсионӣ ба назар мерасанд.

2

Аденомаи простата хусусиятҳои хоси гистологӣ надорад. Ба оризаҳои носозгории ғадуди олооти таносул фишороварӣ ва шаклдигаркунии найи пешоббарор ва гарданаи пешобдон дохил мешаванд (ҷараёни хориҷшавии пешоб душвор мегардад).

Гиперплазияи ғадудчаҳои луобпардаи бачадон дар натиҷаи вайроншавии таносуби гармонҳо ва ба организм ворид гаштани миқдори барзиёди фолликулин ё прогестерон инкишоф меёбад. Аксаран занони калонсол ва солхӯрда, баъзан ҳангоми мавҷуд будани омоси тухмдонҳо, ҳангоми носозгории вазифаи тухмдонҳо занҳо бемор меша-

ванд. Луобпарда ҳангоми ин шакли гиперплазия бо загилаҳои полипозӣ аст. Ба таври микроскопӣ ба марҳилаи аз ҷиҳати вақт тӯлкашидаи нумӯъ дар натиҷаи бошиддат ҳосилшавии эстрогенҳо мувофиқ аст; ғадудчаҳо шакли дарозшуда, пурпечу хам, пило- ё лимфашакл мебошанд. Дар заминаи гиперплазияи ғадудчаҳо метавонанд тағйиротҳои илтиҳобии луоб бо гузариш ба тасаллуб, инчунин саратони танай бачадон инкишоф ёбанд, аз ин сабаб он ҳолати қаблисаратонии бачадон мебошад.

Эндосервикоз - чамъшавии ғадудчаҳо дар ғафсии косяаи маҳбалии гарданаки бачадон бо тағйиротҳои эпителияи онро пушонанда мебошад.

Эндосервикози нуфузкунанда, муқаррарӣ ва сикатшаванда фарқ карда мешаванд. Барои эндосервикози нуфузкунанда номияҳои сохторҳои ғадудчаҳо ҳосанд, ки аз унсурҳои камбиалии эпителияи плазмавии найи бачадон инкишоф меёбанд. Ҳангоми эндосервикози муқаррарӣ ғадудчаҳо аломатҳои номияҳоро надоранд. Барои эндосервикози сикатшаванда дар ғадуд сабзида баромадани эпителияи паҳнак ва ивазшавии он бо призмашакл ҳос аст.

3

Аденомантози гарданаи бачадон - чамъшавии ҳосилаҳои ғадудчаҳо дар зерӣ эпителияи қисмати маҳбалии он мебошад. Салилаҳои гарданаи бачадон аксаран дар маҷроҳ, камтар - дар қисмати маҳбал пайдо шуда, бо эпителияи луобҳосилкунандаи призмашакл ҳосил шудаанд.

Дисплазияи хушсифати ғадуди ширҳосилкунанда бо ҳалалдоршавии тафрикаи эпителия, антемияи он, вайроншавии бофтаҳо, вале бе инвазияи гишои асосӣ ва бо имконияти инкишофи бозгаштпазир тавсиф меёбад. Ду шакли дисплазияро фарқ карда мешавад: ғайриинкишофёбанда ва инкишофёбанда. Шакли ғайринуфузкунанда аз сабзиши бофтаи пайвастукунанда бо қитъаҳои гиалиноз ибo-

рат аст, ки дар он ҳиссачаҳои коҳишёфта ва маҷроҳои ба таври киставӣ васеъшуда баррасӣ шудаанд. Аз ҷиҳати сохти микроскопӣ - ин гиреҳҳои саҳти сафедранг (мастопатияи фиброзӣ) ё гиреҳҳои сафедранги бофтаҳо бо кистаҳо (мастопатияи фиброзӣ - кистозӣ) мебошад.

Шакли инкишофёбанда бо инкишофи ҳучайраҳои эпителия, миоэпителӣ ё барангезиши эпителия ва бофтаҳои пайваструкунанда тавсиф меёбад. Хелҳои он: аденоз, сабзиш намудани эпителияи дохилизамбуруғӣ ва ҳиссагӣ ва аденози тасаллубкунанда. Аденоз (мазоплазия) - калоншавии ҳиссачаҳо аз сабаби инкишофи ҳучайраҳои эпителияи ғадуд мебошад. Инкишофи эпителияи маҷроӣ ва ҳиссагӣ боиси ҳосилшавии соҳти навъи салидӣ, аденоматозӣ ва криошакл ва инкишофи бофтаи пайваструкунанда мегардад.

Ҳангоми аденози тасаллубкунанда (фиброзӣ) аломати асосӣ инкишофи ҳучайраҳои миоэпителӣ мебошад.

4

Бемориҳои илтиҳобии узвҳои таносул ва ғадудҳои ширҳосилкунанда.

Эндо метрит метавонад шадид ва музмин бошад. Шадид баъди таваллудкунӣ ё исқоти ҳамл, аз сабаби пайдоиши чанин ё тифл ба вучуд меояд. Луобпарда бо ғубори римнок ё пӯсида пушонда мешавад. Ҳангоми музмин манзараи назлаи музмини луобпардаи бачадон бо ихроҷҳои луобию римнок ё римнок мушоҳида карда мешавад. Луобпардаи пурхун буда, бо ҳучайраҳои гуногун инфилтратсия шудааст.

Мастит - илтиҳоби ғадуди ширҳосилкунанда мебошад. Мастити шадиди римнок (флегмонозӣ) бештар дар давраи баъдитаваллудкунии занҳо мушоҳида шуда, аксаран бо стафилококкҳо алоқаманд аст. Мастити музмин - одатан натиҷаи шадид буда, характери римнок дорад.

Орхит - илтиҳоби нутфадон мебошад. Орхити шадид - аксаран оризаи сироятҳои шадид (вараҷа, сӯзок махма-лак, тиф), махсусан баногушак мебошад. Орхити музмин одатан ё оқибати шадид ё зохиршавии сирояти музмин (сифилис, сил, антиномикоз) ё осебёбии нутфадон мебошад. Ҳангоми орхити шадид аксаран илтиҳоби римнок инкишоф ёфта, музмин бошад бо илтиҳоби мунташир ё грануломатозӣ тавсиф меёбад.

Простатит - илтиҳоби ғадуди олоти таносул, аксаран дар давраи ҳаёти фаъолони чинсии мардҳо мебошад.

Простатити шадид.

Аз ҷиҳати сохти морфологӣ ҳангоми шакли назлаӣ (катаралӣ) назлаи римноки маҷроҳои ғадуди олоти таносул, пурхунии рағҳо, омози байнибофтаи ғадуд пайдо мешавад; фолликулярӣ - лонаҳои инфилтратсияи илтиҳобии ғадуд; ҳангоми паренхиматозӣ - инфилтратсияи мунташир думмалҳо ва лонаҳои доначасорӣ (гранулятсия). Ҳангоми простатити музмин инфилтратсияи сибрании ғадуд, сабзиши бофтаи доначасор ва хадшагӣ ба вучуд меояд.

5

Омосҳои узвҳои таносул ва ғадудҳои ширҳосилкунанда.

Саратони бачадон - омози бадсифати таносули занона мебошад. Саратони гарданаки бачадон назар ба пайкари бачадон бештар дучор мегардад.

Ҳолатҳои қаблисаратонӣ: эндосервикозҳо, дисплазияи вазнини эпителии гарданаки бачадон.

Аз ҷиҳати сохти гистологӣ паҳнхучайра, гуддаӣ ва гуддаӣ-пахнхучайра чудо карда мешавад.

Саратони бачадон бештар дар занони аз 50 сола болотар дучор шуда, бо ҳалалдоршавии таносуби гормонҳо алоқманд аст, ки боиси табдилёбии бадсифат мегардад. Тағйиротҳои қаблисаратонӣ дар ин маврид - гиперплазия ва салилаҳои эндометрия мебошанд. аксаран ин сабзи-

шҳои экзофилӣ, аз ҷиҳати сохти гистологӣ - аденокарсинома мебошад.

Саратони тухмдонҳо метавонад аз ҷузъҳои мӯътадили байзадон, ҳосилаҳои рудиментарии он, шохаҳои чанинӣ инкишоф ёбад. Бештар шакли гиреҳи дунгичадори андозаашон гуногунро дорад.

Саратони ғадуди ширҳосилкунанда одатан дар заминаи тағйиротҳои қаблисаратонӣ (дисплазияи хушсифати ғадуди ширҳосилкунанда ва папилломаҳои маҷроғоҳо) инкишоф меёбад.

Аз ҷиҳати сохти микроскопӣ - ин гиреҳ, ё шакли мунташир ё саратони пистонак ва майдони пистонакӣ (саратони Печет) мебошад.

Барои шакли гиреҳшакл мавҷуд будани гиреҳ (қутраш якчанд сантиметр), баъзан саҳт, бо қабатҳои сафедранги бофтаҳо пушондашуда ё лонаи нарм дар буриш, ба осонӣ таҷзияшаванда хос аст. Саратони мунташир ғадудро дар паҳноӣ зиёд фаро мегирад, баъзан саратон дар пӯст инкишоф ёфта мебарояд ва дар сатҳи он ҳосилаҳои замбуруғшакли таҷзияшаванда - реше саратониро ҳосил менамояд. Аз ҷиҳати сохти гистологӣ фарқ карда мешавад:

- саратони ғайриинфилтративии (ғайриинвазиявӣ) ғадудҳои ширҳосилкунанда (метавонад дохилиҳиссавӣ ва дохилимаҷроӣ бошад);

- саратони инфилтративӣ (ғайриинвазиявӣ), ки бо дараҷаи гуногуни атипизм (ғайримукаррарият) фарқ мекунад.

Саратони ғадуди олотӣ таносул - аксаран дар пиронсолӣ дучор шуда, қабл аз инкишофи он гоҳо гиперплазияи модулярии ғадуди олотӣ таносул ба амал меояд. Ғадудҳо калон, саҳт, дунгичадор, дар буриш аз бофтаҳои фиброзӣ иборатанд, ки байни онҳо бофтаи саратонии ҳокистарранги зардранг ҷой дорад. Аз ҷиҳати сохти микроскопӣ саратон аксаран сохти аденокарсинома, баъзан - саратони

тафриқанашуда мебошад.

Саратони тухмдонҳо: семинома, саратони чанинӣ, тератобластома. Аксаран семинома дучор мегардад. Саратогни тухмдон аксаран андозаҳои калон надорад, вале решадавониҳои (метастазаи) лимфогенӣ ва гематогениро дар узву бофтаҳои гуногун медиҳад.

ЛЕКСИЯИ 23 ИЛЛАТҲОИ ҲОМИЛАДОРӢ ВА ДАВРАИ БАӢДИҲОМИЛАДОРӢ.

1. *Иллатҳои (патологияи) ҳомиладорӣ.*
2. *Эклампсия.*
3. *Ҳомиладории хориҷибачадон ва найчагӣ*
4. *Исқоти худрустаи ҷамл ва таваллуди бармаҳал.*
5. *Чанинпора, полипи (салилаи) машимавӣ, сирояти зоишии бачадон.*

1

Тағйиротҳои асабухуни, ки ҳангоми ҳомиладорӣ ба вучуд меоянд, метавонанд боиси ҳалалдоршавии инкишофи мӯътадили вай гашта, барои пайдоиши иллатҳои ҳомиладорӣ замина мегузоранд. Ба иллатҳои ҳомиладорӣ дохил мешаванд:

- гестоз;
- ҳомиладории хориҷибачадонӣ;
- исқоти худрустаи ҷамл;
- таваллуди бармаҳал;
- чанинпора.

Баъди таваллуд ё исқоти ҷамл салиласории (полипи) машимавӣ, сирояти хорионэндотелиалӣ, зоишии бачадон инкишоф меёбад.

Гестоз, ё токсикози ҳамиладорон - мафҳуме мебошад, ки обварами ҳомиладорон, нефропатия, презклялексия ва

эклалексияро муттаҳид менамояд.

Дар патогенези гестоз ҳалалдоршавии ҳадшабандии хун нақши калон мебозад, ки ба миқдори муайян бо трамбопластинро ихроҷ намудани машина алоқманд аст. Синдроми ҳадшабандии пошхӯрдаи дохилирагӣ (ДВС-синдром), махсусан ҳангоми экламкия зоҳиршаванда инкишоф меёбад.

2

Экламкия дар байни падидаҳои токсикозаи ҳомиладорон аз ҷиҳати клиникӣ нисбатан аҳамиятноктар ва хатарноктар аст, дар нимаи дуёми ҳомиладорӣ, гоҳо - дар зоишҳо ва давраи баъдиҳомиладорӣ инкишоф меёбад .

Анатомияи эътилолии экламкия.

Тағйиротҳо аз суддати (тромбози) пошхӯрдаи рағҳои хурд, некрозҳои зиёди хурд-хурд ва хуншорӣ дар узвҳои дохилӣ иборатанд. Ҳангоми ташреҳ (кушодан) омосҳо, зардпарвин, тағйиротҳои мағзи сар, шуш, дил, чигар ва гурдаҳо дарёфт карда мешаванд. Дар мағзи сар омосҳо, суддатҳо дар рағҳои хурд, хуншориҳо, дар ядроҳои зериқишрӣ, дар шуш - омос ва пневмонияи омехташудаи геморрагӣ, дар дил - суддатҳо дар рағҳо, некрозҳои лонавии миокард ва хуншориҳо дарёфт карда мешавад. Чигар калон, гуногунранг, бо хуншориҳои сершумор мебошад. Аз ҷиҳати сохти микроскопӣ дар рағҳои хурд суддат, хуншорӣ ва лонаҳои некроз дарёфт мешавад. Гурдаҳо калон, нарм, қабати қишрии онҳо варамида, гуногунранг, қабати мағзӣ - пурхун мебошад.

Аз ҷиҳати сохти гистологӣ тромбози (суддати) паҳншуда ва некрози фибриниоидии рағҳои хурд, дистрофия ва некрози эпителии найчаҳои нефрон, хуншорӣ дар бофтаҳо, махсусан пирамидаҳо ба назар мерасад.

3

Ҳомиладории хориҷибачадонӣ - инкишофи ҷанин дар хориҷи бачадон: дар найча, дар тухмдон ё ковокии шикам бештар ҳомиладории дар тухмроҳа дучор мегардад. Инкишофи ҳомиладории хориҷи бачадонӣ бо он тағйиротҳои тухмроҳаи бачадон алоқаманд аст, ки барои ба самти он ҳаракат намудани тухми бордоршуда монеъ мешаванд (илтиҳоби музмин, нуқсонҳои модарзодӣ, омос).

Ҳомиладории тухмроҳагӣ аксаран дар як тухмроҳа мушоҳида карда мешавад. Агар ҷанини якхучайравӣ (зигота) дар нӯги қисми шикамии тухмроҳа инкишоф ёбад дар бораи ҳомиладории ампулярии тухмроҳа, ва агар дар нӯги қисми бачадон бошад - дар бораи ҳомиладории байнибофтагии тухмроҳа ҳукм ронда мешавад. Ҳангоми инкишофи ҷанин, метавонад найчаро даронда, дар байни баргакҳои пйвандаки васеъ ҷойгир шавад, дар ин маврид ҳомиладории хориҷибачадонии интермегаментарӣ инкишоф меёбад.

Ҳангоми ҳомиладории бачадонӣ дар луобпардаи бачадон, ки ҷанин мутсаҳкам мегардад ва ташаккул меёбад, аксуламали десидуалӣ инкишоф меёбад, ки бо пайдоиши хучайраҳои калони десидуалӣ дар луобпарда ва дар девораи тухмроҳа тавсиф меёбад. Дар зери луобпардаи бачадон ҷанин ворид шуда, шохаҳои хорион то мушакпардаи бачадон ва рағҳои он ворид мегарданд ва унсурҳои бофтагии тухмроҳаро вайрон мекунанд.

Аз ин сабаб дар моҳҳои аввали ҳомиладории тухмроҳагӣ хуншорӣ дар ковокии тухмроҳа ва ҷудо шудани ҷанин дар ковокии бачадон - исқоти нопурраи тухмроҳагӣ ҳамл имконпазир аст. Ҷанин нобудшуда ва пардаҳои он, ки хунолуд мебошанд, тавассути нӯги фибромобриалӣ ба ковокии шикам - исқоти пурраи тухмроҳагии ҳамл номида мешаванд.

Кафидани девори тухмроҳа ва хунравӣ дар ковокии

шикам имконпазир аст, ки метавонад боиси ҳалокати зан гардад. Ҳангоми кафидани тухмроҳа чанини ҳалокшуда метавонад дар ковокии шикам қарор гирад, ки дар он ҷо ба мумификатсия ё оҳаксор мегардад (липтопедитҳо).

Ҳангоми ҷарроҳи намудан ва ҷудо карда гирифтани тухмроҳа ва чанин барои ташҳиси ҳомиладории хориҷи-бачадонӣ ошкор намудани хорион ва ҳучайраҳои десиду-далӣ мебошад.

4

Искоти худрустаи ҳамл ва зоишҳои бармаҳал қатъ намудани ҳомиладорӣ мебошанд. Қатъ намудани ҳомиладорӣ ва ҷудло намудани чанин аз бачадон барвақтар аз 14 ҳафтаи пас аз лаҳзаи бордоршавӣ ҳамчун искоти ҳамл (бачапартоӣ), дар мӯҳлатҳои аз 14 то 28 ҳафта - ҳамчун искоти дермондаи ҳамл, аз 28 то 36 ҳафта - ҳамчун таваллуди бармаҳал ифода карда мешаванд.

Ҳангоми таваллуди бармаҳал аввал тифл таваллуд мешавад, сипас парда бо ҷои кӯдак ба амал меояд. Ҳангоми искоти худрустаи ҳамл аз бачадон тамоми чанин канда мешавад, ки метавонад нигоҳдошташуда ё осебёфта, бо лахтаҳои хун бошад. Ҳангоми тадқиқи гистологии порчаҳои чанин, ки мутсақилон ҷудо мешаванд ё ҳангоми ҳарошдиани девори бачадон канда шудаанд, пардаи чанин, шоҳаҳои хорион ва бофтаи десидуалӣ (пардаи кучандаи бачадон) ошкор карда мешавад.

Искоти сунъии ҳамл аз рӯи нишондодҳои тиббӣ дар муассисаи тиббӣ иҷро карда мешавад. Искоти ҳамл дар шароитҳои зиддисанитарӣ, берун аз статсионари тиббӣ метавонад сабаби сирояти бачадон, инкишофи сепсис (оташак) гардад.

5

Чанинпора - машина бо табдилёбиҳои гидропикӣ ва

кистагии шохаҳои хорион мебошад, ки ба табдилёбӣ ба конгломерати кистаҳо ҳамбастагӣ менамояд. Аксаран дар занони ҷавон мушоҳида карда мешавад. Ҳангоми сабзиши шохаҳои хорион дар қабатҳои чуқури бачадон, махсусан дар ковокии варидҳо ва баъзани сабзида баромадани тамоми девори бачадон дар бораи ҷанинпораи вайроншуда ҳукм мебароранд. Ҳамзмон эмболияи машинавии шуш имкон дорад. Ҷанинпора метавонад бо хорионэпителимия оризодор гардад.

Полипи (салилаи) машинавӣ дар луобпардаи бачадон дар ҷои қисматҳои дар он нигоҳдошташавандаи ҳамроҳак баъди таваллудкунӣ ё исқоти ҳамл ҳосил мешавад. Полип (салила) аз шохаҳо, бофтаҳои пардаи вайроншудаи ҷанин, лахтаҳои фибрин иборат аста; дар бачадон майдончаи бофтаи пайвасткунанда пайдо мешавад. Салилаи машинавӣ сабаби хунравиҳо буда, илтиҳобро дар луобпарда ингоҳ медорад .

Сирояти зоишии бачадон - оризай хатарноки давраи баъдитаваллудӣ мебошад. Барангезандаҳои тез-тез дучоршаванда стрептококк, стафилококк ва қаламчамкиробӣ рӯдаҳо мебошад. Сироятнокшавии бачадон боиси эндометрити римнок мегардад, ки метавонад ҳангоми таваллудкунӣ ва пас аз таваллудкунӣ мушоҳида карда шавад. Сирояти зоишӣ экзогенӣ (хориҷзод) ё эндогенӣ (дохилзод) пайдо шуда метавонад. Экзогенӣ - ҳангоми риоя накардани қоидаҳои бетааффуният (асептика), эндогенӣ- ҳангоми хурҷи сирояти қаблан вучуддошта ҳангоми таваллудкунӣ.

Дар ҳолатҳои вазнин эндометрия меавтонад тааффуний гардад. Сатҳи дохилии бачадон хокистаранги чиркин шуда, бо гӯбори римнок пушонда мешавад. Сироят қад-қадӣ рағҳои лимфавӣ ва варидҳо паҳн мегардад лимфанит, флебит ва тромбофлебит инкишоф меёбад. Ба эндометрит эндометрия ва периметрия ҳамроҳ мешавад, ки

боиси перитонит (илтиҳоби сифок) мегардад. Дар натиҷаи ин бачадон ба лонаи тааффуни табдил меёбад, ки мута-марказияти сироятро муайян мекунад.

ЛЕКСИЯИ 24

МАФҲУМИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТӢ. АКСУЛАМАЛҲОИ ҚУЗӢ ВА УМУМӢ ҲАНГОМИ СИРОЯТҲО. СЕПСИС

1. *Муайян намудани бемориҳои сироятӣ.*
2. *Аломатҳои бемориҳои сироятӣ.*
3. *Сепсис ва септизamia.*
4. *Септикошиемия, эндокардити сепсисӣ, хроничесепсис.*

1

Сироятӣ - бемориҳое номида мешаванд, ки ҳомилони сироятӣ - вирусҳо, бактерияҳо, замбуруғҳо ба вучуд меоваранд. Раванди сироятӣ хеле мураккаб аст ва инкишофи онро ҳам хусусияти барангезанда, ҳам ҳолати реактивии микроорганизм муайян менамоянд.

Хусусиятҳои микроорганизм - барангезандаи бемории сироятӣ- бо ташаккул, сохтори химиявӣ, хусусиятҳои антигенӣ, характери таъсири байниҳамдигарӣ бо организми хуҷаин муайян карда мешавад. Натиҷаи ин таъсири байниҳамдигарӣ ба андозаи муайян аз ҳолати истемаҳои муҳофизатии организм - фагоситарӣ ва масунӣ вобастагӣ дорад. Ҳамзистии микро- ва макроорганизм метавонад се навъ бошад:

симбиоз - ҳамзистии микроб ва макроорганизм ба манфиати якдигар;

комменсализм, ки ҳангоми он микроб ва макроорганизм ба ҳамдигар таъсир намерасонанд;

паразитизм - ҳайоти микроб аз ҳисоби макроорганизм, ки боиси инкишофи беморӣ мегардад. Аксарияти

барангезандаҳои бемориовар ба организми инсон аз муҳити атроф тавассути даромадгоҳҳо рӯдаҳо бо ғизо; тавассути шуш бо ҳаво, ҳангоми газидани ҳашарот ворид мегарданд.

Дар чунин ҳолатҳо сухан дар бораи сирояти экзогенӣ меравад.

Вале захролудшавӣ метавонад эндогенӣ бошад, дар ин маврид сухан дар бораи сирояти эндогенӣ (дохилӣ) ё аутосироят меравад. Ҳангоми раванди сироятӣ новобаста аз характери барангезанда аксуламалҳои масуние пайдо мешаванд, ки ба вайронкунӣ ва элиминатсияи сироят равона карда шудаанд. Антителҳои дар хун гардишкунанда дар ҷавоби барангезиши антигении системаи масунӣ ҳосил мешаванд.

2

Барои бемориҳои сироятӣ як қатор аломатҳои умумӣ хосанд:

ҳар як бемории сироятӣ барангезандаи худро дорад, ки дар хун ё ихроҷҳои бемор ошкор карда мешавад;

барангезандаи сироятӣ дарвозаҳои даромадгоҳи худро дорад, ки барои ҳар як сироят хос мебошанд;

ҳангоми бемории сироятӣ ҳосилшавии аффекти (лонаи аввалия мушоҳида карда мешавад, ки одатан дар дарвозаҳои даромадгоҳ пайдо мешавад.

3

Сепсис - бемории умумии сиротякунанда мебошад, ки аз сабаби дар организм мавҷуд будани лонаи сироят пайдо мешавад ва аз дигар бемориҳои сироятӣ як қатор фарқиятҳо дорад.

Хусусиятҳои паталогоанатомии сепсис аз он иборатанд, ки тағйиротҳои ҷузъӣ ва умумӣ ҳангоми он ягон ҳел хусусиятҳои махсус надоранд, ҳоло он ки ҳангоми дигар

сироятҳо ин тағйиротҳо хосанд.

Сепсис - яке аз сироятҳои нисбатан вазнин мебошад. Ҳангоми он марганҷомии зиёд мушоҳида карда мешавад. Барои пайдоиши беморӣ бактериемия зарур аст, гарчанде он яке аз заминаҳо барои инкишофи сепсис мебошад.

Сепсис ҳамчун шакли махсуси таъсири байниҳамдигарии макро- ва микроорганизм баррасӣ карда мешавад, дар ин маврид ба таъсири инфект ва аксуламали организм ба он аҳамияти баробар дода мешавад. Аксуламали гиперергии организм ба инфект ва набудани масуният мутамарказияти сироят, чараёни ғайридаврагии сепсис, бартарӣ доштани аксуламалҳои умумӣ ва аз даст рафтани қобилияти дар як мавзё чамъ овардани сироятро мефаҳмонанд.

Тағйиротҳои чузъӣ ҳангоми сепсис дар лонаи воридшавии сироят ё аз он дуртар инкишоф меёбанд. Лонаи тааффуни ҳосил мешавад, ки махсусияти илтиҳоби римнок мебошад. Аз лонаи тааффуни сироят тез дар рағҳои лимфагӣ ва хунгард паҳн мешавад.

Тағйиротҳои умумӣ ҳангоми сепсис характери дистрофӣ, илтиҳобӣ ва гиперпластатикӣ доранд. Дистрофӣ дар узвҳои лаҳимаӣ инкишоф меёбанд, илтиҳобӣ аз равандҳои фосилавӣ иборатанд, гиперпластикӣ асосан дар бофтаҳои узвҳои хунофар мушоҳида карда мешаванд. Аз рӯи хусусиятҳои клиникӣ морфологӣ чор навъи сепсис чудо карда мешавад: септисемия, септикопиемия, эндокардити тааффуни ва сепсиси музмин.

Септизамия бо токсикози зоҳиршаванда, реактивияти баланди организм, набудани метастазаҳои (решадаво-ниҳои) римӣ ва чараёни тез тавсиф меёбад. Лонаи тааффуни ҳангоми кушодан одатан вучуд надорад ё сусти зоҳир шудааст. Пӯст ва склераҳо (сулбияҳо) зардча, синдроми геморрагӣ зоҳиршаванда аст. Гиперплазияи бофтаҳои лимфавӣ ва хунофар хос аст. Испурч ва лимфогирехҳо ка-

лонанд. Дар мағзи сурхи устухон - хунофарии пуршиддат мушоҳида карда мешавад. Дар узвҳои лаҳимавӣ (дил, чигар, гурдаҳо) илтиҳоби фосилавӣ инкишоф меёбад. Пайкари онҳо саҳт ва омоснок мебошад.

4

Септикоишемия шакли сепсис мебошад, ки ҳангоми он равандҳои римӣ дар даромадгоҳҳои сироят ва эмболии (суддати) бактериявӣ бо ҳосилшавии римхонаҳо дар узву бофтаҳо асосӣ мебошанд. Ҳангоми ташреҳи аз септикоишемия фавтидагон лонаи таафунӣ асосан дар даромадгоҳҳои сироят, бо лифангит ва лимфаденити римнок ҷойгир шудааст. Дар қисмати лонаҳо ҳамчунин тромбозҳои лимфатикӣ ва ошкор карда мешавад.

Одатан римхонаҳои аввалини метастатикӣ дар шуш, баъдан - дар дигар узвҳои силсилави даври гардиши калони хун (чигар, гурдаҳо) пайдо мешаванд. Равандҳои гиперпластикӣ дар бофтаҳои лимфавӣ ва хунофар септисемия сустар зоҳир мешаванд. Аз ин сабаб лимфаденитҳо яқбора калон намешаванд. Аксуламалҳои фосилавии илтиҳобӣ дар узвҳои лаҳимавӣ хеле мӯътадиланд ё вучуд надоранд.

Эндокардияи таафунӣ (септикӣ) - шакли махсуси сепсис мебошад, ки барои он иллатҳои тааффунии дарғотҳои дил ҳосанд.

Анатомияи эътилолӣ. Хеле ҳос аст ва асосан бо тағйиротҳо дар дил, рағҳо, испурч ва гурдаҳо зоҳир мешавад. Тағйиротҳои асосӣ ба дарғотҳои дил дахл доранд. Дар дарғотҳои тасаллубӣ ва ҳам ғайритасаллубӣ эндокардити коматозӣ-реши пайдо мешавад. Дар ин маврид одатан дар дарғотҳои тасаллубӣ ҳосилаҳои васеи тромботикӣ дар шакли салилаҳо дучор мегарданд, ки ба осонӣ майдо мешаванд ва барвақт бо оҳақ фаро гирифта мешаванд.

Баъди гирифта партофтани ин ҳосилаҳо нуқсонҳои

решӣ, гоҳо сатҳӣ, гоҳо бо ҳалалдоршавии бутунияти даргот, ҳосилшавии аневризми табақаҳо ё вайроншавии онҳо ошкор карда мешаванд. Бо усули микроскопӣ муқаррар кардан мумкин аст, ки раванд бо ҳосилшавии лонаҳои некрози бофтаи даргот (клапан) оғоз меёбад, ки дар атрофи онҳо инфилтратсияи аз ҳуҷайраҳои лимфавӣ, гистиоситҳо, макрофагҳо мушоҳида карда мешавад. Дар байни ҳуҷайраҳо бактериясутунҳо дучор мегардад.

Дар миокард ғафсшавии торҳои мушак дида мешавад. Дар гурдаҳо гломерулонефрити иммунокомплексии мунташир инкишоф меёбад. Испурч калон, бо сактаҳои вақташон гуногун мебошад. Оризаҳои тромбоэмболия бештар дучор карда мешаванд, зеро сарчашмаи тромбоэмболия - тромбоэндокардит - аксаран дар тарафи чап дил мавзё мегарад. Дар заминаи эмболия сактаи шуш, испурч, гурдаҳо, шабакии чашм, некрозҳои пӯст, қаросони (гангренаи) дасту пойҳо, рӯдаҳо, лонаҳои нармшуда дар мағзи сар инкишоф ёфта метавонанд.

Хрониосепсис (сепсиси музмин) бо мавҷуд будани лонаи тааффунии дуру дарози тааффуни ва пӯсидагҳои тааффуни тавсиф меёбад. Тағйиротҳо дар узву бофтаҳо ҳангоми хрониосепсис асосан характери коҳишёбанда (атрофикӣ) доранд. Бо лоғаршавӣ, беобшавӣ зоҳир мегардад. Испурч хурд мешавад, дар чигар, миокард, мушакҳои кундаланграҳ коҳишёбӣ ошкор карда мешавад.

ЛЕКСИЯИ 25

СИРОЯТИ РӮДАҲО. ВАБО, САЛМОНЕЛЛЕЗҲО.

1. *Вабо.*
2. *Салмонеллезҳо.*

1

Вабо - бемории шадиди сироятӣ бо асосан иллатёбии

меъдаву рӯдаи борик мебошад. Ин антропонози қатъӣ мебошад. Барангезандаш вибрион мебошад. Сарчашмаи сироят - бемори гирифтори вабо ё ҳомили вибрион, маҳзани барангезанда - об мебошад. Заҳролудшавӣ энтералӣ (рӯдаӣ) мебошад ва ҳангоми нушидани оби сироятнокшуда ба амал меояд. Давраи инкубатсионӣ 3-5 шабонарӯз давом мекунад.

Анатомияи эътилолӣ. Дар инкишофи вабо се марҳила (давра) чудо карда мешавад: энтерити вабоӣ, гастронтерити вабоӣ ва давраи сисгидӣ.

Энтерити вабоӣ характери зардобӣ ё зардобию геморрагӣ дорад. Луобпарда варам мекунад, омоснок ва пурхун аст, тарашшӯҳи зиёди (гиперсеретсияи) ҳуҷайраҳои қадаҳшакл, гишоҳи ситоплазмавӣ мушоҳида карда мешавад, ки мекафанд ва тарашшӯҳ ба ковокиҳои рӯдаҳо хориҷ карда мешавад. Энтереит ҳангоми муолиҷаи муосир аксаран бо шифоёбӣ анҷом меёбад, вале метавонад бо давраи дуҷуми бемори - гастронтеритӣ иваз шавад.

Ҳангоми гастронтерити вабоӣ падидаҳои энтерит афзоиш меёбанд, ҳуҷайраҳои эпителиалӣ хуббочасор мешаванд ва патмӯякҳо нест мешаванд; баъзе аз ҳуҷайраҳо ба ҳалокат мерасанд ва аз луобпарда чудо мешаванд. Ба энтерит гастрити зардобӣ ё зардобию геморрагӣ (хунрез) ҳамроҳ мешавад.

Беобшавии шиддатёбанда дар ин давра на танҳо бо дарунравӣ, балки бо қайқунӣ низ алоқаманд аст.

Дар давраи амидӣ тағйироти морфологӣ нисбатан равшан зоҳир мешаванд. Дар рӯдаи борик якбора пурхуншавӣ, омос, некроз ва патмӯякҳои ҳуҷайраҳои эпителиалӣ, инфилтратсияи луобпарда бо лимфоситҳо, нейтрофилия, лонаҳои хунраванда мушоҳида карда мешаванд. Ҳалқаҳои рӯдаҳо таранг буда, дар ковокии онҳо миқдори зиёди (3-4 л) моеъи беранг - бе бўй мавҷуд аст. Дар ин моеъ ошкор намудани вибрионҳо муяссар мегардад. Зардобпардаи

рӯдаҳо хушк, бо хунравихои нукта-нукта, доғҳои бунафши зардранг мебошад. Дар байни ҳалқаҳои рӯдаи борик луоби шаффоф, часпак, ришташакли дароз ошкор карда мешавад.

2

Салмонеллезҳо -сирояти рӯдаҳо мебошанд, ки барангезандашон салмонеллаҳо мебошанд. Онҳо антерокозонозҳо мебошанд. Сироят бо роҳи ғизо интиқол меёбад. Сарчашмаи сироят ҳомилон, одамони бемор, гӯшти чорвоу парранда ҳангоми риоя накардани қоидаҳои қассобӣ ва нигоҳдорӣ, тухми мурғ мебошад. Патогенез бо хусусиятҳои салмонеллаҳо, миқдори эндотоксинҳо, ки ҳангоми таҷзияи салмонеллаҳо дар рӯда озод мешаванд, муайян карда мешавад бо таъсири пирогени, ситотоксикӣ, вазо-параптикаӣ тавсиф меёбад.

Анатомияи эътилолӣ. Се шакли салмонеллез фарқ карда мешавад: байнибофтагӣ (захрогин), тааффуни ва тифи шикамӣ.

Шакли байнибофтагӣ одатан ҳангоми захролудшавии ғизоӣ инкишоф меёбад. Барои вай манзараи гастроэнтерити шадидтарин хос аст, ки боиси якбора камобшавии организм мегардад.

Шакли тааффуни аз байнибофтагӣ бо он фарқ мекунад, ки ҳангоми тағйиротҳои каме зохиршавандаи рӯдаи борик гиперемия, омос, гиперплазияи дастгоҳи лимфавӣ, мутамарказияти гематогении барангезанда бо ҳосилшавии римхонаҳои лейкоцитӣ дар узвҳо (шуш, мағзи сар) дида мешавад.

Шакли тифи шикамӣ бо домана монанд аст ва барангезандааш *salmonella paratyphi A* ва *salmonella schoUmulen* мебошад. Дар рӯдаҳо, лимфогирехҳо, испурч тағйиротҳое ба вуҷуд меоянд, ки ба домана монанданд, вале бештар зохиршавандаанд. Аз ин сабаб оризаҳои

рӯдаҳо (хунравӣ, шохрони рӯш) хеле кам дучор мешаванд.

Оризаҳо. Садмаи захрогину сироятӣ, оризаҳои римнок, ҳангоми номувофиқ муолиҷа намудан дисбактериоз.

ЛЕКСИЯИ 26 СИРОЯТИ РӮДАҲО. ИСҲОЛИ ХУНИН. ДОМАНА.

1. *Исҳоли хунин (дизентерия).*
2. *Амебиаз (домана).*

1

Исҳоли хунин (дизентерия) - бемории шадиди сирояти рӯдаҳо бо иллати бартаридоштаи рӯдаи ғафс ва падидаҳои захролудӣ мебошад. Барангезандааш гурӯҳи бактерияҳо - гнигеллаҳо мебошанд. Роҳи сироятнокшавӣ фазлавиву даҳонӣ аст. Давраи инкубатсионӣ то се шабонарӯз.

Анатомияи эътилолӣ. Тағйиротҳои чузъӣ дар луобпардаи рӯдаи ғафс (мустақим ва сигмашакл) инкишоф меёбанд. Дарачаи тағйирёбии онҳо дар самти кӯррӯда зиёд мешавад. Илтиҳоби рӯдаи ғафс колит пайдо мешавад, ки дар инкишофи он се марҳиларо фарқ мекунанд: колити катаралии (назлаи) фибринозӣ, ҳосилшавии решҳо (колитҳои решӣ) ва сиҳатшавии решҳо.

Марҳилаи колити назлаӣ (2-3 рӯз) бо гиперемия ва варамидаи луобпардаи рӯда тавсиф меёбад, ки дар он китъаҳои рӯякии некроз ва хунравӣ дучор мешаванд. Қовокии рӯда аз сабаби ташаннучи мушакпарда танг шудааст.

Ба таври микроскопӣ - кандашавии эпителияи луобпарда, ки дар ситоплазмаи он нимеллаҳо, гиперемия, омос, хунравӣ ва лонаҳои некрози луобпарда, инфилтратҳои лейкоцитарӣ дар пайкар дарёфт карда мешаванд. Дар марҳилаи колити фибринозӣ, аксаран дифтериявӣ (5-10 рӯз), ки назлаи луобро иваз менамояд, дар қуллаи чинҳои он ва

дар байни чинҳо лавҳачаи фибринозии хокистаранги сабз пайдо мешавад. Девори рӯда ғафс, ковокиаш якбора танг аст.

Ба таври гематологӣ некрози ба чун гуногун воридшавандаи луобҳо дида шуда, моддаҳои некрозӣ бо торҳои фибринӣ печонда шудаанд.

Луобпарда дар канорҳои лонаи некрозӣ, ба мисли қабати зерилуобӣ, варам аст, бо лейкоцитҳо инфилтратсия шудааст, бо дигаргуниҳо геморрагӣ (хунрез) аст. Дар қабатҳои зерилуобӣ ва зеримушакӣ тағйиротҳои дистрофӣ ва некрозӣ ошкор карда мешаванд (вакуализатсия, кариолизи ҳучайраҳои асаб, онкози торҳои асабӣ бо афзоиши лейкоцитҳо).

Марҳилаи ҳосилшавии решҳо, яъне колити решӣ дар рӯзҳои 10-12-уми беморӣ пайдо мешавад. Решҳо дар рӯдаҳои мустақим ва сигмашакл аз сабаби кандашавии ҳучайраҳои фибринозӣ ва моддаҳои некрозӣ пайдо шуда, тарҳи ноҳамвор ва чуқурии гуногун доранд. Бо ҳосилшавии решҳо имконияти хунравӣ ва суроҳшавии девораи рӯдаҳо алоқманд аст.

Марҳилаи сикатшавии решҳо бо равандҳои таҷдид (регенератсия) тавсиф меёбад ва дар давоми 3-4 ҳафтаи беморӣ идома меёбад. Нуқсони луобпарда бо доначаҳо пур мешавад, ки сабзиш мекунад. Ҳангоми нуқсонҳои кам таҷдид (регенератсия) метавонад пурра бошад; ҳангоми носозкории амиқу паҳншудаи луобпарда хадшаҳо ҳосил мешаванд, ки боиси тангшавии ковокии рӯда мегарданд. Сусти сикатшавии решҳо имкон дорад, дар ин маврид салилаҳои козиби (псевдополипҳои) луобпарда пайдо мешаванд. Дар лимфогиреҳҳо ретикарӣ ҳангоми исҳоли хун илтиҳоб - лимфаденит бо падидаҳои метаплазияи миелоидӣ пайдо мешавад. Тағйиротҳои умумии ягон ҳел тарҳҳои хос вучуд надорад. Дар испурҷ гиперплазияи ҳучайраҳои лимфоидӣ ба вучуд меояд, вай калон мешавад, аммо хеле кам.

Дар дилу чигар аксаран дистрофияи чарбӣ мушоҳида карда мешавад, ғайр аз ин дар чигар некрозҳои хурдлона имкон дорад. Дар гурдаҳо - некрози эпителияи найчаҳои печубхурдаи гурдаҳо.

Оризаҳо пеш аз ҳама бо тағйиротҳои решии рӯдаи ғафс алоқаманданд: хунравии дохилирӯдавӣ, суроҳшавӣ, стенозҳои хадшагии рӯда, оризаҳои берунирӯдавӣ: артрит, пиелонефрит, бронхопневмония, думмалҳои пилефлебити чигар, амиелоидоз, лоғаршавӣ, захролудӣ.

2

Амебиаз - бемории музмини протозойӣ мебошад, ки асоси онро колити хуруҷкунандаи решӣ ташкил медиҳад. Онро соддатаринҳо аз синфи решапойҳо ба вуҷуд меоваранд. Захролудшавӣ бо роҳи ғизоӣ тавассути амебаҳои сироятнокшуда ба вуҷуд меояд.

Анатомии эътилолӣ. Ба дохили рӯдаи ғафс ворид гашта, амеба ва маҳсулоти фаъолияти ҳаётии он боиси омос ва гистализ, некрози луобпарда, ҳосилшавии решҳо мегарданд. Тағйиротҳои некрозӣ-решӣ нисбатан бештар дучор мешаванд ва дар кӯррӯда кам зоҳиршавандаанд. Аксаран решҳо дар тамоми паҳноии рӯдаи ғафс ва ҳатто дар рӯдаи тухигоҳ ҳосил мешаванд.

Ба таври микроскопӣ китъаҳои некрози луобпарда дар сатҳи болои он варам мекунанд, онҳо ранги хокистаранги тира ва сабзранг доранд. минтақаи некроз ба қабатҳои зерилуобӣ ва мушакӣ чуқур ворид мегардад. Ҳангоми ҳосилшавии реш канорҳои он ковокидор ва дар қар овезонанд. Амеба дар сарҳади байни бофтаҳои мавтшуда ва нигоҳдошташуда қарор дорад.

Аксуламали ҳуҷайравӣ дар девори рӯдаҳо суст зоҳир мешаванд. Ҳангоми ҳамроҳшавии сирояти дуюмбора инфилтрат аз нейтрофилҳо сар зада, рим пайдо мешавад. Решҳои чуқур бо хадшаҳо пайваست шудаанд. Гоҳо шаклҳои флегмонозӣ ва ганренозии колит инкишоф меёбад.

ЛЕКСИЯИ 27 БЕМОРИҲОИ УЗВҲОИ НАФАСКАШӢ. БРОНХОПНЕВМОНИЯ.

1. Бемориҳои узвҳои нафаскашӣ.
Полоиши аэродинамикӣ.
2. Бронхопневмония.

1

Бемориҳои узвҳои нафаскашӣ бо гуногунрангии падидаҳои клиникӣ морфологӣ худ зоҳир мешаванд. Дар пайдоиши бемориҳои узвҳои нафаскашӣ барангезандаҳои биологӣ бемориовар (вирусҳо, бактерияҳо), омилҳои химиявӣ ва ҷисмонӣ, омилҳои ирсӣ ва хусусиятҳои синнусолӣ аҳамияти муҳим доранд. Пайдоиши бемориҳои узвҳои нафаскашӣ на фақат бо тасири омили бемориовар, балки бо ҳолати монеаҳои муҳофизатии системаи нафаскашӣ муайян карда мешавад, ки ба онҳо болоиши аэродинамикӣ, омилҳои гуморалӣ ва ҳуҷайравии муҳофизати умумӣ ва ҷузъӣ дохил карда мешаванд.

Полоиши аэродинамикӣ - ин трахеити мукоселлюлярӣ мебошад, ки бо эпителияи мижгонакдори бронхҳо амалӣ мегардад. Ба омилҳои гуморалии муҳофизати ҷузъии силсилаи нафаскашӣ иммуноглобулинҳои тарашшӯхӣ (Zg A), силсилаи комплемент, интерферон, лезосим, аҳо сулфанат нимфонинҳо, ба омилҳои гуморалии муҳофизатӣ умумӣ бошад - Zg M Zg G дохил карда мешаванд. Омилҳои ҳуҷайравии муҳофизати ҷузъӣ - макрофагҳои алвеоларӣ, муҳофизати умумӣ бошад - лейкоцитҳо мебошанд.

2

Бронхопневмония илтиҳоби шуш мебошад, ки аз сабаби бронхит ё бронхиолит инкишоф меёбад. Вай характери лонавӣ дорад. Беморӣ этиологияи гуногунранг до-

рад: ҳомилони микробӣ (пневмококкҳо, стафилококк, стрептококк, энтеробактерия, замбуруғҳо, миелоплазма), омилҳои химиявӣ ва ҷисмонӣ. Инкишофи бронхопневмония бо бронхит ё бронхиолитии шадид алоқаманд аст.

Бронхопневмония бо роҳи гематогенӣ пайдо мешавад. Дар инкишофи пневмонияи лонавӣ (илтиҳоби лонавии шуш) аутосироят ҳангоми аспиратсия – пневмонияи аспиратсионӣ, падидаҳои рукудӣ, дар шуш – пневмонияи гипостатикӣ, аспиратсияи ва ихтилолҳои асабию рефлексӣ – пневмонияи баъдичарроҳӣ аҳамияти калон дорад.

Анатомияи этиологӣ. Ҳангоми ҳар гуна этиология асоси бронхопневмонияро бронхит ё бронхионит ташкил медиҳанд, ки аз шаклҳои гуногуни зардобӣ, луобӣ, римнок, омехта иборатанд. Дар ин маврид луобпардаи пурхун ва варамнок мешавад, барангезиши луобпарда бо ғадудҳо ва ҳучайраҳои қадаҳшакл пурзӯр мешавад, ҳучайра бо бофтаи рӯйпӯшкунандаи луобпарда канда мешаванд. ки боиси осебёбии механизми мукозитари тозакунии шоҳҳои шуш мегардад.

Девори бронху бронхиолаҳо аз ҳисрби инфилтратсия ғафс мешавад, ки вазифаи гузаронидани бронхҳоро вайрон мекунад. Ин дар навбати худ ба аспиратсияи луобпардаи сироятнокшуда дар шӯъбаҳои дисталии шоҳҳои шуш муосидат менамояд.

Лонаҳои илтиҳоб ҳангоми бронхопневмония одатан дар сегментҳои ақиб ва ақибу поении шушҳо - II, VI, VIII, IX, X пайдо мешаванд. Андозаи онҳо гуногун, ғафс, дар буриш ҳарситаранги сурх мебошанд. Вобаста аз андозаи лонаҳо бронхопневмонияи милиарӣ (алвеолит), асинозӣ, ҳиссагӣ, якҷояшавандаи ҳиссагӣ, сегментарӣ ва нимсегментариро фарқ мекунанд.

Дар алвеолаҳо ҷамъшавии тарашшӯҳ (экссудат) бо омехтаи нейтрофилҳо, макрофагҳо, эритроцитҳо, эпителии кандашудаи алвеоларӣ мушоҳида карда мешавад.

Тарашшӯх нобаробар тақсим мешавад. Тавораҳои омехтаи алвеоларӣ бо инфилтрати ҳуҷайравӣ пушонда шудаанд. Вобаста аз ҳомили сирояти боиси бронхопневмония шаванда хусусиятҳои морфологии он фарқ карда мешаванд.

Бронхопневмонияи стафилококкӣ одатан аз сабаби стафилококки тиллоӣ ба вучуд меояд, аксаран он баъди сирояти вирусӣ аз сар гузарондашуда ошкор карда мешавад. Вай бо чараёни вазнин фарқ мекунад. Аксаран дар сегментҳои IX ва Ч лонаҳои пӯсиш ва некроз дарёфт карда мешавад. Баъди тавассути бронхҳо ҳолӣ шудани рим ковокиҳо ҳосил мешаванд. Дар доираи лонаҳои некроз илтиҳоби дилу хунрез инкишоф меёбанд.

Бронхопневмонияи стафилококкӣ аксаран аз сабаби стрептококки гемолитикӣ, гоҳо дар ҳамбастагӣ бо вирус ба вучуд меояд. Ба таври шадид чараён меёбад. Шуш қаллон мешавад, аз ковокиҳо моеъи хундор мешорад. Дар бронхҳо инфилтратсияи лейкоцитарӣ, некрози девори бронхҳо, ҳосилшавии думмалҳо ва бронхоэктазҳо имкон дорад.

Бронхопневмонияи стрептококкӣ бо ҳосилшавии лонаҳое тавсиф меёбад, ки бо бронхиолаҳо зич алоқаманданд, дар тарашшӯх -нейтро-филҳо, фибриллаҳо, дар кано-ри лонаҳо - минтақаи омос, ки дар он ҷо микробҳо зиёданд. Шуш дар буриш гуногунранг мебошад.

Ҳангоми бронхопневмонияи замбуруғӣ лонаҳои андозаашон гуногун, зич, дар буриш рангашон хокситарранги гулобӣ, дар маркази лонаҳо - таҷзияшавӣ. Бронхопневмонияҳои вирусӣ дар шакли холис камтар дучор мешаванд, зеро ҳангоми онҳо тавораи энтели вайрон мешавад, ки барои инкишофи сирояти дуҷумбораи бактериявӣ му-соидат мекунад.

ЛЕКСИЯИ 28

БЕМОРИҲОИ УЗВҲОИ НАФАСКАШӢ. БРОНХОП- НЕВМОНИЯИ ХУНОҚӢ. САРАТОНИ ШУШ.

1. Пневмонияи хуноқӣ.

2 . Саратони шуш.

1

Пневмонияи хуноқӣ - бемории сироятию аллергии шадид мебшад, ки ҳангоми он як ё якчанд ҳиссаҳои шуш иллатнок гардида, дар алвеолаҳо тарашшӯҳи фибринозӣ, дар чанб (плевра) бошад - ғубори фибринозӣ. Барангезандаи беморӣ пневмококкҳо мебошанд.

Морфогенез, анатомияи эътилолӣ. Чор марҳилаи инкишофи пневмонияи хуноқӣ чудо карда мешавад - хунҷамъшавӣ, сурхрангӣ, тирарангӣ, ҷавобшавӣ. Ҳамаи марҳилаҳо 9-11 рӯзро дар бар мегиранд.

Марҳилаи хунҷамъшавӣ як шабонарӯз идома ёфта, бо гиперемияи якбора ва омози микробии ҳиссаи иллатёфта тавсиф меёбад. Шуш калон, саҳт пурхун.

Марҳилаи сурхрангӣ дар рӯзи 2-юми беморӣ пайдо мешавад. Дар заминаи пурхунӣ ва омозилиадиази эритроцитҳо пурзӯр мегардад, ки дар ковокиҳои алвеолаҳо ҷамъ мешавад. Ба онҳо нейтрофилҳо омехта мешаванд, байни ҳуҷайраҳо нахҳои фибрин меафтанд. Бофтаи шуш сурхи сиёхранг, зичии чигариро ба даст меоваранд. Лимфогирехҳои атрофӣ нисбати ҳиссаи иллатёфтаи шуш калон, пурхунанд.

Марҳилаи тирарангӣ дар рӯзи 4-6-уми беморӣ пайдо мешавад. Дар ковокиҳои алвеолаҳо (хубочаҳо) фибрин ҷамъ мешавад, ки бо макрофагҳо фагоситатсия шуда, пневмококкҳо таҷзия мешаванд. Ҳиссаи шуш дар ин марҳила калон, зич, вазнин аст, дар ҷанбаи ғуборҳои зиёди фибринозӣ мавҷуданд. Дар буриш шуш ранги хокистарӣ дошта,

аз сатҳи арзанмонанд моёъи хира мешорад. Лимфагиреҳҳои решаи шуш сафеди гулобӣ, калонанд, ба таври гистологӣ дар онҳо манзараи илтиҳоби шадид ба назар мерасад.

Марҳилаи ҷавобшавӣ дар рӯзи 9-11-уми беморӣ фаро мерасад. Тарашшӯҳи фибринозӣ бо таъсири ферментҳои протеолаитикии нейтрофилҳо ва макрофаҳо об ҷаббида мешавад. Ба падидаҳои умумии пневмонияи ҳуноқӣ тағйиротҳои дистрофикии узвҳои лаҳимаӣ, пурхунии онҳо, гиперплазияи испурҷ ва мағзи сурхи устухон, пурхунии (омоси) мағзи сар дохил карда мешавад. Дар гиреҳҳои асабӣ симпатикии гардан гиперемияи якбора, инфилтратсияи рағҳо ва тағйиротҳои дистрофикии гиреҳи асаб мушоҳида карда мешавад.

Оризаҳо. Оризаҳои шуш аз сабаби вайроншавии вазифаи фибринолитикии нейтрофилҳо инкишоф меёбанд. Ҳангоми нокифоягии ин вазифа моддаи фибрин дар алвеолаҳо ба ташаккул - карнификатсия дучор мегардад. Шуш ба бофтаи беҳавои зичи гӯштин мубаддал мешаванд.

Ҳангоми фаъолнокии аз ҳад зиёди нейтрофилҳо инкишофи думмал ва тосидани шуш имконият дорад. Ҳамроҳшавии рим ба плеврити фибринозӣ боиси биопиемаи ҷанб (плевра) мегардад. Оризаҳои ғайришушӣ ҳангоми мутамарказияти сироят мушоҳида карда мешаванд Медиастенити римнок, перикардит, перитонит, римхонаҳои мендалитики дар мағзи сар, менингити римнок, эндокардити шадиди решӣ ё полинозӣ-решӣ, артрити римнок пайдо мешавад.

2

Саратони шуш дар аксари ҳолатҳо дар эпителияи бронхҳо ва ҳеле кам - аз эпителияи алвеоларӣ инкишоф меёбад.

Этиология ва патогенез барои саратони марказӣ ва канории шуш аҳамияти яхела надоранд.

Дар этиологияи саратони марказии шуш пеш аз ҳама моддаҳои нафасгирандаи консерогенӣ, тамокукашӣ аҳамият доранд. Дар инкишофи саратонии канории шуш нақши моддаҳои консерогенӣ хеле калон аст.

Анатомияи эътилолӣ.

Саратони наздирешагӣ (марказӣ) дар луобпардаи қисмати танагӣ, ҳиссагӣ ва ибтидоии бронхҳои сегментарӣ, сараввал дар шакли ўқдаи (пайсаи) начандон калон инкишоф меёбад, минбаъд бошад вобаста аз характери инкишоф (экзофилӣ, эндофилӣ) шакли рушди эндобронхиалии мунташир, ўқдадор, шохнокшуда ё ўқдадору шохнокшударо мегирад. Аксаран ва барвақт ба андозаҳои калон нарасида, бо ателектази сегментарӣ ё ҳиссавӣ оризадор мешавад ё ки боиси вайроншавии вазифаи гузаронандагии бронх, инкишофи пневмония, думмал, бронхоэктазҳо мегардад ва ба ин васила саратони бронхҳоро рӯйпуш менамояд.

Ҳангоми ба ҷанб (плевра) паҳн шудани саратон плеврит характери зардобию хунрез ё хунрез дорад. Ба таври гистологӣ саратони наздирешагӣ сохти ҳучайрапахн, гоҳо саратони ғадудӣ ё тафриқанашударо дорад.

Саратони канорӣ дар луобпардаи шӯъбаи канории бронхи сегментарӣ, шохаҳои он, гоҳо – аз эпителияи алвеоляҳо пайдо мешавад. Муддати зиёда ба таври экспансивӣ дар шакли ўқда инкишоф ёфта, то даме ба таври клиникӣ зохир намешавад, ки ҳангоми муоинаи тасодуфӣ муқаррар карда нашавад, ба ҷанб (плевра) ё бронхҳои танагӣ ё сегментарӣ нарасад, ки фишурдашавӣ ва афзоиши онҳо боиси вайрон шудани вазифаи гузаронандагии бронхҳо ё амелектази компрессионӣ ё бактерасионӣ мегардад.

Аксаран саратон дар қисмати хадша дар наздикии ҷанб дар ҳар гуна қисмати шуш инкишоф ёфта, метавонад ба ҷанб гузарада, ки дар натиҷа вай ғафс гаридад, дар ковокии ҷанб тарашшӯхи зардобию хунрез ё хунрез ме-

гардад, ки ба шуш фишор меоварад.

Саратони омехта (фаровон) бофтаи нарми сефедранг, гоҳо тачзияшаванда мебошад.

Намуди микроскопии саратон гуногунранг мебошад. Дар саратони тафриқашудаи шуш, одатан, аломатҳои бофтаҳо нигоҳ дошта мешавад, ки аз он баромадааст: лоубҳосилкунӣ дар аденокарсинома, кератинҳосилкунӣ дар саратони хучайрапахн.

Саратони хучайрапахн (эпидермоидӣ) метавонад зиёд, мӯътадил-ё камтафриқашуда бошад. Барои зиёдтафриқашуда ҳосил шудани кератин ва ташаккули дурдонаҳои саратонӣ, барои мӯътадилтафриқашуда - митозҳо ва гуногуншаклии хучайраҳои он, барои камтафриқашуда гуногуншаклии хучайраҳо, миқдори зиёди митозҳо хос аст.

Аденокарсиномаи зиёдтафриқаноки шуш аз сохторҳои атсинарӣ, тубулярӣ ё пистонакӣ иборат аст, ки хучайраҳои онҳо луобро барангезиш медиҳанд, аденокарсиномаи мӯътадилтафриқаноки сохтори ғадудию бонуфуз дорад, дар он миқдори зиёди митозҳо аст, луобҳосилшавӣ танҳо дар қисме аз сохторҳо мушоҳида карда мешавад.

Аденонасиоломаи камтафриқанок аз сохторҳои чарбӣ (салидные) иборат аст. Саратони тафриқанашудаи анапластикӣ хурдхучайра ва калонхучайра шуда метавонад. Хурдхучайра аз хучайраҳои хурди лимфоситмонанд ва шакли донаи ҷавмонанд бо ядроҳои гиперхромӣ иборат аст.

Саратони калонхучайра аз хучайраҳои калони гуногуншакл баъзан азимчуссаи бисёрядродор иборат аст. Саратони ғадудию панҳнғадудӣ, ки ҳамчунин омехта номида мешавад, аз ҳамбастагии ду шакл - аденокарсинома ва саратони хучайрапахн иборат аст.

Оризаҳо: решадавонӣ ва тағйиротҳои дуҷумбораи шуш. Решадавони дар лимфогиреҳо наздибронхиалӣ ва бифуркатсионӣ, гарданӣ ва ғайра (лимфогенӣ) пайдо ме-

шаванд. Дар байни решадавониҳои гематогенӣ решадавонӣ дар мағзи сар, гурдаҳо ва ғадудҳои болои гурда нисбатан хосанд. Саратонҳои наздирешагӣ аксаран решадавонии лимфагенӣ, саратони канорӣ бошад - гематогениро ҳосил мекунанд.

Тағйиротҳои дуҷумбораи шуш бо инкишофи ателепсикоз, некрози омос (ҳосилшавии ковокиҳо, хунравӣ, пӯсиш) алоқаманданд.

ЛЕКСИЯИ 29 БЕМОРИИ СИЛИ АВВАЛИЯ.

1. Муайянкунӣ ва хусусиятҳои бемории сил.
2. Этиология ва патогенез
3. Тавсифи бемории сили аввалия.
4. Анатомияи эътилолии бемории сили аввалия.
5. Вариантҳои ҷараёни бемории сили аввалия.
6. Шакли лимфогенӣ, ҷараёни музмини бемории сили аввалия.

1

Бемории сил - бемории музмини сироятӣ мебошад, ки хангоми он ҳама узвҳои одам, вале бештар шуш иллатнок мегарданд.

Хусусиятҳои аслии, ки онро аз дигар сироятҳо фарқ мекунонанд:

- убиквитарият (дар лот. *ubique* - «ҳамаҷо») сироятҳои эпидемиологӣ, клиникӣ ва морфологӣ;
- духӯрагии сил, ки вобаста аз таносуби масуният ва аллергия метавонад падидаи: сироятнокшавӣ ва ҳам беморӣ бошад;
- полимброфизми падидаҳои клиникӣю морфологӣ;
- ҷараёни музмини мавҷшакл - банавбат ҳамдигарро иваз намудани хуруҷҳо ва беҳбудии (ремиссияи) беморӣ.

2

Этиология ва патогенез. Силро микобактерияи сил ба вучуд меоварад, ки соли 1882 аз тарафи Кох кашф карда шуда буд. Патогенез (бемориоварӣ) аз воридшавии микобактерияҳо ба организм ва тасъсири байни ҳамдагарӣ бо он, бофтаву увзҳо иборат аст. Пайдоиш, чараён ва анҷоми беморӣ ба андозаи муайян бо ҳолати масунии организм, реактивияти он асоснок гардидааст.

Анатомияи эътилолӣ. Падидаҳои клиникӣю морфологии сил фарқ карда мешавад: сили аввалия, гематогенӣ, дуҷумбора.

3

Бемории сили аввалия тавсиф меёбад:

- инкишофи беморӣ дар давраи сироятнокшавӣ, яъне ҳангоми вохӯрии аввали организм бо мабдаи сироят (инфект);
- сенсбилизатсия (муҳасисшавӣ) ва аллергия, аксуламалҳои гиперҳассосияти навъи фаврӣ;
- бартарӣ доштани тағйиротҳои тарашшӯхӣ-некрозӣ;
- аксуламалҳои махсус дар шакли васкулит, артерит, серозит ва ғайра.

Одатан роҳи захролудшавӣ аэрогенӣ мебошад, роҳи мененгиалӣ низ имконпазир аст.

4

Анатомияи эътилолӣ. Зоҳиршавии морфологии сили аввалияи маҷмӯи аввалияи сил мебошад. Вай аз се ҷузъ иборат аст: лонаи иллат дар узв- лонаи аввалия ё аффект, илтиҳоби силии лимфарағҳо - лимфангит илтиҳоби силии рағҳои минтақавии лимфагиреҳҳо- лимфаденит.

Ҳангоми захролудшавии аэрогенӣ дар шуш лонаи аввалияи сил (аффект) ба таври зеричанбӣ дар сегментҳои

нисбатан хубтар тахвияшаванда (ҳавогузаронанда), аксаран дар қисми рост дар сегментҳои шуш - 3, 8, 9, 10 пайдо мешавад. Вай аз дигаргуниҳои илтиҳоби тарашшӯҳӣ иборат аст, айнаи замонтарашшӯҳ тез дучори некроз мегардад. Лонаи пневмонияи панирмонанд ҳосил мешавад, ки бо минтақаи илтиҳоби атрофӣ ихота карда ушдааст. Андозаҳои ҳолати беморӣ гуногун аст: он ё алвеолите мебошад, ки базӯр ба таври микроскопӣ фарқ карда мешавад, вале аксаран илтиҳоб ҳубобчаи ҳаводори шуш (асинус) ё ҳиссача, гоҳо – сегмент тамоми ҳиссачаро зиёд менамояд.

Раванди махсуси илтиҳобӣ хеле тез ба рағҳои назди лонаи аввалия паҳн мешавад - лимфангити силӣ инкишоф меёбад. Вай аз лимфостаз ва қад-қади рағҳои лимфавӣ ва бофтаҳои омосии периваскулярӣ (атрофи рағҳо) ташаккул ёфтани дӯнгичаҳои силӣ иборат аст.

Гӯё раҳчае аз лонаи аввалия ва лимфогиреҳҳои назди-решагӣ ҳосил мешавад.

Баъдан раванди илтиҳобӣ тез ба лимфогиреҳҳои бронху шушҳо (бронхопулмоналӣ), бронхҳо (бронхиалӣ) ва бифуркасионӣ мегузарад, ки дар онҳо раванди махсуси илтиҳобӣ бо некрози тез инкишофёбандаи панирмонанд инкишоф меёбад. Лимфаденити интиҳоии силоӣ пайдо мешавад. Лимфогиреҳҳо калон мешаванд, дар буриш ба моддаи панирмонанд иборат аст. Дар насчи миёнадевор, ки дар назди лимфогиреҳҳои ба таври панирмонанд тағйирёфта ҷойгир шудаанд, илтиҳоби периорокалӣ инкишоф меёбад, дар ҳолатҳои нисбатан вазнинтар ҳатто лонаҳои фалламонанд дучор мешаванд.

Ҳангоми захролудшавии гизой (алиментарӣ) маҷмӯи аввалияи силӣ дар рӯдаҳо инкишоф ёфта, ҳамчунин аз се ҷузъ иборат аст. Дар бофтаи лимфоидии қисми поёнии рӯдаи борик ё кӯррӯда дӯнгичаҳо ва некрозҳои силӣ бо минбаъд дар луобпарда ҳосилшавии решҳо (аффекти аввалияи) ташаккул меёбанд. Баъдан лимфангити силӣ бо

пайдо шудани дунгичаҳо кад-қади рағҳои лимфагард ва лимфаденити панирмонанди нисбати аффекти аввалияи лимфагиреҳҳои репсонарӣ пайдо мешавад.

5

Се варианти чараёни бемории сили аввалия фарқ карда мешавад:

- фуру нишастани сили аввалия ва сиҳатшавии лонаҳои маҷмӯи аввалия;
- шиддатёбии сили аввалия бо мутамарказияти раванд;
- чараёни музмин.

Фуру нишастани сили аввалия ва сиҳатшавии лонаҳои маҷмӯи аввалия. Ин равандҳо дар лонаи аввалияи шуш оғоз меёбанд. Сараввал илтиҳоби гирдилонавӣ чаббида мешавад, аксуламали тарашшӯхӣ бо сермахсул (продуктивӣ) иваз мешавад; дар атрофи лонаи пневмонияи панирмонанд навард аз ҳучайраҳои эпителиодӣ ва лимфодӣ ҳосил мешавад. Аз беруни ин навард гранулемаҳои фиброзии силӣ пайдо мешаванд. Дар атрофи лонаи аввалия ғилофаке ҳосил мешавад, ки қабатҳои берунаи он аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок иборат аст, қабати дохилии ғилофак тадричан бо тору нахҳо ғанӣ мегардад ва бо қабати беруна омехта мешавад. Аз тарафи қабати беруна рағҳои хунгарду лимфагард баромада, ки метавонанд ба қабатҳои дохилии ғилофак рафта, бевосита бо моддаи панирмонанд иртибот пайдо намоянд, ки беоб, оҳаксор (петрификатсия) мешаванд. Дар қабати беруна ҳучайраҳои бисёрҷаҳрагӣ пайдо мешаванд, ки моддаи оҳаксоршудаи панирмонандро чаббида мегиранд. Дар ҷойи онҳо болоҷаи устухонӣ бо ҳучайраҳои мағзи сурхи устухон ҳосил мешавад; масалан, лонаи аввалаи саҳтшуда ба устухоншуда (лонаи Гон) табил меёбад. Дар рӯдаҳо дар ҷои решӣ аввалия ҳангоми сиҳатшавӣ ҳадшача, дар лимфагиреҳҳо бошад - петрификатҳо ҳосил мешаванд.

Шиддатёбии сили аввалия бо мутамарказияти раванд дар чор шакл зоҳир мегардад: гематогенӣ, лимфогенӣ, дар инкишофи аффе́кти аввалия ва омехта. Шакли гематогенӣ (мутамарказшавӣ) аз сабаби барвақт воридшавии микобактерия ба хун (диссеминатсия) аз аффе́кти аввалия ё аз лимфогиреҳҳои ба таври панирмонанд тағйирёфта инкишоф меёбад. Микобактерия дар узвҳо боиси ҳосилшавии дӯнгичаҳои андозаашон аз арзанмонанд - сили арзанмонанд - то калони андозаашон баробари нахӯд ва зиёдтар мегардад. Аз ин сабаб шаклҳои арзанмонанд ва калонлонаи мутамарказияти гематогенӣ фарқ карда мешавад.

6

Шакли лимфогенӣ бо ба раванд ҷалбшавии илтиҳоби махсуси лимфогиреҳҳои бронхиалӣ, бифуркатсионӣ, зери ва болоиқулфакӣ, талхагӣ зоҳир мегардад. Дар ин ҳолат лимфогиреҳҳои ба таври панирмонанд тағйирёфта ковокии бронхҳоро фишор медиҳанд, ки боиси инкишофи пучшавии шуш (ателектаз) ва пневмония мегардад.

Инкишофи аффе́кти аввалия - шакли нисбатан вазнини шиддатёбии сили аввалия мебошад, ки ҳангоми он некрози панирмонанди минтақаи гирдилонавӣ фаро расида, дар атрофи аффе́кти аввалия қитъаҳои тозаи илтиҳоби тарашшӯхӣ пайдо мешаванд.

Лонаи аввалия аз атситарӣ ба лобулярӣ табдил меёбад, сегментарӣ, лобулярӣ - пневмонияи панирмонанди лобулярӣ пайдо мешавад. Ин шакли аз ҳама вазнини сили аввалия мебошад. Дар дигар ҳолатҳои лонаи аввалия лобулярӣ ё сегментарии пневмонияи панирмонанд об мешавад ва дар ҷои он суроҳии аввалияи шуш ҳосил мешавад.

Шакли аввалия ҳангоми сустшавии организм пас аз сироят, ҳангоми авитминозҳо, гуруснагӣ ва ғайра мушо-

ҳида карда мешавад. Дар ин маврид аффеки калони аввалия дарёфт карда мешавад, бронхоаденити панирмонанд метавонад бо обшавии моддаи некрозӣ ва ҳосил шудани носурҳо ориздор гардад.

Чараёни музмини сили аввалия дар он ҳолатҳое пайдо мешавад, ки дар аффеки сиҳатшудаи аввалия раванди махсуси илтиҳобӣ дар ҷузьи лимфогиреҳчаи маҷмӯи аввалия чараёни оҳиста-оҳиста шиддатёбандро бо ивазшавии хуруҷҳо ва фурунишинӣ касб мекунад. Дар ин маврид муҳассисшавии (сенсibiliзатсияи) организм ба вуҷуд меояд - ҳассосияти он ба таъсири гуногуни ғайримуқаррарӣ зиёд мегардад.

Реактивияи баланди организм ба таври клиникӣ бо озмоишҳои пӯстии туберкулинӣ ва дар бронху устухонҳо пайдо шудани тағйиротҳо ошкор карда мешавад (пролифератсияи мунташир ё уқдагии ҳуҷайраҳои лимфоидӣ, макрофагҳо, равандҳои гиперпластикӣ дар бофтаи хунофар, диспротеиноз, инкишофи амилоидоз).

ЛЕКСИЯИ 30 СИЛИ ГЕМАТОГЕНӢ.

1. Сили гематогенӣ. Намудҳои сили гематогенӣ.
2. Сили мутамаркази гематогенӣ
3. Сили гематогенӣ бо иллати бартаридоштаи шуш.
4. Сили гематогенӣ бо иллатҳои бартаридоштаи ғайришушӣ.

1

Сили гематогенӣ як қатор падидаҳои бемориеро муттаҳид менамояд, ки дар организми одам баъди мӯҳлати муайяни баъди аз сар гузарондани сирояти аввалия пайдо мешаванд ва инкишоф меёбанд ва сили баъди аввалия мебошад. Сили гематогенӣ дар бемороне пайдо мешавад, ки сирояти аввалия дар онҳо тағйиротҳоро дар шакли ло-

наҳои кишт дар узвҳои гуногун боқӣ гузоштааст.

Се намудани сили гематогенӣ фарқ карда мешавад:

- мутамарказ;
- сил бо иллати бартаридоштаи шуш;
- сили гематогенӣ бо иллатҳои бартаридоштаи ғайришушӣ.

2

Сили мутамаркази гематогенӣ шакли нисбатан вазнини беморӣ бо доначаҳои ҳамвор дар узвҳо, дӯнгичаву лоначаҳои сили мебошад. Дар баъзе ҳолатҳо дар тамоми узвҳо омосаҳои некрозӣ бе аксуламалҳои профилеративӣ ё сусти зоҳиршавандаи тарашишӯхӣ (намуди некрози сили мутамарказ) ташаккул меёбанд. Ин сепсиси (оташаки) пуршиддаттарини сили мебошад. Дар ҳолатҳои дигар дар узвҳо дунгичаҳои хурди арзанмонанд пайдо мешаванд- ин сили шадиди умумии арзанмонанд мебошад. Вай аксаран бо мененгит анҷом меёбад. Гоҳо сили шадиди умумии калонлона мушоҳида карда мешавад, ки бо ҳосилшавии лонаҳои калони сили (то 1 см) дар узвҳо тавсиф меёбад.

3

Сили гематогенӣ бо иллати бартаридоштаи шуш дар шуш бартарӣ доштани доначаҳо тавсиф меёбад, ҳол он ки дар дигар узвҳо онҳо ягонаанд ё вучуд надоранд. Дар шуш мавҷуд будани доначаҳои зиёди хурди арзанмонанд дар бораи сили арзанмонанди шуш шаҳодат медиҳад. Вай метавонад шадид ва музмин бошад.

Ҳангоми сили арзанмонанди шадид шуш вармида, патнок мебошанд; дар онҳо дӯнгичаҳои хурде ламс карда мешаванд, ки ҳамеша дар сегментҳои болоӣ назар ба поёӣ ғафстар ҷойгир шудаанд.

Ҳангоми сили арзанмонанди музмин ҳадшабандии дӯнгичаҳо ва инкишофи эмфиземаи устувори шушҳо им-

конпазир аст, ки аз сабаби он таҳмили дил зиёд мегардад ва хучайраҳои мушаки меъдачаи чапи дил ҳаҷман калон мешаванд, ки онро ҳамчун - дили шушӣ мушоҳида карда мешавад.

Ҳамчунин сили музмини калонлона ё гематогенӣ-пош-хӯрдаи шуш фарқ карда мешавад, ки барои он асосан мавзеъгирии қишрию ҷанбии лонаҳо дар ҳарду тарафи шуш ва аксуламали сермахсули бофтаҳо инкишофи пневмосклерози шабакадор, эмфизема ва дили шушӣ ва мавҷуд будани лонаи ғайришушии силӣ хос аст.

4

Сили гематогенӣ бо иллатҳои бартаридоштаи ғайришушӣ аз лонаҳо-киштҳои инкишоф меёбад, ки бо роҳи гематогенӣ дар давраи сирояти аввалия дар ин ё он узв ворид карда шудаанд. Аксаран устухонҳои скелет (сили устухону буғумҳо) ва силсилаи ихроҷи таносул (сили шуш, узвҳои ихроҷу таносул), пӯст ва дигар узвҳо иллатнок мегарданд.

Сили устухону буғумҳо аксаран дар кӯдакон дучор мегардад, аз лонаҳои кишт дар мағзи сурхи устухон инкишоф меёбад (остеомиелити силӣ). Қойи дӯстдошта танаи мӯҳраҳо (спондилити силӣ), эпифизи устухонҳои буғуми косу рон (коксити силӣ) ва зонуҳо (гонити силӣ) мебошад. Ҳангоми сили устухонҳо нисбатан хатарноктар ҳосилшавии секвестрҳо мебошад, яъне қитъаҳои мавтшавии устухон, вайроншавии он, шаклдигаркунии буғумҳо.

Сили гурдаҳо аксаран яктарафа мебошад. Бисёр вақт дар шахсони давраи балоғати ҷинсӣ ва пиронсолӣ зоҳир мегардад.

Лонаҳои барвақтӣ дар қабати қишрӣ, баъдан дар пистонакҳои пирамидаҳои пайдо мешаванд; дар ин ҷо созмоншиканӣ (деструксия) бо ҳосилшавии ҳуфраҳо(ковонҳои) оғоз мешавад. Берун аз сурохиҳо фосилаи байни

бофтаи гурдаҳо бо лимфоситҳо, гистоситҳо инфилтратсия шудааст. Ҳангоми бо моддаи панирмонанд маҳкам шудани ҳолиб пионефроз инкишоф меёбад. Тадриҷан ба раванди илтиҳобӣ роҳҳои пешоббарор, пешобдон, ғадуди олоти таносул, зоидаи нутфадон дар занҳо – дар луобпардаи бачадон, тухмроҳаҳо, байзадон (хеле км) ҷалб карда мешаванд.

ЛЕКСИЯИ 31 СИЛИ ДУЮМБОРА.

1. Муайян намудани сили дуюмбора.
Тавсифи сили дуюмбора.
2. Анатомияи этилолӣ. Оризаҳо

1

Сили дуюмбора (реинфицированный) дар организми одами калонсол инкишоф меёбад, ки қаблан сирояти аввалияро аз сар гузаронидааст, ки вайро бо масунияти нисбӣ таъмин намудааст, вале аз имконияти беморшавии такрорӣ – баъди сили аввалия муҳофизат накардааст ва барои он хос мебошад:

- ба таври интиҳобӣ мавзёғирии шушии раванд;
- паҳншавии тамосӣ ва интраканаликулярӣ (шоҳаҳои бронхҳо, роҳи меъдаву рӯдаҳо);
- ивазшавии шаклҳои клиникаию морфологӣ.

1

Анатомияи этилолӣ. Ҳашт шакли сили дуюмбора чудо карда мешавад, ки ҳар яке аз онҳо инкишофи минбаъдаи шакли қаблиро инъикос мекунад. Дар байни шаклҳо-марҳилаҳо чудо карда мешавад:

- шадиди лонавӣ;
- фиброзӣ-лонавӣ;

- инфилтративӣ;
- сил;
- пневмонияи панирмонанд
- шадиди серковок;
- фиброзӣ-серковок;
- таллайюфӣ.

Сили шадиди лонавӣ ба таври морфологӣ бо мавҷуд будани як ду лона дар сегментҳои I ва II аксаран тарафи рости шуш (лонаҳои реинфекти Абрикосов) тавсиф меёбад, ки аз эндобронхити махсус, мезобронхит ва кажбронхити бронхи иборат аст. Раванд қад-қади бронхиолаҳо ба лиҳимаи ҳар ду шоҳаи шуш мегузарад, ки дар натиҷаи он бронхопневмонияи атсинозӣ ё лобурярии фалламонанд инкишоф меёбад. Дар лимфогирехҳои решаи тарафҳои шуш раванди реактивии ғайримуқаррарӣ инкишоф меёбад. Ҳангоми сари вақт муолиҷа намудан, асосан худруста, раванд фуру менишинад, лонаҳои некрози панирмонанд беғилофак мешаванд, лонаҳои реинфект пайдо мешаванд.

Сили фиброзӣ-лонавӣ - марҳилаи чараёни сили шадиди лонавӣ мебошад, ки баъди давраи фурунишинии беморӣ раванд аз сари нав хуруҷ мекунад. Ҳангоми сиҳатшавии лонаҳои Абрикосов лонаҳои калони беғилофакшуда ва қисман сурохнашуда пайдо мешавад, ки дар хуруҷкунии раванд аҳамият доранд ва бо пайдошавии лонаҳои атсинозӣ, лобулярии пневмонияи панирмонанд тавсиф меёбанд, ки аз сари нав беғилофак мегарданд. Вале тамоюл нисбати шиддатёбӣ фуру менишинад. Раванд аз доираи сегментҳои I ва II берун намебарояд, ҳамзамон дар байни лонаҳои ғилофакшуда ва оҳаксор на фақат лонаҳои реинфект балки лонаҳое мавҷуданд, ки оқибати киштҳои гематогениро дар давраи сирояти аввалия инъикос мекунад (лонаҳои Симонов).

Сили инфилтративӣ - марҳилаи навбатии раванд ме-

бошад, ки ҳангоми он тағйиротҳои тарашшӯҳии байни лонаҳои панирмонанд аз доираи ҳиссачаҳо ва ҳатто аз сегмент берун мебароянд. Илтиҳоби гирдилонавӣ нисбат ба тағйиротҳои панирмонанд бартарӣ пайдо мекунад. Лонаи мазкур инфилтратаи Ассман-Редекер номида мешавад. Лонаи гиридилонавӣ метавонад ҷаббида шавад ва дар давраи сиҳатшавӣ як ё ду дигаргуниҳои ҷабиданашудаи панирмонанд боқӣ мемонанд, ки беғилофак мешаванд ва беморӣ аз сари нав характери сили фиброзӣ-лонавиरो мегирад.

Туберкулема ҳамчун марҳилаи махсуси таҳаввули сили инфилтративӣ пайдо мешавад, ки илтиҳоби гирдилонавӣ ҷаббида мешавад ва лонаи некрози фалламонанд боқӣ мемонад, ки бо ғилофак ихота шудааст. Қутри туберкулема ба 2-5 см, дар сегменти 1 ва 2, аксаран аз тарафи рости шуш ҷойгир шудааст. Пневмонияи панирмонанд ҳангоми шиддатёбии сили инфилтративӣ мушоҳида карда мешавад, ки дар натиҷаи он тағйиротҳои панирмонанд аз гирдилонавӣ бартарият пайдо кардан мегиранд. Лонаҳои атсинозӣ, лобулярӣ, сегментарии панирмонанди шуш ҳосил мешаванд, ки ба қисматҳои калони шуш ҳамроҳ шуда метавонанд. Пневмонияи панирмонанд характери ҳиссавӣ (лобарӣ) дорад, ки дар заминаи илтиҳоби ҳиссаи шуш (лобит) инкишоф меёбад. Шуш ҳангоми пневмонияи панирмонанд калон, сахт аст, дар буриш ранги зард, дар ҷанб ғуборҳои фиброзӣ дида мешавад.

Сили шадиди серковок бо ҳосилшавии ҳуфраи таҷзия, сипас ковокӣ дар ҷои лона - инфилтрат ё туберкулема тавсиф меёбад. Ҳуфраи таҷзия дар натиҷаи обшавии римнок ва суюқшавии моддаҳои панирмонанд, ки бо микробактерияҳо якҷоя бо балғам ҷудо мешаванд. Ин ҳатари баланди тухмнокшавии бронхогении шуш, инчунин ҷудошавии микробактерияҳоро ба муҳити атроф ба вуҷуд меоварад. Ковокӣ дар ин маврид бо ковокии бронхи сег-

ментарӣ пайваст мешавад.

Сили фиброзӣ-серковок аз сили шадиди серковок пайдо мешавад, ки раванд характери музмин мегирад. Қабати дарунии ковокӣ -пиогенӣ (некротӣ) аз лейкоцитҳои таҷзияшаванда бой аст, миёна - қабати бофтаи силии доначадор; беруна - бофтаи пайвасткунанда. Ковокӣ як ё ҳарду сегментро ишғол менамояд. Дар атрофи он лонаҳои гуногунранг, бронхоэктазҳо муайян карда мешавад. Раванд тадричан ба самти аникокаудалӣ паҳн мегардад, аз сегментҳои болоӣ ба поёни ҳам бо роҳи тамос ва ҳам бо бронхҳо поён мефарояд:

Сили таллайюфӣ - варианти инкишофи сили фиброзӣ-серковок буда, дар шуши иллатёфта дар атрофи ковокиҳои инкишофи пурзӯри бофтаи пайвасткунанда ба амал меояд, дар ҷои сикхатшавии ковокиҳои ҳадшаи рост ҳосил мешавад, часпиши ҷанбӣ пайдо шуда, тарафҳои шуш шаклашон дигар мешавад, ғафс ва камҳаракат мешаванд, бронхоэктазҳои сершумор пайдо мешаванд.

Оризаҳо. Ҳангоми сили дуюмбора миқдори бештари оризаҳо бо ковокиҳои алоқаманд аст: хунравиҳо, даромадани мӯҳтавии ковокиҳои ба ковокии ҷанб, ки боиси пневмоторакс ва плеврити римнок мегардад (эмпиемаи ҷанб).

ЛЕКСИЯИ 32 СИФИЛИС (ОТАШАК).

1. Муайянкунӣ.
2. Анатомиаи эътилолӣ.
3. Сифилиси аҳшӣ.
4. Нейросифилис, фалаҷи шиддаткунанда,
табоҳати камар

1

Сифилис (оташак) - бемории музмини сироятӣ

зӯҳравӣ буда, бо иллатнокшавии пӯст, луобпардаҳо, узвҳои дарунӣ, устухонҳо, системаи асаб тавсиф меёбад.

Барангезандааш -трепонемаи паридаранг - анаэроб мебошад.

Воридшавии барангезиш ба организм тавассути эпидермиси (пӯстпардаи) осебёфта ё эпителияи луобпарда ба вучуд меояд. Заҳролудшавӣ бо роҳи таносулӣ, камтар - бо роҳи ғайританосулӣ ба амал меояд. Давраи инкубатсионӣ - 3 ҳафта. Трепонема тез ба лимфогиреҳҳои, канорӣ ворид мегардад, сипас ба чараёни хун меафтад ва дар организм паҳн мегардад.

2

Анатомияи этилолӣ.

Се давраи сифилис фарқ карда мешавад.

Давраи аввалаи сифилис бо пайдошавии саҳтшавиҳо дар даромадгоҳҳои сироят тавсиф меёбад, ки дар ҷои онҳо решӣ сатҳии бедарди мудаваар бо қаъри ҳамвори ҷилдор ва канораҳои ғизлати ҳамвор, тағоякмонанд пайдо мешавад. Ба ин васила аффеки аввалияи сифилисӣ - каллаҳчи саҳт ё решӣ саҳт ҳосил мешавад. Аффеки аввалия ҳангоми заҳролудшавии таносулӣ дар узвҳои таносул (сараки узви таносул, лабҳои калону хурди фарҷ), ҳангоми ғайританосулӣ - дар луобпардаи ковокии даҳон, ангуштони даст (момодояҳо, патологоанатомҳо) мавзё мегардад.

Ҳангоми ба раванд ҷалбшавии лимфогиреҳҳо (калон, ҷафс мешаванд) дар ҳамбастагӣ бо аффеки аввалия маҷмӯи аввалияи сифилисӣ ҳосил мешавад. Инфилтрат дар атрофи рағҳои борики хурд ҷойгир мешавад, ки дар онҳо пролефератсияи эпителия, то ҳуди пурра маҳкамшавии ковокӣ мушоҳида карда мешавад. Дар байни ҳучайраҳои қабати бофтаи пайвасткунанда пайдо шуда, ҳадшабандӣ ба вучуд меояд ва баъди 2-3 моҳ дар ҷои аффеки аввалия

хадшача ҳосил мешавад. Лимфагиреҳҳо тасаллуб мешаванд.

Давраи дуҷумбора бо пайдоиши сифилидҳо - лонаҳои зиёди илтиҳобӣ дар пӯст ва луобпардаҳо тавсиф меёбад. Намудҳои гуногуни сифилидҳо: розеолаҳо, филофакҳо, рихинакҳо. Барои ҳамаи сифилидҳо омоси лонавии пӯст ва луобпардаҳо, серковокшавии қабати эпителиявӣ, пурхунии рағҳо, инфилтратсияи илтиҳобӣ дар атрофи онҳо, некрози девораҳо умумӣ мебошад. Сифилидҳо аз трепонемаҳо бой мебошанд. Дар лимфагиреҳчаҳои калоншуда омос, гиперплазия, лонаҳои некроз, чамъшавии трепонемаҳо мушоҳида карда мешавад. Пас аз сиҳатшавии сифилидҳо (баъди 3-6 ҳафта аз оғози доначасорӣ) хадшачаҳои на он қадар калони сершумор, баъзан нестшаванда боқӣ мемонанд.

Давраи сеҷумбора баъди 3-6 соли пас аз захролудшавӣ фаро расида, дар шакли илтиҳоби музмини мунташири байнибофтагӣ ва ҳосилшавии гуммаҳо зоҳир мегардад. Илтиҳоби музмини байнибофтагӣ дар чигар, девораи аорта, шуш, бофтаи хусияҳо (байзадонҳо) мушоҳида мегардад. қад-қад рағҳо инфилтратҳои ҳучайравӣ мушоҳида карда мешаванд, ки аз ҳучайраҳои лимфоидӣ ва плазмавӣ иборат буда, эндотериит ва лимфангити сермахсул ба назар мерасанд. Баъдан дар узвҳои иллатёфта талайюфи сифилисӣ инкишоф меёбад. Гумма- лонаи илтиҳоби сифилисии сермахсули некрозӣ, гранулемаи сифилисӣ аст.

3

Сифилиси аҳшӣ узвҳои даруниро аксаран дар давраи сеҷумбора иллатнок менамояд. Дар клиникаи сифилиси аҳшӣ эътилоли силсилаи дилу рағҳо, силсилаи марказии асаб аҳамияти бештар дорад.

Эътилоли дил ҳангоми сифилиси аҳшӣ метавонад дар шакли миокардити гуммозӣ ва тоникӣ зоҳир шуда бо ин-

кишофи кардиосклерози фаровон ба анҷом расида метавонад.

Ҳангоми иллатнокшавии шараёнҳои қутрашон гуногун артериити сермахсул пайдо мешавад, ки бо артериосклероз ба анҷом мерасад. Ҳамчунин мезоартрити сифилисӣ инкишоф меёбад: дар синдарунпардаи аорта пулакчаҳои сафедранги дунгичадор бо кашишхӯриҳои хадшамонанд пайдо мешаванд.

Ҳангоми мезоартити сифилисӣ дар девораи аорта раванди илтиҳобӣ пайдо мешавад, ки аз тарафи рағҳои гиодихандаи аорта ва адвентисия то мушакпарда паҳн мегардад. Инфилтрат торҳои чандири пардаи миёнаро вайрон мекунад, дар онҳо майдонҳои бофтаи пайваस्तкунанда бо порчаҳои торҳои чандир пайдо мешаванд.

Устувории девораи аорта кам мегардад, ковокии он васеъ мешавад - аневризмаҳои сифилисии аорта ҳосил мешаванд. Аз девори аорта илтиҳоб метавонад ба дарғоти аорта гузарад. Онҳо (табақаи дарғот) сафедранг мешаванд, дар натиҷаи хадшабандӣ шаклашро дигаргун мекунад, байни ҳамдигар мечаспанд, ки боиси нуқсони сифилисии аортавӣ мегардад.

3

Нейросифилис метавонад дар ҳар гуна давраи беморӣ, вале бештар дар аввалия мушоҳида шуда метавонад. Шаклҳои гумоозӣ ва муқаррарии сифилиси системаи асаб, эътилоли рағҳо, фалаҷи пуршиддат ва табоҳати камарро фарқ мекунанд. Гуммаҳо дар мағзи сар андозаҳои гуногун доранд - аз арзанмонанд то тухми кабутар. Шакли муқаррарӣ бо инфилтратаи илтиҳобии лимфоситарӣ зоҳир мегардад.

Фалаҷи пуршиддат падидаи дермондаи сифилис мебошад, ки бо камшавии вазнӣ мағзи сар, тунукшавии ҳамгаштҳо, қоҳишёбии гирехҳои зеркишрӣ ва мағзча тавсиф

меёбад.

Ба таври микроскоӣ дар таркиби бофтаи мағзи сар тағйиротҳои илтиҳобӣ ва дистрофӣ, ҳалокати ҳуҷайраҳои асаб, қитъаҳои миелинизатсия, ихтилоли ҷойгиршавии ҳуҷайраҳои мағзи сар ошкор карда мешавад.

Табоҳати камар - падидаи дермондаи сифилис мебошад, ки ҳангоми он ҳароммағз иллатнок мегардад. Дар буришҳои кундаланг сутунҳои акиби он тунук ба назар мерасанд ва ранги хокситаранг доранд. Дар мағпардаи нарми ҳароммағз тағйиротҳои илтиҳобӣ дарёфт карда мешаванд. Дар қитъаҳои илтиҳоб ва дар моддаи хокистаранги ҳароммағз трепонемаи паридаранг ошкор карда мешавад.

ЛЕКСИЯИ 33 БЕМОРИҲОИ ШАДИДИ РЕСПИРАТОРӢ.

1. Муайянкунии бемориҳои шадиди респираторӣ-вирусӣ.
2. Этиология ва патогенез.
3. Анатомиаи эътилолӣ.
4. Оризаҳо

1

Сироятҳои шадиди респираторӣ-вирусӣ - гурӯҳи бемориҳои аз ҷиҳати клиникию морфологӣ монанди шадиди илтиҳобии узвҳои нафаскашӣ, ки аз сабаби вирусҳои пневмотропӣ ба вучуд меоянд.

Аксаран дар вақтҳои хуноки сол дар шакли ҳодисаҳои спорадӣ, эпидемия, пандемия дучор мешаванд.

Зуком (грипп) (аз франс. *grippe* - «дастгир кардан») - сирояти шадиди респираторию вирусӣ мебошад, ки вирусҳои зуком ба вучуд меоваранд.

Этиология.

Барангезандаҳои зуком - вирусҳои пневмотропии КРН-дори се варианти ба таври антигенӣ асоснокшудаи серологӣ А/А(1), А(2), В, С. Вирионҳои шаклашон гирдаи кутрашон 80-100 нм аз молекулаҳои КРН иборатанд, ки ба таври гипогликопротеинозӣ бо парда (капсид) пушонда шудаанд. Бо ёрии нейралипидаза вирус пардaro ҳал мекунад ва ба дохили ҳуҷайраи ҳуҷаин ворид мегардад. КРН-полимераза ҳосилшавии вирусро фаъол мегардонад.

Патогенез. Сироят бо роҳи ҳавой-қатрагӣ паҳн мешавад. Давраи инкубатсионӣ 2-4 рӯз давом мекунад. Чаббиши (адсорбсияи) аввалаЮ воридшавию афзоиши вирус дар ҳуҷайраҳои эпителии бронхополярӣ ва алвеолярӣ, эндотелии муйрағҳо ба вучуд меояд, ки боси вирусемияи аввалия мегардад.

Вируси зуком ба эпителии бронху хирной таъсири ситопатикӣ (ситолитикӣ) расонда, боиси дистрофия, некроз, кандашавии он мегардад. Вайроншавии бутунияти тавораи эпителиалии бронхҳо ва хирной пайдоиши вирусемияи дуҷумбораро муайян менамояд.

Вируси зуком хусусияти таъсири вазопатӣ (вазопалатикӣ) расондан (пурхунӣ, ташаннуҷ, палмо- ва геморрагия) ва фруӯ нишондани силсилаҳои муҳофизатии организм - нейтрофилҳо (фурӯ нишондани фагоситоза), фагоситҳои моноситарӣ (фурӯ нишондани хемотамис ва фагоситозҳо), силсилаи масуниятро (инкишофи аллергия, пайдо шудани маҷмӯҳои музими масунӣ) дорад.

Тағйиротҳои чузъи - ринит, фарингит, трахеит, бронхит, пневмония, инчунин тағйиротҳои умумӣ - ихтилолҳои носозкории гардиш, дистрофияи элементҳои лаҳимаӣ, илтиҳоб пайдо шуда метавонанд.

3

Анатомияи эътилолӣ.

Шаклҳои сабӯк (амбулаторӣ), вазнини миёна ва вазнини зуком фарқ карда мешаванд.

Шакли сабӯки зуком бо иллатёбии луобпардаи роҳҳои нафаскашӣ тавсиф меёбад, ки дар он ҷо риноларинготрахеобронхити катаралӣ инкишоф меёбад. луобпарда варамида, пурхун, бо мӯхташавии барзиёди зардобию луобӣ мебошад.

Ба таври микроскопӣ дар заминаи пурхунӣ, омос ва инфилтрати лимфоидию ҳучайравии қабати зерэпителиявӣ дисрофияи гидротикӣ ҳучайраҳои эпителияи мижгонакдорӣ, нест шудани мижгонакҳои онҳо мушоҳида гардида, фаъолияти тарашшӯҳии ҳучайраҳои қадаҳшакл ва гадудҳои луобӣ пурзӯр мегардад; бисёре аз ҳучайраҳои эпителия луобпардаҳо аз гишаи асосӣ канда шуда меафтанд.

Дар ситоплазмаи ҳучайраҳои эпителий идҳолаҳои базофилӣ ва оксифилӣ (фуксинофилогенӣ) хос аст. Шакли сабӯк ба таври мусоид чараён меёбад, баъди 5-6 рӯз бо шифоёбии комил анҷом мепазирад.

Зукоми вазнинии миёна бо ҷалбшавии роҳҳои болоии нафаскашӣ, бронхҳои хурд, бронхиолаҳо, лаҳимаи шуш ба раванд чараён меёбад. Дар хирной ва бронхҳо илтиҳоби зардобию хунрез, гоҳо бо лонаҳои некрози луобпарда инкишоф меёбад.

Дар заминаи пурхунӣ, қитъаҳои ателектаз (пучшавӣ) ва эмфиземаи шадид лонаҳои пневмонияи зукоммонанд пайдо мешаванд: дар алвеолаҳо тарашшӯҳи зардобӣ, макрофагҳои алвеоларӣ, ҳучайраҳои эпителияи алвеолӣ, эритроцитҳо, нейтрофилҳо дида мешавад; тавораҳои байниалвеоларӣ аз ҳисоби профилератсия ва инфилтратсия ҳучайраҳои лимфосидӣ ғафс мешаванд.

Чараёни вазнинии миёна муосид аст: шифоёбӣ баъди

3-4 ҳафта фаро мерасад.

Шакли вазнини зуком намудҳои зерин дорад:

- бо захролудшавии умумӣ асоснок гардидааст;
- оризаҳои шуш аз сабаби гирифтани сирояти дуҷумбора.

Ҳангоми зукоми дорои захролудшавии зохиршавандаи умумӣ дар хирной ва бронхҳо илтиҳоби зардобию хунрез ва некроз пайдо мешавад. Дар шуш лонаҳои зиёди хурди пневмонияи зардобию хунрез мавҷуд аст, ки бо эмфиземаи шадид ва ателектаз иваз мешаванд.

Омоси захрогини хунрези шуш имкон дорад. Гоҳо беморон дар рӯзи 4-5-уми беморӣ ва хунравӣ дар марказҳои рағҳаракатдиханда ё норасоии нафаскашӣ ба ҳалокат мерасанд.

Зукоми вазнин бо оризаҳои шуш бо ҳамроҳшавии сирояти дуҷумбора (стафилококк, стрептококк, пневмококк, қаламчамикроби рими кабуд) асоснок гардидааст.

Одатан дараҷаи тағйиротҳои илтиҳобӣ ва вайроншавии аз хирной ба шуш зиёд мегардад, дар ҳолатҳои вазнин ба ҳалқ ва хирной илтиҳоби зардобию хунрез бо қитъаҳои васеи некроз дар луобпарда ва ҳосилшавии решҳо меафзоянд. Паҳнбронхити вайроншавӣ инкишоф меёбад, ки боиси ташаккули бронхиэктазҳои шадид, ателектази лонавӣ ва эмфизема мегардад.

Бронхопневмония (шитозии ҳиссагӣ, азивии ҳиссагӣ) бо тамоюл ба чаббиш, некроз, хунравӣ хос аст.

Ҳаҷми шушҳо калон шудааст, дар буриш намуди гуногунранг- «шуши калони гуногунранги некрозӣ». Гоҳо ба раванди ҷанб-ҷалб шуда, плеврити зардобӣ ё фибринозӣ пайдо мешавад.

Дар узвҳои дарунӣ ҳамбастагии тағйиротҳои дистрофӣ ва илтиҳобӣ бо ихтилолҳои гардишӣ мушоҳида карда мешавад. Дар мағзи сар варамидаи моддаи он мушоҳида карда мешавад, ки даромадани бодомакҳо ба сӯро-

хии калони пушти сар ва фавти бемор ҳамроҳӣ мекунад.

Тағйиротҳои дистрофӣ ва илтиҳобӣ ҳамчунин дар гирехҳои асабҳои гумроҳ ва симпатикӣ, инчунин танай асабҳои канорӣ дида мешавад.

Дар кӯдакони хурдсол назар ба калонсолон беморӣ вазинтар ҷараён меёбад.

4

Оризаҳо асосан дар шуш мушоҳида карда мешавад. Ҷамъшавии тарашшӯҳ, ки бронхит ва бронхиолитро мусадид мекунад, тасаллуби девори бронхҳо боиси инкишофи бронхостазҳо, пневмофиброз, эмфиземи музмини обструктивӣ, норасоии шушу дил мегардад.

Марганҷомии зуком аз захролудшавӣ, хунрезӣ дар марказҳои нафаскашӣ (мағзи сар), аз оризаҳои шуш (пневмония, эпитемаи ҷанб), норасоии дил ё дилу шуш фаро мерасад.

ЛЕКСИЯИ 34

ҲАСБАИ ЭПИДЕМИЯВӢ. ТУЛЯРЕМИЯ.

1. *Ҳасбаи эпидемиявӣ.*

2 *Туляремия.*

1

Ҳасбаи эпидемиявӣ (typhus exanthematicus) - бемории шадиди табларзагии риккетезӣ мебошад, ки бо иллати рағҳои хурд, мағзи сар, токсикоз тавсиф ёфта, бо доначаҳои розеолезӣ-нетехиалӣ паҳн мегардад.

Аксаран одамони калонсоли синни аз 20 то 40 сола бемор мешаванд.

Этиология и патогенез.

Ҳасбаро риккетсияҳои *Provassek gn. Roха-Lима* ба вуҷуд меоваранд. Сарчашмаи беморӣ ва маҳзани риккет-

сия одами бемор, ҳомилаш бошад- шабушки либос (гоҳо сар) мебошад. Вай аз одами бемор сироятнок мешавад ва сипас ҳангоми газидани одамони солим тавассути фазлаи худ риккетсияро ҳангоми хоридани пӯст паҳн мекунад.

Давраи инкубатсионӣ 10-2 рӯз давом мекунад, сипас давраи табларзагии беморӣ оғоз мегардад, ки бо иллатнокшавии маҷрои микрогардиш ҳамроҳи мекунад. Дар натиҷаи ба эндотелияи рағҳои хурд воридшавӣ ва дар он афзоиш ёфтани риккетсияҳо васкулити мутамаказ бо иллати силсилаи марказии асаб, махсусан мағзи дарозрӯя ва пӯст инкишоф меёбад. Дар ҳафтаи 2-3-юми беморӣ дар баландии давраи табларза метавонанд ихтилолҳои гипотенос ва нафаскашӣ инкишоф меёбанд (падидаҳои бульоирӣ). Иллати силсилаи симпатикии асаб ва ғадудҳои болои гурда гипотонияро пурзӯр мекунанд, ки боиси ихтилоли фаъолияти дил мегарданд.

Анатомияи эътилолӣ. Тағйиротҳои ҳангоми ҳасба фақат бо ёрии микроскоп ошкор карда мешавад. Дар пӯст изҳои доначаҳои дар шакли доғу нуктаҳои қаҳваранг ва сурх, доначаҳои конъюнктивалӣ дида шуда, ҳамчунин мененгити зардобӣ ошкор карда мешавад.

Ҳангоми тадқиқи микроскопии узвҳо, махсусан СМА ва пӯст, тағйиротҳои муйрағҳо ва шараёнчаҳои ошкор карда мешаванд, ки барои васкулити ҳасабӣ хосанд. Аввал варамкунӣ, созмоншиканӣ (деструксия), ташаккули тромбҳои мушоҳида гашта, сипас инкишофи эндотелия зиёд мегардад; дар девораи рағҳои некрози лонавӣ инкишоф меёбад.

Якчанд намуди васкулити ҳасбаӣ чудо карда мешавад; васкулити серозӣ, васкулити проинфилтӣ, васкулит некрозӣ. Аксаран эндотромбоваскулити ҳасбаии деструктивӣ-пролиферативӣ дучор мегардад.

Л.В. Попов (1875) лонаҳои инфилтратсияи эндо- ва перивискуляриро кашф намуд, ки шакли укдахоро доранд,

онҳо гранулемаҳои ҳасбаии Попов номида шуданд. Дар мағзи асосӣ гранулемаҳо бо минтақаи калони ҳучайраҳои нуфузкунанда (гимогранулематози рағҳо) ихота карда мешаванд.

Доначаҳои ҳасбай (энзинтема) дар пӯст дар рӯзи 3-5-уми давраи табларзагии беморӣ пайдо мешаванд. Мета-вонад чунин хунрезихое (ҳалқачаҳое) пайдо шаванд, ки одатан ҳангоми ҷараёни вазнини ҳасба мушоҳида карда мешаванд. Дар мағзи сар уқдаҳои ҳасбай дар ҳафтаи 2-юми беморӣ ҳосил мешаванд ва дар оғози ҳафтаи 6-уми беморӣ нест мезананд. Онҳо дар таркиби мағзи сар, косаҳои зерқишрӣ, мағзи дарозрӯя, ҳиссаи ақиби гипофиз ошкор карда намешавад. Аз ин сабаб дар бораи инкишофи энсефалит бо менингити зардобӣ ҳукм намудан мумкин аст, зеро дар мағзи сар ташаннучҳо, гиперемия, муфтаҳои периваскулярӣ аз ҳучайраҳои плазматикӣ мушоҳида карда мешаванд.

Дар силсилаи асаби симпатикӣ тағйиротҳо бо ҳосилшавии гирехҳо ва инфилтратҳо аз ҳучайраҳои лимфоидӣ инкишоф ёфта, ҳучайраҳои асаб хеле тағйир меёбанд - менингити ҳасбай. Ҳамчунин системаи канории асаб иллатнок мегардад - неврит.

Иллатҳои дил ҳангоми ҳасба амалан ҳама вақт мушоҳида карда мешаванд, инкишофи тағйиротҳои дистрофии мушакпарда ва миокардити интермиалӣ ба вучуд меояд, ки бо инфилтратсияи лннавӣ, гоҳо - мунташири ҳучайраҳои инфилтративӣ, лимфоситҳо, ҳосилшавии гранулемаҳо зоҳир мегардад. Дар ғадуди сипаршакл илтиҳоби фосилавӣ, дар ғадудҳои болои гурда - энзо- ва приваскулитҳо, суддати эндоваскулитҳои барои ҳасба хос инкишоф меёбад.

Оризаҳои ҳасба бо тағйиротҳои рағгову системаи асаб алоқаманданд. Аксаран ихтилолҳои ғозиявӣ инкишоф меёбанд. Сирояти дуҷумбора ҳамроҳ мешавад, аз ин

сабаб баногӯшак (паратит) ва отити римнок пайдо мешавад, ки бо сепсис ба анҷом мерасад.

2

Туляремия - бемории сироятии табиӣ-лонавӣ аз гурӯҳи антропозоонозҳо бактериявӣ мебошад, ки ба таври шадид ё музмин чараён меёбад.

Этиология. Беморию *Francisella tularensis* ба вучуд меорад.

Эпидемиология ва патогенез. Сарчашмаи беморӣ ҳояндаҳо мебошанд, ки тавассути онҳо бо роҳи тамос, ҳавоӣ-қатрагӣ, гоҳо ғизоӣ *Francisella tularensis* интиқол меёбад.

Давраи инкубатсионӣ - 3-8 шабонарӯз. Дар ҷои воридшавии барангезанда аффеки аввалия (римча, ярашавӣ) пайдо шуда метавонад, гоҳо он вучуд надорад. Бактерияҳои лимфогенҳо ба лимфогиреҳо мерасанд, ки дар он ҷо илтиҳоб инкишоф ёфта, хиёракҳои (бубонҳои) аввалияи тулярий ҳосил мешаванд.

Анатомияи эътилолӣ. Шаклҳои хиёракии шушӣ ва тифозии туляремия ҷудо карда мешаванд.

Ҳангоми шакли хиёракӣ ҳамаи ҷузъҳои маҷмӯи аввалияи тулярий зоҳиршаванда мебошанд. Дар ҷои воридшавии сироят римча, сипас реш пайдо мешавад. Некрози пӯстпарда (эпидермис), дар пӯст бошад гранулемаи туляремиядор мушоҳида карда мешавад. Онҳо аз эпителияҳои ҳуҷайраҳои лимфодӣ, азимҷусса, лейкоцитҳои полиморфӣ иборатанд. Агар оғоз ба таври якбора зоҳиршаванда бошад, пас метавонанд носурҳо, решҳои муддати дароз сихатнашаванда, хадшаҳо ҳосил шаванд. Ҳангоми мутамарказият гранулема ва лонаҳои пӯсиш дар испурч, чигар, мағзи устухон, шуш, узвҳои эндокринӣ дарёфт карда мешаванд. Ҳангоми чараёни музмини беморӣ грналуҳои туляремӣ ва тасаллуб дарёфт карда мешавад.

Шакли шушии туляремия (ҳангоми заҳролудшавии

ҳавой-қатрагӣ) бо пневмонияи аввалияи туляремӣ ва лимфоденити лимфагиреҳҳо тавсиф меёбад.

Шакли тифозӣ бо септисемия бо хунрезихои зиёд дар узвҳо бе тағйиротҳои чузъии пӯст ва тағйиротҳои лимфагиреҳҳо тавсиф меёбад.

Марг бештар ҳангоми шаклҳои тифоидӣ (сепсис) ва шушӣ (пневмония) фаро мерасад.

ЛЕКСИЯИ 35 ТОУН ВА БЕМОРИҲОИ СӢХТАНӢ.

1. Тоун.

2 Бемориҳои сӢхтанӣ

1

Тоун (pesbis) - бемории шаддидтарини сироятӣ аз гурӯҳи бемориҳои паразитӣ (конвенсионӣ) мебошад.

Этиология. Онро қаламчамикробӣ тоун (*Yersinia pestis*) ба вуҷуд меоварад, ки анаэроб ва факултативӣ анаэроб мебошад. Вай метавонад фибриномуғия ва гиалуронидазаро ҷудо намояд, дар нейроситҳои полиморфӣ-ядрӯй ва макрофагҳо нуфуз мекунад.

Эпидемиология и патогенез.

Тоун - антропозоопози муқаррарӣ мебошад. Сарчашмаи сироят ва маҳзани барангезандаи тоун ҳайвоноти ваҳшӣ, ҳояндаҳо, ҳайвоноти ҳонагӣ- гурба, шутур мебошанд. Барои тоун эпидемия ва пандемия ҳос аст. Ду роҳи захролудшавии одам имкон дорад: аксаран аз ҳояндаҳои бемор ҳангоми газидани канаҳо (тоуни хиёракӣ ё пӯстию хиёракӣ), гоҳо - бо роҳи ҳавой-қатрагӣ аз одами бемори гирифтори пневмонияи тоунӣ (тоуни нахустини шушӣ).

Давраи инкубатсионӣ аз якчанд соат то 6 шабонарӯз давом мекунад. Аз ҷои захролудшавӣ барангезанда ба таври лимфогенӣ паҳн гаштиа, боиси лимфаденит (хиёраки

аввалияи тоунии тартиби якум) мегардад. Баъдан хангоми паҳншавӣ хиёракҳои аввалияи тартиби дуюм, сеюм, ва ғайра пайдо мешаванд. Мутамарказияти гематомии барангезанда хос аст, тоун ҳамчун сепсис чараён меёбад, зеро эндоситобиоз ва масунияти гуморалӣ намерасад. Хактери махсус ва динамикаи тағйироти бофтаҳо мушоҳида карда мешавад - илтиҳоби зардобӣ хунрез бо некрозӣ-хунрез ё римнок ҳамчун аксуламал ба некроз иваз мешавад.

Анатомияи эътилолӣ. Шаклҳои хиёракӣ, устухонию хиёракӣ (пурра) нахустини шушӣ ва нахустини тааффунии тоун фарқ карда мешавад.

Тоуни хиёракӣ бо калоншавии лимфогиреҳҳои минтақавӣ (хиёракҳои нахустини тоунии тартиби якум) тавсиф меёбанд. Лимфогиреҳҳо часпидаанд, ғизлати ҳамирмоямонанд, беҳаракатанд, дар буриш сурхи сиёҳранг бо лонаҳои некроз.

Ҳангоми тадқиқи микроскопӣ: лимфаденити шадидтарини зардобӣ хунрез. Бофтаи гиреҳи инфективӣ бо хун ва моеи зардобӣ, лонаҳои некроз ҷаббида шудааст, лимфаденит хунрезу некрозӣ мегардад. Метавонанд решҳое пайдо шаванд, ки баъдан ҳадша баста мешаванд.

Ҳангоми паҳншавии лимфогенӣ хиёракҳои нав пайдо мешаванд (хиёракҳои аввалияи тартиби дуюм, сеюм ва ғайра). Паҳншавии гематогенӣ боиси инкишофи бактеремияи тоунӣ ва септисемия мегардад, ки бо доначаҳо, хунрезҳои зиёд, пневмонияи дуҷумбораи тоунӣ, дисторфия ва некрози узвҳои лаҳимавӣ зоҳир мегарданд.

Доначаҳо аз пайсаҳо, римчаҳо, эритмеа иборат аст, вале бо ҷузъҳои ҳатмии хунрез ва некрозӣ.

Тағйиротҳои дистрофӣ ва некрозӣ ба узвҳои зиёди лаҳимавӣ - дил, чигар, гурдаҳо ва ғайра дахл доранд.

Шакли пӯстӣ хиёракии (пӯстӣ) тоун бо инкишофи аффекти аввалия ва эритемияи тоунӣ (ё ҳатфпӯсти хунрезии тоунӣ) қайд карда мешавад. Дар ҷои ҳафтпӯст карбун-

кул омос, ғафсшавии пӯст мушоҳида карда шуда, минбаъд ҳафтпӯст яра мешавад.

Барои муқаррар намудани ташҳиси тоун дар мизи сексионӣ гузарондани тадқиқи бактериоскопӣ ва минбаъд бактериологӣ бо кишти қаламчамкиробӣ тоун ҳатмӣ аст.

Оризаҳо ҳангоми тоун марговаранд. Инҳо септисемия, захролудшавӣ, оризаҳои шуш мебошанд.

1

Бемории сӯхтанӣ.

Бемории сӯхтанӣ - бемории шадиди сироятӣ аз гурӯҳи антропонозҳои бактериявӣ мебошад.

Этиология. Бемоорию қаламчамикробӣ спораустувор ва дар муҳити атроф устувори сӯхтанӣ (*Vac. anihracis*) ба вучуд меоварад, ки аз тарафи Р. Кох (1876) чудо карда шудааст.

Эпидемиология ва патогенез. Захролудшавӣ бо роҳҳои гуногун ба вучуд меояд. Агар захролудшавӣ тавассути пӯст ба амал ояд, шакли пӯстӣ пайдо мешавад, бо роҳи зидди-санитарӣ - шакли рӯдагӣ, ҳангоми нафас кашидани ҳавои дорои спораи барангезандаи бемории сӯхтанӣ - шакли аввалияи шушии беморӣ.

Давраи инкубатсионӣ 2-3 шабонарӯзро ташкил медиҳад. Баъди ба организм ворид шуданаш бактерияи сӯхтанӣ ғилофак ҳосил менамояд, ки ба фагоситоз ва бақароршавии масуният монеъ мегардад. Сироят аввал ба таври лимфогенӣ бо чамъшавии инфект дар лимфогиреҳҳои минтақавӣ, сипас ба таври гематогенӣ паҳн мегардад, ки боиси бактериемия ва сепсис мегардад.

Анатомияи эътилолӣ. Шаклҳои пӯстӣ, рӯдагӣ, аввалияи шушӣ ва аввалияи тааффунии сӯхтанӣ фарқ карда мешавад. Дар ҷои воридшавӣ доғи сурх ҳосил мешавад, ки дар маркази он ҳубобчаи дорои моеи зардобию хунрез ҳосил мегардад. Дар нагузашта қисмати марказии он не-

кроз, сиёҳ мегардад - ҳафтпӯсти сӯхтанӣ ҳосил мегардад. Лимфадениги минтақавии зардобию хунрез инкишоф меёбад.

Шакли конъюктивӣ ҳангоми воридшавии спораҳо ба мултаҳима (конъюктива) инкишоф меёбад ва бо илтиҳоби зардобию хунрези бофтаҳои чашм (офтальмит), чараёни бозгашти насчи атрофи он ҳамроҳӣ менамояд.

Ҳангоми шакли мушакии беморӣ дар шӯъбаи поёнии рӯдаи тихигӯҳ қитъаҳои васеи инфилтратсияи хунрез ва решҳо пайдо шуда, илтиҳоби зардобию хунрези он инкишоф меёбад.

Шакли аввалияи шушӣ бо трахеити хунрез, бронхит ва пневмонияи зардобию хунрези лонавӣ ё ҳамроҳшаванда тавсиф меёбад.

Барои шакли аввалияи таафунӣ падидаҳои умумии сироят ҳангоми мавҷуд набудани тағйироти мушакҳо ҳос аст.

Ҳангоми тадқиқоти гистологӣ илтиҳоби зардобию хунрези пардаҳо ва бофтаи мағзи сар бо вайроншавии девораи рағҳои хурд, кафидани онҳо, дар ковокии рағҳо чамъшавии микдори зиёди микробҳои сӯхтанӣ ошкор карда мешавад.

Марги беморони гирифтори сӯхтанӣ аз сабаби сепсис ба амал меояд.

ЛЕКСИЯИ 36 СИРОЯТҲОИ КӢДАКОНА. МАХМАЛАК.

1. Муайянкунии махмалак. Этиология ва патогенез.

2. Анатомиаи этиологӣ

1

Махмалак (аз итал. scarlatm - «арғувонӣ, қирмизӣ») - яке аз намудҳои сирояти стрептококкӣ дар шакли бемо-

рии шадиди сироятӣ бо тағйиротҳои чузъии илтиҳобӣ, асосан дар ҳалқ буда, бо паҳншавии муқаррарии дончаҳо ҳамбастагӣ менамояд.

Аксаран бо маҳмалак кӯдакони то 16 сола бемор мешаванд, гарчанде калонсолон низ метавонанд бемор шаванд.

Этиология.

Барагезандааш - стрептококки гемолитикии гурӯҳи А. Заҳролудшавӣ асосан бо роҳи ҳавой-қатрагӣ ва тавассути ашёҳои гуногун, маҳсулоти хӯрокворӣ (маҳсусан тавассути шир) ба амал меояд.

Патогенез.

Ҳангоми маҳмалак муносибати байниҳамдигарии микро- ва макроорганизм аз рӯи се самт муайян карда мешавад - заҳрогенӣ, аллергӣ ва тааффуни. Аффекти аввалияи маҳмалакӣ ва маҷмӯи аввалияи маҳмалакмонанд дар ҷои қароргирии аввалияи стрептококк (микроҳавза, гоҳо шуш) бо ҳамроҳшавии микроаденити минтақавӣ пайдо мешавад.

Маҳмалаки экстрабункалӣ - ин мавзъегирии аффе́кт ҳангоми бемории мазкур дар беруни бодмакҳо мебошад. Азбаски антителаҳои зиддизаҳрогенӣ ҳосил мешаванд, падидаҳои умумии заҳрогенӣ (долначаҳо, ҳарорат, заҳролудшавии умумӣ) то охири ҳафтаи 1-ум ва оғози ҳафтаи 2-юм (давраи 1-уми маҳмалак) пайдо шуда, падидаҳои сироятӣ-аллергӣ сар мезананд, зеро паҳншавии ҷисмҳои микробӣ аз аффекти аввалия қад-қади роҳҳои лимфавӣ ба маҷрои хун ва таҷзияи онҳо ва аллергизатсияи организм бо антилеҳои онҳо (давраи 2-юми маҳмалак) пайдо мешавад. Сепсис инкишоф ёфта метавонад, охир тағйиротҳои аллергӣ нифозати тавораҳои бофтаҳо ва маҷрои рағҳоро банд менамояд, ин бошад барои бо стрептококк олудшавии узвҳо мусоидат мекунад.

2

Анатомияи этилолӣ.

Дар давраи 1-уми беморӣ дар ҳалқу бомомакҳо пурхунии якбора мушоҳида карда мешавад, ки дар луобпардаи даҳон ва забон (забони малинагӣ) нуфуз мекунад. Аптикаи катаралӣ пайдо мешавад (бодомакҳо калон, сероб, сурхи равшан мебошан), вале дере нагузашта онро гулӯдарди (ангинаи) некрозӣ иваз мекунад (дар бофтаҳои бодомакҳо лонаҳои хокситаранг, калонҳачми некрозӣ пайдо мешаванд). Ҳангоми кандашавии моддаҳои некрозӣ решҳо ҳосил мешаванд.

Ҳангоми тадқиқоти микроскопӣ дар луобпарда ва бофтаҳои бодомакҳо пурхунии якбора, лонаҳои некрозӣ мушоҳида карда мешаванд, дар заминаи омос ва таррашӯхи фиброзӣ занҷираи стрептококкҳо, дар марзи бфотаи солим бошад- инфилтратсияи лейкоцитарӣ ошкор карда мешавад.

Ҳангоми маҳмалак лимфоденит ба назар мерасад - лимфогирехҳои гардан калон, сероб, пурхун, бо лонаҳои некроз ва инфилтратсияи зоҳиршавандаи некроидӣ мебошанд.

Тағйиротҳои умумӣ бо доначасорӣ зоҳир мегардад. Дар 2 рӯзи аввали беморӣ доначаҳо хурднукта, сурхи равшанд, дар тамоми сатҳи бадан (ба ғайр аз секунҷаи бинию лаб) мебошанд. Дар пӯст пурхунӣ, инфилтратҳои периваскулярӣ, омос, таашшӯхот, дар қабатҳои рӯякии эпителия бошад аксаран тағйиротҳои дистрофӣ, паракератоз бо некрози минбаъда мушоҳида карда мешавад.

Тағйиротҳо дар узвҳои зиёде ба назар мерасанд. Гиперплазияи В-минтақаҳо бо плазматизатсия ва метаплазияи миелоидӣ дар испурч, луобпардаи бофтаи рӯдаҳо дида мешавад.

Тағйиротҳои дистрофӣ ва инфилтратҳо дар чигар, миокард, гурдаҳо мушоҳида карда мешаванд.

Тағйиротҳои дистрофии нейронҳо ва ихтилоли хунгардиш дар мағзи сар ва гиреҳҳои асаби наботӣ ҷойдоранд.

Ин тағйиротҳо вобаста аз вазнинии чараён ва шакли махмалак дигаргун мешаванд.

Ҳангоми шакли вазнини захрогени дар ҳалқ пурхунӣ (гиперемияи) якбора мушоҳида мегардад, ки ҳатто то ба сурхрӯда паҳн мешавад. Марг дар шабонарӯзи 2-3-юми оғози беморӣ фаро мерасад.

Ҳангоми шакли вазнини тааффуни дар қисмати аффе́кт раванд характери паҳншудаи римию некрози бо ҳосилшавии думмали ақби ҳалқ, отит-артрит ва остимелити римию устухони чака, глимфаденити римию некрози, некрози бофтаҳои нарм, саҳт - бо бартарӣ дошта ни некрозо мегирад. Дар баъзе ҳолатҳои вазнин септиконемия бо метостазҳои римиюки узвҳо инкишоф меёбад.

Дар давоми 3-5 ҳафтаи беморӣ давраи дуҷум оғоз мегардад. Вай аз гулӯдарди мӯътадили назлай (катаралӣ) оғоз гашта, ҳамроҳшавии гломерулонефрити шадид ва анҷомёбӣ бо нефросклероз имконпазир аст. Ҳамчунин доначаҳои пӯст, васкулитҳо, артритҳои зардобӣ, эндокардити серозӣ мушоҳида карда мешаванд.

Тамоюлҳо аз тағйиротҳои римию некрози вобаста мебошанд, ҳоло оризаҳо ва ғавт аз сабаби истифодаи антибиотикҳо амалан дучор карда намешавад.

ЛЕКСИЯИ 37 СИРОЯТҲОИ КӢДАКОНА. ГУЛӢЗИНДОНАК.

1. *Муайянкунии гулӯзиндонак.*

Этиология ва патогенез.

2. *Анатомияи эътилолӣ*

1

Гулӯзиндонак (аз юнонӣ. diphthera - «парда, қабат») - бемории шадиди сироятӣ мебошад, ки асосан бо илтиҳоби фибринозӣ дар лонаи тақаррури аввалияи барагезанда ва захролудшавии умумӣ тавсиф ёфта, бо ҷаббиши эндотопогени микроб алоқаманд аст.

Аксаран кӯдакони аз 7 сола болотар бемор мешаванд. Этиология и патогенез.

Қаламчамикроби гулӯзиндонак ба оилаи коринобактерияҳо дохил мешавад, ки захре чудо мекунад, ки биосинтези фермиентҳои маҷмӯи нафаскаширо фурӯ менишонад ва аз ин сабаб нафаскаширо фалаҷ менамояд. Дар натиҷаи ин равандҳои холинергӣ тағйир ёфта, синтези кейс-холаминҳо халалдор мешавад ва боиси ҷамъшавии онҳо дар бофтаҳо мегардад.

Гулӯзиндонак нисбати барангезанда сирояти ҷузъӣ мебошад, зеро паҳншавии гепатогенӣ мавҷуд нест. Қаламчамикроби гулӯзиндонак дар қисмати даромадгоҳҳо афзоиш меёбад, эндотоксин чудо мекунад, ки боиси некрозӣ эпителия, васеъшавии ҳазалии рағҳо, омоси бофтаҳо ва баромадани фибриноген мегардад.

Дар зери таъсири тромбопластин фибриноген хадша мебандад ва пардаи фиброзиро ҳосил мекунад. Экзотоксин асосан ба силсилаи дилу рағҳо, асаб ва ғадудҳои болои гурда таъсир мерасонад. Ҳангоми ҷудошавии эндотоксин ҳамчунин осебҳои эпителияи гурдаҳо баамал меояд.

2

Анатомияи этилолӣ.

Тағйиротҳои ҷузъӣ аксаран дар луобпардаи ҳалқ, бодмакҳои гулӯ, роҳҳои болоии нафаскашӣ мавзӯ мегеранд.

Бодмакҳо калон, луобпарда пурхун аст, бо пардаҳои

гафси зарди сафедранг пушонда шудааст. Илтиҳоб характери фиртеритикӣ дорад.

Қабатҳои болоии эпителия мавт (некроз) шудаанд, луобпарда бо тарашшӯҳи фиброзӣ ва омехтаи лейкоцитҳо чаббида шудааст, ки дар сатҳи он губорҳои фаровонро ҳосил мекунанд. Пардаи фиброзӣ дуру дароз канда наместавад, аз ин сабаби навъи гулӯзиндонакии илтиҳоб ҳамеша бо тағйиротҳои умумӣ ҳамбастагӣ менамояд, ки аз имконияти чаббиши дуру дарози токсин вобастагӣ доранд.

Лимфагиреҳҳои минтақавӣ хеле калон шудаанд, пурхун, бо дигаргуниҳои зардранги сафеди некрозӣ ё лонаҳои сиёҳранги хуншорӣ дар буриш мебошанд.

Дар дил миокардити захрогӣ мушоҳида карда мешавад (ковокҳои дил дар дарозрӯягӣ васеъ, мушакҳо хира, дар буриш гуногунранг мебошанд).

Фалаҷи барвақтии дил ҳангоми гулӯзиндонак чудо карда мешавад, ки миокардит дар оғози ҳафтаи 2-юми беморӣ инкишоф меёбад ва боиси марг аз норасоии шадиди дил мегардад.

Дар силсилаи аввал тағйиротҳо дар асабҳои канорӣ ва гиреҳҳои асаби наботӣ мавзё мегиранд.

Аксаран торҳои асаби забону ҳалқ, симпатикӣ ва диафрагмавӣ, гиреҳи асаби III гардани синаптикӣ ва гиреҳи асаби тихигоҳии гумроҳ иллатнок мегарданд. Неврити лаҳимавӣ (парехиматозӣ) бо таҷзияи пардаҳои асаб инкишоф ёфта, цилиндрҳои меҳварӣ камтар осеб мебинанд.

Дар моддаи мағзии ғадудҳои болои гурда хуншорӣ, дистрофия ва некрози ҳучайраҳо, дар моддаи кишрӣ дигаргуниҳои хурди некрозӣ, нестшавии чарбҳо мушоҳида карда мешавад.

Дар гурдаҳо - нефрози некрозӣ, дар ҳолатҳои вазнин - некрозҳои фаровони моддаи кишрӣ. Марг аксаран аз фалаҷи барвақтии дилҳангоми миокардиоситҳо ё фа-

лаҷҳои баъдинаи дил Ӣ невритҳои паренхиалӣ фаро мерасад.

Гулӯзиндонаки роҳҳои нафаскашӣ бо илтиҳоби хунравии ҳалқ, хирной, бронҳо бо захр фиброзии ба осонӣ бартарафшаванда тавсиф меёбад, ки ҳангоми сулфазанӣ дар шакли қолабҳо аз роҳҳои нафаскашӣ чудо мешаванд. Аз ин сабаб токсин ҷаббида намешавад ва падидаҳои умумии захрогинӣ мавҷуд нестанд.

Илтиҳоби хунравии ҳалқ ҳангоми гулӯзиндонак хунравии ҳақиқӣ, паҳншавии раванд ба шохаҳои хурд-хурди бронҳо бошад - хунравии поёнраванда номида мешавад.

Оризаҳо бо истифодаи интубатсия, трахеотомия алокаманданд, ки ҳосилшавии яраҳо, сироятнокшавии дуҷумбораи онҳо имконпазир аст, ки боиси римнокшавии тағоякпардаи ҳалқ, фиенгон, медиатинити римнок мегардад.

Марги беморонро априксия Ӣ пневмонияи ҳамроҳшаванда ва тамоюлҳои римнок ба вучуд меовард.

Эмқунии ғайлолона беморшавӣ ва ғавтро аз гулдӯзиндонак хеле кам намуд.

ЛЕКСИЯИ 38 СИРОЯТҲОИ КӢДАКОНА. СУРҲАКОН.

1. Муайянкунӣ. Этиология ва патогенез.

2. Анатомиаи эътилолӣ

1

Сурҳакон (аз ихтисораи лот. тоқӣғс - «беморӣ») - бемории сироятии баландсироятпазири кӯдакон мебошад, ки бо илтиҳоби зиёдшавандаи луобпардаҳои роҳҳои болоии узвҳои нафаскашӣ, мултаҳима ва дончаҳои доғдору серпайсаи пӯст тавсиф меёбад.

Аксаран кӯдаклони аз 3 сола болотар гирифтор мешаванд, калонсолон аз сурҳакон хеле камтар осеб мебинанд.

Этиология ва патогенез.

Барангезандаи сурхакон - вируси КРН-дор буда, ба микровирусҳо дохил мешавад, андозааш 150 нм мебошад. Интиқол тавассути роҳи ҳафой-қатрагӣ ба амал меояд, ки вирус ба роҳҳои болоии узвҳои нафаскашӣ ворид мегардад. Ба таври таҷрибавӣ исбот карда шудааст, ки даромадгоҳҳои асосӣ ҳалтачаи мултаҳимавӣ мебошад.

Сараввал дар эпителияи пардаи акулетӣ вирус боиси тағйиротҳои дистрофӣ мегардад, сипас ба хун ворид мегардад, ки вирусемияи кутохмуддатро ба вучуд меоварад. Баъдан вирус дар бофтаҳои лимфоидӣ ҷойгир мешавад ва боиси азнавсозии масунии он мегардад. Вирусемия нисбатан зохиршаванда ва давомнок гардида, доначаҳо пайдо мешаванд. Бо анҷом расидани доначасорӣ пӯст вирус аз организм нест мешавад. Давомнокии беморӣ 2-3 ҳафта мебошад. Вируси сурхакон ҳолати анергияро ба вучуд оварда, зеро вазифаи таворагии эпителия, фаъолнокии фагоситарӣ ва ғайраро фруӯ менишонад.

2**Анатомияи этилолӣ.**

Илтиҳоби назлаӣ дар луобпардаи ҳалқ, хирной, бронхҳо, мултаҳима инкишоф меёбад.

Онҳо варамида, пурхун мешаванд, тарашшӯҳи луобпарда якбора баланд мегардад, ки боиси пайдоиши тимоғ, сулфазанӣ, ашкшорӣ мегардад.

Омос ва некрозҳои луобпаарда боиси ташаннучи рефлектори мушакҳои он-сабаби хунравӣ мегарданд. Ба таври микроскопӣ дар луобпардаҳо пурхунӣ, омос, дистрофияи ҳубобчавии эпителия, то некроз ва кандашавии он мушоҳида карда мешавад.

Дар рӯзи 5-уми беморӣ метаплазияи эпителияи луобпардаҳо дар ҳамвории бисёрқабата мушоҳида мегардад, ки якбора вазифаи таворагии эпителияро паст мефарорад.

Эпителия дар луобпардаи лунҷҳо мувофиқан ба дандонҳои решагии поёнӣ дар шакли доғҳои сафедранг муайян карда мешавад, ки доғҳои Билгиовский-Филатов-Коплин номида мешаванд.

Экзатема дар шакли доначаҳои доғҳои мунаввари серпайса аввал дар лунҷҳо, дар рӯй, бинӣ, бадан, сипас дар сатҳҳои қатшавандаи дасту пойҳо пайдо мешаванд.

Ба таври микроскопӣ унсурҳои доначаҳо аз қитъаҳои омос, гиперемия (пурхунӣ), экстравазатҳо бо инфилтратсияи периваскулярии лимфоситарӣ дар қабабти пистонакшакл иборатанд. Бо хун таъминшавии пӯст то дигаргуниҳои некрозӣ, падидаҳои шохсории нопурра (паракератоз) ба вучуд меояд. Сипас кандашавии дигаргуниҳои нодуруст шохронишуда ва некрозӣ ба амал меояд, ки бо пӯстпартоии лонавӣ (сабусакмонанд) ҳамбастагӣ менамояд. Дар бодомакҳо ва гирехҳои лимфавӣ макрофагҳои бузургҷуссаи бисёрҷабҳдор мушоҳида карда мешаванд.

Оризаҳо.

Аксаран дар байни оризаҳо иллатнокшавии бронху шуш дучор мегардад, ки бо ҳамроҳшавии сирояти дуюмбораи вирусӣ ва бактериявӣ алоқаманданд. Гузариши раванд ба лаҳима ба таври наздибронхиалӣ ҷойгиршудаи бронхҳо боиси инкишофи пневмонияи наздибронхиалӣ ва баъдан иллатнокшавии музмини шуш ва анҷомёбӣ бо пневмосклероз мегардад.

Ҳангоми усулҳои муосири муолиҷа чунин оризаи шуш хеле кам дучор мегарданд.

ЛЕКСИЯИ 39 **БЕМОРИҲОИ СИЛСИЛАИ ЭНДОКРИНӢ.** **ДИАБЕТИ ҚАНД.**

1. Муайянкунӣ. Таснифот.
2. Анатомиаи эътилолӣ

1

Диабети қанд (бемории қанд) - беморие мебошад, ки бо норасоии нисбӣ ё мутлақӣ инсулин асоснок гардидааст. Асоси бемориро норасоии инсулини (В-хучайраҳои) ғадуди зери меъда ташкил медиҳад.

Таснифот.

Намудҳои зерини диабети қанд ҷудо карда мешаванд: худруста, дуҷумбора, диабети ҳомиладорон ва силсилавӣ (субклиникӣ). Намуди худрустаи диабети қанд диабети навъи I (инсулинвобаста) ва диабети навъи II (инсулинновобаста) - ро дарбар мегирад.

Диабети дуҷумбора - ин беморие мебошад, ки ҳангоми бемориҳои ғадуди зери меъда (диабети панкреатитӣ), бемориҳои узҳои силсилаи эндокринӣ (акромегалия, синдроми Итсенко-Кушинг, феохромоцитом), синдромҳои худрустаи генетикӣ (атаксияи Луи-Бар, дистрофияи миотонӣ ва ғайра) инкишоф меёбанд.

Диабети ҳомиладорон ҳангоми ҳомиладорӣ оғозшуда, ҳалалдоршавии таҳаммулпазирӣ нисбати глюкоза сармезанад, дар бораи дибасти интиҳой (субклиникӣ) бошад - ҳангоми ҳалалдоршавии таҳаммулпазирӣ нисбати глюкоза дар одамони қомилан солим.

Аз ҳамаи намудҳои номбаршудаи диабети қанд тоҷикон диабети қанди худруста ҳамчун бемории муштарак баррасӣ карда мешавад.

Ба пайдоиши диабети қанд ҳамчун беморӣ омилҳои зиёди ҳатарнок таъсир мерасонанд, ки баъзе аз онҳоро шартан ба ду ғуруҳи қалон тақсим намудан мумкин аст:

ихтилолҳои аз ҷиҳати генетикӣ ҷудогонаи вазифа ва миқдори В-хучайраҳо (пастшавии синтези инсулин, ҳалалдоршавии табдили прокарин ба инсулин, синтези инсулини аномалӣ);

омилҳои муҳити атроф, ки бутунӣ ва фаъолияти В-хучайраҳоро ҳалалдор мекунад (вирусҳо, аксуламалҳои

аутоимунӣ; ғизое, ки боиси фарбеҳӣ мегардад, баландшавии фаъолнокии адренергии системаи асаб).

Ҳангоми намудҳои гуногуни диабетӣ худруста аксаран омилҳои муайяни хатар дучор мешаванд. Ҳангоми диабетӣ навъи I, ки одатан дар ҷавонон инкишоф меёбад (диабетӣ решӣ) алоқамандӣ бо сироят (титрҳои баланди антителаҳо ба вирусҳои Коксанӣ, сурхча, баногӯшаки эпидемиявӣ), тамоюли генетикӣ (мутаҳидшавӣ бо антителаҳои муайяни гистомувофиқат - B(8), B(15), DW(3), DW(4) ва ғайра), аутоиммунизатсия (мавҷуд будани антителаҳо ба B-ҳуҷайраҳо) хос аст.

Барои диабетӣ навъи II, ки аксаран дар калонсолон (солхӯрдаҳо) дучор мегардад ва диабетӣ калонсолон номида мешавад, омилҳои мубодилавии зиддиинсулинӣ ва пастшавии фаъолнокии ретсептории B-ҳуҷайраҳои ҷазирачаҳои ғадуди зерӣ меъда, ҳуҷайраҳои инуслинвобатсаи бофтаҳои аҳамияти асосӣ пайдо карда, баъзе аз онҳо аз рӯи навъи аутосомӣ-феминантӣ мерос гирифта мешаванд.

Муттаҳидшавӣ бо антителаҳои муайяни гистомувофиқат ҳангоми ин намуд диабетӣ қанд ба назар намерасад.

Ҳангоми синтези нокифояи инсулини ғадуди зерӣ меъда ҳалалдоршавии синтези гликоген, баланд шудани миқдори қанд дар хун (гипергликемия), пайдо шудани қанд дар пешоб (глюкозурия) пайдо мешавад.

Гиперилгидемимия, асeton- ва кетонемия пайдо шуда, дар хун моддаҳои пурра туршнашудаи «балластӣ» пайдо мешаванд, атсидоз инкишоф меёбад, зеро дар чунин шароит қисми зиёди қанд (глюкоза) аз ҳисоби табдилёбии ҷарб ва сафедаҳо ҳосил мешавад.

Дар натиҷаи ҳалалдоршавии мубодила ва аутогенинсулинемия ҳангоми диабет иллатнокшавии рағҳо, инкишофи микро- ва макроангиопатияи диабетӣ ба вуҷуд меояд. Ин тағйиротҳо яке аз падидаҳои аз ҳама хоси клини-

кию морфологии диабети қанд мебошанд.

2

Анатомияи эътилолӣ.

Тағйиротҳо ҳангоми диабети қанд асосан дар ғадуди зери меъда, рағҳои хунгард ва гурдаҳо ба амал меоянд. Андозаи ғадуди зери меъда аксаран хурд шуда, липоматоз ва тасаллуби (склерози) он ба амал меояд. Вазифаи инкретории В-ҳучайраҳо якбора паст шудааст, баъзе аз чазирачаҳо қоҳишёфта ва тасаллубӣ мебошанд, дигарҳо баръакс, дар натиҷаи таллофӣ гипертрофӣ мебошанд.

Бо ёрии усулҳои махсуси тадқиқоти гистохимиявӣ деградатсияи В-ҳучайраҳоро ошкор анмудан мумкин аст, ба таври макроскопи бошад ғадуди зери меъда одатан тағйирнаёфта ба назар мерасад.

Чигар аксаран каме калон аст, дистрофияи чарбии гепатоситҳо инкишоф меёбад (гликоген дар гепатоситҳо ошкор карда намешавад), инчунин фарбеҳшавии ҳучайраҳои чигар ба назар мерасад. Ҳамчун аксуламали маҷрои рағӣ ба ихтилоҳои мубодилавӣ (ниҳонӣ ва ошкор) ва дар хун гардиш намудани маҷмӯи масунӣ .макро- ва микроангиопатияи диабетӣ инкишоф меёбад.

Макропатияи диабетӣ аксаран аз атеросклерози шарёнҳои наъби чандир ва чандиру мушакӣ, микроангиопатия бошад - аз ҷаббиши лимфатикии девори рағҳои хурду кутох (иллати плазморагии гишо) дар ҳамбастагӣ бо аксуламалҳои эндотелия ва перителия, ки бо тасаллуб (склероз) ва гиалиноз анҷом меёбад, иборат аст.

Микроангиопатия ҳангоми диабет характери мутамарказ дорад ва дар гурдаҳо, шабакияти чашм, пӯст, луобпардаи роҳи меъдаву рӯда, ғадуди зери меъда, мағзи сар, машина, системаи канории асаб ва дигар узвҳо мушоҳида карда мешавад.

Микроангиопатияи диабетӣ дар гурдаҳо нисбатан

зохиршаванда аст ва баъзе падидаҳои хоси морфологии хуро дорад.

Вай бо гломерулонефрити диабетӣ тавсиф меёбад, ки метавонад дар шаклҳои ўкдавӣ, мунташир ё камхунӣ, инчунин «компоненти тарашшӯҳӣ» («кулоҳчаҳои фибринӣ» ва «иллати капсулярӣ» зохир гардад.

Ҳамчунин микроангиопатияи диабетӣ метавонад дар шакли гломерулонефрити диабетӣ зохир гардад, вале он кам дучор мегардад. Асоси ин тағйироти гурдахоро пролифератсияи ҳуҷайраҳои калобачаҳо дар ҷавоби тезшавии мезанглия бо маҳсулоти «бластони» мубодила ва мсаҷмӯи масунӣ, ҳамчунин ҳосилшавии зиёд ё моддаи гишомонанд ташкил медиҳад. Дар фарҷом гиалинози мезанглия ва мавти калобачаҳо ба назар мерасад.

Гломерулосклерози диабетӣ зохиршавии муайяни клиниро дар шакли синдроми Книсмелстил, Уникон дорад, ки бо протеинурияи баланд, омосҳо фишорбаландии шараёнӣ зохир мегардад.

Микроангиопатияи диабетӣ ҳангоми дар гурдаҳо пайдо шуданаш морфологияи хос дорад. Дар девори шараёнҳо, махсусан навъи мушакӣ гипогранулемаҳо пайдо мешаванд, ки аз макрофаҳо, гипофаҳо ва ҷисмҳои бегонаи бузургҷусса иборатанд. Ҳамчунин барои диабет пайдоиши инфилтратсияи ҳуҷайраҳои ҷарбии силсилаи истиомакрофагӣ (испурч, ҷигар, лимфагиреҳо) ва пӯст хос аст.

Оризаҳо

Оризаҳо ҳангоми диабети қанд зиёд ва гуногунранганд. Бо ангиопатия чунин оризахое ба мисли қаросони дасту пойҳо, сактаи миокард, норасоии гурдаҳо, нобиноӣ алоқманд аст. Аксаран сирояти римнок инкишоф ёфта, бемории сил бо мутамарказияти раванд ва бартарияти тағйиротҳои тарашшӯҳӣ хуруҷ мекунанд.

Фавт ҳангоми диабет аз оризаҳо (аксаран аз қаросо-

ни дасту пойҳо, сактаи миокард, уремияи бо сироят ори-
здоршуда) фаро мерасад. Иғмои диабетӣ ҳоло хеле кам
дучор мегардад.

ЛЕКСИЯИ 40 БЕМОРИҲОИ СИЛСИЛАИ ЭНДОКРИНӢ. БЕМОРИҲОИ ҒАДУДИ СИПАРШАКЛ.

1. Муайянқунии ҷоғар Таснифот.
- 2 Ҷоғари Хашимито, ҷоғари Редил

Дар байни бемориҳои ғадуди сипаршакл ҷоғар (стру-
ма), тиреоидитҳо ва омосҳо ҷудо карда мешавад. Тамоми
ин бемориҳо бо гипертиреоидид (тиреотоксикоз) ё гипо-
тиреоидит ҳамбастагӣ менамоянд.

1

Ҷоғар (струма) - бемории ғадуди сипаршакл мебошад,
ки калоншавии мунташир (ҷоғари мунташир) ё укдагии
(ҷоғари укдагӣ) ба вучуд меояд. Ҳамчунин ҷоғари мунта-
ширу укдагӣ (омехта) ҷудо карда мешавад. Аз рӯи сохти
гистологӣ ҷоғар коллоидӣ ва лаҳимавӣ (паренхиматозӣ)
мешавад.

Ҷоғари коллоидӣ аз фолликулҳои андозаашон гуно-
угн сохта шудааст, ки бо коллоидҳо пуранд.

Вобаста ба андозаи фолликулҳо ҷудо карда мешавад:
ҷоғари макрофолликулярӣ коллоидӣ -фолликулҳои
калони кистамонанд, эпителия дар онҳо ғафс шудааст;

ҷоғари микрофолликулярӣ коллоидӣ - фолликулҳои
хурд;

ҷоғари макро- ва микрофолликулярӣ - дар баробари
фолликулҳои калон хурд низ дучор мешаванд.

ҷоғари макро- ва микрофолликулярӣ - дар баробари
фолликулҳои калон ва хурд низ дучор мешаванд.

Дар чоғари коллоидӣ баъзан ҳуҷайраҳои эпителии инкишоф ёфта шакли пистонакро ба худ мегиранд, ки онро чоғари инкишофёбандаи коллоидӣ меноманд. Баъдтар дар таркиби ғадуди чоғар бо хун таъминшави ҳалалдор мешавад, некроз дида мешавад. Дар таркиби бофта оҳакнокшавӣ ба амал меояд, дар байни фолликулаҳо бофтаи пайвастананда инкишоф меёбад баъзан устухон пайдо мешавад.

Чоғари паренхиматозӣ бо инкишофи эпителии фолликулаҳо фарқ мекунад, ки дар натиҷа фолликулаҳои ҳаҷман хурди бе коллоид ё коллоидашон кам пайдо мешаванд.

Аз ҷиҳати сабаб ва хусусиятҳои клиникию-морфологи намудҳои зерини бемории чоғарро фарқ мекунам:

Чоғари эндемикӣ – ин беморӣ дар одамоне пайдо мешавад, ки дар ҷойҳои аниқу муайян истиқомат мекунам. Сабаби пайдоиши бемории чоғар кам будани йод дар таркиби оби нушокӣ мебошад. Ғадуди сипаршакл ҳаҷман калон мешавад, сохти коллоидӣ ё лаҳимагӣ дорад. Дар ин ҳолат вазифаи ғадуд суст мешавад. Мавҳуми критинизми эпендимиро ҷудо мекунам, ҳангоме, ки бемории чоғар дар қудакон пайдо мешавад, дар онҳо инкишофи сусти умумии ҷисмонӣ ва ақлӣ мушоҳида карда мешавад.

Чоғари торадикӣ дар синни ҷавони ё дар синни пас аз бабалоғатрасидан пайдо мешавад. Ин намуди бемории чоғар ба организми одам таъсири муайян намерасонад. Лекин ҳангоми нисбатан инкишофёбӣ узвҳои ҳамсояро ба монанди: сурхреда, хирной, ҳалқро пачақ мекунад, ки дар натиҷаи вазифаи он узвҳо ҳалалдор мекунад. Метавонад чоғари – базедовӣ ба амал ояд, дар ин ҳолат бофтаи рейпешкунандаи фолликулаҳо хуруҷ мекунад дар пайкари ғадуди сипаршакл инфилтрат ҷамъ мешавад.

Чоғари захрноки диффузӣ (бемории Базедов, бемории Грейв). Сабаби пайдоиши ин беморӣ аутоинсулинизант-

сия: ауто - антителиаҳо мебошад, ки даррокҳои тироситҳо-ро асетилнок мекунад. Аз ҳамин сабаб ин бемориро ба бемории антигении даррокҳо дохил мекунад. Барои бемории ҷоғари захрноки диффузӣ хусусиятҳои хоси морфологиро фарқ мекунад: инкишофи пистонакшакли хучайраҳои бофтаи рейпешкунандаи призмашакли фолликулаҳо, инфилтратсияи пайкари ғадуд, пайдошавии фолликулаҳои ҷавон бо маркази афзоиш бо нишондодҳои клиникӣ (тиреотоксикоз бо осебҳои дил, чигар, силсилаи асаб ва ғайра).

2

Ҷоғари Хашимото -ин бемории ҳақиқии аутоимунӣ мебошад.

Ҷоғари Ридел бо хусусиятҳои хоси худ фарқ мекунад: лаҳми ғадудро бофтаи фиброзӣ ишғол мекунад, дар натиҷа пайкари ғадуди сипаршакл мустаҳками саҳти сангмонанд мешавад («ҷоғари оҳанин»).

Баъзе мутахассисон ҷоғари Хашимото ва ҷоғари Риделро ба гурӯҳҳои алоҳидаи тиреодитҳо ҷудо мекунад.

МУНДАРИЧА

	МУҚАДДИМА.....	3
ЛЕКСИЯИ 1	Патологияи сохти микроскопии хучай- раҳо.....	4
ЛЕКСИЯИ 2	Маълумоти умумӣ дар бораи дистро- фияҳо. Дистрофияи паренхиматозӣ.....	9
ЛЕКСИЯИ 3	Дистрофияи мезенхималӣ.....	19
ЛЕКСИЯИ 4	Дистрофияи омехта.....	31
ЛЕКСИЯИ 5	Вайроншавии гардиши хун.....	43
ЛЕКСИЯИ 6	Тромбоз. Эмболия.....	49
ЛЕКСИЯИ 7	Сакта. Вайроншавии гардиши лимфа...	58
ЛЕКСИЯИ 8	Маълумоти умумӣ дар бораи омосҳо. Эпидемиология. Омосҳои эпителиалӣ..	63
ЛЕКСИЯИ 9	Омосҳои ғайриэпителиалӣ. Омосҳои мезенхимиалӣ ва бофтаи Меланин- хосилкунанда.....	86
ЛЕКСИЯИ 10	Омосҳои бофтаҳои хунофар ва лим- фоидӣ.....	93
ЛЕКСИЯИ 11	Бемориҳои тарбодӣ. Тарбод. Нуксон- ҳои дил.....	100
ЛЕКСИЯИ 12	Эътилоли хучайраҳои хун ва мағзи хун. Камхунӣ.....	108
ЛЕКСИЯИ 13	Эътилоли хучайраҳои хун ва мағзи ус- тухон. Лейкозҳо. Лимфогранулематоз..	111
ЛЕКСИЯИ 14	Бемориҳои узвҳои ҳозима. Гастрит.....	114
ЛЕКСИЯИ 15	Бемориҳои узвҳои ҳозима. Решмараз...	117
ЛЕКСИЯИ 16	Бемориҳои узвҳои ҳозима. Аппендисит (илтиҳоби кирмрӯда).....	120
ЛЕКСИЯИ 17	Саратони узвҳои ҳозима.....	122
ЛЕКСИЯИ 18	Бемориҳои чигар. Гепатитҳо.....	129
ЛЕКСИЯИ 19	Бемориҳои чигар. Таллайюф.....	133
ЛЕКСИЯИ 20	Бемориҳои гурдаҳо. Гломерулопатия...	135
ЛЕКСИЯИ 21	Бемориҳои гурдаҳо. Амилоидози гур- даҳо. Тубулопатия.....	140
ЛЕКСИЯИ 22	Бемориҳои узвҳои танусол ва гадудҳои сина.....	142
ЛЕКСИЯИ 23	Иллатҳои ҳомиладорӣ ва давраи баъди ҳомиладорӣ.....	148

ЛЕКСИЯИ 24	Мафҳуми бемориҳои сироятӣ. Ақсула- малҳои ҷузъӣ ва умумӣ ҳангоми сиро- ятҳо. Сепсис.....	153
ЛЕКСИЯИ 25	Сирояти редаҳо. Вабо, Салмонеллезҳо.	157
ЛЕКСИЯИ 26	Сирояти редаҳо. Исҳоли хунин. Дома- на.....	160
ЛЕКСИЯИ 27	Бемориҳои узвҳои нафаскашӣ. Брон- хопневмония.....	163
ЛЕКСИЯИ 28	Бемориҳои узвҳои нафаскашӣ. Брон- хопневмонияи ҳуноқӣ. Саратони шуш- ҳо.....	166
ЛЕКСИЯИ 29	Бемории сили аввалия.....	170
ЛЕКСИЯИ 30	Сили гематогенӣ.....	175
ЛЕКСИЯИ 31	Сили дуҷумбора.....	178
ЛЕКСИЯИ 32	Сифилис (оташак).....	181
ЛЕКСИЯИ 33	Бемориҳои шадиди респираторӣ.....	185
ЛЕКСИЯИ 34	асбаи эпидемиявӣ. Туляремия.....	189
ЛЕКСИЯИ 35	Тоун ва бемориҳои сеҳтанӣ.....	193
ЛЕКСИЯИ 36	Сироятҳои кедакона. Маҳмалак.....	196
ЛЕКСИЯИ 37	Сироятҳои кедакона. Гулезиндонак.....	199
ЛЕКСИЯИ 38	Сироятҳои кедакона. Сурҳакон.....	202
ЛЕКСИЯИ 39	Бемориҳои системаи эндокринӣ. Диа- бети қанд.....	204
ЛЕКСИЯИ 40	Бемориҳои системаи эндокринӣ. Бемо- риҳои ғадуди сипаршакл.....	209

Барои бақайдгири

АНАТОМИЯИ ЭЪТИЛОЛӢ

(ПАТОЛОГӢ)

Курси лексияҳо барои донишгоҳҳои тиббӣ

Ба матбаа 28.02.2011 супорида шуд. Ба чопаш 88.03.2011 имзо шуд.
Чопи офсет. Коғази офсет. Андозаи 60x84 $\frac{1}{16}$, 13 ҷузъи чопӣ
Супориши №30. Адади нашр 200 нусха.

Дар матбааи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон
ба номи Абӯалӣ ибни Сино ба таъъ расид.
ш. Душанбе, хитбони Рӯдакӣ -139